

新杏簪谈

巫君玉 著

北京新杏簪书店出版

(京)新登字 207 号

图书在版编目(CIP)数据

瓣杏医谈/巫君玉著. —北京:北京科学技术出版社,
1996.5

ISBN 7-5304-1797-5/R·336

I. 瓣… II. 巫… III. ①中医学:临床医学·经验②医话
IV. R24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 13985 号

北京科学技术出版社出版
(北京西直门南大街 16 号)
邮政编码:100035

*

各地新华书店经销
秦皇岛市卢龙印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 32 开本 11.75 印张 264 千字
1996 年 5 月第一版 1996 年 5 月第一次印刷
印数 1-5000 册

定价:15.60 元

冯 序

我与巫君玉兄是无锡同乡，但我们却是在北京认识的。那是1955年下半年，经过朋友的介绍，请君玉兄来给我看病，无意中在我的书桌上看到了无锡友人严古津的来信，原来古津也是他的朋友，这样我们不仅是同乡，而且更是朋友了。从那时起直到现在，我们相交已整整40年。

君玉兄是名医，不仅仅现在是，就是在那时，他也已颇为同道所推崇了。那时，人民大学校医室有位中医赵大夫，他经常给我说巫大夫的脉案好，了不起，很少有人能到这样的水平的。只要他一搭上脉，就能对你的病情了如指掌！这是这位赵大夫常常给我这么说的。

君玉不仅是名医，更是诗人，他写诗很有功力，而且十分勤奋。所以后来，并非为了看病，往往为了诗，为了书画，也经常在一起。因为君玉还写得一手很好的文征明的行书，还能作泼墨画。

1966年的“文化大革命”，把我们各自都投入了灾难。“文革”一开始，我就在人民大学受到了冲击，但我丝毫也没有想到一个医生，象君玉兄这样的优秀医生，竟然也会受到冲击！那是医院里的另一位好友，也是君玉兄的崇拜者专门来偷偷告诉我的，后来我到医院去看病，果然见不到他了，据说已经全家被遣回无锡了。而且回去时处境很困难。从此我日日夜夜地惦记着他，不知道究竟是为了什么？但有一点我是十分清楚的，他绝不会有什问题，说他有问题，无非是为了要整他

故意编出来的。

“文革”的发展越来越失控了，全国爆发了武斗，就在这使人朝夕悬悬的时候，又一个消息传来说君玉不幸了！这对我是一个晴天霹雳，几乎把我震呆了。除了伤痛外，我已经不能用头脑来思维、来辨别了，一连好多天我几乎难以自持。过了些时日，我的理智大概恢复了一些了，忽然我想到这不可能，一个人人皆称赞的良医，怎么会有这种可能呢！我的思路往这方面一想，顿时天地宽了，愈想愈觉得不可能，于是我一直在盼望着奇迹的出现。

1969年我下放到江西余江干校，我自己说我真正“来作江西社里人”了，但这个社，不是黄山谷的江西诗社，而是人民公社。1971年我探亲回北京，路过无锡，先在无锡停留几天，当我已买好回京车票，午饭后就要上车的时候，忽然听到邻居说，东埭来了一位名医，是北京来的，诊脉好得不得了。这三句话，顿时使我想到，这必定是他。我就问，你知道这位医生的名字吗？他说不知道，只晓得姓“巫”！这一下我高兴得跳了起来，连忙叫亲戚去退火车票，这顿饭也没有心思吃了，立刻就请亲戚陪同我去东埭。

经过不少周折，大概我们是下午2时多到东埭的，找到了医院，我就直接问传达室巫大夫的诊室，然后直奔目标。到了诊室门口，只见长长的候诊队伍，君玉正背向着我在仔细地给病人诊脉。这一下什么疑虑都消失了，我好象突然得到了什么似的，反而放心了，不忙去惊动他了。我耐心地等他看完了一个病人后，就轻轻地走进去拍拍他的背，他毫无意地回头一看，却忽然看到我，真是“乍见翻疑梦”，他一时竟说不出话来。停了一回，他方才说，我要看完这许多病号，请你先到家里坐一会儿罢。于是他立即把我引到家里，又匆匆赶回诊室。到

傍晚的时候，他才下班回来。前后5年的睽违反而一时不知从何说起。他留我吃了晚饭，才匆匆让我赶回城里。回到北京，我写了一首赠他的诗：

蓟门风雨与君同，湖海十年西复东；

谣诼曾挥旧交泪，短筇每忆故人风；

堂堂应向天涯在，落落何妨一壺中；

细雨布帆彭泽路，五湖烟水恰相逢。

此诗平仄多有未叶，只是记一时兴感而已。自从这次我亲眼见到了他，还与他共餐长谈后，我好象放下了一个沉重的包袱，感到轻松多了。1972年我从干校回来，就特地到东垞去看他。他约我到东垞公社去看他的朋友杨甲，办公室就紧贴在太湖边上。杨甲是公社工业书记，是码头搬运工出身，身体魁梧，体力过人，性格豪爽，而又颇能脱俗。当天晚上，杨甲拿了一壶酒，提了马灯，背了竹篓，带我们到湖边捉螃蟹。我们在湖边坐下，一边喝酒，一边等螃蟹来看灯光。果然不到10分钟，螃蟹就爬来了，杨甲尽拣大的抓，小的就掷回湖里去，大约不到1小时，就足足装了一篓子，估计有30多只大螃蟹，于是决定第二天来一次螃蟹宴。第二天清早，杨甲又让我们上小机船游五里湖，这也就是传说范蠡五湖泛舟的地方。清早，湖面上雾气濛濛，一切都在朦胧中。我们上了小船，轻飘飘地就向湖心滑去。小机船是用马达发动的，所以一路上冲波踏浪，发出达达达的响声，震得湖面上有如滚动着阵阵轻雷，划破了静谧的湖面。不想却惊动了水底的游鱼，吓得它们直向空中乱蹿，有时接连几条一二尺长的大鱼从头上飞过，而且连续不断，有时竟掉进船舱里来。我们在五里湖只小小的绕了一圈，就掉进舱里几条尺来长的大鱼。于是中午既有蟹又有鱼，真正是鱼米之乡。可惜在80年代初，杨甲却因肝病去世了，我每次与君玉兄

回忆起这段经历，都要发出深深的感叹！关于这次五湖之游，君玉兄很快就寄我以诗，诗云：

鼋渚山前一日游，崖寒风急素波秋；

至今情趣未消尽，半逐轻云落蓟州。

那时，君玉仍在东峰，我已从干校回到了北京。于是朋友们都想念他，尤其是许多病人，常到医院里探询，打听巫大夫什么时候回来，有的病员竟发出呼吁，要求把巫大夫请回来。1977年春天，我又接到君玉寄来的诗《春暮怀其庸兄》，诗云：

江南又见柳华滋，正是忆君最剧时；

迷眼新花春欲暮，牵心旧梦觉还迟；

家山不买五湖宅，市阁忍听陌路歧；

人我因循两未就，燕支明月引深思。

其实，这时也正是北京的朋友和病友最想念他的时候，大家都盼着他回来。

终于，君玉于1979年重回北京了，他本来就什么问题也没有，这次回来，仍旧还他一个清清白白。

前些年，我在主编《红楼梦大辞典》，其中有不少医药和疾病方面的条目，这叫一般的人是做不了的，我就请他帮忙，他在百忙中慨然答应，于是这部辞典里有关医药方面的条目，就有了最好的撰写者。

君玉兄不仅从不间断业务，时时为病人服务，有时家里也病人求诊不断，但君玉兄还潜心于钻研学问，对于医古文文献的研究和临床经验的总结，从未松懈，因而他积累了不少宝贵的经验。他的这些论文，就是他数十年钻研的心得结晶。

与此同时，君玉兄的诗集也将刊行了。前些时候，我有幸先睹为快，拜读一过。我惊叹他在这样忙碌的情况下，居然积下了厚厚的一大本诗集，而且诗写得极好，我就自愧不如。我

看现在大学教授中能有这样功力的人也不会很多。我读完了他的诗集，结合我平时对他的了解，随手题了一首诗，作为我与他40年相交的一个认识的概括，现在就抄在下面，作为本文的结束：

已是杏林第一伟，吟诗又见月当头；
平生风味陶彭泽，雨暴风狂立乱流。

冯其庸

1995年4月6日夜，岁在乙亥上

巳后三日，于京华瓜饭楼

自序

此集之作，大都始于70年代，时因“文革”南贬，僻处湖隅，赖邑长乡亲护持，藉免灭没而得业所素业，自以县城下工，无复问世之望，此第为同道、同学间研习而记耳，1979年重返都下，出长鼓楼中医院，进而分领京华医事，亲褚墨者盖稀，1987年得还就故业，稍复续笔，迄今计之，前后已20有余年矣。同学诸君中亟欲以此刊布者，因求50年代而后已刊、已发之文，合为一集，名之曰医谈，盖总40余年学习之识悟、临床之实践而铄累寸积者也，以其命笔随意，掇多作少，故篇则或短或长，词则或文或白，曰论曰话，均不成例，不若径名“医谈”之为得也，况乎譬如春蚓秋虫，正不欲掩其随时之情也哉。私心所有望者，或可藉微言以通大义，得薪积而后居上，此固势之必然者也！夫医效之求，累世皆作，自否定之定律而观之，后之进者能得宏扬华夏之学，则虽斯集之复祇亦何憾焉！

巫君玉

1994年春识于京华寓所之瓣杏斋

目 录

痧症和刮痧疗法	(1)
感冒	(4)
伤寒	(7)
尿路结石	(12)
乙脑浅见	(17)
中医学中的整体观念	(20)
急性支气管炎辨证随谈	(30)
五行说与中医学	(33)
眩晕	(46)
漫谈肝炎	(50)
对三焦的探讨	(56)
中医学对“阴阳”的运用	(66)
肠病	(72)
一、痢疾	(73)
二、肠风	(77)
三、便秘	(78)
四、虫病(附:钩虫病)	(80)
头痛	(84)
中风	(87)
对脾的认识	(92)
脾胃病的诊治体会	(99)
表证辨治三要	(106)

卫、气之分用药有别	(108)
溃疡病可参用外科治法	(109)
“失水”之治应找捷径	(110)
直中三阴症	(112)
梦渡梦飞	(113)
敏于听者多虚	(113)
治虚人呕泄养重于药	(114)
瘧症之治	(115)
同药不同效其因诸多	(116)
药证相符宜守方	(116)
“医者意也”辨	(117)
“长夏”说	(118)
冬不藏精说	(119)
伏气说	(120)
前人论喉症虚实之治	(121)
梅核气	(121)
对“溃疡病”辨证论治的管见	(122)
慢性胃炎浅识	(128)
健脾益气治疗笔谈	(133)
河间学说的渊源与成就浅探	(135)
外感热病表证的辨证	(139)
冬令进补琐谈	(148)
谈外邪发病及其化热	(152)
外感热病前期辨治续谈	(158)
学习《素问·四气调神大论》	(171)
学习《素问·金匱真言论》	(177)
学习《素问·灵兰秘典论》	(189)

学医读书之道	(194)
《内经》成书时期说	(195)
通过反鬼神观点看《内经》的唯物思想	(196)
“若火熏之”我识	(199)
小议暑症“汗出而散”	(206)
从仲景条文谈“热入血室”的辨治	(201)
论麻杏甘膏汤证	(208)
大青龙汤多面观	(210)
少阳丛谈	(212)
脉学管见	(220)
脉诊记识	(234)
一、孕脉	(234)
二、滑脉	(235)
三、弦脉	(236)
四、长脉	(236)
五、濡脉主表湿	(236)
六、扎、革脉之异同	(237)
七、无根脉	(237)
八、来去至止	(239)
九、辨脉在于习	(239)
十、浮中沉定脉法及举按寻	(240)
十一、寸关尺之据	(241)
十二、脉之神气、胃气	(242)
色诊琐谈	(242)
舌诊记要	(244)
以茵陈蒿汤为主治疗黄疸的疗效观察和体会	(246)
82例传染性肝炎疗效观察	(251)

柿胃石病案报告	(258)
60 例上消化道出血的临床观察	(261)
9 例破伤风治疗小结	(271)
医案三则	(276)
一、健脾益气法治愈十二指肠溃疡案	(276)
二、肝硬化腹水案	(278)
三、补气摄血法治愈过敏性紫癜案	(280)
阑尾脓肿 9 例小结	(282)
慢性腹泻的治疗	(287)
对“热入血室”的虚实辨治	(291)
术后呃逆病案二则	(295)
石淋虚实辨证	(297)
中药配合动脉导管结扎治愈巨块型肝癌 1 例	(302)
肺癌诊治管见	(305)
越鞠丸义解	(311)
越婢义解	(311)
治痢用血药	(312)
治痢用涩药一得	(313)
黄连阿胶汤治肠溃疡	(313)
狗肉治疟	(314)
南北用药异同	(314)
“异法方宜”新证	(315)
灵芝五色变化为其生化过程	(316)
三七可行血	(317)
地黄肭肭种神	(318)
药品之效因产地异	(319)
药性有新效	(319)

“雪上一枝蒿”中毒例	(320)
“白常山”无截疟之功	(321)
煎药宜讲求	(322)
中药有过敏	(323)
草药有捷效	(324)
四日疟	(332)
曾见异病	(333)
惊吓气厥	(334)
附文	(335)
温课小启	(335)
《中医内科急症》跋	(335)
《伤寒研究》小序	(336)
《倚云轩医话》序	(337)
《北京郊区县中医院论文集第一辑》序	(338)
《“正气存内”与“意导”》文按	(341)
《北京郊区县中医院论文集第二辑》序	(342)
扬长避短,增强内在活力,开拓中医事业	(343)
《温病条辨》方歌诀叙	(354)
《当代中医实用临床效验方》小序	(355)
发展中医的几个认识问题	(356)
后记	(361)

痧症和刮痧疗法

痧症是夏、秋季的多发病，发作暴急，变化迅速，大致症状是：头昏身倦，胸腹烦满，一般无很高的寒热，或腹痛、或吐泻、或四肢青紫厥冷、或神志昏乱、或抽风、发疹等变症极多，但并非悉见，甚则可于数小时内致人死亡。此病流行很广，不特闽、浙等地数数流行，北京地区亦常有发病，根据《痧胀玉衡》“润州因而谓非药可疗”的记载，则东北地区亦有此病。由于地区不同，本病的名称亦多样，王养吾说：“在北曰青筋、风马头瘟，江浙则为痧，闽广则为瘴气，其实一也。”吴鞠通亦说：“俗名发痧，又名干霍乱。”此外尚有“白虎病”、“绞肠痧”等名称。本病是由秽气、暑气、伏热、寒气冰伏过时、郁为火毒等等所引起，总之，是疫疠之气所引发的疾病。在没有痧症这一名称以前，混杂于霍乱、中恶、瘟疫等病中论述。从症状对比，本病与夏、秋季的胃肠道疾患、中暑等接近。对本病的治疗，分刮、放、药三法。其中刮痧法经济简便，又有捷效，在劳动人民中流行最广、最久，有推广的必要。

刮痧起源于何人，目前无从查考，微以园说是“针灸遗意”，最早见于文字记载的是《景岳全书》的“刮痧新按”，此是痧症名称的最早记录，此后在《痧胀玉衡》、《痧症全书》、《沈氏尊生》、《温病条辨》、《医钞类编》等书中均有记载；由此可知，刮痧疗法由来已久。操作方法大体上有两种，郭右陶说：“背脊颈骨上下及胸前肋肋、两背肩臂痧，用铜钱蘸香油刮之，或用刮舌刮子脚蘸香油刮之；头额、腿上痧，用棉纱线蘸香油刮之；大、小腹软肉内痧，用食盐以手擦之。”王养吾所记刮法与此相同。另一种是刘松峰新定刮法：“脖项后当中洼处刮一道；脖项

后左右大筋上各刮一道；前身两肩下、肘上软肉缝各斜刮一道；两肋肋软缝中左右各斜刮三道；左右肩靠着肩并软肉处各刮一道；背脊骨两旁竖刮，自项下至腰各刮一道；背后肋肋软缝中左右各三道。以上皆用钱蘸盐水刮之。两臂内用蒜藤一缕、燃松绳，蘸水刮之，但要出痧，红紫为度。诸穴（指各刮处）并治一切痧症，唯蒜藤刮臂弯专治眩晕恶心痧。若非痧症，刮之亦不红紫。”

以上两种刮痧法，从部位上看出出入不大，只是后者具体一些。目前通常所用的刮痧部位为：后项中线，两侧线，后背中线（由大椎穴至腰椎），两侧线至肩胛下缘至肋尽处，两肩自颈至肩尖，以之比较古法背部位置，亦无很大出入，其他如前胸、前膊、腹部等处，目前比较少用，腹部只在腹痛剧烈时用，前项是在胸闷、咽紧时用，前额、鼻梁部是在头昏痛时用，并且项、额、鼻梁均为用手、食指加以提捏至出红痕为止。用具：目前用瓷碗、铜钱者多，不用棉线或蒜藤，至于刮舌刮子脚，因南方人不习惯刮舌而无此物，故以河北地区为多用。用香油、盐水的目的，是为了使皮肤滑润，防止碗口或铜钱磨伤皮肤；目前多数使用香油，因其滑润胜于盐水；亦有用滑石粉替代者。

刮痧之所以能治疗疾病，张景岳说：“盖五脏之系咸附于背，故向下刮之则邪气亦随而降；凡邪气上行则逆，下则顺，改逆为顺，所以得愈。”吴鞠通说：“刮则其血皆分，住则复合，数数分合，动则阳生，关节通利而气得转，往往有随手而愈者。”由此可知，经络中的气机得到通畅而正常运行，就是治愈疾病的机理。从经络上看，后背不独是五脏之系，六腑的俞穴也有所系，并且，所刮的三道直线，正是督脉和太阳经所过。太阳主表，主头痛、脊痛，主一身之表的阳气；督脉总督诸经，主少腹冲心作痛；俞穴是各脏腑经气输转的地方，以俞穴治脏腑诸疾

是针灸学的常理，所以腹胀、胸闷、吐泻绞痛、头昏呕恶等可以因刮而愈。根据经验，胸脘痞闷多刮背的上半部，腹部胀痛多刮背的下半部，往往可收到腹中鸣响而病愈的良效。《景岳刮痧案》记载：“荆人四旬，八月终患呕吐、胸腹满痛，盐汤探吐不效而愈甚，至声不能出，忆有刮痧法，乃用瓷碗蘸温水与油刮背心，良久，觉胸中胀滞渐有下行之意，稍见宽舒，始能出声，顷之腹中大响，泻如倾而痛减，得睡一饭顷。”此正是经络脏腑之气得通的具体描述。由此看来，背部较其他部位在刮痧疗法中占有更重要的位置。他处之刮，不过一经或数经之气得利，背部则脏腑表里之气俱可因刮而利，所以张景岳曾指出：“虽近有两臂刮痧之法亦能治痛，然毒深病急者，非治背不可也。”

刮痧法虽然是治疗痧症普遍运用的方法，但还不是治疗痧症唯一的方法，只是刮、放、药三法中的一法，《痧症全书》说：“痧感肌表，人不自知则入半表半里，故胸中作闷，或作呕吐而腹痛生焉，此可焮刮而愈；痧毒入里，故欲吐不吐，欲泻不泻，冲心则心胸大痛，攻腹则盘肠吊痛，可放痧而愈。”“痧阻于气分宜刮，壅于血分宜放。”“在肤里发不出者则用刮。”《痧胀玉衡》说：“痧入于气分而毒壅者宜刮，痧入于血分而毒壅者宜放。”“肌肤间痧，用油、盐刮之，则痧毒不内攻；血肉痧，看青紫筋刺之，则痧毒有所泄。”“其有在血、在脏、在腑者，非刮能愈。”由此可知，刮痧法是邪在气分、在表或在半表半里之时应用的；如果邪入于血，宜用放痧法（针刺及针刺放血）；邪气入脏入腑的重症，宜用药治。不过，刮痧法在畅通经络气机，使正气奋发的机制方面，是对各种痧症均有利的，不会引起副作用或其他不良情况，仅仅是疗效因邪犯深浅而有所不同，所以可以放心运用。

痧症发病暴急，变化迅速，在此情况下往往鉴别困难，《痧

张玉衡》和《痧症全书》两本专著中，又据症状不同列出很多痧症名称，未免繁散杂乱。徵以园的按语中记有试痧法：“以生黄豆嚼之，不腥者痧，腥者非痧。”民间流传的另一种试痧法是：吃生芋艿不麻者为痧。此方不唯试痧，并且能作痧症的治疗药，故一并附记于此。

本病的禁忌较多，龙眼、大枣、桃、李、杏、菱、辣酱、胡椒、粉条、面筋、糯米、猪肉、羊肉、鸡肉、鱼肉及茶、酒、醋、姜等，占人均列入禁忌。总之，生冷粘腻厚味等食品，以及辛辣、酸涩之味在所不宜。由于痧症是秽浊郁结，气血不畅，邪气实而正气滞，上述食品确有不宣，如若不忌，则引邪深入，助纣为虐；就是愈后，也以易消化少渣的食物、小量多次进食为宜。

（本文系 60 年代初为《健康报》所写科普文，压缩后刊出。）

感 冒

感冒，通常亦叫做伤风，如果病情重于一般感冒的叫重伤风，它包括了近代医学中的“上呼吸道感染”和“流行性感冒”等病。顾名思义，感是感受时邪，冒是冒于风寒，因而感冒的发病主要因素是气候的寒暖失常。只要人体抵抗能力不能适应气候的变化，不论什么季节均可发病，所以中医书中通常称为“四时感冒。”

由于四季气候不一，人体素质也有不同，所以感冒的见症也就不同，感冒的一般症状是：恶风寒，发热，头痛头昏，鼻塞作嚏，流涕，嗓子干痛，始而无汗，继而有汗，再而咳嗽。张景岳说：外感“邪轻而浅者，止犯皮毛，即为伤风，皮毛为肺之合而

上通于鼻，故其在外则为鼻塞声重，甚者并连少阳、阳明之经而或为头痛，或为憎寒发热，其在内则多为咳嗽，甚则邪实在肺而为痰为喘。有寒胜而受风者，身必无汗而多咳嗽，以阴邪闭郁皮毛也；有热胜而受风者，身必多汗、恶风而咳嗽，以阳邪开泄肌腠也。有气强者，虽见痰嗽，或五六日，或十余日，肺气疏则顽痰利，风邪渐散而愈也；有气弱者，邪不易解而痰嗽日甚，或延绵数月，非用辛温必不散也；有以衰老受邪而不慎起居，则旧邪未去，新邪继之，多致终身受其累，此治之尤不易也（《景岳全书·杂证谟·伤风》）。”至于脉、舌方面，亦都随症而异：浮脉为感冒最多见者，受寒者脉浮而紧，受风者脉浮而缓大，受湿者濡，挟火者洪，有痰者滑，兼燥者毛；唯虚人脉不浮，阴虚脉多细小，阳虚脉多软弱。感冒舌苔，多为薄白，苔腻者湿，质红苔黄者热，苔厚者有食滞。

以古人的见解证之临床，感冒的病程大体上是：始于皮毛，终于肺。恶寒发热，头痛畏寒，作嚏流涕，无汗，是初期症状。此期治疗应以解表为原则。伤于风的要用辛凉解表，受于寒的要用辛温解表。辛凉药可用桑菊饮、银翘散，或雷少逸的辛凉解表法之类；辛温解表可选用香苏散、葱豉汤之类。夏秋季受湿的，可用藿香正气散、苏羌达表汤。秋未感受燥邪的，凉燥则用杏苏散，温燥则用桑杏汤等。若冬季天气温和，雨雪稀少，非时之暖使人体内有郁热，一患感冒往往化热极速，在第一期时就突出了咽痛、鼻腔口唇燎泡、目赤、高热、舌尖红赤、脉象浮大等症状，在此情况下用辛凉药，最为合宜。吴鞠通、叶天士等均主张禁用辛温，即使表气未开而有恶寒、身痛、无汗之症，亦只能用辛凉复辛温的方法，如合用荆芥、防风、紫苏等，不宜用麻、桂之类，若需合用麻、桂时亦需加大银花、牛子、连翘等药的用量，增入栀子皮、芦根，可以使表解热退而不至

于温多伤阴。

第二期的症状是不恶寒而但发热，略有汗而咽痛，咳嗽痰白而少，这时卫分之邪已进入气分，威迫肺气。如果无咽痛、舌赤而确为寒邪致病，可仿伤寒法用桂枝汤以和营卫。但此期多属于风寒化热者，所以仍需以银翘散为主，加入黄芩、山梔、前胡、杏仁等清热化痰药。喘重可用麻杏甘石汤；咽痛重可用普济消毒饮去升麻、柴胡；咳嗽者，此际尚属肺气不宣之时，所以咳嗽痰少而白，亦不易咯出，应以宣利肺气为主，用苦桔梗、杏仁、冬瓜仁、牛子、前胡、马兜铃等利肺化痰，不能即用滋、敛，亦不宜于燥痰，滋敛过早则邪难外解，会使咳嗽缠绵不愈，甚至“伤风不醒变成癆”，燥痰不当则促使阴伤，且此期痰尚不多，亦无痰可燥。

第三期症状：一般发热已退，咽痛、脣鼻燎泡也基本控制，主要表现为咳嗽。本病咳嗽的转变：初起是痰白而少，不易咯出，继之是痰渐多而易咯，痰色亦渐黄而浓。此时若无肺部感染，则是感冒咳嗽向愈的征象。疾病到此期，胸部闷痛、呛咳气促等情况渐见缓解，患者痛苦较前大减，可用化痰肃肺法，用杏仁、萎皮、枳壳、陈皮、竹茹、川贝或浙贝、苦桔梗、旋复花、杷叶等药，或加用荆芥、苏叶调肺胃气机，或加用黄芩、山梔以清余热，其他如止嗽散、杏苏散也可酌情选用。

本病除合并肺炎者外，很少见阳明腑证或逆传心包证，其早期治疗，则与“温邪上受，首先犯肺”者相同，并必需区别受风、受寒、挟湿、挟燥的不同而分别用药。至于素体阳虚的人，发表中要参用甘温，党参、黄芪可以选用；平素阴虚的人，可以用加减葳蕤汤，否则正气无力托送外邪，达不到解表要求；个别素体蕴湿患者，可加滑石、茯苓皮、通草、薏仁等；挟食滞的可用山楂、麦芽、神曲等。这样方能丝丝入扣，切中病机。病初

服解表药之后,要喝点热开水,避风,以助药力发挥,如果药后冒风冒寒,表气难开,效果降低。治咳嗽时,服药最好量少次多,这亦是《内经》“适其所至”之理。这是医者在治疗感冒时应该注意提请患者注意的。

(本文系 60 年代初为《健康报》所写科普文,压缩后刊出。)

伤 寒

一、定 义

按现代医学记载,是由伤寒杆菌引起的急性全身性传染病,主要病变是小肠淋巴结的肿胀、增生、坏死和溃疡形成,临床上一般均有持续性高热,玫瑰疹,相对性肝脾肿大。

中医学中的伤寒病,包括了一切热性病,《内经》上说:“今夫热病者,皆伤寒之类也”,说明包括了近代所称的伤寒,就其症状而论,属于《难经》所云伤寒有五之一的湿温范畴。

二、病 原

中医认为本病是由感受湿热而来,故多夏秋季发病。

三、症 状

本病初起,患者仅自觉胃呆、身倦腰痛或头身疼痛等,很少有呕吐或腹泻。病一发作,先恶寒,旋即发热,这时病邪在卫分,继而不恶寒但发热,周身无力,头痛身痛等亦相继增重,渴不欲饮,胸痞,面呈无欲状态,舌苔白腻,身有微汗,大便闭或

利,这时病邪渐入气分,在卫分、气分之时,是属于表的,所以脉搏多有浮象,或兼濡、或兼大,二三日后,热度早轻夜重而日渐增高,六七日后,病情日渐增重,两颊发赤,左肋下胀痛,右腹角有压痛或雷鸣,大便仍是闭或利,苔渐干燥,舌尖转为红色而粗糙无苔,以后苔日渐后退,红色区日渐增大呈三角形,同时胸腹部出现红疹,用手压之退色,去压后复现,此种疹子以后能分批出现,每批持续三四日后退去,称之为温病发疹,说明病邪已迫入营分。此后热度继续增高,早晨稍低,傍晚又增,如此持续不退。此期患者之尿色深黄,浓度亦大,口渴,头痛。由于高热之故,患者易于发生昏谵耳聋、循衣摸床等症,这种现象因与其他症状伴合之不同,可分为阳明腑证,热入血分或逆传心包等;如果同时出现舌苔黄厚或灰厚而下裂,大便闭结,或热结旁流、腹部拒按时,是阳明腑证;若出现舌质绛红,或者光红如镜,鼻衄牙宣等时,是入血分而伤阴;如其神昏谵语,肢厥或见抽搐,是邪入心包,可致险症。有的大量便血,使患者急剧贫血,体温骤降,脉搏加速而弱,是属危候。此期胸腹部可出现小水泡,称之为白痞(早期邪在气分时,亦可出现白痞,属于湿郁于表,汗出不彻范围)。过此危候之后,热度渐低,舌尖绛渐复,白痞消失,渐向痊愈。热度初降时并不稳定,心力弱,脉搏快,如病中营养不良,或素体不强,则体虚更甚,往往稍一动作或精神稍一紧张,即心跳特甚。此时期如调护失宜,易引起复发。复发在中医认为有二种原因:早进肉食或饮食过多而起的叫食复,早下床活动过多而起的叫劳复。

四、诊 断

本病之诊断,可以临床症状及化验等为依据,临床上以热度、舌苔、脉搏、皮疹、脾大为最重要。化验方面,白细胞减少,

几乎持续整个病程，肥达反应通常在第二周中出现阳性，血液中可培养出伤寒杆菌。

五、预 后

中医对此病的预防，与其他热病相同，正气的强弱有很大关系。如老人、婴儿、酒客，或素有贫血、心肺肾脏疾患的，预后多不良。

六、辨证与治疗

以利湿清热为原则，不能误汗误下，大抵在初期时，邪在卫气之间，宜用疏解表邪；迨至湿渐化热，宜用清热燥湿；入营入血时，宜清血解毒；伤阴时宜育阴；邪入心包时，宜芳香开窍；后期阴虚低热，宜用滋阴。

（一）初起邪在卫气之间，宜疏解表邪。

1. 症恶寒无汗，身重头痛，舌白不渴，胸痞，脉濡，邪在卫分，宜藿香、香薷、茯苓、薄荷、牛蒡子之属。

2. 恶寒已除，余症如前，或有汗，或无汗者，宜三仁汤（杏仁10克 滑石15克 通草6克 白蔻6克 竹叶6克 厚朴6克 生苡仁15克 半夏10克。各药为常规用量，下同）。

3. 胸痞身重，头痛，寒热起落如疟，舌苔黄白相杂者，宜小柴胡汤（柴胡10克 黄芩10克 甘草5克 半夏10克 生姜5克）。去人参 大枣，加川朴6克 藿香10克 六一散15克 苍术6克 苡仁15克 白蔻5克 通草5克。

4. 不饥不渴，机窍不灵，余症如前者，宜用三香汤加減（瓜蒌皮10克 桔梗10克 焦山栀10克 枳壳8克 郁金6克 香薷8克 降香5克）。

（二）病起三四日，湿渐化热，胸膈微汗，舌尖渐红，舌苔

转黄、或干或腻，用芳香化浊、苦寒燥湿。

1. 前症湿重于热的，用梔子厚朴汤（梔子 10 克 厚朴 10 克 枳实 6 克），加六一散 15 克 连翘 12 克 白蔻 5 克 半夏 8 克 陈皮 10 克 藿香 10 克。

2. 前症热重于湿的，用梔子 10 克 黄连 6 克 黄芩 8 克 茵陈 10 克 木通 6 克 枳壳 6 克 白蔻 6 克等。

3. 邪在气分，发热、胸闷、眼迷，有时谵语，湿遏热伏，蒙闭上焦者，宜枳壳 10 克 梔子 10 克 豆豉 6 克 桔梗 6 克 黄芩 10 克 苓皮 15 克 郁金 8 克等加减于三香汤中。

4. 邪已化热，未伤营分，口渴引饮，面目俱赤，有汗，入晡热甚，脉洪，舌尖赤，苔黄，用白虎汤（生石膏 30 克 知母 12 克 甘草 6 克 梗米一撮）。

（三）热渐入营，或者入血，高热动衄，发疹或发斑，甚或昏谵，用凉血解毒、芳香逐秽。

1. 高热、唇干，舌燥、齿板，呻吟乱语，卧不安席，宜黄连解毒汤加味（黄连 6 克 黄柏 10 克 黄芩 10 克 梔子 10 克 知母 10 克 连翘 15 克 大青叶 15 克）。

2. 症状如前，舌尖绛，发热早轻暮甚，邪入于营而渴不多饮，用清营汤（水牛角 30 克 生地 15 克 元参 10 克 竹叶 3 克 麦冬 10 克 丹参 7 克 黄连 6 克 银花 20 克 连翘 15 克），甚者用清宫汤（元参 15 克 莲子芯 2 克 竹叶 3 克 麦冬 10 克 丹参 7 克 黄连 6 克 银花 20 克 连翘 15 克 水牛角 30 克 连翘麦冬 10 克）。

3. 高热动衄，症状如前，用玉女煎去牛膝 熟地，加鲜生地 元参（生石膏 30 克 知母 10 克 麦冬 10 克 鲜生地 25 克 元参 15 克）。

4. 高热而见红疹，用银翘散去豆豉，加鲜生地 大青叶 丹皮 紫草等（连翘 15 克 银花 20 克 苦桔梗 7 克 薄

荷5克 竹叶6克 生甘草5克 芥穗5克 牛蒡子10克
茜根30克 鲜生地20克 大青叶12克 丹皮10克 紫草
10克)。发斑者用化斑汤(生石膏30克 知母12克 生甘草
6克 元参15克 水牛角30克 梗米一撮)。

5. 高热伤阴,热入心包,神昏谵语,循衣摸床,用紫雪丹
或安宫牛黄丸,兼服清宫汤。

6. 邪灼心包,营血已伤,肝风欲动,壮热口渴,舌焦红,神
昏谵语,或笑或痉,用安宫牛黄丸或至宝丹。煎服:羚羊角(磨
冲)3克 钩藤30克 石决明(先煎)30克 鲜生地25克
元参12克 麦冬12克 石菖蒲7克等育阴熄风之品。

(四)大便秘结,或热结旁流,高热不退,无便血症,可酌
用润下软坚等通便法。

1. 腹满拒按,高热昏迷,大便数日不通,舌苔干黄或黑,
脉沉实,可因其症热轻重,分别运用三承气汤。

大承气汤:大黄12克 厚朴10克 枳实10克 芒硝
10克(兑服)。

小承气汤:大黄3克 厚朴6克 枳实6克。

调胃承气汤:大黄3克 芒硝10克(兑服) 甘草6克。

以上三方用量均略有变更。

2. 大便稀溏而腹仍拒按,右下腹可触及粪块者为热结旁
流,可用调胃承气汤。

3. 阴伤,阳明燥结,数日不得大便,用增液承气汤[元参
30克 麦冬25克 生地25克 大黄8克 芒硝5克(兑
服)]。此症多舌绛苔少。与前两条多燥黄苔、黄腻苔有别。

按:伤寒后期,余热在阴分,夜热早凉,起伏不退者,用青
蒿鳖甲汤(青蒿10克 知母10克 鳖甲15克 细生地12
克 丹皮10克)。

七、饮食与护理

本病应当多饮果汁，如梨汁、藕汁、橘汁等，及多饮开水。对于粘腻之物，如厚粥、浓肉汁等，在所禁忌，食之往往可以骤发高热，神昏、谵语，或高热稽留不退，生冷青菜及粗糙的食物，亦应禁忌，目的是保护肠道。一般以米汤、豆浆、菜汤、菜泥等易消化的食品为佳，瘦肉煮成无脂肪清汤，亦可酌予，但绝不宜食肉，即后期体温初降之际，亦不能骤进，以防“食复”。

本病初起一二日间，经表解消导之后，患者往往感到饥饿，此时宜抑制食欲，仅可进液体食物，否则食物积滞，重者引起高热神昏，轻者延长病程；病将愈时，饥饿感亦特甚，此为病特点之一，此时要留心进食，不能按患者要求吃饱，或早吃肉食，以防食复、食遗，宜将易于消化而富有营养之物，用少量多次办法供给患者，热退 10 天之后，允许恢复正常食量。

由于本病病重期长，患者要卧床休息，并须防止褥疮，所以要用柔软之床褥，并经常变换体位，病愈 1 周之后，才许患者在床上小坐，以后再逐渐增加体力活动，以防劳复。

（本文曾发表于北京市《中医争鸣》1960 年第 9 期，原为基层中医辅导之用。）

尿路结石

一、本病的近代概念

尿路结石，包括肾结石、输尿管结石、膀胱结石三类。结石大小形状不一，大者可充塞肾盂、肾盏而如珊瑚、鹿角状，在膀

胱则可大者如鸡卵、小者如砂。由于结石的大小、位置及其对机体的影响不同,临床症状也就不同。如结石尚未影响到排尿流畅情况,亦未影响到尿路的生理收缩功能时,可以不发生症状;如结石较大,或影响尿流时,可出现酸、胀、重等钝痛感觉;如结石嵌顿尿路,尤其是在输尿管时,则引起剧烈疼痛,并可放射至耻骨联合、睾丸、同侧大腿等处,间或可放射至腰、臀、骶骨三部或胃部。与此同时,由于结石刺破血管可伴现血尿;完全阻塞尿流时,可出现排尿中断或尿闭(多见于下尿道嵌顿)。较小结石,虽可通过尿道排出,但往往有尿痛、尿频、血尿出现。如果由于尿路炎症严重,或由结石引起肾盂积水或脓肿时,则除了局部症状外,还可出现发热等全身症状。

结石的形成,常以凝血块、粘液块、上皮细胞片、细菌团等有机质为核心,与尿液中的磷酸、鞣酸、尿酸、盐类等结合而成。输尿管疾病容易使尿液郁滞,引起出血,粘液增多,上皮细胞多量脱落及菌团形成,故可为本病的诱发原因,其他与饮食、生活习惯方面亦有关系。

二、中医对本病的认识

在中医学中,近代始参用结石名称,既往均将本病概括于“淋病”门中。“淋病”名早见于《金匱》,至隋《诸病源候论》分淋病为“石、气、膏、劳、热、血、寒”7种,《千金方》后各家,均有大同小异的分类,至明李士材《医宗必读》,分为6类,即:“膏、石、劳、气、血、冷”,迄今中医人员,大体上均沿用这一分类;这6类中,证之临床症状,石淋、血淋,尤以石淋是符合于本病的。

《金匱》:“淋之为病,小便如粟状,小腹弦急,痛引脐中。”

《诸病源候论》:“若饮食不节,喜怒不时,虚实不调,则脏

腑不和，致肾虚而膀胱热也。膀胱津液之府，热则津液内溢而流于辜，水道不通，水不上不下，停积于胞。肾虚则小便数，膀胱热则水下涩，数而且涩则淋漓不宣，故谓之淋，其状小便出少起数，小腹弦急，痛引于脐。”

《医学入门》：“淋皆由肾气郁，小肠、膀胱不利，或忿怒、房劳、忍尿、酒肉、湿热下流于肝经。初则热淋、血淋，久则水炼为砂石淋，如汤罐煎久而生碱。”

《丹溪心法》：“淋症所感不一，或因房劳，或因忿怒，或因醇酒，或因厚味。盖房劳者阴虚火动，忿怒者气动生火，醇酒厚味者酿成湿热，积热既久，热结下焦，所以淋漓作痛，初则热淋，血淋，久则煎熬水液，稠浊如膏，如砂石。”

《医宗必读》：“石淋者，有如砂石，膀胱蓄热而成。正如汤瓶久在火中，底结白碱也。”

《张氏医通》：“诸淋所发，皆肾虚而膀胱生热也，水火不交，心肾气郁，遂使阴阳乖舛，清浊相干，蓄在下焦，故膀胱里急、膏、血、砂石从水道出焉，于是有淋漓不断之状，甚者窒塞其间，令人闷绝（此句是指嵌顿）。”

“石淋者，脐腹隐痛，小便难，痛不可忍，溲如砂石，或黄或赤或浑浊，色泽不定，正如汤瓶久受煎熬，底结白碱。”

《医宗金鉴》：“湿热久蓄石淋成，溲如砂石茎中痛。”

综上所述，可以看出，石淋的病因是：醇酒、厚味、房劳、忿怒、忍尿等。石淋的病理机制是肾虚膀胱热；湿热蕴结下焦，煎熬水液而成砂石；石淋的症状是：少腹弦急，痛引脐中，小便短涩、灼热、刺痛，尿中有砂石，或则挟血，甚则窒塞其间，令人闷绝。这些症状与尿路结石是相同的，无症状的结石不能包括，因古人据症而治，因症求医，所以不可能提到无症状的疾病。

三、本病的中医治疗

古人对于淋病的治疗,有忌汗、忌补之说。如张仲景说:“淋家不可发汗,发汗则便血。”张路玉说:“最不可用补气之药,气得补而愈胀,血得补而愈涩,热得补而愈盛,水窠不行,加之谷道闭遏,未见其有能生者也。”这是因为淋病的成因是热积下焦,津液受到煎熬,发汗重耗津液,则犯虚虚之戒;补涩加重热邪,则犯实实之戒。淋病属热的见解,除上节引述之外,楼全善说:“诸淋皆属于热,虽有冷淋,盖千百中之一也。”张景岳说:“淋之初病,则无不由乎热剧,无容辩矣。”刘完素在《素问玄机原病式》中更详细地谈到冷淋的治疗:“世传方论,虽曰冷淋,复用榆皮、黄芩、瞿麦、茯苓、通草、鸡苏、郁李仁、梔子之类寒药治之而已,其说虽妄,其方乃是,……或谓患淋而服茴香、益智、滑石、醇酒温药而愈者,然则冷欤?殊不知此皆利小便之药也,盖醇酒、益智之性虽热,而茴香之性温,滑石之性寒,所以能开发郁结,使气液宣通,热散而愈也。”古人对淋病属热、忌汗、忌补的观点,当然有一定的限制,但在淋病初起的治疗上是正确的。正如张景岳说:“淋之初病无不由于热剧。”石淋是由于津液久受煎熬而成的理论,已经成为指导临床的依据。综合古人观点,我们在尿路结石的治疗上,其主要方面,应该是“清其积热,涤其砂石”,其辅助方面,应该是针对本病伴发的尿血和疼痛而来的止血、止痛,温通药只能在“宣通”角度上去运用;及至后期,如果肾虚或气虚症状明显,才能随症运用养阴、补气的药物。根据这个原则,提出下面几类药物,以求执简驭繁。

消石类 如:虎杖、大金钱草、鱼枕骨、芒硝、琥珀等。

清热利湿类 如:瞿麦、石苇、海金沙、木通、冬葵子、大黄

等。

止血类 如：大蓟、藕节、丹皮、旱莲草、地榆、茅根、生地等。

止痛类 如：延胡、乌药、芍药、甘草等。

古人在治石淋方面，从《金匱》的“瓜蒌瞿麦丸”等方面后，提出了很多方药，都是我们今天治疗尿路结石的先导药，故仍选列在下，以便借鉴。

《本事方》：虎杖根，洗剉一合，水五合，煎成一盏，去滓入乳香、麝香少许，温服。

《圣济总录》瞿麦饮：瞿麦、黄芩、生甘草、木通各一两，葵根五钱，以上俱洗、剉，车钱子五钱。每服四钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，温服。

《医宗必读》神效琥珀散：琥珀、桂心、滑石、大黄、葵子、膩粉、木通、木香、磁石。共为末，每服二钱。灯芯、葱白煎汤调下。

独圣散：黄蜀葵花子俱用，炒一两，为末。每服一钱，食前米饮下。

石苇散：石苇、赤芍、茅根、木通、瞿麦、芒硝、葵子、木香、滑石。

《张氏医通》加味葵子茯苓散：葵子三两，茯苓、滑石各一两，芒硝五钱，生甘草、肉桂各二钱半。右杵为散，饮服方寸匕，日三服。小便利则愈。

《蒋问斋医案》竭淋煎：赤苓、猪苓、泽泻、萹蓄、瞿麦、车前子、木通、黑山栀、滑石、生草梢、琥珀、血余炭、王不留行、菊花根汁。血淋加地榆炭、怀牛膝、小蓟。砂石淋加元明粉、鲤鱼齿、鱼枕骨，研细水飞吞。

中医治疗尿路结石，见之于报道的已经不少，最快的可在数天之内使结石排出，迟则长达数月。这与结石的位置和大小

有关,大体方药均如上述。如果我们能够进一步弄清结石的不同结构和成因,将可找到更好的治疗办法。

(本文为1973年10月无锡县医学讲座讲稿)

乙脑浅见

乙型脑炎属中医暑温、伏暑范畴。又因其见风动、昏厥等症而称为暑风、暑厥。此种定名,均基于发病季节及症状而来,可以作为辨证的依据而指导治疗。无论是暑温、伏暑,或其继发的暑风、暑厥,总离不开暑。暑是湿和热混合构成的。因此,湿和热两者的比例轻重是非常要紧的,它直接关系到治疗效果。从此点出发,对当时天气中的湿和热的比重区别也是非常重要的。这就是《内经》中谈到的“主气”、“客气”问题,也是祖国医学中的整体观的内容之一。大家知道,石家庄治疗乙型脑炎时大量使用石膏而取得了良好效果,但在翌年北京治疗时用石膏就未取得效果。其原因就在于前者天气酷热而雨量少,后者则该年经常大雨,首都马路二侧曾经水深及膝,所以虽在同一区域,同一病种,而用同一药物效果却不同。

乙型脑炎的症状轻重不一,重者可出现暑风、暑厥情况,轻者则仅微热而已。这种轻重区别,可以出现在同一年,同一地区,这又是人体正气的问题。忆60年代初,曾见一患儿仅有微热,问诊中无自感不适,与健康儿童同样活动,但腰穿证实为乙脑;同时另一患儿则昏迷达60日左右,醒后语言均已丢失,关节亦见强直,经反复教练语言及按摩后始恢复(此儿以后无后遗症,智力亦如常人)。此种情况涉及到治疗上的问题,是提示我们要分别对待,与前述的“因时”关系一样,未可泥于

一方、一法。

乙脑的治疗，既要注意到天时和患者的正气，又要注意到具体症状，轻症初起略如外感者，但以芳化宣邪或辛凉解表即可，此点取决于舌苔脉象，其中尤以舌苔的依据为重。舌苔白润是暑湿，用芳化；苔薄白少津是热重，用辛凉兼芳化。此时脉象多数，或挟濡，或挟大，极少其他脉象，因为小儿不象成人复杂，内伤者少。

乙脑的传变，大致可分为如下几个方面：

（一）由肺经逆传心包：症情为发热伤阴，病邪直达心包络而出现神昏。此类以高热为主症，始起舌苔不厚，继见鲜红光绛，渐以昏迷之后再见动风。亦有昏迷抽风同见者。

（二）顺传阳明，此类又分为两种情况，其一为热邪进入阳明，由阳明热盛而灼伤津液，再致昏迷、抽搐俱见。其二为湿邪壅遏阳气，升降不利，犯膈而见昏迷。前者之苔，虽由白转黄，但腻象较少见；后者则多少要见腻苔。后者多先见时迷时清，初起昏迷时往往呼之可清，不呼又渐嗜睡而迷；前者则往往昏搐后难于呼醒。本类昏迷，一般在时日上均较第一类为缓见。

（三）传入阳明后转腑证者较少见，笔者在临床中尚未见过，但小儿挟食挟滞之可能未可必无，故在传变推理上亦未可必无腑证的出现。

乙脑的抽风，大致上亦有两种情况：比较多见的是强直性，也多在本症热盛时见到；另一种是“痙痲”，往往在抽风后期才有。“痙痲”的抽搐症状并不明显，需要细心体会。医者往往要在握住患者的手指、手腕时才能感到有轻微的抽搐存在。这二种不同的抽风，分别属于实与虚二个不同范畴，用药不可一概而论；属实的，以攻病为主；属于虚的，就必须顾到正

气,尤其是其中的阴分。

有一点要注意的是,患者在输液的情况下往往看不到红光舌,而多见薄白苔。要注意其他症状的综合情况,不能一概认定是阴分未伤。笔者所见到的昏迷、抽风病例中,由于输液均不见红光舌。即如前述之昏迷、痙痙达60日的患者亦然,这就说明未可概以阴分未伤去认证了。

处理乙脑,以不闭表窍为首要。初病固然如此,在昏迷、抽风时亦要如此,目的在于使邪有出路,即叶天士所说的“入营犹可透热转气”之理。近代医学中用酒精擦浴来退热,有引邪外出的道理,是很符合中医要求的;若病情已经弄清,表证全无者可以酌情使用冰袋,否则热型不清,脉、舌俱见假象,难于辨证。

药物选用方面,初期用辛凉芳化,已如前述。初入阳明的“白虎”为主,湿邪夹杂者可以用芳香或辛苦,昏迷时亦以凉开、芳开为法;苦寒直折之品,使用机会较少,因本病病势多急转直下,伤阴者多,腑实者少,暑湿之邪为主,食滞燥屎仅属挟症,所以硝黄少其对象,亦于理不便。证之过去临床,常出入于“银翘”、“三仁”、“藿香正气”、“白虎”、“菖蒲郁金”、“三宝”以及“清营”、“三甲”、“大定风”等辛凉芳化、甘寒育阴、柔肝镇肝熄风之品中,尚可收功。前述昏迷60日之重症患儿用药,除“牛黄”、“至宝”之外,亦始终出入于“银翘”、“白虎”之间达40日而愈。

犀角、羚羊之用,古来原有定法,犀角清热解毒,故用于邪重热盛之证,羚羊平肝熄风,故用于抽风之实证。“痙痙”之时,已非其用,即用亦需伍于柔养之品中。若一见乙脑即犀羚并进,不唯无其必要性,且于财力物力上亦属欠妥,总以审症使用为宜。

“三宝”使用于高热神昏、抽搐时，通常在无湿邪夹杂证的高热时就可使用“紫雪”，有良好的退热作用。昏迷之由于湿邪犯膈而来的，初时用“菖蒲郁金汤”加服“万氏牛黄清心丸”，不宜于即用“安宫”、“至宝”，否则劳而无功，或有如古人所云：“引邪深入之弊”。反之如系暑温湿轻热重，湿为热化，耗阴入营，由肺逆传心包者，则“万氏牛黄”不中用，直需“安宫丸”合“清宫汤”入育阴之品；甚则神志全迷、高热、抽风，则用“至宝”。前言之昏迷重症例，曾2次易“至宝”为“万氏牛黄”，均立见发热情况，此情今忆犹新。

乙脑临床表现，近代以高热、昏迷、抽搐为三大症，三症均有险情，就中医言，以内闭外脱、阴竭阳脱两种情况为最险，二者均源于高热，而继见于昏迷、抽搐之后。内闭外脱，犹可以清热、开窍、开窍为治，病势本质尚实。阴竭阳脱则为近代由呼衰而心衰之症，此时唯宜双救气阴，设肢厥、脉微、大汗则参附亦在必用，笔者仅见到内闭外脱证，阴竭阳脱证在蒲辅周老治疗中有好经验。

中医学中的整体观念

整体观念，是中医学的理论基础，它反映在《内经》而下的各代中医著作中，如“阴阳”学说、“五行”学说，以及“辨证论治”观念等等，都是古人力图用来说明入体内在因素和外在因素的辩证统一性的，因而整体观念就贯穿于中医学的生理、病理、病因、诊断、防病、治病等各个方面。

现在试从下面三个部分来讨论这个问题。

一、外在环境的整体性

(一) 人与自然

人是自然界生物之一，生活在自然界里，自然界的一切运动变化是人时刻接触的，因此，人与自然界是不可分割的整体。这种人与外在环境的整体观，在中医学中是非常突出的。《素问·六微旨大论》说：“天气下降，气流于地，地气上升，气腾于天，故高下相召，升降相应而变作矣。”后人把这种天气下降、地气上升的现象称之为“气交”，而“人在气交之中”并且是在“变”的气交之中。“变”，不独是自然界运动的变，人体也在因之而“变”，所以《灵枢·邪客篇》提到“人与天地相应也”，这就是说人与自然界是对立统一的整体。

1. 自然气候变化对人体生理的影响

春、夏、秋、冬，是自然界的四个季节，其表现在气候方面是春温、夏热、秋凉、冬寒，这种气候变化，影响着自然界一切生物。植物表现为发芽、生长，茂盛（开花），稳定（结果），枝叶凋落的过程，这在《内经》称为生、长、化、收、藏。动物有冬天毛厚，夏天毛稀的适应表现。具体到人，同样也不能例外，适应冷热的增减衣服，还只是外在表现，机体内部的气、血活动情况，也随之改变：春、夏阳气发泄，气血趋向于表，表现为皮肤松弛，多汗；秋、冬阳气收藏，气血趋向于里，表现为皮肤致密，汗少，溺多。脉象表现为：“春弦、夏钩、秋毛、冬石”。《素问·脉要精微论》说：“春日浮，如鱼之游在波；夏日在肤，泛泛乎万物有余；秋日下肤，蛰虫将去；冬日在骨，蛰虫周密。”即此。就是在一日之间的气候变化，也未始不导致人体的相应变化。白天，尤其是中午的气候总是比夜里热一点，只是在幅度上没有四季那么明显。

人在自然界生活的亿万年过程中，养成了一套适应规律，这是在自然界实践中得来的，这个实践的过程是认识过程，也是斗争过程。我们单是理解人对自然气候适应的一面是不够的，更应该理解斗争的一面，如《内经》既提到了“虚邪贼风，避之有时”、“邪之所凑，其气必虚”（这个虚，是就人体正气与致病因素的相对性而言的），又反对“以酒为浆，以妄为常”而致“耗散其真”。这是要求增强机体的“正气”或“真气”来对抗疾病，也是对抗自然界气候异常的办法。《素问·上古天真论》的“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来”就是说要增强“正气”，绝不是无所作为。

2. 自然气候变异与发病、治疗的关系

自然界气候既影响到人的生理、也必然影响到人的发病，中医学把四季气候分为风、寒、暑、湿、燥、火六种，在正常情况下，称之为“六气”，在致病情况下，称之为“六淫”。六气产生于四时气候的综合变异，空气的流动为风；温度的改变为寒、为热（火）；湿度的改变为燥、湿；湿与热并为暑。在正常情况下，六气对生物生长、发展起有利的作用。六气分布在四时，有它应该出现的季节，如果不按常规出现，或者在人体正气适应不了的情况下，就变为致病因素，如冬不寒而热，夏不热而寒，或者冬寒太过、夏暑太盛等，这在《内经》中叫做“太过”、“不及”、“至而不至”、“未至而至”，因之而引起的疾病，中医学中分别称为“伤寒”、“伤风”、“中暑”、“风湿”、“湿温”、“秋燥”、“暑温”等。《素问·金匱真言论》：“春善病鼃蛆，仲夏善病胸胁，长夏善病洞泄寒中，秋善病风疟，冬善病痹厥”，就是由于气候变化所致的。

自然气候与发病的关系，在《内经》中反应于“运气”学说。“运气”中的“主气”、“客气”，有一定的自然气候规律为依据

(主气是各年各个季节中主要的常规气候,客气是各年各个季节中出现的异常气候),如把它绝对固定下来,不分南北,或者用“支干”来推算,就变成形而上学的东西了。所以,后来的医家提出了一二百里之外客气即可改变的意见(张介宾)。雨不会全国同时皆下,大风也不会同时全国皆吹。久雨区的发病情况就与晴区不同,雨水多的年份也就与雨水少的年份治法不同。要随着当时、当地的气候情况来认识和掌握发病情况及治疗方法。

我国幅员广大,南北气候不同,发病也有不同。《素问·异法方宜论》说:“东方之域……鱼盐之地,海滨傍水,其民食鱼而嗜咸……故其民皆黑色疏理,其病皆为痲疡,其治宜砭石……西方者金玉之域,砭石之处,其民陵居而多风,水土刚强……其民华食而脂肥,故邪不能伤其形体,其病生于内,其治宜毒药……北方者,天地闭藏之域也,其地高陵居,风寒冰冽,其民乐野处而乳食,脏寒生满病,其治宜灸焫,……南方者天地所长养,阳之所盛处也,其地下,水上弱,雾露之所聚也,其民嗜酸而食腐(胍),故其民皆致理而赤色,其病挛痹,其治宜微针,……中央者,其地平以湿,天地所以生万物也众,其民杂食而不劳,故病多痿、厥、寒热,其治宜导引按跷。”虽然因其当时条件所限而有局限性,但说明因地方不同、气候不同、饮食不同而发病不同的原则是正确的,所谓“水土不服”病,就是因为人不能适应在迁移后的气候饮食而引起的。

由于四季气候不同、各地方气候不同、临时客气不同而病有所异,因而治疗上要因时、因地、因人而异,《内经》在这方面有不少提示,如《素问·五常政大论》说:“地有高下,气有温凉,高者气寒,下者气热;故适寒凉者胀,之温热者疮;下之则胀已,汗之则疮已。”又说:“西北之气,散而寒之,东南之气,收

而温之，所谓同病异治也。”“用热远热，用寒远寒”《素问·六元正纪大论》说：“司气以热，用热无犯……司气以温，用温无犯”等等。这些都是因地方、气候的不同而提出的治疗法则，这就是“同病异治，异病同治”之说的依据。

中医学中的“天人相应”之说，导源于《内经》，有其科学的一面，也有牵强附会的地方，如《灵枢·邪客篇》中“天圆地方，人头圆是方以应之，天有日月，人有两目。地有九洲，人有九窍”等类记载。我们在了解人与自然的整体性时，必须加以区别。

（二）人与社会

我国土地广，人口众，民族多，历史悠久，长期处于封建阶级社会，这种客观存在对人的情志、境遇有影响，对机体起一定的作用；在生产关系改变而人的思想还没有完全改变时，情志的问题还起作用；就是将来，工作不同，风俗习惯不同，人与人之间的問題等也必然对人体产生一定的影响，这就是人与社会的整体性。

《素问·疏五过论》中说：“尝贵后贱，虽不中邪，病从内生，名曰脱营，尝富后贫，名曰失精。”又说到“故贵脱势”的“精神内伤”和“始富后贫”易生“皮焦筋屈、痿躄为挛”的病。《素问·通评虚实论》说：“消瘵仆击，偏枯痿厥，气满发逆，肥贵人则高粱之疾也。”《素问·生气通天论》说：“高粱之变，足生大丁，受如持虚。”并且提出了“高粱之体”和“菽藿之体”的同病异治，如《灵枢·根结篇》说：“膏粱菽藿之味，何可同也。”《素问·异法方宜论》中也谈到了由于地区饮食的不同而导致发病的不同情况。推而广之，后世四大家的出现，也未始不是因为社会关系而形成他们的各有专长。刘完素生于北方（金·河间人），正当宋南渡后人民因战争而动荡不安，热性病流行较

中,为他的“主火”观点具备了社会基础。李东垣虽与刘氏所处地区相同,但正当金、宋战争又继以金、元的战乱时期,人民生活极度困苦,饥饱失调,精神不安定,劳役频繁,构成了内伤病的社会因素,这就是李氏《脾胃论》所以产生的原因。朱丹溪的社会背景就更清楚了,他处于南宋建都、上层统治者集中的地方。朱氏在“阳有余阴不足论”中说:“夫以温柔之盛于体,声音之盛于耳,颜色之盛于目,馨香之盛于鼻,谁是铁汉,心不为之动也,善摄生者……宜暂远帷幕,自各珍重,保全天和。”穷奢极欲的生活情况,就是朱丹溪“阳常有余,阴常不足”论点的社会基础。

近代才清楚的,长江中下游地区的血吸虫病,东北的克山病,以及四川、河南地区的痔疮较多情况,和其他职业性疾病,都反映了人与环境的整体关系。工农业的发展会带来污染问题,以至于太空污染,这又要求我们从人与社会的整体方面去作进一步的认识,去发现其发病机制,制订新的防治方法。

二、内在环境的整体性

(一) 机体的整体性

中医学强调机体内在的整体性,从脏腑、经络等机体的实质,到阴阳、五行等的说理工具都贯穿着这一观点,也反映到诊法、治则方面。

1. 脏腑、经络方面的整体性

中医学把脏腑称作“十二官”。“官”,有官能之意,所以中医学中的脏腑不完全依赖于解剖学,在一定程度上,是基于解剖学的发展,是把内脏功能活动联系起来的,如《素问·灵兰秘典论》说:“凡此十二官者,不得相失也。”由于人的生命活动,起源于内脏功能的活动,所以内而消化、循环;外而言、行、

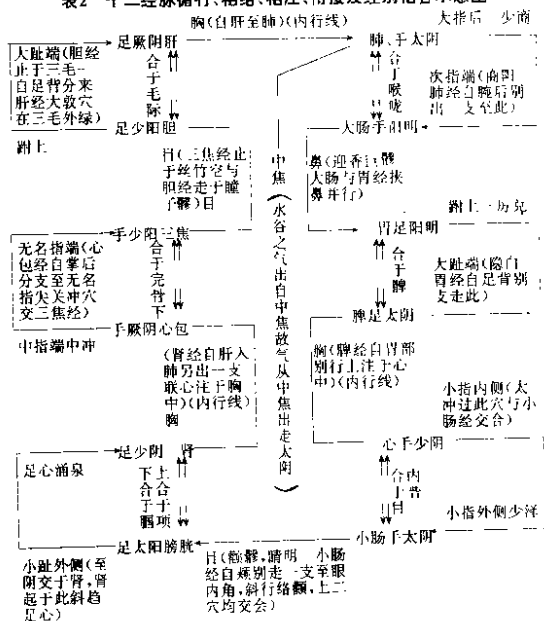
视、听、嗅，无一不是内脏功能的体现。生命活动，是内脏整个的协调活动的体现，所以中医学把脏腑关系之一称为“表、里”，把耳、目、鼻、口、舌作为“五脏之使”而称之为“五使”，这无非是说明其整体性。

脏腑同居于一个整体之内，必然相互影响，所以《素问·灵兰秘典论》有“十二脏之相使”的说法。在经络学说中，既将十二个脏腑配成表里关系，即肺与大肠、脾与胃、心与小肠、肝与胆、心包与三焦、肾与膀胱，使脏腑成为整体，又将十二个脏腑所发出的经络连成一体，使内脏与体表成为整体，并且认为十二经是气血运行的径路，是一个互相贯连的循环。《灵枢·营气篇》说：“气从太阴出，注乎阳明……下注肺中，复出太阴，此营气之所行也，逆顺之常也。”通过这条径路“行血气而营阴阳，濡筋骨，利关节。”（参见附表1、2）。

表1 五脏所主、丽、使、志、生、藏、化表

五脏	所主	所丽 (其华)	所使 (开窍)	五志 (高级神经活动)	所生	所藏	化液
心	血脉	色	舌	喜	血→脾	神	汁
肝	筋	爪	目	怒	筋→心	魂	泪
脾	肉	唇	口	思	肉→肺	意	涎
肺	皮	毛	鼻	忧	皮毛→肾	魄	涕
肾	骨	发	耳 (…阴)	恐	骨髓→肝	志(精)	唾

表2 十二经脉循行、相络、相注、衔接及经别相合示意图



注: 1. 虚线表示: ① 经别所合, 这样使阴经的作用均达于头 (厥阴本经上头, 其他原均至咽喉为止);

② 表示相络、相注。

2. 整体的表里关系, 是由下述情况来完成的: ① 内脏的贯注相络; ② 肘膝以上、躯干头颈由经别起, 相表里经的相合; ③ 十二经脉的起始衔接; ④ 四肢关节以下, 由别络起相表里经的联接。

3. 除上述的构成人体整体外, 另有经筋相合: 足三阳经筋合于面部部, 足三阴经筋合于生殖器, 手三阳经筋合于头角, 手三阴经筋合于胸腋; 这样使三阴三阳之间又以阴阳两类产生联络。

上述 2 表可看出内脏之间、内脏与体表之间、内脏与功能之间的整体性,加上其间错综复杂的关系,如:“目受血而能视”的心与目的关系,和“厥阴之脉络阴器”的肝与前阴的关系等等,内在整体的不可分割性就更明显了。

2. 阴阳、五行之与整体性

阴阳、五行,是中医学的说理工具。是涉及面极为广泛的课题。其重点作用之一,就是用来说明整体问题。

中医学把人体概括为阴阳二类物质,用来阐明人体结构、组织、生理、病理等方面的对立统一关系,二者既相互资生,又相互制约。《素问·阴阳应象大论》说:“阳生阴长。”又说:“阳为气,阴为味,味归形,形归气,气归精,精归化(资生),精食气,形食味,化生精,气生形(功能物质相互资生),味伤形,气伤精(太过而伤、相互抑制),精化为气,气伤于味(物质转为功能、功能为物质的转化所消耗)。”说明了人体物质与功能的资生、制约关系。《内经》:“阴在内阳之守也,阳在外阴之使也。”也说明阴阳二者间的关系,即机体的物质和功能关系。

阴阳二者是一对矛盾,必须统一于一个机体内,如果不能统一,就出现疾病或导致死亡。《素问·生气通天论》说:“二者不和,若春无秋,若冬无夏,……故阳强不能密,阴气乃绝,阴平阳秘,精神乃治,阴阳离决,精气乃绝。”至于“五脏为阴、六腑为阳”和经络方面的“三阴三阳”以及“阴中之阳、阴中之至阴”等,也无非是就脏腑功能的属性来说明其相互关系,从而构成机体整体的不可分割性。

在病因、病理上,中医学也用阴阳来划分,如“风为阳邪”、“寒为阴邪”、“阳胜则阳病”、“阳胜则阴病”、“阳胜则热、阴胜则寒”等的说理,进而到“重阴必阳、重阳必阴”的危重阶段,也就是“热深厥深”的病理机制所在。

五行,是以五种物质的相互关系,来比喻脏腑的相互关系的。五行的四条规律,相生、相克、相侮、相乘的意义,是用以说明五脏之间的统一性的,后人根据这四个规律,产生了“水不涵木”、“木火刑金”等的病理机制,以及“培土生金”、“滋水涵木”、“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”等的治疗方法,甚至还有“隔一隔二之治”等,这些都是从整体观念上建立起来的。

阴阳和五行学说,虽然有其唯物性和辩证性,但也有一定的局限性,尤其是五行学说,硬把宇宙间一切事物求为五类,这是不符合客观实际的,如五谷、五畜的比类,《内经》“五常政大论”、“五畜五味篇”、“金匮真言论”三篇所提到的内容就相互不同。

(二) 治疗上的整体性

治疗是根据人的外在环境和内在环境的变化而产生的,上面已经约略谈到,针刺疗法中的“缪刺”、“上病治下、下病治上”也是根据整体观念建立起来的。《素问·缪刺论》说:“夫邪客大络者,左注右,右注左”,“邪客于经,左盛则右病,右盛则左病,亦有移易者”,所以要“以左取右,以右取左”。如现在常用的腰扭伤刺手,落枕针脚的治法,就是根据下病治上、上病治下而来的,收效相当好,张仲景的“六经辨证”是《内经》异病同治的发展,如今天我们常运用在阳明经证的白虎汤,阳明腑证的承气类等。此一学说在温病学中也有反映,这也是从整体观念面来的。

三、整体与局部的辩证关系

据上所述,可以看出整体观念在中医学中所占的地位。凡是要学习中医学,运用中医学于临床,就首先要弄清这个问

题,才能找出解决矛盾的方法。但我们在强调整体的同时,不应忽视局部,因为整体来源于局部,局部可以影响整体。在一定情况下,我们之所以要重视整体,其目的在于更好地解决局部问题。在临床中,如某些外科疾患的疖肿用局部切开、引流、外敷的办法,收效是良好的;有些早期癌肿,如果能取得局部切除的条件,也可收到根治效果。这样可以使局部的病变不影响整体,及早解决局部的问题,可促使整个机体得到良好的反应。因此,在整体与局部之间要辨证地对待。

(1973年10月初稿,1978年6月修订。曾用于江苏苏州地区中医学术交流及无锡县西学中班讲座。)

急性支气管炎辨证随谈

由于人体对急性支气管炎没有免疫性,每于气候变化时发生,因此,该病属常见病、多发病,并可因屡次发作而转化为慢性支气管炎;所以,恰当治疗本病,不仅能及时减轻病员痛苦,而且是预防“老慢支”的重要环节。

本病临床以咳嗽为主症,伴有畏寒、头痛、鼻塞、咽痒、声哑及发热等症状,应该包括在中医的外感咳嗽范围内。中医学的咳嗽门中,常以外感咳嗽和内伤咳嗽两类分述。所谓外感咳嗽,是指伴有表证的咳嗽,表证是恶风(或恶寒)、发热、头痛、身痛的总称。以之对照急性支气管炎,是符合临床的。当然,初起以表证面目出现的疾病很多,如肺炎、上感、流感、麻疹、猩红热、伤寒、部分肾炎等都有此种现象,其中凡有咳嗽而伴表证的,在中医学中都可类同的方法治疗,即“异病同治”。

1. 气候方面的辨证

天气四时的气候不同，春风、夏热、秋燥、冬寒，此其常规；本病既好发生于气候变化之时，就必然是受到四时气候的影响，也因此而划在外感咳嗽范围中。病有表证，就要用疏表、解表的药，但证之临床，对不同的表证用千篇一律的处方是要碰壁的；其原因，除了机体功能的不同而外就是气候不同的问题，夏天感受湿邪的表证，与冬天感受寒邪的表证发病症状迥异。

大凡表证无汗、头痛、身痛重、恶寒重、痰少而白、脉浮紧、苔薄白，多为风寒。主方可用杏苏散、金沸草散。

畏风发热，头痛有汗，痰少胸痛，口干，咽痛，脉浮大或浮数，舌红，苔白或黄，为风热。主方可用桑菊、银翘。

口鼻干燥，唇燥，咽痒，形寒，毛立，咳声清亮，干咳无痰，甚则痰中挟血丝，胸痛，舌尖、边红，苔涩或黄，脉浮数或浮涩，为燥邪，多见于秋季西风初起之时，主方可用桑杏汤，或加减清燥救肺汤。

湿邪为咳，痰多易咯，咳声重浊，胸痞，泛恶，头重如裹，形寒不甚，发热不扬，有汗而粘少，苔多白腻，脉多濡滑略数，主方可用藿香正气、三仁合二陈。湿邪好犯脾胃，所以本病肺胃同病者为多见。

以上就常规气候而言，此外对异常气候变化也要注意，假如在天高气爽的秋天而连续下雨，则湿邪亦可出现，这就是“客气加临”的问题，用药就必须跟着加减，其他可以类推。

2. 咳嗽和吐痰情况的辨证

本病初起伴有表证时，往往咳嗽无痰，一二日后，可吐出少量稀痰或粘稠痰，此时咯之仍然不易，到痰出易咯时，若发热已退，往往是向愈的表现，若仍发热而痰质浓稠，要注意并

发肺炎。在常规情况下,大体上可将本病全程划分三个阶段,治疗上要各有其侧重点,才能收效较快。

第一阶段时,表证方见,咳嗽无痰,要疏表宣肺,此时要根据其感受外邪的不同分别给药。

第二阶段,表证渐退,痰不易咯,要肃肺化痰,此期除湿邪为病者外,不妨增用点润药,如杏仁、薏仁、冬瓜仁之类,而应该少用镇咳药或不用镇咳药。因为邪郁于肺,痰不出则邪无从去,如果使用带有拟可待因作用的药物如川贝、象贝等,或许可止咳几小时,但终究要咳出这些痰才会好。咳嗽的机制之一,是机体要排除肺内异物,痰是异物之一,已经变成痰的液体如果不去掉,反而不利;在此情况下,祛痰是应该考虑的,此时用川、象贝,不如用枇杷叶、旋复花,可以直接从痰的分泌处起作用。当然药是要随症使用的,如果患者下咳频繁,以至不能休息,而且痰少、稀白,是可以用镇咳药的,因此时肺内痰量不多,热也不多,只有顽咳,用镇咳药不致有所妨碍,此外在剧咳引起出血时也应使用。

第三阶段,痰色或黄或白,成块易咯,胸痞、胸痛渐见松爽,可以直接用止咳化痰法。止咳在于降气,是中医的老规律,如枳壳、桑白皮,重者葶苈、苏子等可以选用。降肺的进一步是降胃,胃在肺下,如果胃气不降,肺气也就不降,而胃热上腾,肺气也必然上逆而为咳,所以临床要留心到这一点。病未及胃,可以单降肺气,胃气亦逆,就要兼用降胃。如《伤寒论》“喘家作,桂枝加厚朴、杏子汤佳”条中厚朴的使用,就含有此意,降气药要分寒、热,化痰药要分清、温,如果痰色白,半夏、陈皮可以入选。如果痰色黄,竹茹、竹沥、蛤壳等就较为合适,当然还要加用清药如黄芩、梔子之类,广东的蛇胆陈皮,草药中的鱼腥草、金荞麦也是理想的药物。

本病到此，如痰除、咳止，就是痊愈，如果发热不退，痰质浓稠，往往是合并肺炎的情况，要重用清热解毒之品，麻杏甘膏汤合并大剂银翘，有较好效果。

3. 传变方面的辨证

本病病邪是“六淫”，病位在肺；以“口鼻而入”为主，次以“皮毛而入”，从皮毛而入的，以感受风寒之邪为多见，由于邪束皮毛，肺气失宣，引起咳嗽，寒邪不解，可以化热，所以也可以见到发热，风热、暑热、燥邪则从口鼻而入者为多，湿邪则口鼻、皮毛均可侵入。

至于《内经》“五脏六腑皆令人咳”的机制，以及肺脾、肺肾等病机，见于内伤咳嗽者为多，与本病关系只有患者体质问题。本病合之叶天士卫气营血四层辨证，以卫、气二层为多见，除痰中挟血者外，一般很少营、血症状出现，秋燥、风热门中，亦或可见到营分证的光红舌，但比之温病中的病邪深入营分、血分情况，病机上有可通之理，程度上有区别之处，当其表证未解时，应以祛邪为急务，即使见到营分证，也要育阴不妨解表，前谈清燥救肺汤要加减使用，就在于要防止邪留深入。

（1974年10月初稿，1980年3月修改，本文为1974年无锡县中医学学术交流稿。）

五行说与中医学

五行说在中医学中，从第一本中医书籍《内经》就已经出现，并且有很多篇章论及，以后历代医家都运用这种学说，中间精芜相杂，所以在清皇朝以后，出现了五行存废的争论，成

了中医学重大争鸣课题之一。随着社会的发展,科学的前进,这个课题确实是客观现实的问题,是我们无法回避而需要面对的课题,现就个人见解,从下述方面来讨论。

(一) 五行的起源和转变

1. 五行的产生是唯物的

五行一词,最早见于《尚书》和《内经》。《尚书·洪范》述箕子答周武王问说:“鲧堙洪水,汨陈五行:一曰水、二曰火、三曰木、四曰金、五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰直曲,金曰从革,土爰稼穡,润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穡作甘。”《尚书·大传》中记载着一个故事说:“武王伐纣,至于商郊,停止夜宿,士卒皆欢乐以达旦,前歌后舞,假于上下,咸曰:孜孜无怠,水火者,百姓之所饮食也,金木者,百姓之所兴生也,土者,万物之所资生,是为人用。”此外,《尚书·甘誓》中也有五行字样的记载。

上述记载,表明五行是殷代的产物。根据殷代“卜辞”记载:“己巳、王卜,……东土受年,南土受年,西土受年,北土受年”,“戊寅卜,王贞,受中商年”,表明在殷代已有五方观念,这种五方观念与五行有密切关系,在后来各家“比类”中,以及《内经》中经常相联而谈。但五行在殷周交替时期,只是作为文字记录了下来,并划定其内容为水、火、木、金、土五种物质,并且总结了这五种物质的特性。这五种物质的发现,是伴随着人类进化而来的,每种物质的发现与运用,都给人类进化以动力,恩格斯说:“摩擦生火,第一次使人支配了一种自然力,从而最终把人同动物界分开。”(《反杜林论》)人类在50万年前就知道使用火(据周口店发现),肯尼亚的卢多尔夫湖附近发现,260万年前的地层中有砾石工具,说明人类在那时已用石器了(上海人民出版社《自然辩证法杂志》45页,1974第一期

《人类起源问题的一些新认识》，李炳文等）。山顶洞人遗址内有赤铁矿砂（周口店）。仰韶遗址中有陶器，那时开始有文字性质的符号，龙山文化时期晚期，已经铜石并用（山东章丘龙山镇遗址），殷墟中有铜等金属工具；这些考古学上的发现，都说明这五种物质是我们祖先在劳动中逐渐认识和运用的。这才是真正的五行起源。《史记·历书》中“黄帝考定星历，建立五行，起消息”的说法，不论其可信与否，也已经是氏族奴隶社会时代了，决不是五行的最早认识。由此可见，五行是建筑在物质基础上的。此外，从古代文字的形象化上，如火作，水作，木作等，不仅可见到其形象，也可见到其特性，这也是五行唯物基础的佐证。

箕子答周武王问，是利用五行来对抗西周统治者利用“天命”进行统治（据杨荣国氏）。这与禹灭有夏氏的借口“威慑五行”（《尚书》）以及后来武庚抗周的利用五行，同是五行被用于政治的表现，是与周承接殷商天帝思想、并以上帝意志来宣传相对抗的；因而在当时社会里，五行仍然是唯物的。《尚书·大传》中记载的“是为人用”，就是说人所依赖生活的是五种物质。

2. 五行的发展

五行说在西周以至战国，尤其是后一时期，因为诸子百家的争鸣，有了重大发展。

（1）在唯物基础之上

《左传》襄公二十七年，宋国大夫子罕说：“天生五材，民并用之，废一不可。”

（2）向辩证法的发展

《孙子》：“兵无常势，水无常形，能因敌变化而胜者谓之神，故五行无常胜。”

《墨子》：“火烁金，火多也，金靡炭，金多也。”（《墨子·经说下第四十三》）“五行毋常胜，说在多。”（《墨子·经下第四十一》）

《国语·郑语》：“夫和实生物，同则不继，以他平他谓之和，故能丰长而物生之，若以同裨同，书乃弃矣。故先王以上与金、木、水、火杂，以成百物，是以和五味以调口，刚四肢以卫体，和六律以聪耳，正七体以役心。”

《国语·鲁语》：“地之五行，所以生殖也。”

《管子·水地篇》谈到水：“藏于万物，产于金石，集于诸生。”

（3）向取象比类的发展

《左传》昭公二十五年，郑子大叔与晋赵简子问答中说：“闻之先大夫子产曰，天地之经，而民实则之……则天之明，因地之性，生其六气，用其五行，气为五味，发为五色，章为五声。”

《左传》昭公十三年，史墨说：“天有三辰，地有五行。”

（4）向唯心范畴的发展

《管子·地水篇》：“水者何也，万物之本原也，诸生之宗室也，美、惠、贤、不肖，愚俊之所产也。何以知其然也？夫齐之水道燥而复，故其民贪蠹（粗）而好勇；楚之水淖弱而清，故其民轻果而贼；越之水浊重而泊（浸也），故其民愚疾而垢；秦之水泔最而稽，淤滞而櫟，故其民贪戾，罔而好事；齐晋之水枯旱而运，淤滞而櫟，故其民谄谀葆诈，巧佞而好利；燕之水萃下而弱，沉滞而櫟，故其民愚戇而好贞，轻疾而易死；宋之水轻劲而清，故其民闲易而好正……。是以圣人之治于世也，不人告也，不户说也，其枢在水。”

邹衍“终始五德之运”（《汉书·郊祀志》）以“主时世盛衰

兴亡，皆随金、木、水、火、土五德为转移”（《辞源·酉集》邹衍条）。

《管子》虽是从自然界本身所固有的现象去说明自然现象的变化，但把水的作用扩大到认为是决定社会、国家，人的体质、容貌、性格和道德品质等方面的因素。这种观点是错误的。《邹衍》的观点，是认为有一种主宰者安排的。必然“代”的观点就是“天命”支配世界的观点。这种观点是后来《春秋繁露》、《白虎通义》等书谬论的鼻矢。

3. 五行的唯物性为唯心主义所代替

从前节所引述可以看出，五行在殷末以来的唯物基础上，经过春秋战国时期的历史阶段，形成了两种趋势：一是向辩证法的发展。这一发展，以五种物质的相互关系为基础，逐渐出现了生、克、乘、侮的规律，如《管子》的“水出于金石”，《墨子》的量胜观点等，另一是经过无条件扩大的错误比类而转入唯心范畴。

取象比类是一种认识物质与物质关系的方法，用五行这为当时人们所常见而不可缺少的五种物质形态来概括世界种种复杂现象，包含着事物的存在和它所具有的属性。它的客观合理因素，对古代唯物主义哲学起了深远的影响，恩格斯指出：这种唯物主义，它在自己的萌芽时期就十分自然的把自然现象的无限多样性的统一看作不言而喻的，并且在某种具有固定形体的东西中，在某种特殊的東西中寻找这个统一，比如泰勒斯就在水里去寻找（《自然辩证法·科学历史摘要》，人民出版社1971年出版，第164页）。前引《管子》对水的作用就是如此。这种比类的缺点，是容易把物质和物质的个性混为一谈。春秋战国诸子运用这一方法来说理中，墨家的类比、归纳、演绎等法是比较进步的，量胜观点就是其中之一，是墨家的

“取”(已了解的)和“予”(给予案断)的结合,是有条件的,是“异类不比”。而有些子中就无条件的予以类比,以至于附会到人事、思想、行为,到汉代的《春秋繁露》、《白虎通义》里的五行,变成以封建道德为标准五种德行,以至于流衍成为“繁纬”、“卜筮”,成了完全脱离物质的学说。下面引述一点,以见大概。

《春秋繁露·五行之义第四十二》:“故五行者,乃忠臣孝子之行也,五行之为言,犹五行(五种德行)也”,《春秋繁露·五行五事第六十四》中又说:“王者与臣无礼貌、不肃敬,则木不曲直而夏多暴风,风者木之气也,其音角也,故应之以暴风。”

《白虎通义·五行》篇中说:“言行者,欲言为天行气之义也,地之承天,犹妻之争夫,臣之争君也。”“土尊不任职,君不居部,故时有四也。”“父死子继何法,法木终火王也?”

五行说至此,大体上已经为唯心主义所代替。

(二) 五行与中医学的关系

1. 五行是如何进入中医学的

在最早的中医书籍《内经》中有很多五行的论述,因而了解五行与中医学的关系,必从《内经》始,而《内经》之所以能用五行来作说理方法,有其特定社会关系,它涉及到《内经》的成书时期。今天可以肯定的是:汉成帝以前成书,收集了春秋以来的医学论述。理由是:

(1)《内经》名称最早见于记载的是《汉书·艺文志》,该书中并有《内经》卷数的记载,因此说明《内经》在汉成、哀之前就有(《汉书·艺文志》记汉成、哀时刘向父子所校的书籍)。秦始皇在“焚书”时,保存了医药书籍,但在春秋战国诸家均未提及《内经》。因此,可以认为《内经》在秦时尚未成书。

(2)《内经》有正月建寅的记载。按《史记》记载：自黄帝至夏禹是正月建寅；殷、周、鲁并是正月建子；秦建亥，汉初沿用建亥历法；至汉武帝元封七年改用“太初历”建寅，所以改元封七年为太初元年（《历书第四》）。夏代以前虽建寅，但目前考古发现殷商时代的甲骨文尚简单，夏代以前没有《内经》这样的长篇文字是可以肯定的。实际上历法到殷商后期才随着农业生产的发展而逐渐发展起来，加上周代建子在《内经》中一无记述的客观情况，可以肯定《内经》的成书不在春秋战国时期，可以放到汉成、哀时刘向、刘歆父子校书之前这段时期来考虑。

(3)《内经》有“州都之官”的记载，这是郡县性质的官制，郡县制是秦汉的制度。《内经》又有“收租税”（《灵枢·九针十二原篇》）的记载，收租税也是封建社会的事，因此可以把《内经》的成书时期放到封建社会时期。

(4)从《内经》的内容上看，观点很不统一，既有老、庄的“恬淡虚无”观点（《素问·上古天真论》），又有反鬼神观点，如《灵枢·贼风第五十八》的记载，以及《素问·五脏别论》“拘于鬼神者不可与言至德”的记载。即以五行为例：既有《管子》、《邹衍》的“生”和“克”，又有《墨子》、《孙子》的“乘”和“侮”，反映着春秋战国时期学术上百家争鸣的情况。“入国问俗，入家问讳，上堂问礼”（《师传篇》）的记载，反映着大小奴隶主的封国情况，而“讳”和“礼”，是孔子所主张的。以及《素问·疏五过论》的“封君败伤”、“故贵脱势”、“始富后贫”的记载，反映了春秋战国时期奴隶主的相互争夺情况。因此，可以认为：《内经》的大部分篇章内容，是出于春秋战国时期的。

《内经》既然是春秋战国时期至汉刘向校书时的产物，那正是五行说流行、发展的时候，《内经》就不可能不受到五行

学说的影响和渗透。反之,医学上的成就,在当时也是影响到百家争鸣的,如《韩非子》的《五蠹》、《解老》、《扬权》、《显学》等篇中,就有不少把医疗知识作为其论证内容。东汉的王充,也以生理、病理来论证他的观点(“超奇论”、“论死”、“物势”等篇)。就这样,自然科学中的医学,哲学中的五行,两者就很自然地结合起来了。

2. 《内经》中的五行

《内经》中关于五行的运用,大体上可分两类:

(1) 比类取象 一一《内经》把人体内在组织、生理、病理现象,以五行之间的关系做了广泛的比类联系,此外又把与人类生活有关的自然界事物,按其不同性能、作用和形态,分别归属于五行,如《素问·金匱真言论》的“东方青色,人通于肝……”,《素问·阴阳应象大论》的“天有四时五行,以生长收藏,以生寒、暑、燥、湿、风,人有五藏化五气,以生喜、怒、悲、忧、恐”和“东方生风,风生木,木生酸,酸生肝,肝生筋,筋生心,肝主目……”一节,《素问·移精变气论》的“理色脉而通神明,合之金木水火土,四时、八风、六合,不离其常,变化相移,以观其妙,以知其要”,又如《素问·玉机真藏论》以四季气候变化和自然界的生长收藏现象来解释脉象的“春弦”、“夏钩”、“秋浮”(毛)、“冬营”(石)。其他如《素问·天元纪大论》、《素问·五运行大论》、《素问·气交变大论》、《素问·五常政大论》等篇,均有此类记载。

此种比类,可以分为两个方面:一为人体内在的脏、腑、五官、形体、情志等隶为五类,二为自然界的方位、色、味、气候、季节、生物变化等隶为五类。并对此二者作相互联系(见表3)。

表 3 自然界与人体的比类

自然界							五行	人 体						
五音	时间	方位	五味	五色	气候	发展过程		脏	腑	五官	形体	情志	五声	变动
角	春旦	东	酸	青	风	生	木	肝	胆	目	筋	怒	呼	握
征	日中	南	苦	赤	暑	长	火	心	小肠	舌	脉	喜	笑	代
宫	日西	中	甘	黄	湿	化	土	脾	胃	口	肉	思	歌	哕
商	日入	西	辛	白	燥	收	金	肺	大肠	鼻	皮毛	悲	哭	咳
羽	夜半	北	咸	黑	寒	藏	水	肾	膀胱	耳	骨	恐	呻	栗

这种比类归纳,来源于取象的不同,如《素问·五运行大论》的“燥胜则地干,湿胜则地泥,寒胜则地裂,火胜则地固”,其中把风和动联系起来,以此为例,发展到“其用为动”,“在变动为握”(《素问·阴阳应象大论》),“诸风掉眩,皆属于肝”,“诸暴强直,皆属于风”(《素问·至真要大论》);这样就把自然现象和人体的生理、病理联系起来了。这种方法,是使人体与外在环境构成统一的整体,试图比较系统地对人与自然、人的生理及病理等关系方面作出解释。恩格斯说:“自然哲学所能用以执行这任务的唯一办法就是拿想的、幻想的联系来代替它还不知道的真正的现象联系,拿虚构来代替缺乏的事实,单只在想象中把真实的缺陷填补起来。这样做时,自然哲学吐露了好多天才的思想和猜到了好多后来的发现,但也有过不少的废话和胡说。”(《费尔巴哈与德国古典哲学的总结》)正是如此,《内经》在运用五行的比类推理上是有其优点的,即反鬼神和形成一个整体观方面,而在另一方面也有着不少谬论,这表现在违反了“异类不比”的条件和

无条件的扩大方面,如四时中另分“长夏”以配五行之说和脾寄旺于四时不另分“长夏”的矛盾,以及五行配五谷、五畜的不能统一(如表4)。这种不统一,表现了比类中的硬性凑合。

表4 五行与四时、动物、植物的关系

素 问	春		夏		长夏		秋		冬	
	畜	谷	畜	谷	畜	谷	畜	谷	畜	谷
五常政大论	犬	麻	马	麦	牛	稷	鸡	稻	猪	豆
金匮真言论	鸡	麦	羊	黍	牛	稷	马	稻	猪	豆
五音五味篇	犬	麻	羊	麦	牛	稷	鸡	黍	猪	豆

此外,包括比类到天文方面的情况,如上应太白星、荧惑星、辰星、钺星、岁星(《素问·气交变大论》)等想以五行概括宇宙万物的企图,也同样是牵强的;虽然天文变化与地球有一定的关系,但在当时的历史条件下尚不足以知此,并且星座何止五种。但应该注意到的是《内经》中五行比类方面的“论病以及国,原诊以知政”(《汉书·艺文志》)的现象。其居主导方面的是病和诊,而不是国和政,因而仍应该认清其与“五德终始”观点在目的上的不同。

生、克、乘、侮规律同样是《内经》用来解释人体内在的、人体与自然二种关系方面的四条规律,也可以说是事物与事物之间的关系的概括方法。

生,是相生,是互相资生的关系,即水→木→火→土→金→水。这一关系,在《尚书·洪范》中并未提到,也没有按这种关系来安排五种物质的关系,能够最早见到的是《管子》的水“产于金石”的说法,但当时尚未形成一套相生关系,到《内经》中才可见到其形成,如《素问·六微旨大论》有“复行一步土气治之,复行一步金气治之,复行一步水气治之,复行一步木气

治之，复行一步君火治之”的记载。其实这是日常生活自然观的总结，自然水源的在高山流出，传说中的“钻木取火”，金属矿的在地下发现等都是相生关系的起源。

克，是克制、制约的关系，即水→火→金→木→土→水。这一关系，始于邹衍的“五德终始”论，擅用五行的生克来解释朝代的兴和亡，而《内经》在这方面的解释是与邹衍截然不同的，如《素问·宝命全形论》中“木得金而伐，火得水而灭，土得木而达，金得火而缺，水得土而绝，万物尽然，不可胜竭”的记载，保持着五种物质间的相互制约现象，都是日常生活中可以见到的，是古代劳动人民所必然经历的事情，尤其是“土得木而达”的记载，更区别于一般的相克，更真实地描绘了自然现象，也就更明显地区别于邹衍的“五德终始”说。

乘，是乘虚侵袭。侮，是恃强凌弱之意，《素问·五运行大论》说：“气有余则制己所胜，而侮所不胜，其不及，则己所不胜侮而乘之，己所胜轻而侮之，侮反受邪（指素所胜者），侮而受邪，寡于畏也。”《素问·六节脏象论》说：“未至而至，此谓太过，则薄（作侵犯解）所不胜而乘所胜也”，“至而不至，此谓不及，则所胜妄行，而所生受病，所不胜薄之也。”“变至则病，所胜则微（病轻），所不胜则甚，因而重感于邪则死矣，故非其时则微，当其时则甚也。”由此可见，乘是原来“克我”的关系在病理下的称谓，侮则含有“反克”的意思。这种乘和侮，是基于《墨子》的量胜观点和《孙子》的变化观点而来的，是五行说在辩证性方面的丰富。

中医学运用这四种规律的错综关系，来解释生理、病理的发生、转化情况，是具有辩证性的，从这四种规律形成其来源于诸子百家的观点已可看出，此外还可从《内经》的记述中看出：如《素问·五常政大论》提到正常的五行是：“木曰敷和，火

曰升明，土曰备具，金曰审平，水曰静顺。”不及的五行是：“木曰委和，火曰伏明，土曰卑监，金曰从革，水曰润流。”太过的五行是：“木曰发生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰坚成，水曰流衍。”《素问·天元纪大论》说：“五行之治，各有太过不及也，故其始也，有余而往，不足随之，不足而往，有余从之。”《素问·藏气法时论》说：“五行者金木水火土也，更贵更贱，以知死生，以决成败，而定五脏之气，间甚之时，死生之期也。”又说：“病在肝，愈于夏，夏不愈，甚于秋，秋不死，持于冬，起于春。”《素问·玉机真藏论》说：“其卒发者，不必治于传，或其传化有不以次。”这些都说明了五行的相生、相克都不是绝对的，要看具体的条件。五行的每一行也各有正常、不及、太过的区分。从而有比较系统的、充分的说理性。但同时也应注意不能将如《素问·平人氣象论》的“肝见庚辛死，心见壬癸死，脾见甲乙死，肺见丙丁死，肾见戊己死”等生、克规律绝对化起来。

（三）如何评价五行说在中医学中的地位

中医学运用五行说是广泛的，古人用以说明体内与体外关系、局部与整体关系，说明生理上所以能够统一（如：金克木、木生火、火克金的三者关系来保持平衡），说明发病及其转变、预后以及用来指导诊断，建立治疗方法（如：培土生金、滋水涵木、抑木扶土、壮水制火、佐金平木、补火生土，以及隔一、隔二之治等），以至用来解释药物的作用等等。直到今天我们还在使用着，因此五行说在中医学中是处于基础地位的。但五行说不是具体的实质所在，只是一种说理的工具，与经络学说、脏腑实质是有所不同的。五行说作为一种哲学，要按照能否如实反映实际去衡量，即按照辩证唯物主义的标准去衡量。五行说的进步性，无非是古人企图用来说明事物与事物之间相互关系的诸方面，从而理解人体生理、病理与外界自然关系

的整体性,这是符合于唯物辩证法要求的。在当时的历史条件下,五行说起到了反对“天命”、反对鬼神的进步作用,中医学曾经依靠这个作用,“以近乎系统的形成描绘出一幅自然界联系的清晰图画”(恩格斯),所以在一定程度上推进了中医学的发展,这是五行说在历史上的功绩,是我们必须承认的,否则我们就不是历史唯物主义者。但是,“如果现象形态和事物的本质会直接合二为一,一切科学就都成为多余的了”(《资本论》),今天即使从五行说的合理部分,(舍去其机械性和唯心性)——整体观来看,五行说仍然是属于现象形态方面的联系,并不能全部反映事物的本质方面的发展、变化和相互关系。

中医学面对的是有机组合的人体所产生的实质或功能疾病的治疗,即对这种实质或功能的矛盾纠正、补偿或改变。因此必须对这种实质或功能的真实变化进行研究探索,而不应停留在对其假定解释的合理性上,所以应该在五行生克乘侮规律的辩证性、整体观的基础上,作出新的努力,才能使中医学阔步猛进。

(四) 小结

1. 五行说起源于劳动人民用五种物质来反对“天命”论,并企图用以解释宇宙及一切事物,是唯物的。

2. 五行说在春秋战国时期的百家争鸣中,派生出唯物和唯心两大体系,到《春秋繁露》、《白虎通义》等著作中已为唯心主义所代替。

3. 中医学中的五行,来源于百家学识,因而菁芜并存。五行说的合理部分是整体观,有其历史功绩。

4. 五行说的合理部分,尚不能对宇宙万物作出全面解释,只能指导人们认识自然的表面联系,因而不应墨守五行

说,不应满足于生克乘侮规律的辩证性,要对事物的本质功能及其相互影响努力探索,才能使中医学有所发展,有所前进

(本文发表于1974年苏州地区中医学术交流会,1982年压缩后发表于《新中医》第11期。)

眩 晕

眩晕是一种症状,眩是视物缭乱,晕是自觉旋转,头脑不清,当这一症状出现时,患者痛苦、恐惧,感觉象要失去知觉似的。近代所称的美尼尔综合征、高血压、脑供血不足、神经官能症、贫血以及小脑疾患等均可出现眩晕症状。

中医对本病的治疗首先注意区别外感和内伤,外感风热或风寒有时也可引起眩晕,但在没有机体本身因素,即内伤眩晕的基础时,往往表现为头昏或头痛,而不是眩晕。所以我们在临床上对痛、昏、眩、晕要加以区别,要通过“四诊”去仔细分析;凡是有“表证”的,都有外感或挟有外感,外感要针对风热或风寒去分别用辛凉或辛温解表的方法治疗,即使有内伤因素相兼,也不能离开“解表”法,只能用解表为主的药物。这种外感头痛,中医习惯上不包括在眩晕证中论述,而归之于外感或头痛门中,所以本病是就内伤方面来谈的。

(一) 病因病机

有关眩晕症的最早记载是《内经》:“衄蒙招尤,目瞑耳聋,下实上虚,过在足少阳、厥阴”;“诸风掉眩,皆属于肝”;“髓海不足则脑转耳鸣,胫酸眩冒,目无所见”;“上虚则眩”。这是说眩晕的原因是“风”、“髓海不足”、“上虚”。

张仲景说:“心下有痰饮,胸胁支满,目眩。”(《金匱要略》)

这是说眩晕的原因是“痰饮”。

朱丹溪说：“无痰不作眩”，“无火不晕”。这是说眩晕的原因是“痰”、“火”。

张景岳说：“无虚不作眩。”这是说眩晕的原因是“虚”。

综上所述，本病的原因是风、虚、痰、火。

风如何来？原因在于：

1. 情志内伤：如恼怒、暴躁而引起风阳上旋。
2. 房室不节，水不涵木，肝失所养，风阳遂致上旋。
3. 思虑太过，五志化火，既伤肝阴，又伤脾运，更伤肾阴，同样可致水不涵木。

火如何来？缘于风阳太过而化火，或思虑太过而化火，或痰郁、气郁而化火。

痰如何来？痰是机体内水湿不按正常运化，有所积聚而来，其所以不能运化，在于脾虚或气郁，痰阻以后导致：①清阳不升于脑，脑无所秉而眩晕；②痰郁生热而成“痰火”，不仅痰阻清阳，而且痰热干脑而致眩晕。

虚如何来？其原因是：

1. 忧思伤脾，不能运化精微，不能“取汁变化而赤”，成为血虚而不能奉养于脑。在这一病机中，当其不能运化精微之时，已经挟有气虚因素。

2. 由上述风的产生原因中的1,2,3条所转化而来的肾阴不足，久之则肾阳亦不足，成为髓海空虚。此条病机中，要分清肾阴虚或肾阴阳俱虚情况。

综上所述，可见本病的病因是风、火、痰。内在的因素是阴虚、阳虚、血虚。它的发病，与情绪、思虑过度有较大的关系。病理上涉及的主要脏腑是肝、胆、肾、脑、脾。临床分型以风阳上旋、肝肾阴虚和痰阻清阳三者较多。

(二) 症状和治疗方药

1. 风阳上旋：性情躁急，面色时时潮红，失眠，梦多，口苦，舌质红，苔黄，脉弦数。代表方：天麻钩藤饮（天麻、钩藤、石决明、菊花、黄芩、牛膝、杜仲、益母草、夜交藤、山栀、桑寄生、茯神）。

2. 肝肾阴虚：腰膝酸软，遗精疲乏，舌红，苔少，脉弦细数。代表方：杞菊地黄汤（杞子、菊花、地黄、山萸肉、丹皮、茯苓、山药）加磁石、龙骨、牡蛎。左归饮（熟地、山萸肉、山药、杞子、牛膝、菟丝子、龟版胶、鹿角胶）。

3. 髓海不足：眩晕每发于思虑劳心之后，体质羸弱，精神萎靡，面色不华，腰膝酸软，健忘，少寐，两耳失聪，脉弦细无力，甚或软弱而大，舌色淡白。代表方：龟鹿二仙胶（鹿角、龟版、杞子、人参），大补元煎（人参、山药、熟地、杜仲、当归、山萸肉、杞子、炙草）。阳虚甚时用右归饮（鹿角胶、杞子、菟丝子、熟地、山药、山萸肉、杜仲、当归、附子、桂枝）。

4. 痰湿中阻：胸痞，脘闷，恶心，头重如蒙，食少，寐多，苔白腻，脉濡滑。代表方：半夏白术天麻汤（姜半夏、陈皮、茯苓、炙草、天麻、白术）。

5. 痰郁化火：多梦，易惊，头脑胀痛，心烦，心悸，口苦，嘈杂，脉弦或滑，苔黄腻。代表方：温胆汤（姜半夏、陈皮、茯苓、甘草、竹茹、枳实）加黄连、黄芩、胆草。

6. 心脾不足，血不上奉：面色晄白，肤发不泽，体倦，懒言，心悸，少寐，甚则晕厥，脉细涩，舌淡不华。代表方：归脾汤（白术、党参、黄芪、当归、炙草、茯神、远志、炒枣仁、木香、龙眼肉、生姜、大枣），养荣丸（熟地、白芍、当归、党参、白术、茯苓、甘草、黄芪、肉桂、五味子、陈皮、远志、姜、枣），气虚挟痰用六君子汤（党参、白术、茯苓、炙草、姜半夏、陈皮）加黄芪、山药、

山萸肉。中气虚寒、便溏，肢冷，用近效术附汤（白术、附子、甘草）。

上列各方仅就代表性而出，临床可以加减或选用其他处方。应该注意的另一点是，本病的阳亢型患者，多数有情绪急躁、肝经火旺的情况，要劝其控制，在饮食上要避免辛辣刺激食物；鸡、羊、虾等热性食物也在禁列。

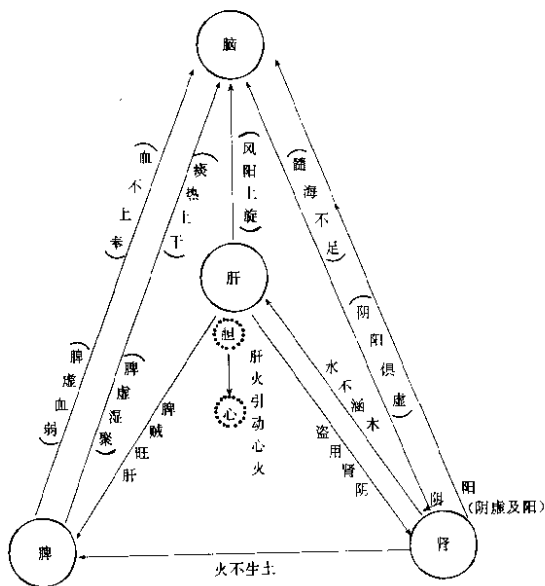


图1 眩晕病机示意图

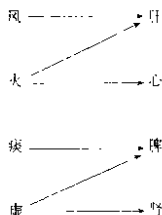


图2 归脏关系示意图

(本文为70年代无锡县医学讲座稿)

漫谈肝炎

肝炎在中医学中,由于出现的症状不同而有较繁的区分,大体上,有黄疸的肝炎可以概括在“黄疸门”中,无黄疸的肝炎可以概括于“郁证门”中。由于中医根据辨证而施治,所以不仅不同于西医的将有黄疸和无黄疸系统于一个理论范围内,而且不论在黄疸或无黄疸的任何一病中,也有很多区分。

一、黄 疸 型

(一) 中医对黄疸的几种论述

“黄疸”之名,最早见于《内经》,后世根据其见症不同,而有“二十八候”、“三十六黄”的区分;从罗天益以后,概括为“阴黄”、“阳黄”两类,又根据黄疸的发病情况而有几种区分:

1. 湿热郁蒸发黄——此类是今日黄疸肝炎中较常见的一种,其起因有外感湿热,有酒食不节而湿热内受,有劳伤过度。我们从外感而起一因上,可以想到肝炎的传染性;从酒食

不节一因,可以想到酒精中毒等引起的肝炎;从劳伤过度一因,可以想到肝糖与肝炎的关系。

2. 由疫疔引起的“瘟黄”——此为由其他急性热性传染病引起的肝炎或其他肝病,此可与巢元方氏所述的“急黄”同列,《外台秘要》上记载此证“涕、泪、汗、唾、小便如柏汁”,与天行病候最重者无别,此证除暴发型黄疸性肝炎外,还可使我们想到“急性肝坏死”或“急性黄色性肝萎缩”的病情。

3. 由暴受惊恐而引起的“胆黄”——此为精神-神经引起的肝炎;张景岳氏认为是惊恐伤胆、胆液外泄而来,从而亦可使我们想到胆汁逆行入血而致黄疸的一条肝炎病理。

4. 由疟疾引起的“疟黄”——此为疟疾导致肝脏中毒,或疟原虫破坏红细胞过多,析出胆红素而致。

其他尚有小儿的“胎黄”、“孕妇发黄”等。

古人对黄疸的记载,包括着现代各种产生黄疸的疾病,当然也包括了黄疸型肝炎。因此在上述各条中,或多或少地涉及了黄疸型肝炎的病因、病理等方面,只是由于历史条件的不同,而与西方医学在分类、发病因素等认识上有所不同。证之临床治疗,古人的阴黄、阳黄、急黄三种辨证施治,可以概括黄疸型肝炎的治疗。

除受惊而起的“胆黄”外,古人认为在病因上都与湿热有关(从治疗上看,也可把“胆黄”包括在阴黄、阳黄的辨证之中)。在脏腑上都与脾胃有关,这是从《内经》脾主一身水湿的理论和《金匱》“黄家所得,从湿得之”的论点上导源而来的。叶天士对此有较为系统的论述:“阳黄之症,湿从火化,瘀热在里,胆热液泄”,“阴黄之作,湿从寒化”,“胆液为湿所阻,渍于脾,浸淫肌肉,溢于肌肤”,从而说明了胆汁与黄疸的关系。急黄症在《巢氏病源》上的记载是“热毒所加,故卒然发黄,心满

气喘，命在顷刻”，说明此证在病因上仍然与热有关，湿热交蒸，郁而化毒，但因其病势骤急，治疗上要走温病“逆传心包”的径路，从而稍有别于阴阳二黄。

（二）辨证治疗

黄疸颜色鲜明，或兼见身热烦渴、胸脘痞闷、便干、溲赤等症的为阳黄；黄疸颜色黯灰，或兼见形寒、食少、神倦、腹胀、便溏、溲少等症的叫阴黄。大体上阳黄多为黄疸型肝炎初起，属湿属热，但有偏于热或偏于湿的区别；阴黄则可因阳黄久久不退，黄疸加深而来，也可因机体虚寒而产生，属寒属湿，而有偏寒或偏湿之分，易见于黄疸型肝炎的后期及黄疸反复出现的情况下。黄疸的色泽如何，反映着正邪双方对峙的力量比例，也反映着病的新久、长短情况。正的方面，是指脾胃的运化功能，邪的方面，是指湿热或寒湿，因此本病的治疗原则就应该从此二者来考虑。新病或脾胃力量好的，可以清利湿热为主；久病及脾胃力量低的，要兼顾正气。不论是阴黄或阳黄，湿邪都是共同具有的，所以古人有“但利其小便”和“治黄不利小便，非其治也”的说法。以上都是治黄原则。

湿热两停，可用茵陈汤和四苓汤为代表方；

偏重于热的，可用栀子柏皮汤、栀子大黄汤等；

偏重于湿的，前方加用平胃散；

兼有表邪，可随证选用银翘散、麻黄连翘赤小豆汤、香苏散；

寒湿停留，用茵陈术附汤；

湿重脾虚前方加用胃苓汤；

兼有肝气郁滞，用逍遥散、柴胡疏肝散等。

急黄症热毒壅盛，要重用清热解毒，在热邪伤阴情况下，虽有湿邪也只能兼顾，不应忽视清热解毒的治则。可以选用黄

连解毒汤、茵陈汤、清瘟败毒散、三黄汤，重症可用千金犀角散，神昏可选用神犀丹、牛黄丸等。

以上各方，举其大概而言，临证可以相互参选，不宜固用一方。至黄疸退后，仍须调理肝脾以巩固效果，如肝功能仍不佳，可按无黄疸型肝炎辨证进治。

二、无 黄 疸 型

本型由于没有象黄疸等症状，而不易被及时发现。本型往往以消化系症状和倦怠面目出现，也有以外感症状出现的。正因为不能及时发现，所以发病日期也就难于正确推算，从而也难于做到早期治疗，给预防和缩短病程的要求带来一定困难，要求我们在主观上能够努力做到早期发现的方法，只有在临床遇到疑似情况时，不忽略对肝脏的检查。

（一）中医的论述

无黄疸型肝炎的中医辨证，较之黄疸型肝炎为分散，因其有肝、脾肿大，可以属于“积聚门”；因其有胁痛、胸痞、腹胀等症，可以属于“胁痛”、“郁证”等门；因其在病程中可以出现黄疸，又可属于“黄疸门”（其中尤以阴黄症为多见）；求其能够贯通病证全程的，朱丹溪氏的“六郁”说似较为通达。

郁证之来，始于气者为多见；气郁而水湿不化，可致“湿郁”；气郁而运化不健，可致“食郁”；气郁而湿食不化，泛而为痰，可致“痰郁”；气郁久而化热，热甚化火，可为“火郁”；气郁而血失所帅，可致“血郁”。中间合病、变病，遂致证情错综复杂，但以气郁为必见症状；证之临床，有痰湿并病、湿食并病、痰热并病、气血并病等等。在变病方面：火郁可以伤阴，气、痰、湿、食、血五郁，均可寒化、热化，其所以寒化或热化，视病员的体质、饮食、营养、性情等而定。

郁之始,就本证而论,首先在肝,以及于脾,肝脾两者在本证临床中是多见、常见的一对关系。脾运弱而胃不化,在湿、痰、食郁中均可见到。推其原,是肝郁侮脾而来,肝郁化热,或见本象,或见伤阴,由气及营,由肝及肾,故可见到肾阴不足证,肝舌是其见症之一。脾虚气弱要依赖命火,支持运化,久之肾阳亦弱,故可见到脾肾阳虚证,腹胀、肢寒、便溏等可由此而来。肝火引动心火,消耗心阴,可见到心悸、不寐、面赤等。肝失疏泄,或因本经郁热而下注,或因肾气不足而下注,可见到少腹疝痛之肝气下注证。迨至气郁而后血郁,则肝脏肿大自然明显。

以上为六郁的变化和脏腑关系二方面的概况,证之临床症状是灼然易见的。再从现代生理、病理方面看,就肝与血的关系、肝与消化的关系、肝与神经的关系以及肝与糖、肝与眼睛方面等等来对照,也有一定的证实,只是理论体系不同而分析不同罢了。

(二) 治疗方药

肝气郁滞,用柴胡疏肝散;肝郁化火,用龙胆泻肝汤、清肝饮、化肝煎;肝阴不足,用调营敛肝饮;肝肾阴虚,用一贯煎、滋水清肝饮;肝气下注,寒用暖肝煎、热用金铃子散;气滞血瘀,用丹参饮、旋复新绛汤,重者用复元活血汤、失笑散、血府逐瘀汤等;肝脾不和,用逍遥散;肝脾两虚,用归芍六君子汤;气痰俱滞,用四七汤;气食俱滞,用越鞠丸;脾虚气滞,用香砂六君子汤;脾肾阳虚,用附子理中汤、右归饮加参、术;黄疸出现时,仍按黄疸型肝炎辨证施治。

三、几个有关问题

1. 退黄

从提倡草药以来,在退除黄疸,尤其是阳黄方面,涌现了很多有效药物,其中如茵陈、崩大碗、黄疸树等都是比较好的。茵陈和崩大碗两药,用量要大,一天不少于 60 克时有明显效果,群众中有用崩大碗 500 克打汁服用治胆石黄疽,也有较快的效果。黄疸树是群众常用药物,但须栽培,不如前二药来原容易,三药均属苦寒,对脾胃虚弱者要酌情伍用佐药,如白术、红枣之类,以保胃气。

黄疸的形成,是胆汁郁滞而来,或阻于胆,或阻于肝,因而疏肝利胆药物如郁金、梔子、大黄、芒硝等都可以随症择用。

2. 降酶

近来对单味降酶药物的观察中,发现半边莲、五味子、板蓝根、败酱草、紫草等均有明显效果,但其中除五味子外,都属苦寒药,对虚寒体质的病员不相宜;脾胃虚弱或郁湿的病例用楂、神曲、麦芽、藿、佩等助消化、宣胃气的药物,往往收效。

3. 恢复肝功能

在转氨酶恢复后,恢复肝功能其他项目的治疗往往旷日持久。根据经验,伍用扶正药似乎有佳效,如四物、四君之类;用胎盘粉冲服也有效。此点,与《中医学新编》(447 页)中提的胎盘对促进肝功能恢复有好处的记载是相符的。

4. 缩小肝脏

肝脏的肿大,在中医学中认为是血瘀所致。在近代医学中肝脏瘀血也是肿大原因之一,所以要缩小肝脏,除了用软坚药物外,化瘀是其要点,习惯使用的牡蛎、鳖甲、山甲、丹参、三七、石见穿,都属于此类。其间牡蛎一味,能软坚散结,但因其

有敛涩作用,故临床服用后常见有肝区作痛情况(根据北京市中医医院经验也是如此),因而除因肝肿大影响门静脉回流而引起肠壁充血所致的便秘者通月外,余时可考虑减用或断续使用。

5. 糖的作用

近代生理学认为,肝对糖原量储存有一定的限量,约为100~350克左右,当其在一定的时间范围内储足量后,其他进入体内的糖就不能转化为肝糖原,此时糖就不能对肝功恢复起作用。中医学认为糖味甜属湿,过服时可以助长湿邪困脾,《内经》有:“甘先入脾,久而增气,物化之常也,气增而久,夭之由也”以及“脾恶湿”的论述,证之临床,曾见到因过多食糖而出现灰苔情况。所以在肝炎治疗中,不必过量服糖,而舌苔的灰润、白腻与否,似是其区分。

6. 中西药要否同用

根据经验(通过对照组),中西药同用和单独使用中药的效果相同,因而本病治疗中要求的是中西药有机配合,而不必同一性的中西药同用。要正确做到这一点,在目前中药性能尚未完全了解时有一定困难,须要继续努力。

(本文曾发表于1974年苏州地区中医学术交流会,经压缩后又刊于1981年北京市《东城医药》,1986年收入《北京市老中医经验选编》第二集。)

对三焦的探讨

三焦是中医学中历来的探讨课题之一。从《难经》起直到现在,仍然没有统一的观点,中间有中医,也有1949年后西医

学习中医的不少人参与了这一工作。探讨的焦点,集中在名和实的方面,尤其是“实”的具体所指方面。一种是有名无形观点。持这一观点的,起自《难经·二十五难》及《难经·三十八难》的“有名而无形”的论述,此后有王叔和、王冰、滑伯仁、张景岳、赵养葵等人。另一种是有名有形观点,持这一观点的有陈无择、李念莪、唐容川、虞抟、徐灵胎、章太炎、祝味菊等人。但持这一观点的在对“实”的探讨中,见解很不统一,陈无择、唐容川等认为是“油膜”,虞抟认为是“腔子”,章太炎创认淋巴,其他尚有认为是脊神经(赵意空)、水液平衡调节系统(夏涵、程家正)、胰腺(赵棣华)等的。这种不统一的见解,都有一定的依据和理由,在没有阐明三焦的实质之前,确是很难一致的。但这种不统一,至少对中西医结合工作是不利的,我们应该求得解决。

对三焦的探讨,应该遵循历史唯物主义和辩证唯物主义的原则,首先力求正确了解古籍所指的原义,因为在 2000 多年前的粗浅解剖条件下,决不可能象今天那样细致和正确,中间必然会有象恩格斯在《费尔巴哈与德国古典哲学的总结》中说过的“拿想的、幻想的联系来代替它还不知道的真实的现象联系,拿虚构来代替缺乏的事实”的情况,因此古籍所说的三焦,不可能就是现代的某一个单独的脏器,这一点在目前已经显现了,如古籍所说的心、肝等脏器,它既有同于、又有不同于今天所说的心、肝等内脏的功能和实体了,如果我们一定要它们“对号入座”,其结果不仅探索不到古人的原意,而且会坠入五里雾中。相反,我们也不能认为古籍所说是纯属虚构,一无所指,那是不符合于中国医学几千年来对疾病的防治效果的,否则就用不到我们去探索了,所以只有正确了解古籍的原意,才能分清其正确与非正确,才能“去粗取精,去伪存真”,才有

“批判吸收、整理提高”的基础。为了达到这点,在对三焦的探索方面,应该以出现争论的原始记载和与之相近时期的有关记录作为依据去进行探讨,后期中医对三焦的争论,都是以这些记载为基础而各抒己见,并不能替代原始论述的意图,就只能参考其进步发明的方面。根据上述原则,现就《内经》、《难经》的论述为主,谈点个人看法。

(一) 三焦的命名

三焦之名,始见于《内经》,是作为六腑之一提出的,并且在《素问》的“举痛论”、“宣明五气篇”、“调经论”以及《灵枢》的“五癯津液别”、“大惑论”、“营卫生会”、“决气”、“平人绝谷”等篇,都分别提出上焦、中焦、下焦三个名称,这是表明三焦有三个部分,合此上、中、下三个部分而为三焦,这三个部分,就是三焦之“三”的来源。历代医家对此是没有异议的。

“焦”,应该有热的含义,《说文》中解释是“火所伤”,“火”有发热的内涵作用,而“所伤”在正常的人体生理范围内是不可能存在的,只应该是所成,如果在人体内经常存在一个起“所伤”作用的脏器,就不能维持机体的平衡,只有在所成的基础上,才能促使机体的生长发展。综观《内经》、《难经》论述的三焦功能,可以清楚地了解这一点。无论是上焦的“宣五谷味,熏肤充身泽毛”(《灵枢·决气》),中焦的“泌糟粕,蒸津液,化其精微”(《灵枢·营卫生会》),下焦的“渗入膀胱”和“如渫”等(同上),都是依靠这个热能而出现的。因此,三焦的“焦”正同于现代口语中常见的“心焦”、“焦急”等词,只是以火和热的含义作为形容,而并不是现实中被火烧焦的“火所伤”。在《内经》、《难经》中,只有“肾气焦”(《灵枢·天年》),“肺热叶焦”(《素问·痿论》),“皮毛焦”(《难经·二十四难》)等的焦,才有近于“火所伤”的意义,那是病态性的产物,不同于三焦在生理

方面的体现。“焦”的另一个含义是《礼记·内则》“濡炙之举焦”、《说文》解释焦是“所以然持火也，从火、焦声”，并引《周礼》说明是“以明火热焦也”；《释文》称“焦，字又作焦”，说明焦、焦是通用字，这种熟物之义，才是三焦之焦的正义。唐容川对三焦的解释是能够说明这种作用的。

（二）三焦是脏腑之一

《素问·金匱真言论》说：“胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦、六府皆为阳。”《难经·三十八难》也说：“所以府有六者，谓三焦也。”这说明《难经》虽说三焦是“有名而无形”，但并没有否认三焦是六腑之一，因此三焦是六腑之一这点，在后世也没有异议。

《灵枢·本输》篇既称三焦为“中渚之府”，又称之为“孤之府”，《难经·三十八难》也称之为“此外府也”。此种“外府”、“孤府”之义，与大肠为“传导之府”，小肠为“受盛之府”，胆为“中精之府”，胃为“五谷之府”，膀胱为“精液之府”的含义应有不同，只有“中渚之府”（《灵枢·本输》、《难经·三十五难》略同）的含义，与其他五府在官能上是相同的。之所以同，在于它与脾、胃、大肠、小肠、膀胱都是“能化糟粕，转味而出入”的“器”（《素问·六节藏象论》），都具有“传化物而不藏”（《素问·五脏别论》）的特点，都是“传化之府”（同上），这是三焦所以为府的基本原因。其所以不同，是指它在上、中、下三个部分中的功能，是其他府所不能比拟的，所以就称之为“孤”，为“外”。在古人的比喻中，作为“心主之官城”的心包络，与三焦同样具有外的特点，加上经络上两经互络的沟通特点（《灵枢·经脉》），就变成了相表里的关系，从经络的循行上看，十二正经所以不同于奇经处之一，是内有独立的府，外有双行线的经，三焦经是具备这一特点的，这也是三焦作为脏腑之一的原

因,也是后来中医无异议的原因。

(三) 三焦的部位分界

比较明显提出三焦部位分界的是《灵枢·营卫生会》篇：“上焦出于胃上口，……中焦亦并胃中，出上焦之后，……下焦者别回肠，注于膀胱而渗入焉，故水谷者，常并居于胃中，成糟粕而俱下于大肠，而成下焦。”当然，《灵枢·营卫生会》篇中的主旨，在于说明营卫的所出、运行及其作用，正是通过其所出的论述，提到了三焦在上述的分界，与《内经》其他篇中所提到的一致。《灵枢·平人绝谷》篇在描述胃的宽度、长度时提到“上焦泄气，出其精微，慄悍滑疾，下焦下溉诸肠”，《灵枢·五味》篇中提到“谷始入胃，其精微者，先出于胃之两焦，以溉五藏”都意味着胃是中焦，胃上是上焦，下焦是在胃下。《灵枢·五味篇》说：“辛入于胃，其气上走上焦，……甘入于胃，其气弱小，不能上至于上焦。”这里的“上走上焦”和“不能上至于上焦”，都说明上焦在胃以上。又如《素问·举痛论》说：“悲则心系急，肺布叶举而上焦不通”，则更明显提出上焦是胸中。《灵枢·五癯津液别》篇说：“水谷并行于肠胃之中，别于回肠，留于下焦，不得渗膀胱则下焦胀”，这也是下焦在胃以下的分界说明，还指出了回肠以下是下焦的范围。基于《内经》的记述，《难经·三十一难》就明确指出：“上焦者，在心下下膈，在胃上口，……其治在膻中；中焦者，在胃中脘，不上不下，……其治在脐傍；下焦者，在脐下，当膀胱上口，……其治在脐下一寸。”《难经·三十五难》又说：“膀胱者，谓黑肠，下焦所治也。”《金匮·肺痿肺癰咳嗽上气病》篇说：“热在上焦者，因咳为肺痿”，《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》说：“以热在下焦，少腹当硬满。”《伤寒论·辨少阴病脉证并治》说：“小便白者，以下焦虚有寒”。根据《内经》、《难经》及其以后较近时代书籍的记录，都

可以看出三焦部位的分界是明显的,即上焦在胃上口以上,包括胸中;中焦是胃部范围;下焦在回肠以下的少腹部位,包括大、小、广肠和膀胱等。

(四) 三焦的作用

在《内经》、《难经》中,同样有三焦在生理、病理方面的论述,可以通过这些得出三焦作用的概貌。

上焦的作用,大致符合于心肺功能及其对体内和体外的关系,如《素问·调经论》中说:“阳受气于上焦,以温皮肤分肉之间。”表明肺与大气(即所说的阳)交换而使全身皮肤、分肉得到温养的作用,此一功能的另一来源,是从饮食吸收方面来的,所以《灵枢·决气》篇中说:“上焦开发,宣五谷味,熏肤、充身、泽毛,若雾露之溉,是为气。”由于古人不可能弄清心肺功能对全身作用的具体过程和细节,就只能以“气”和“雾”来形容其性能。如《灵枢·平人绝骨》篇说:“上焦泄气,出其精微,慄悍滑疾。”《灵枢·营卫生会》篇也说:“上焦如雾。”这便是上焦作用的抽象概括。古人也认识到如果这种“气”或“雾”状物质的作用不足和闭塞,就会造成“气消”。如《素问·举痛论》说:“悲则心系急,肺布叶举,而上焦不通,营卫不散,热气在中,故气消矣。”更可由于“上焦不通”而引起畏寒,如《素问·调经论》说:“今寒气在外,则上焦不通,上焦不通则寒气独留于外,故寒慄。”由于肺主皮毛的关系,当外邪侵袭皮毛而出现“上焦不通”时,还可引起发热,如《素问·调经论》说:“上焦不通,则皮肤致密,腠理闭塞,元府不通,卫气不得泄越,故外热。”这种寒慄和外热,就是外感病初起时,形寒发热的病理,是通过“上焦不通”而来的。不仅如此,上焦功能的闭塞,还可因“闭则气还,还则下焦胀”(《素问·举痛论》)而出现腹胀。以及令人“卒然多卧”和“已食若饮汤”,如《灵枢·大惑论》说:

“邪气留于上焦，上焦闭而不通，已食若饮汤（汤，熟水热者；故‘已食若饮汤’为胸脘灼热之状），卫气久留于阴而不行，故卒然多卧焉。”这种病理情况，涉及到了三焦的整体性，也是中医学中的整体观，这是因为“肺主皮毛”，具有卫外功能，是卫气作用的一部分；我们结合卫气的所出来看三焦的整体功能，如《灵枢·营卫生会》篇说的“卫出于下焦”，《难经·六十六难》：“三焦者元气之别使”，“原于脐下肾间动气”等的记载，就可以理解到这一点。此外，如《金匱》的“热在上焦，因咳为肺痿”的论述，也是上焦与肺功能的病理关系的很好说明。

中焦的功能，《灵枢·营卫生会》篇有“此所受气，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血”的记载。《灵枢·决气》篇也说：“中焦受气取汁，变化而赤，是为血。”（受气指受元气，取汁指取水谷腐熟后之汁），《难经·三十一难》也有“主腐熟水谷”的记载，这都说明中焦的功能符合于消化功能和部分造血功能。所以《灵枢·决气》篇又说：“营出于中焦”，《灵枢·营卫生会》篇说：“中焦如沤”，所谓“沤”，就是对腐熟水谷的形容。不论中医或近代医学，都认为饮食是血液的物质基础，这种从饮食的摄入到消化、吸收再而转化为血液的过程，就是中焦的功能。

下焦的功能，大致可分为两个方面，一是排泄二便的功能，如《灵枢·营卫生会》篇说：“下焦如渫”。《难经·三十一难》说：“主分别清浊，主出而不内，以传道者。”这里把大小便形成的功能也包括进去了。另一是机体能量、热量的产生，如《灵枢·营卫生会》篇说：“卫出于下焦”，正是根据这一点，《难经》推论说：“三焦之原”是“肾间动气”，是“生气之原”，是“五脏六腑之本，十二经脉之根”（见《难经·八难》及《难经·六十六难》），后来张景岳、赵养葵、唐容川等人把两肾之间定为命

门，作为三焦的发源之处，原气由此而出，游布全身，变成了对抗外邪的“卫气”。正因为有这种原气的产生，才起到了“下焦下溉诸肠”（《灵枢·平人绝骨》篇）的作用，才能使水液有可能“渗而俱下，济泌别汁，循下焦而渗入膀胱焉”（《灵枢·营卫生会》篇），从而使下焦形成“渫”的作用，使整个三焦对体内水液转化也形成“渫”的作用。如果这种作用失常，就会出现水肿、少腹胀、尿闭、遗尿等症状，如《灵枢·邪气脏腑病形》篇说：“三焦病者，腹气满，少腹尤坚，不得小便，窘急，溢则水，留即为胀。”《灵枢·本输》篇说：“实则闭癃，虚则遗溺。”《灵枢·五癃津液别》篇说：“水谷……留于下焦，不得渗膀胱，则下焦胀，水溢则为水肿。”张仲景也说：“以热在下焦，少腹当满硬”；“小便白者，以下焦有寒”；“热在下焦者，则尿血”。这些记述，从病理角度证明了下焦有分别清浊，形成大小便及排泄的功能，如果热能不足或郁滞，就会出现病变。

下焦的这两种作用是相辅相成的，不仅如此，下焦的作用也对上、中两焦起着作用。在这点上，《难经·八难》及《难经·六十六难》的论述开了先河，《中藏经》更清楚地说：“三焦者，人之三元之气也，总领五脏六腑、营卫经络、内外左右上下之气，三焦通，则内外左右上下皆通，其于周身灌溉，和内调外，营左养右，导上宣下，莫大于此也。”这就使三焦形成了一个整体，从而使脏腑功能也形成了整体——当然三焦的作用只是使脏腑功能形成整体的一个枢纽。正因为如此，所以三焦有病，上则可出现咳嗽、面浮、喉痹、嗌肿；中则可出现胀和“不欲食饮”；下则可出现二便失常。由于三焦对机体水液代谢的关系重大，而下焦又是个主要排水口，所以古人就以下焦来泛指三焦，而称之为“渫”。这正是出于整体而言的，并不是忽略了上、中两焦，我们从《内经》中“下焦如渫”与“三焦者决渫之官”

看,是可以体会的。

(五) 三焦的实质

三焦的实质,是历来争论最大的问题,从前述的三焦分界及上、中、下三部功能的分和合的情况,判断三焦的功能是必然有其物质基础的,否则,就变成无本之木、无源之水了。首先提出三焦“有名而无形”的《难经·二十五难》说:“心主与三焦为表里,俱有名而无形。”大家知道《难经》所说的心主是指心包络,今天已知心包络是确实存在的,谁也不会根据《难经》去争论它的名与形。三焦的实质,可以在《灵枢》中找到有关记录。

其一,《灵枢·营卫生会》篇说过:“循下焦而渗入膀胱焉。”这个“循”,必然要有物始可循。

其二,《灵枢·本输》篇说:“三焦膀胱者,腠理毫毛其应……。密理厚皮者,三焦膀胱厚;粗理薄皮者,三焦膀胱薄,疏腠理者,三焦膀胱缓,皮急而无毫毛者,三焦膀胱急;毫毛美而粗者,三焦膀胱直;稀毫毛者,三焦膀胱结也。”《灵枢·论勇》篇也说:“勇士者,……三焦理横,怯士者,……其焦理纵。”固然,《灵枢》所说的“其应”未必正确,但其有物所指的原意是清楚的,也就是根据有物的概念而与其他脏腑一样,建立了“府”和“经”。

据上所述,三焦有其实质是肯定的,那末它的实质究竟是什么?三焦既然分成上、中、下三部,并有其畔界,这就不可能是与现代医学中同样性质的某一种脏器,而只能与中医学中所说的其他脏器一样,是实质和更广泛的功能的混合。结合古籍,对三焦的功能,尤其是整体功能,可以得出一个概念:三焦不是某个个别脏器的作用,而是几个脏器,以至于几个系统的作用,其间包括:呼吸、循环、消化、造血、泌尿等系统和能量

的产生,当然也就包括了近代所提出的淋巴、油膜、水液平衡等作用在内,实际上连部分神经和部分内分泌功能也包括在内。

既然三焦包括多种系统功能,那末连结这多种系统的是什么呢?使多种系统成为一个整体的是什么呢?《内经》称三焦是“孤府”,《难经》称三焦是“外府”,《中藏经》称三焦是“孤独之府”,这个“孤”,应该是孤家寡人的孤,是形容其无与伦比。这个“外”,应该是外面的外,是包于六脏五腑之外的意思。所以《中藏经》说它“莫大于此”。后来的《医学正传》说得更清楚:“三焦者,指腔子而言,包涵乎肠胃之总司也。胸中膈膜之上曰上焦,膈膜之下,脐之上曰中焦,脐之下曰下焦,总名曰三焦。其可谓之无所受乎,其体有脂膜在腔子之内,包罗乎六脏五腑之外也。其心包络实乃裹心之膜,包于心之外,故曰心包络,其系与三焦之系连属。故指相火之脏腑皆寄于胸中,此指始而未知终也。”李念莪说它“际上极下,象同六合而无所不包也,十二藏中,惟三焦独大,诸藏无与匹也。”符合三焦包括多种系统功能的实际情况。这种包于六脏五腑之外,形成机体中最大的腑的东西,就是三焦的实质。今天在解剖中可以找到的胸膜、腹膜,以至于由其连结的肠系膜及其他物质等,无不是三焦的实质,如剖开这层膜,就见到虞抟所说的“腔子”了。

依据古籍论述,可以想象这样一个模式:三焦这个包裹在脏腑之外的大腔子,分成上、中、下三个范围,由下焦产生能量,给予了各个范围中所有脏器以热能,使中焦在摄取水谷之后产生“如沤”的作用而生血,使上焦在交换大气后起到“如雾”的作用,外以温养皮肤、分肉,内而“通调水道,下输膀胱”,使下焦能“下溉诸肠”而排便,能“分别清浊”、“渗入膀胱”,连同上焦下输而来的水液得以成溺排出,从而完成“如渎”的作

用。如果没有在外面的这一层大包裹,下焦便失去了蒸发的空间,能量不能聚用,则中焦不能“腐熟水谷”,上焦不能“输布津液”,下焦也就失掉了“气化”的基础。

由此可见,以三个范围中所包括的某个脏器来作为三焦的实质,或者以某一个系统来作为三焦的实质,都不如以这一层包裹之膜作为实质更易于体现中医学的脏象精神,更符合于古籍所记述的意图。

(1975年11月初稿,1976年6月修改。本文在无锡县学术交流会上发表。)

中医学对“阴阳”的运用

阴阳学说是华夏民族在长期社会实践中逐渐形成的一种自发的、朴素的辩证思维,被广泛运用于各个领域。中医学用以说明生理、病理、诊断、药物及治疗等方面的性质、活动、变化等问题;因此,阴阳对中医学来说,是基础理论的重要组成部分,是一种说理工具。它对中医学理论的形成和发展有着深远的影响。

一、阴阳进入医学领域

古人通过对宇宙间各种事物的认识和观察,总结出了事物与事物之间和每一个事物的内涵中,存在着既对立而又统一的运动规律,以阴阳分别代表这两个方面。从文字上溯源,《易经》中的“八卦”,是阴阳最早的记录,用“—”的符号代表阳,用“- -”符号代表阴,并用这种符号的多少组成卦,以表示事物的变化;《易经》中的“无平不陂,无往不复”之说,已经具

有物极必反的朴素辩证思想,并且说明了“平”和“陂”、“往”和“复”的二种对立而又统一的性质。在《国语》、《左传》等书籍中,已经有用阴阳来说明具体事物的记载,如对地震、陨石的解释是因“阳伏而不能出,阴迫而不能蒸”。在医学方面,《史记·医和传》中解释疾病的发生是“阴阳之事”,而中医学的最早书籍《内经》对阴阳已有系统的记载了。从《汉书·艺文志》中既载录了《黄帝内经》等医籍,也记有阴阳家的著作的情况分析,可以溯知阴阳学说之进入医学领域,是学说之间的相互渗透,其目的在于丰富和发展自身。

二、阴阳的基本内容

阴阳代表着对立的事物,或一事物内部对立双方的属性。如昼与夜、晴与雨、热与寒、动与静等等。由于阴阳双方的运动变化,构成了一切事物,并推动其发展变化。一般来说:凡是活动的、上升的、明显的、进行性的、功能的、亢进的都属于阳;沉静的、下降的、隐晦的、退行性的、机能衰减的、器质的都属于阴,如《内经》有“天为阳,地为阴”,“水为阴,火为阳”,“阳化气,阴成形”等记载,就是用上下、寒热、趋向及其变化表现来划分的。

事物的阴阳属性是相对的,不是绝对不变的,不是局限为某一特定事物的,这种相对性表现在:①在一定条件下阴阳可以转化,阳可变阴,阴可变阳。根据对立面的变更而属性亦变更;②阴阳中可以再分阴阳。如脏为阴、腑为阳,而脏中的心与肾又可据在上在下的不同而划作心为阳、肾为阴;每一个脏中又可再分阴阳,如心阴心阳、肾阴肾阳等。又如昼为阳、夜为阴,而上午称阳中之阳,下午为阳中之阴等。这种事物与事物之间的对立统一的一个方面,一事物内部的对立统一的一个

方面,都是在运动中变化发展的。

三、阴阳的四种关系

(一) 阴阳的相互对立

阴阳是两种不同属性的概括,如小与大、动与静等有如上述,这种相互对立性,主要表现为它们之间的相互制约和相互斗争方面,如夏季本以阳热盛,而夏至后阴气却随之而生,用以制约炎热的阳;冬季本以阴寒盛,而冬至后阳气即随之而生,以制约严寒的阴。这种相互制约,还表现在一方面太过,会引起另方面的不足;相反,一方面的不足,也会导致另方面的太过。所以《素问·阴阳应象大论》说:“阴胜则阳病,阳盛则阴病。”阴阳互相制约的过程,也就是相互运动的过程,否则就不能制约,《素问·疟论》说:“阴阳上下交争,虚实更作,阴阳相移”,就是说明两者之间不是平静的、各不相关地共处于一个统一体中,而是相互排斥,相互斗争的。由于这种不断的排斥与斗争,才推动了事物的变化和发展。

(二) 阴阳的相互依存

阴阳双方既是对立的,又是依存的,任何一方都不能脱离另一方面而单独存在。上为阳,下为阴,没有下也就无所谓上;热为阳,寒为阴,没有寒也无所谓热;实为阳,虚为静,没有实也无所谓虚。就人体生理方面而言,出与纳、呼与吸、循而环,也都是如此,如果出纳呼吸中的任何单独一方不存在,那末另一方也势必不存在了,即使少有不协调,也就是病态了。这些都说明阴之与阳,都是以另一方面的存在为条件。阴阳的这种相互依存关系,旧说称之为“互根”,在机体上还表现在物质与功能的关系方面:机体的物质属阴,功能属阳,物质是功能的

基础,没有物质就存在不了功能;而如果没有功能,就不能发挥物质的作用,就不能产生新的物质和功能。如气属阳、血属阴,气依靠血来产生,血又依靠气来运行,血可生气,气又可生血。只有两者配合得好,才是正常情况,否则也就是病态,所以《素问·阴阳应象大论》说:“阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也。”就是说明这个依存道理。

(三) 阴阳的相互消长

阴阳的相互对立、相互依存,不是处于静止状态的,而是处于互为消长的不断运动变化之中。如四季气候的变化,从冬至春到夏,是由寒到热,从夏至秋到冬,是由热变寒;前者是“阴消阳长”的过程,后者是“阳消阴长”的过程,由于这种消长变迁,才能化生万物。就机体而言,机体活动要消耗一定营养物质,就是“阳长阴消”过程,而各种物质的代谢,又必然要消耗一定的能量,这就是“阴长阳消”的过程。这种消与长,一般是处于相对平衡状态中的。所谓“动态平衡”,这是正常状态。如果这种“消长”关系超出一定限度,不能保持相对平衡,就出现某一方面的偏盛偏衰,也就是疾病的发生。

(四) 阴阳的相互转化

阴阳发展到一定阶段,可以向各自的相反方面转化。即阴化为阳,阳化为阴。如果说“阴阳消长”是一个量变过程的话,那末转化就是质变的过程。在正常生理下,这种转化,是物质转化为功能(阴转化为阳),功能产生新的物质(阳转化为阴)的过程,是《素问·阴阳应象大论》所说的“重阴必阳,重阳必阴”的道理,也是上节中提到的气候变化问题。或者称之为“寒极生热,热极生寒”。

就病理而言,如中毒性肺炎、中毒性菌痢等某些急性传染病,由于病毒大量耗伤机体正气,在持续高热情况下突然出现

体温下降、面色苍白、四肢厥冷、脉微欲绝的阴寒危象，就是“热极生寒”、“重阳必阴”的情况。此时如果抢救及时得当，体温上升，色脉转和，由危转安，则又是阴转为阳的情况。临床上常可见到的疾病的由表入里、由里出表、由实转虚、由虚转实等变化，也是阴阳转化的表现。

以上阴阳的相互对立、依存、消长、转化几个方面的关系，是相互联系、相互影响和互为因果的，这是阴阳学说的基本内容。了解了这些内容，就易于理解中医学对阴阳学说的运用了。

四、阴阳在中医学中的应用

（一）组织、生理方面

中医学将人体的组织结构划分为阴阳两类，现举例如：

阴：下部，体内，内侧，背，五脏，血，物质；

阳：上部，体表，外侧，腹，六腑，气，功能。

在五脏中间，依据阴阳的相对属性，又可出现变易；如五脏都属阴（以脏对腑而言），而以五脏中的心对肾而言，则心属阳，肾属阴，因为心在上，肾在下（以上对下而言）。在一脏腑之间，又各有阴阳，如心阴心阳，肾阴肾阳，胃阴胃阳等，这种划分正说明阴阳不是局限为某一特定事物的。与物质之间的转化，也必须保持相对的平衡，如肾阴之与肾阳，胃阴之与胃阳，如果不能相反相成，就是病态。总之机体的各组织结构之间，以及每一组织结构本身，虽然关系复杂，但都可用阴阳来概括说明，所以《素问·宝命全形论》说：“人生有形，不离阴阳。”

（二）病理方面

人体阴阳失去相对的平衡，就是疾病的发生，是阴阳出现偏盛偏衰的结果。阴胜则阳病，会出现水、寒、湿的疾患；阳盛

则阳病,会出现火、热、燥的疾患。阴虚不能制阳,就出现虚寒证;阴虚不能制阳,就出现阴虚阳亢的虚热症。阴阳中任何一方虚损到一定程度就导致对方的不足,所谓“阳损及阴”,“阴损及阳”,最后则出现阴阳两虚证,如某些慢性病中由于气虚而致血亏,或阴虚而阳无生化之源等。人体的抗病机能和致病因素,以及它们的斗争情况,也都可用阴阳来说明。病邪有阴阳之分,阳邪致病,多伤人阴气;阴邪致病,多伤人阳气;伤阴则造成机体内阳亢阴虚而出现热证,伤阳则使机体阴盛阳衰而出现寒证,这又是“阴盛则阳病”或“阳盛则阴病”的另外一种情况。

（三）诊断方面

首先要分清阴阳,才能抓住疾病的本质。不管临床症状多么千变万化,都可以“阳证”、“阴证”来概括,如“八纲辨证”中的表、热、实属阳,里、虚、寒属阴。又如望诊中见色泽鲜明者属阳,晦暗者属阴。听诊中的声音洪亮属阳,低微断续属阴。切诊中的浮、数、大、滑、实等脉属阳,沉、迟、小、涩、虚等脉属阴。当然中间有错综变化的症状,难于据一症划分,那就要按全身情况和整个疾病过程,细心比较而确定它的阴阳属性,如“热深厥深”,表寒而实为内热,但据其厥而定为阴寒就错误了,要从舌质绛、脉沉而有力来区别其不同于阴厥。

（四）治疗和药物

疾病的发生是阴阳偏盛偏衰,是二者的对立统一受到破坏而出现的;因此,推本求原的治疗法则,就是调整机体阴阳的偏盛偏衰,建立新的对立统一、新的动态平衡。所以《素问·阴阳应象大论》说:“治病必求于本。”所谓本,就是阴阳。《素问·至真要大论》又说:“谨察阴阳所在而调之,以平为期。”阳盛发热,可用“热者寒之”的方法;阴盛而寒,可用“寒者热之”

的方法。这都是“损其有余”的办法，也是“正治”法；阳虚畏寒，可用补阳的方法，阴虚发热，可以用补阴的方法，进一步可因“热之不热，是无火也”，而用“益火之原，以消阴翳”，或者因“寒之不寒，是无水也”，而用“壮水之主，以制阳光”等方法。这就是“阳病治阴，阴病治阳”，因为阳亢的实质或阴盛的实质均在对方，是对立面的不足。

不仅可以根据阴阳的本质建立治疗原则，也可根据阴阳来选用药物。《素问·阴阳应象大论》说过：“辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴”；“味厚者为阴，薄为阴之阳，气厚者为阳，薄为阳之阴，味厚则泄，薄则通，气薄则发泄，厚则发热”。因此，寒凉、滋润的药物属阴，温热、燥烈的药物属阳；药味酸、苦、咸的属阴，辛、甘、淡的属阳；具有敛降作用的属阴，具有升散作用的属阳。临床就用这种对药物的概括来配合治疗原则，用来调整机体的内部的阴阳，求得相对的平衡。根据《内经》“味厚则泄，薄则通，气薄则发泄，厚则发热”的记载，还可想到在用阳性或阴性的药物太过的情况下，可以导致阴阳向各自的相反方向发展的不好结果，如桂枝本可解肌，太多就增加发热力量，地黄本可滋阴，太过就可导泻等均属于此。

（本文成稿于1976年3月，为锡南地区学术交流会议讲稿。）

肠 病

大肠有“传导”、“变化”的功能，就是把小肠消化吸收后传送入大肠的“糟粕”（食物残渣）加以再吸收其部分水分（这种再吸收作用，是《脾胃论》中“大肠主津”说法的依据），而变为

成形的大便,传送、导引,排出体外,从而最终完成食物在体内的消化过程。

大肠受病,主要表现在大便异常方面,如痢疾、泄泻、便秘以及肠鸣腹痛、里急后重等,这种变异的原因,有如下述:

第一是机体本身功能的改变——大肠居小肠之下,是整个消化系统的组成部分,小肠的分别清浊功能和脾胃运化功能是否正常,必然会影响到大肠,如泄泻或便秘的成因就与此有关。大肠本身功能的改变,“化物”的作用失常也可以引起肠道疾患。

第二是外邪引起大肠功能或器质上的改变——如湿热、疫毒侵入而引起的痢疾就是如此。

肠病按部位而言,应该包括小、大、直肠三个部分,由于中医学中常把小肠功能概括在脾的功能方面,所以把“泄泻”列入脾病中论述。其他如直肠病变的痔疮,属外科范畴,故亦不在本文论述,本文仅就大肠本身病变的痢疾、肠风、便秘展开讨论。

一、痢 疾

痢疾为常见的肠道传染病,临床上以腹痛、里急后重、下痢脓血便为主症。《内经》称本病为“肠澼”,《伤寒》、《金匮》称之为“下利”,晋代以后始称为“痢疾”,亦名之为“滞下”,义为下之不爽。中医学中的痢疾,包括着近代医学中的急、慢性细菌性痢疾,以及原虫性痢疾。对痢疾的传染性,在元时已有认识,当时称之为疫,即后文所提之疫毒痢,《丹溪心法》有“又有时疫作痢,一方一家之内,上下传染相似”之文。根据致病因素和临床症状的不同,分为“湿热痢”、“疫毒痢”、“久痢”、“休息痢”等,以及有“赤痢”、“白痢”、“噤口痢”等称。

(一) 病因病机

本病多发于夏秋季,中医学认为本病的致病由于:①外感暑湿、时疫之气,②饮食不洁或过食生冷。此两大因素与季节有着密切关系。当上述两类邪气壅积肠中,使大肠的传导功能失常,气血凝滞,湿热郁蒸,损伤肠道的脂膜血络,遂致出现里急后重,便下脓血。由于湿热有所偏重,以及气分受邪或血分受邪亦有所偏重,而使症状亦不一致;如果湿胜于热,气分受邪甚于血分,则下痢白多于赤,反之则下痢赤多于白。气分受病尚未伤及血络,则下痢白,为受病尚轻,反之则重。如脾胃素弱,或湿热困阻运化或耗伤胃气,或热邪灼伤胃阴而出现呕吐,则为“噤口痢”。痢疾中的呕吐往往可见,称为“噤口”,则多指胃气,胃阴受伤而出现呕吐者,二者轻重不同,严重的湿热痢亦可见此症。如湿滞且又脾胃阳气素虚则为寒湿痢,或感受暑湿后虽已入里,而表仍未解,可以出现形寒发热。痢疾的发热,不仅在此情况下可见,如果邪入血分,劫液伤津时亦可出现。《内经》“肠澼下血,身热则死”的记载,今天固然不能作为绝对准则,但其严重性仍须注意,对劫液伤津时的发热,尤其如此,因为可以引起神昏痉厥等症。

感受时疫之气深重,可以直入营血、内陷心包、化火内焚,以致突然高热神昏、痉厥,如正气不足以支持,则更可因而虚脱。此条病机与前述湿热深重、伤营劫液者有其相同之处,但有轻重缓急之别。

急性痢疾失治或误治,迁延日久,正虚邪恋,成为慢性久痢,每因饮食不当、受凉或劳倦而反复发作,其间迁延不愈而便次不多者为“久痢”,有一定的恢复时期而屡屡发作的,叫“休息痢”。这种慢性痢疾,正气的盛衰与其发作有密切关系,大体上可分阳伤或阴伤两类,其湿蕴不化的,多伤脾胃阳气,

再而可以伤及肾阳；其热邪内郁，留恋不化的，多易耗伤阴血。

（二）辨证论治

本病的治疗，要根据正邪盛衰、病程长短的不同情况而分别对待。一般情况而论，急性发作、病程短的多邪实证，要用清化湿热、除邪之品为主，参以调气和血，以调整肠腑功能，不宜早用收涩，以免留邪不去。前人把清化湿热、消导积滞、调气和血作为治痢三法，所谓“行血则便脓自愈，调气则后重自除”，对急性痢疾的治疗是有一定作用的。慢性久痢，病程长，多见虚实夹杂证，治疗要照顾到正气，不宜一味攻邪，要标本同治，更要区分伤阳伤阴的不同。

1. 肠府湿热证

（1）痢下赤白，稠粘气臭，日夜十余次或数十次，里急后重，腹痛，肛灼，口干粘苦，溲赤短，脉弦数或滑数，舌苔白腻或黄腻，兼有发热者用芍药汤（黄芩、黄连、当归、芍药、肉桂、甘草、大黄、木香、槟榔）去肉桂，加枳壳、马齿苋。无热用白头翁汤（白头翁、秦皮、黄连、黄柏）。

（2）兼有表证不解，畏寒发热，胸痞气滞，痢下尚夹粪便，或白多红少；用荆防败毒散（荆芥、防风、羌活、独活、柴胡、枳壳、川芎、茯苓、甘草、桔梗、薄荷、生姜）。热势已重，用葛根芩连汤（葛根、黄芩、黄连、甘草）。

（3）兼有积滞，重者加用木香槟榔丸，轻者加用保和丸。

（4）呕吐频作，加用玉枢丹或另用苏连饮（苏叶、黄连）呷服。

2. 疫毒炽盛证

（1）热毒炽盛，发病骤急，痢下脓血，鲜紫相杂，高热烦渴，腹痛急剧，肛痛而坠，儿童可于未见痢下时即呈高热、昏迷、痉厥，舌红，苔黄腻或糙，脉滑数或沉伏，用黄连解毒汤（黄

连、黄柏、黄芩、梔子)加白头翁、赤芍、丹皮。

(2) 热邪入营,神昏烦躁,前方加服神犀丹或紫雪丹。

(3) 热甚动风,痉厥抽搐,前方再加钩藤、石决明、全虫,仍用紫雪等。

(4) 正虚邪陷,面白肢冷,脉细欲绝,宜先回阳救脱,用参附汤(人参、附子),回苏后再辨证施治。

3. 噤口痢

体弱年老,正气不足,湿热邪毒,上逆犯胃,呕恶不能食,此类症情,较之湿热症中的呕吐严重,要另行对待。

(1) 初起热甚,舌红苔糙黄,面色赤,脉大或弦,痢下不爽者,宜苦降辛通,用半夏泻心汤(姜半夏、干姜、人参、大枣、黄连、黄芩)去人参,加大黄、竹茹、陈皮。

(2) 干呕不止,胃气渐虚,舌淡苔少,面色渐淡,热势或轻或无,或午后潮热,用开噤散(人参、黄连、石菖蒲、丹参、石莲子、茯苓、陈皮、冬瓜皮、陈米、荷叶蒂)。

(3) 胃阴不足,口干舌红,苔少而黄,用半夏泻心汤去干姜,加石斛、麦冬、沙参、竹茹。

4. 久痢

(1) 痢疾迁延不愈,便下紫暗稀薄,或常挟粘白,甚至滑泄脱肛,腹中隐痛,喜按喜温,食少神疲,舌淡,苔白,脉弱;此为脾阳虚弱,用桃花汤(赤石脂、梗米、干姜)或养脏汤(诃子、粟壳、肉蔻、当归、白术、白芍、人参、木香、肉桂、甘草)。

(2) 虚实夹杂,脾虚邪滞,症同前述而舌苔厚腻,用温脾汤(大黄、人参、甘草、干姜、附子)加减。

(3) 脾虚而累及肾阳,滑泄脱肛,肢冷脉沉,舌淡苔白;用养脏汤加附子。

(4) 痢久不愈,下赤白脓血,粘稠如冻,腹痛里急后重,心

烦口干，体瘦乏力，舌红苔少，脉细数，此为久痢伤阴，用驻车丸（黄连、阿胶、干姜、当归）加白芍、乌梅、地榆、生甘草、石斛。

（三）单方草药

1. 马齿苋、地锦、辣蓼、白头翁、石榴皮，择其中一二种，一日用 30～60 克，煎服。

2. 大蒜浸出液保留灌肠（10%），或口服生蒜 3～5 瓣，一日 3 次。

3. 水菖蒲根粉 0.3～0.5 克，装胶囊服，日 3 次。

4. 大黄、肉桂等份，研粉，每服 1.2 克，日 3 次。治久痢。

5. 至圣丹：鸡胆子去壳，成人每服 10 粒，胶囊装服或馒头皮包吞，日 3 次，7～10 天为一疗程，治原虫性痢疾。

注：3、4、5 三方，不适用于溃疡病人。

二、肠 风

肠风，是便血的一种，包括在《金匱》“近血”范围中。《金匱》以先便后血为远血，先血后便为近血，根据张景岳的解释，远血的来源“或在小肠，或在于胃”。就是说，来源远，故称远血；这类便血，相当于近代的上消化道出血和伤寒的肠出血，包括在血症、温病中。对近血，张景岳认为“或在广肠，或在肛门”，来源近，所以叫近血；此类便血，是包括本病在内的。中医中的近血，包括了肛门、直肠、结肠等部位的出血，如痔疮、肛裂、结肠或直肠癌、肠息肉，以及腹型过敏性紫癜等病的出血，其间痔疮、肛裂等出血，属外科范围。

（一）病因症治

肠风的名称，见于《素问·风论》论曰：“久风入中，则为肠风飧泄。”说明肠风的主因是由于风邪久留不去，内乘肠腑而来。《灵枢·百病始生篇》说：“阴络伤则血内溢，血内溢则后

血。”张景岳说：“火盛则迫血妄行。”由此可见，肠风的便血，是在风邪内乘的基础上化火伤络而形成。风邪如不化火伤络，则成为飧泄。

因此，本病的下血，色鲜而四溅，不杂大便，并伴有肠鸣腹痛，多见舌红苔少，脉象滑数，宜泻肠凉血，用槐花散（槐花、侧柏叶、荆芥炭、枳壳）合地榆散（地榆、赤芍、黄连、青皮）。热轻者可用赤小豆当归散（即原药）。

肠风挟湿，下血紫黑，或如豆汁；此往往由醇酒厚味而来，脉见濡数，或则滑大，舌苔黄腻，用苍术地榆汤（原药）加黄连、山栀，防风。

后期便血过久，阴血亏虚，见有头晕目眩，舌淡，脉细数，用槐花散加当归、阿胶。

（二）单方草药

1. 旱莲草，景天三七：单味用 30～60 克煎服。
2. 刘寄奴 15 克，芽茶 3 克，乌梅 1 枚，煎服。
3. 槐花研末，米汤送服，每服 9 克。

二、便秘

便秘一症，常见于其他病证中，如伤寒、温病中的承气证、增液承气证（增液承气汤：玄参、麦冬、生地、大黄、芒硝）、新加黄龙汤证等（新加黄龙汤即调胃承气汤加人参、姜汁、麦冬、生地黄、元参、海参）都以大便秘结为主症。由于有专篇讨论，本篇中不再赘述，本篇仅就单独出现的习惯性便秘来讨论。

（一）病因症治

便秘的形成，原因很多，《素问·至真要大论》有“大便难……病本在肾”的记载，《金匱》有“亡津液，胃燥，故大便难”的记载，后人更有虚秘、实秘、气秘、冷秘、热秘之分；总之与大肠

的传导功能和“主津”的作用有着密切关系,以及其他脏器能影响到大肠功能的,也有关系,如脾、胃、小肠、肾以及肝、肺等,所以张洁古说:“有老人津液干燥,妇人分产亡血,及发汗,利小便,病后气血未复,皆能作秘。”

便秘的一般症状是排便困难,往往三四日或五六日大便1次,部分患者除大便秘结外,可不见其他明显自觉症状,但长期患有本病的,往往引起痔核、肛裂,或有腹胀、纳减、眩晕、口干等症。又可因为致病原因的不同而出现其他不同兼症。兹按病因及临床表现的不同概括为热、气、虚、冷四种来论述其病因、病理和证治。

1. 燥热(包括热秘、实秘、风秘的一部分):多因恣食厚味酒辣,肠胃燥热,津液不布,而致大便秘结难行,《金匱》称之为“脾约”,是脾为胃热所约束,不能为胃行其津液。可以见到口臭,潮赤,胸脘痞满,苔黄,脉滑实等证,甚则口舌生疮,宜清润苦泄,用麻子仁丸(麻仁、杏仁、芍药、大黄、枳实,蜜为丸)或更衣丸(芦荟、朱砂)。

风秘一症,前人认为系风邪入于大肠,燥炼津液而来,临床多见燥热症,故可以与燥热治法同例而加用风药,用润肠丸(羌活、归尾、大黄、桃仁、麻仁,蜜丸)。

2. 气滞(气秘):此由忧思郁结,或用脑多而活动少,使气失升降、津液不行、大肠失于传导而来,可以兼见胸胁痞满,噫气频作,纳少胃呆,宜顺气行滞,用六磨汤(沉香、木香、槟榔、乌药、枳实、大黄)或用苏子降气汤(苏子、半夏、前胡、甘草、厚朴、陈皮、当归、沉香、生姜)加枳壳、杏仁。后者用于轻症。

本条可因病机和体质的不同而转入实证或虚证。

3. 虚秘:易见于老人、虚人、妇人产后亡血,或病后气血不复,津液不复,致肠间干燥;或气虚不运,大肠不能传导而

来。症见头晕，咽干，形瘦，唇白，食少，溲清，或便后乏力，气短汗出。虚秘要分气血，气虚的要点在于虚而不运，脉多虚软，舌苔薄淡；血虚的要点在于阴血不足润肠，脉多细涩，苔多光少。气虚宜益气润肠，用黄芪汤（黄芪、陈皮、麻仁），血虚宜养阴润肠，用五仁丸（桃仁、杏仁、柏子仁、松子仁、郁李仁），或单用生地或首乌煎服，六味地黄丸亦可选用。

4. 冷秘：由寒冷之气横于肠胃，凝阻阳气，使津液不运；此类便秘，多见于老人，伴有轻度腹痛，得按、得温则舒，面白，溲清，脉象沉迟；宜温通温润。温通用半硫丸（半夏、硫黄），温润用苁蓉润肠丸（苁蓉、沉香、麻仁）。

便秘治法，不能一概以硝、黄通下，张石顽说：“若老人、虚人，及病后肾水本亏，以致燥结，再用硝、黄下之，是虚其虚，目下取快一时，来日复秘愈甚”，近代对大黄有了新认识，机理就更清楚了。

四、虫病（附：钩虫病）

肠寄生虫病的种类很多，有蛔、绦、蛲、钩虫等；由于历史条件的限止，中医学中对肠寄生虫的生活史和感染途径缺少完整的认识，对有些寄生虫病并不列入虫门，《金匱》称蛔虫为“蚘”，《诸病源候论》称绦虫为“寸白虫”，论云：“长一寸而色白，形小扁”，正是寸白虫的一个节片。蛲虫在中医学中或称为“线虫”，而对钩虫则缺少记载，按症状归之于湿热或萎黄类中，民间亦称之为“桑叶黄”、“黄胖病”等，故本篇讨论中将其另作一章，其他虫症治法雷同，均在本章讨论。

（一）病因病理

前人对虫的产生，都归之于湿热，认为是湿热郁蒸而生，这是因为看不到虫进入人体之故，但《金匱》有“食生肉，饱饮

乳,变成白虫”,“食脰,饮乳酪,令人腹中生虫为瘕”的记载,以及认为猪肉、牛肉能令人腹中生虫,或生寸白虫,《诸病源候论》对寸白虫的产生,有“以桑枝贯串牛肉炙食,并食生栗所作”,“食生鱼后即食乳酪,亦令生之”等的记载,都说明了生鱼、生肉、乳酪可以引起虫病。

虫病的症状,视人体正气的强弱而异。感染轻、体质强者症状就轻,或无明显症状,反之则就较为明显。由于虫的不同特性,临床症状亦异,如蛔虫喜攻动,易于出现腹痛,蛔虫入胆时则腹痛尤甚,虫多而结于肠道可出现肠梗阻症状称为“蛔结”。蛲虫常有夜间肛痒。虫积日久,则脾胃受损,而致食欲、消化均不正常,或食欲不振,或贪食易饥,或有异嗜,睡中磨牙、易惊,或便秘,或腹泻,甚则面黄肌瘦,气虚血弱。

(二) 辨证施治

肠虫病的治疗方法,大体上是驱虫和扶正两个方面,虫积证明显而正气未衰的,当先驱虫;正气不足,脾胃运弱的,要健脾和胃,调补气血后再行驱虫,或攻补兼施。

虫积症除异嗜及睡中磨牙外,每可见到颜面白斑,下唇颗粒点,舌面红点或花剥苔等证。儿童的颜面白斑及唇点较成人明显,且多指甲菲薄或有白斑。蛔、绦、蛲虫的鉴别,借助于大便检查为最可靠。在直接诊察中,除前述虫证外,下列情况可资参考:

蛔虫:腹痛明显,多绕脐,异嗜症明显。

绦虫:便中可见到虫体节片,患者衬裤及被服上有时亦可发现。

蛲虫:多晚间肛门作痒。

1. 驱虫:以化虫丸(苦楝根皮、鹤虱、槟榔、芜荑、枯矾、使君子、胡粉——另方用胡黄连、元胡粉)为主方。加减法:

(1) 兼有食滞，腹胀痛，脉沉实，加大黄、黑丑。或用追虫丸(黑丑、槟榔、雷丸、木香、茵陈、皂角、苦楝根皮)。

(2) 蛲虫：加用醋水各半外洗肛门，每晚睡前1次，连洗1周，每日要换衬裤。或用韭菜汁外洗。

(3) 绦虫：加南瓜子、雷丸，加重槟榔用量。

(4) 姜片虫：加重槟榔用量。

(5) 蛔虫入胆，《金匱》有“蚘厥”的记载，认为是“虫上入膈”所致，用乌梅丸(乌梅、细辛、干姜、黄连、黄柏、当归、附子、川椒、桂枝、党参)，或用胆蛔汤(榧子、使君子肉、槟榔、乌梅、苦楝根皮)加郁金、木香、枳壳。民间专用：菜油60克，煎红糖60克顿服。

2. 扶正

(1) 健脾和胃：本法用于由肠虫引起运化失司的腹胀，腹泻，恶心，胃呆纳少，肢体倦怠，苔白脉软等症，用六君子汤(党参、白术、茯苓、炙草、陈皮、姜半夏)为主。

加减法：湿困脾运，症见面色浮黄，脘痞呕吐，舌苔腻厚，去白术，加苍术、厚朴，另服伐木丸(苍术1000克，神曲120克，醋煨皂矾500克，共为末，水泛为丸)。

(2) 调补气血：本法用于色萎，头昏，心悸、气短，肢体倦怠，或兼有下肢及眼睑浮肿，脉细，舌淡，苔薄少；用十全大补汤(党参、白术、茯苓、甘草、熟地、白芍、当归、川芎、黄芪、肉桂)。

附：钩虫病

钩虫病，民间称为“桑叶黄”，早期称为“粪毒”，由于此病之来，往往为在粪田或蚕桑期在桑田中劳动而起之故；后期因于贫血而出现萎黄无力，则称之为“黄胖病”(煤矿地区或许另有名称)，中医学中对其早期咽痒咳嗽时归之于咳嗽门，后期

则以气血两虚来对待。

本病多见于雨季及蚕桑期间,初感时往往四肢起疹作痒,尤以下肢为多见,继以咽痒咳嗽,此种咳嗽,痰少而咽痒特甚,甚至可咽,耳皆痒,此为区别于其他外感咳嗽之处。从中医的观点看,季节上的湿热以及粪毒,是本病的致病因素,当湿毒之邪由肌表侵入,乘袭于肺时,咳嗽就因之而起,继之湿邪困脾,生化受阻,而致气血渐形衰少,所以萎黄无力。甚至可因脾不统血而出现下血的情况。

本病的确诊,依靠便检,但要到中后期才能在大便中找到虫卵。早期要靠临床的咳嗽特点和手足发痒起疹的病史,中后期的全身虫积症并不象蛔虫症明显,在巩膜上可以见到由上下眼睑内底部延伸出来的小血管顶端或边缘有浅紫色云状斑点。

本病的治疗,早期咳嗽时要解毒清湿,肃肺止咳;中期可以驱虫;后期要重视补脾养血,兼用驱虫。

1. 解毒清湿,肃肺止咳 用:杏仁,前胡,旋复花,百部,大黄,元明粉,桑白皮,象贝,葶苈子,苏子,枳壳,枇杷叶等。热重可参用麻杏甘膏汤(原药)。

2. 驱虫 用:化虫丸加雷丸、榧子、贯众。

3. 补脾养血 用:归脾丸及劳动养血丸(原名白龙丸)。

本病治疗中要抓住早期,能达到通便则较为理想,不仅咳嗽可止,而且往往也可切断本病的进一步发展。本病的咳嗽为皮肤感染后(手足感染为多,初感时有明显瘙痒起疹症状),虫卵成幼虫经呼吸道再入血液所引起,故不能以为咳嗽治愈后即为本病治愈,必需抓住大便虫卵检查,据虫卵的有无而确定下一步治疗,虫入血液后,借血液繁殖而破坏红细胞,此便是黄胖的成因,所以补脾养血之时亦必须伍用杀虫剂。

头 痛

头痛在临床上可见于多种急、慢性疾患中,有时还可成为主症。因为脏腑清阳之气上于头,手足三阳会于头,主一身之阳的督脉亦达巅顶,所以称头为“清阳之府”、“诸阳之会”,脏腑经络发生病变,直接或间接的都可影响头部而产生头痛,所以涉及的疾病比较广泛,现概括为外感、内伤两大类来讨论。

(一) 病因病理

在内、外因中,以风邪、火气最易引起,所谓“火性炎上”,“伤于风者上先受之”,“巅顶之上,惟风可到”。此外,又因内脏虚弱,清气不升,或风湿袭阻,阳气郁滞,也可出现头痛。再则,“脑为髓海”,有余不足,亦是产生本病的因素。

外感头痛,多由坐卧当风,或受寒冒暑而来,其中风邪为痛者多,《内经》有“风气循风府而上,则为脑风”,“新沐中风,则为首风”的记载。临床上有风邪挟寒,阻遏太阳的;有风邪挟热,侵扰清空的;有风邪挟湿,蒙蔽清阳的,均可使脉络气血不畅而产生头痛。外感头痛经久不愈,或素有痰火,复因当风受凉,邪入于脑而为时作时止的慢性病“头风”。又有风湿挟热毒上犯的“雷头风”。

内伤头痛,多因肝、脾、肾三脏病变及气血失调所致。属于肝的:如情志失和,肝失调达,郁而化火;上犯头部;或肝阴不足,肝阳上亢而为头痛;或肝经寒气上逆而致头痛。属于脾的:如饮食失调,脾失健运,痰浊内生,阻遏清阳而为头痛。属于肾的:如肾精不足,髓海空虚而起的头痛;亦有肝、肾阴虚,阳亢而致的头痛。亦有气滞血瘀日久,经隧不通而起的;或因思虑过度,心脾受伤,气血虚损;或因久病、或因失血,致营血不足,

不能上荣于脑而致头痛的。

(二) 辨证施治

应分别外感、内伤，证候虚实，以及注意病程的长短久暂，疼痛的性质部位等方面。一般说：暴病、持续性剧痛多实，外感证多实，痰浊、瘀血多实；久病、病势缓或时发时止者多虚。内伤证多虚，其间每多虚实互见，如阴虚阳亢、正虚邪恋的证候。头痛部位，大体上按经络分布区来定：后太阳，侧少阳，前阳明，巅顶属厥阴、督脉。

1. 外感头痛

(1) 风寒头痛：初起形寒头胀，渐至头痛，伴有后颈板滞，全身关节不舒，口不作渴，脉象浮紧，舌苔薄白。用川芎茶调散（川芎、薄荷、荆芥、防风、白芷、羌活、细辛、甘草）。

(2) 风热头痛：痛时亦有胀感，口渴，咽痛，或面红目赤，溲赤短，苔薄微黄，脉浮数，甚至可头痛如裂，烦渴饮冷，口唇生疮，溲赤，便秘，苔黄舌红，脉滑数。用桑菊饮（桑叶、菊花、薄荷、桔梗、连翘、杏仁、甘草、芦根），重者加石膏、黄芩，或用黄连上清丸（黄连、黄芩、黄柏、山栀、菊花、薄荷、葛根、桔梗、连翘、天花粉、元参、大黄、姜黄、当归、川芎）。

(3) 风邪挟湿：痛时昏胀沉重如裹，四肢困倦，胸脘痞满。用羌活胜湿汤（羌活、独活、防风、藁本、蔓荆子、川芎、甘草）或神术汤（苍术、藁本、川芎、羌活、白芷、甘草、细辛、姜、葱）。偏热加黄芩、黄连。

(4) 头风：时休时作，往往在刮风前痛重，刮风时痛反减轻，正如《内经》云：“首风之状，头面多汗，恶风，当先风一日则病甚，头痛不可以出内，至其风日则病少愈”。恼怒，烦劳，情志失达均可引发，发时痛剧连眉梢，目不欲开，头不能举。用消风散（羌活、荆芥、防风、藁香、厚朴、僵蚕、蝉衣、人参、茯苓、陈

皮、甘草)茶调内服。

(5) 雷头风:头中如雷鸣,外生疙瘩,红肿热痛,并有恶寒,壮热,脉浮数,苔黄腻。用清震汤(升麻、苍术、荷叶);热重加黄芩、黄连;湿痰重加姜半夏、僵蚕。

2. 内伤头痛

(1) 肝阳旺盛:头痛剧烈而胀,耳鸣,心烦,面红,目赤,苔黄,脉弦数。用龙胆泻肝汤(龙胆草、栀子、黄芩、柴胡、生地、车前子、泽泻、当归、木通、甘草);兼有大便秘结,加大黄、元明粉。

(2) 肝风头痛:痛而且眩,不能张目,巅顶如压,筋惕,肉瞤,舌红,脉弦或弦细。用天麻钩藤饮(天麻、钩藤、石决明、山栀、黄芩、牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、茯神)。

肝风而兼血虚:用驯龙汤(当归、生地、白芍、羚羊角、珍珠母、龙齿、菊花、薄荷、桑寄生、钩藤、独活、沉香)。

(3) 肾阴虚:痛而且晕,眼花,腰酸痛,遗泄,舌红苔少,脉细弦。用杞菊地黄汤(生地、山萸肉、丹皮、山药、泽泻、茯苓、枸杞子、菊花)。

(4) 肝经寒痛:痛时头内寒冷,畏风常欲蒙被而卧,面色惨郁青晦,呕吐涎沫,肢冷,脉沉弦或沉紧。四肢末厥冷甚者用当归四逆汤(当归、桂枝、白芍、细辛、木通、甘草、大枣),畏寒而呕吐涎沫甚者用吴茱萸汤(吴茱萸、人参、生姜、枣)加当归、肉桂。

(5) 痰浊上蒙:头痛昏重,或偏于一侧,逢天阴时痛重,胸脘痞满,呕恶痰涎,食欲呆滞,神倦懒言,舌苔白腻,脉滑或兼弦,或濡。用半夏天麻白术汤(半夏、白术、天麻、陈皮、茯苓、甘草)。

痰浊挟热而起者:昏胀如痛,梦多,易烦,心悸,嘈杂,脉滑

或弦，苔黄腻。用温胆汤（竹茹、枳实、半夏、陈皮、茯苓、甘草）加黄芩、黄连或龙胆草。本条与气虚条病机，均为清阳不升于脑，但此为湿邪蒙遏而清阳受阻，故用运脾化湿；气虚条则为中气不足，清阳无力以升，故用升补。

（6）肾虚虚弱：此为髓海不足，督脉空虚；头痛并不甚剧而寒冷，畏寒殊甚，见风如直入脑中，痛亦在头部中间，得热可减，兼有耳鸣，重听，健忘，腰膝酸软，色萎，神倦，脉沉弱或沉细，舌苔淡白。用右归丸（鹿角胶、杞子、菟丝子、熟地、山药、山萸肉、杜仲、当归、附子、肉桂）。

（7）瘀血阻滞：头昏而痛如刺，痛有定处，有头部外伤史，常缠绵不愈，舌质暗紫或有瘀点，脉象滞涩。用通窍活血汤（赤芍、川芎、桃仁、红花、生姜、老葱、麝香、红枣）加白芷、当归。

（8）血虚头痛：头痛且晕，目花，面色少华，心悸，舌淡，脉虚细。用补肝养营汤（生地、当归、白芍、川芎、菊花、陈皮、甘草）。

（9）气虚头痛：头昏痛而有悠忽空洞感，劳则剧，卧则痛减，形寒少华，心悸气短，舌苔薄白，脉多虚软。用补中益气汤（黄芪、党参、白术、陈皮、升麻、柴胡、甘草、当归、姜、枣）；如虚而挟痰，用六君子汤（党参、白术、茯苓、甘草、半夏、陈皮）。

中 风

中风以卒然仆倒，不省人事，或半身不遂，意识欠清，或口眼喎斜，舌强言蹇为主症；轻者亦有不经昏仆而突然口眼喎斜或半身不遂者。

中风最早见于《内经》，并有偏枯、喎痺、喎斜等症状论述，《金匱》以经脉空虚、外风入中为主要原因，这是后来“外风”之

说的主要依据,并以中络、中经、中腑、中脏的区别来论病位及病情轻重,之后在《千金》、《外台》、《济生方》等书中,均以内虚而外风入中立论。金、元以后,有了新的论述,刘河间主火,李东垣主气,朱丹溪主痰,认为这是中风原因,后世称此为“类中风”(明·昆山王履提出),而将《金匱》所提的原因为“真中风”。经此之后,到赵养葵、张景岳等,逐渐形成了“内风”学说,认为中风不是外来风邪所引起,而是本气自病。经朱丹溪到缪仲淳,根据地区气候的不同,更有西北多外风、多真中,东南多内风、多类中的说法。到叶天士确定中风是由体内阳气变动,产生内风引起,认为其变动在肝,其原在肾,王清任提出了瘀血学说。近世张山雷将《内经》“气之与血并走于上,则为大厥”的论述,作为中风病理。

历史上各家不同见解的矛盾,使中风学说不断发展和丰富起来。

一、病因病理

本病的发生,虽然症状骤作,但有一定的远期病程,多与年龄、体质、情绪、饮食有关,《内经》有“偏枯痿厥,肥贵入则苶梁之疾也”的记载,李东垣认为“凡人年逾四旬,气衰之际,或忧喜忿怒,伤其气者,多有此证,壮岁之时无有也,若肥盛者间亦有之,形盛气衰之故也”,此种认识,虽不尽然,但均有一定道理。

中风的病因,可分为外风、内风、火盛、湿痰、气虚、血瘀等方面;这些因素,在临床上可以互见,如外风之所以能中,有气虚正虚的内因,以及内风之可以化火,气虚之可生湿痰等。总之本病的特点是本虚标实,虚的方面是气、阴、血,实的方面是风、火、痰、瘀,因而其病理方面,可以概括为:正虚风邪外入;

心肝阳亢，肾水不足内风暗动；痰浊郁胃；气虚血瘀等四个方面。其中外风的因素是最早提出的，随着历史的发展，已经不在中风中占主要地位，但在口眼喎斜和半身不遂方面，仍可依据这一理论进行治疗，故仍列入，兹分述如下：

1. 正虚风邪外入：由于正气不足，经脉空虚，风邪入中，使经络气血逆乱，而致喎斜不遂，肌肤重着不仁，进而可以循经入于脏腑，而致神志不清，痞厥失语。

2. 心肝阳亢，肾阴不足。

(1) 火盛：平日动作起居、饮食失宜，心火暴甚，肾水虚衰不能制火，形成阳实阴虚，热邪怫郁，气血并奔，而致心神昏冒，筋骨不用。

(2) 内风：平素肝肾阴虚，或长期恼怒忧思，五志过极，消烁阴血，使肝阳虚亢，血燥生热，风阳上升，窍络阻塞而致中风。

以上两者，均为阴不足而阳有余现象，要点在于前者为阳有余，后者为阴不足，一对矛盾面的主次有所不同。

3. 痰浊郁胃：平时嗜酒食肥，痰湿内生，郁而化热，热极生风，风阳挟痰挟湿，上腾而蒙蔽清窍，横窜而阻塞经络，致气血逆乱，阴阳失调而为中风偏枯。

4. 瘀血：可挟见于中风各期中，朱丹溪说：“半身不遂，大半多痰，在左属死血、瘀血，在右属有热并气虚。”王清任以气虚血瘀立论，认为气虚不能运血，致使经络间气血俱见瘀阻，清气失于上而神志不清，气血瘀于身而肢体不遂，用补阳还伍汤。今天看来，左右之分未必中肯，补阳还伍汤的使用也必需辨证。中风当昏厥之时，应以救脱、开闭、回苏等法急救，到恢复阶段，审其确为气虚血瘀，而无风阳痰热见症，用本方才比较恰当。

二、辨证施治

辨证要注意三个方面：

辨病位深浅：分清中脏、中腑、中经、中络；中脏腑者病邪深，中经络者病邪浅。

辨邪正虚实：辨清脱证、闭证、中脏腑中的闭证及中经络属实，中脏腑的脱证属虚。

辨标本主次：风、火、痰三者偏胜为标。精、气、阴血不足为本，一般在暴中昏迷之时先辨闭证、脱证，神志苏醒后再分中腑或中经络。

（一）中脏

突然昏倒，昏睡不省人事，发热或不发热，兼有半身不遂，口眼歪斜，口流涎沫。此时要分闭、脱，闭中又须分阳闭、阴闭。

1. 阳闭：昏不识人，牙关紧闭，两手握拳，肢体拘急，面赤气粗，鼾睡，痰声重浊，身热无汗，二便闭结，苔黄或腻，舌红或卷，脉弦滑数。宜熄风清火，豁痰开窍。用羚羊钩藤汤（羚羊角、钩藤、桑叶、菊花、生地、白芍、川贝母、竹茹、茯神、甘草），另用至宝丹或安宫牛黄丸化服。

2. 阴闭：昏仆牙紧，握拳，痰涎壅盛，静而不烦，面白唇紫，四肢欠温，苔白腻，脉沉滑。宜化痰熄风温开。用导痰汤（制半夏、陈皮、茯苓、甘草、枳实、制南星）加天麻、僵蚕、石菖蒲、全虫，另服苏合香丸。

3. 脱证：昏迷鼾睡，目合口开，手撒汗多，溲便失禁，面白，呼吸微弱，舌淡苔白，脉细数或沉微欲绝。若面色见红，脉浮大无根，为虚阳浮越重危证。宜救阴回阳固脱。回阳固脱用参附汤（人参、附子）加龙骨、牡蛎、五味子。救阴固脱用地黄饮子（熟地、巴戟天、山萸肉、肉苁蓉、石斛、麦冬、官桂、白茯苓、

制附子、石菖蒲、远志、五味子)加磁石。

脱证属虚,元气衰微欲脱,忌用牛黄、全宝、苏合丸等开窍药。

(二) 中腑

由中脏转出,或由中经络转入;出者为轻、入者为重,亦有昏仆自苏醒后出现的。故中腑证与中脏、中经,均不能截然分开。辨证要点,在于神智、脉舌方面,以神智呆滞或昏乱,语言蹇涩或失语,半身瘫痪,二便失禁或闭结,舌体颤动或痿软无力、或强木为主症,或则兼有口眼喎斜、痰盛等症,脉弦数或浮大、或沉细涩,苔黄或白、或腻、或腐,舌红。现分述如下:

1. 肝阳旺盛者:脉弦数有力,舌红苔少或黄。宜平肝熄风。用羚羊角骨汤(羚羊角骨、钩藤、石决明、白芍、地龙、天竺黄、茯苓、杜仲、牛膝)。

2. 痰盛者:脉弦滑,舌苔黄腻或白腻。宜熄风豁痰,用导痰汤加黄芩、僵蚕、地龙、竹沥。

3. 气虚者:脉多浮大,或大而无力的,舌胖而有齿痕,兼见肢体酸软、不用或麻木,气短神疲。宜益气通络。用六君子汤(党参、白术、茯苓、甘草、半夏、陈皮)加菖蒲、桑寄生。

兼有瘀血则舌见瘀黯。宜益气化痰。用补阳还伍汤(黄芪、赤芍、川芎、当归尾、地龙、桃仁、红花)。

4. 阴虚血亏者:脉多沉细涩,舌红苔少,兼见肢体萎软,筋惕肉瞤。宜养血熄风,补肝益肾。用大定风珠(白芍、阿胶、龟版、生地、麻仁、五味子、牡蛎、麦冬、炙甘草、鳖甲、鸡子黄)或地黄饮子出入。

(三) 中经络

初起或有一时性意识欠清,或清醒而见口眼歪斜,颜面及四肢麻木、沉重,或拘急抽搐,头眩而重,口多痰涎,舌欠灵活,

或兼见寒热，或一侧、或一肢不遂，苔白腻或薄白，脉弦滑或弦细。

中经中络之间，是病情轻重之分，大体以一侧或一肢不遂，或沉重不用者为中经，余症可以兼见，经络之间，治法相同，故合而讨论。

1. 风痰重者：脉浮滑或数，苔多白腻。宜祛风豁痰，养血通络。用大秦芩汤（秦芩、石膏、甘草、川芎、当归、芍药、羌活、独活、防风、黄芩、白芷、生地黄、白术、茯苓、细辛）。

2. 阴虚阳亢者：脉弦数，舌红苔少，头昏痛较重。宜平肝滋阴潜阳。用天麻钩藤饮（天麻、钩藤、石决明、牛膝、杜仲、黄芩、栀子、益母草、桑寄生、夜交藤、茯神）加首乌。

中风一证，方药甚繁；如大便便秘之用三化汤（大黄、厚朴、枳实、羌活）。口眼喎斜之用牵正散（白附子、白僵蚕、全虫）。语言蹇涩之用资寿解语汤（羚羊角、桂枝、羌活、甘草、防风、炮附子、酸枣仁、天麻）。后期肢体偏枯之用大活络丹、小活络丹，均可随证参酌。至于辛温开散之品，自内风之说起而用者渐少，此类药物，自当审慎。

中风治疗，无论在暴中或恢复期，均宜与针灸共同治疗，尤其是恢复期和中经络证方面。针灸而外更可采用按摩，收效较单服药物为理想。

（1977年苏州地区中医提高班讲稿）

对脾的认识

脏象学说在中医学中起到基础的作用，但较之近代医学的脏器组织，却是同名异实的；这一问题的存在，是形成中医

学识和西医学识不同的原因之一，现试就脾来进行探求。

（一）脾主运化，是消化吸收功能的主持

脾是中医学中五脏之一，与其它心、肺、肝、肾四脏一样，都具有“藏精气而不泻”的特点，但它又有与其它四脏不同之处，《素问·六节脏象论》中说：“脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者，仓廪之本，营之居也，名曰器，能化糟粕而转味入出者也。”《素问·灵兰秘典论》也说：“脾、胃者，仓廪之官，五味出焉”，这都说明脾与胃的作用是在于消化功能方面的，所谓“仓廪之本”或“仓廪之官”，都是指出消化功能作用的重要性的。

脾与胃在消化作用上是相辅相成的，《素问·经脉别论》中说：“饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺。”《素问·太阴阳明论》中说：“四肢皆禀气于胃而不得迳至（据《太素》互移），必因于脾，乃得稟也”。又说：“足太阴者三阴也，其脉贯胃属脾络噤，故太阴为之（为胃——据明·吴昆山注）行气于三阴，阳明（指胃）者表也，五脏六腑之海也，亦为之（为脾，注同上）行气于三阳”。《素问·奇病论》中也说：“五味入口，藏于胃，脾为之行其精气”，这都是指胃所摄入的饮食，经消化后的养料，必须经过脾的作用才能输送到其它脏器和全身；所以《素问·刺禁论》中概括说：“脾为之使，胃为之市”，所谓“市”，是指饮食入于胃，有如货物之集于市，所谓“使”，是指脾为胃“行其精气”，有如使者。正由于脾对消化功能的这种重要作用，所以《内经》在某些篇章中简略去胃而直接说“脾主四肢”（《素问·太阴阳明论》）、“脾主肌肉”（《素问·五脏生成篇》、《素问·宣明五气》等篇），或者说“谷气通于脾”（《素问·阴阳应象大论》）等等，这并不是忘掉了胃，而是用脾概括了胃。反之，有些《内经》章节中，又用胃来概括脾，如《灵枢·经脉篇》说：“谷入于胃，脉道以通，气血乃行”，《灵枢·营气篇》说：

“谷入于胃，乃传之肺”，《灵枢·营卫生会篇》说：“谷入于胃，以传与肺”，《灵枢·五味篇》说：“胃者五脏六腑之海也，水谷皆入于胃，五脏六腑皆禀气于胃”等等，这就因为脾与胃两者的作用是相辅相成的。

由于脾是消化吸收功能的主持，所以当脾有病变时，都有消化道症状的出现；如“五脏生成篇”、“诊要经终论”、“脏气法时论”、“热论”、“刺热篇”、“厥论”、“四时刺逆从论”、“标本病传论”、“本神篇”、“终始篇”、“经脉篇”、“刺疟论”、“五邪篇”、“痹论”等《内经》篇章关于脾病的记载中，都有腹胀、呕逆、肠鸣以及泄泻等消化道的症状；《灵枢·经脉篇》在脾病中，更系统地记载了“食则呕，胃脘痛，腹胀”，“食不下”，“溏瘕泄”等消化道症状。后来的《难经》时“脾泄”的症状，也有“腹胀满，泄注，食即呕吐逆”的记录。

据此，可以这样认为：脾是消化功能的主持，并且在这方面更高于胃的作用。这一作用用来与近代医学脏器中的脾对照，很显然两者是不能等同的。

（二）脾是气血之源

脾既是消化吸收功能的主持，如果消化吸收不良，必然影响到机体的正常营养需求，从而削弱机体的功能，《内经》对“脾主四肢”的关系有一段病理性的描述：“今脾不能为胃行其津液，四肢不等禀水谷气，气日以衰，脉道不利，筋骨肌肉皆无气以生，故不用焉”，足以说明此理；“脾主肌肉”的关系也是如此。

《内经》以气、血、津液等作为营养物质，认为均来源于水谷，是通过胃的摄纳、脾的运化而输送到全身的，如《灵枢·营卫生会篇》说：“人受气于谷，谷入于胃，以传与肺，五脏六腑皆以受气，其清者为营，浊者为卫，营行脉中，卫行脉外，周营不

已”，又说：“中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸精液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身，莫贵于此，故得独行于经隧，命曰营气。”《灵枢·邪客篇》说：“五谷入于胃也，其糟粕、津液、宗气分为三隧，故宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉而行呼吸焉；营气者，泌其津液，注之于脉，化以为血，以荣四末，内注五脏六腑，……卫气者，出其悍气之慄疾而先行于四末分肉皮肤之间而不休者也”（以上为三隧之二，宗气为一隧，营卫均出于津液为一隧，另一隧为糟粕，“俱下于大肠”者，此节未及），《灵枢·决气篇》亦说：“五谷与胃，为六气（精、气、津、液、血、脉）之大海”，这都说明了脾胃功能对营、卫、气、血等营养物质生成的关系及其重要性，所以后人有了“脾胃为后天之本”和“人以胃气为本”的说法。据此，可以清楚：脾（包括胃）是气血之源，中医有“脾统血”的说法，就是从血的角度来概括脾的作用的。也就是《素问·玉机真脏论》中“脾脉者……孤脏以灌四旁者也”的道理所在。

正因为脾胃通过气、血、津液，可以影响到整个机体，所以《素问·通评虚实论》说：“头痛耳鸣，九窍不利，肠胃之所生病也。”李东垣对此有明确的解释，说是“九窍者五脏主之，五脏皆得胃气乃能通利”，“脾胃一伤，五乱互作”，李氏更扩大到“气或乖错，人何以生？此病从脾胃生者四也”，这也是《灵枢·本神篇》“脾虚则四肢不用，五脏不安”之义。这些记载，都可从病理的角度来反证或旁证脾是气血之源的。但在脾的这一功能方面，与近代医学脏器中脾的造血作用尚不能等同，因为脾是气血之源，是就营养来源这点说的，而真正的造血功能，《内经》中并未说清；但不属于脾这点，《内经》中是涉及的，《灵枢·营卫生会篇》说脾胃在“蒸津液，化其精微”后，要“上注于肺脉乃化而为血”，《灵枢·邪客篇》也说要“注之于脉”后才“化

以为血”，这说明“精微”尚只是血液的前身，而脾只是起到“取汁”、“蒸津液”、“化精微”的作用和将这些血液的原料输送到造血有关的脏器方面去。血的生成当在脾这一作用之后。“气”是由血这一物质通过对脏器，包括脾本身和其它脏器的营养而产生的功能；依据物质产生功能的原理——在中医学中，如“宗气”的心肺功能等——在脾产生“气”的作用上是易于清楚的，其来源同样是“水谷”。

（三）脾有调节体内水液的作用

脾既然支配着水饮的运化，也就必然要受到水饮的影响，《素问·经脉别论》中“饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行”的记载，是指水饮在脾正常运化下的情况。《素问·宣明五气篇》中“脾恶湿”的记载，是指脾功能不足以运化水饮时为水湿所困的情况。这种脾既主运化水饮而又“恶湿”的情况，是一个事物运动的两个方面；就其“恶湿”而言，其关键在于脾功能与所要运化的水饮的双方比重情况，或者是水饮超过了脾的正常功能，或者是脾功能的低落，致不足以运化机体日常需求的水饮，两者均可出现“恶湿”的情况；但其主要矛盾面是截然不同的，前者责之于水饮之多，后者责之于脾功能低下。脾的能否正常运化水和饮，就是对体内水液的能否调节。根据这一情况，所以中医历来将多种疾病与脾联系起来，举例言之如下：

1. 咳嗽、痰饮：由于脾对水饮“上归于肺”的功能失常，输送过多或不纯，超过了肺“下输膀胱”的正常作用，或者如《素问·咳论》说的：“其寒饮食入胃，从肺脉上注于肺，则肺寒”，使肺受到刺激，所谓“形寒饮冷则伤肺”而形成“痰饮”作咳；或者脾胃有热，夹杂于津液中一起“上注于肺”，所谓“湿热蒸肺”而作咳，所以后人有了“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”之说。

2. 泄泻：如果“脾不能为胃行其津液”，一方面可以因四肢不得禀水谷之气而形成“痿病”，一方面留在胃中的津液势必要与糟粕一起“俱下于大肠”，这就成为泄泻，正如《素问·脏气法时论》所说的“脾病者……虚则腹满肠鸣，飧泄，食不化”，《难经·五十七难》也说：“脾泄者，腹胀满，泄注”。

3. 水肿：在脾的运化水饮功能不足情况下，再加以肺、肾功能不足，使水津不能“四布”，或虽能“四布”而不能“五经并行、下输膀胱”，均可出现水肿，如《素问·阴阳别论》说：“三阴结，谓之水”，《灵枢·本神篇》说：“脾气……实则胀满，经洩不利”就是指脾、或肺脾功能低下，不能运化水湿而致的水肿。其它如《素问·水热穴论》说：“肾者胃之关也，关门不利，故聚水而从其类也”，《素问·咳论》中对咳嗽引起的面部水肿，也认为是“此皆聚于胃，关于肺”，这些记载表明，虽然某些水肿并不以脾胃为主因，但尚与脾胃有一定关联。所以中医历来在治疗水肿中强调脾的作用，尤其脾的阳运作用。

以上就脾对水液运化不足所致病的皎皎者而言，其它如由于水湿失于正常运化而致的消化不良，中医治疗时同样要求责之于脾。这一脾对机体水液的调节作用，与近代医学脏器的脾来对照，也是不能等同的。

（四）小结

以上从中医古典文献中探索了脾功能的三个方面。这三个方面，大致上已概括了脾的主要功能。据此，可以归纳为：

1. 在脾的三方面功能中，运化（即消化吸收）是主要的，因为只有消化吸收功能旺盛以后，才可能产生气、血、津液，而对体内水液的调节，是在脾对气、血、津液的输送过程中同时完成的，是一个过程的两个方面；并且，消化吸收的作用，又需要有气、血、津液的产生和对水液的调节来作为其去路而始能

完成；实质上这三个方面是脾功能的一个整体，仅仅是运化旺盛与否居于支配地位罢了。

2. 当这些功能出现异常时，或者是消化吸收不良，或者是输送异常，都可出现病理状态。因此，前面所引的病理，都是脾功能失常所引起的（文中所及，以不足者为主，谈太过的少；谈内因的多，谈外邪的少，是由于重点要理解脾的功能之故）。

3. 既然脾功能居于消化吸收的主持地位，那用以对照近代脏器功能时，就只能相类于消化系统方面，而不能相等于脾的实质，虽然《灵枢·本神篇》有脾大、脾小、脾高、脾下的记载，《难经·四十二难》也有“脾重二斤四两，扁广三寸，长五寸，有散膏半斤”等关于实质性的记载，但毕竟与近代医学脏器中的脾的功能是不同的，因此就不能认为可相等于近代脏器中的脾，这一点是确定的。实际上中医学中的脏象，不同于近代医学中的脏器这一点，不仅表现于脾，在其它心、肺、肝、肾四脏方面莫不如此；如果一定要“对号入座”，就必然使学习者“如坠五里雾中”；造成如此的原因是很多的：中医理论受历史的限制，参与着哲学的解释是其一，而西方医学在进入我国时的翻译上的出入也是其一，所以我们只有先正确认识中医学中的真实所指，再去对照近代医学中的脏器作用和病理；只应该对照，不强求等于，只有这样，才能促进中西医结合在正确的道路上前进。

（本文发表于1977年9月无锡县学术交流会）

脾胃病的诊治体会

一、抓 整 体

脾胃病是覆盖面较宽的体系性疾病群。如何理解脾胃病的内涵,由于中医学与西医学是不同的体系,对脾胃的概念,尤其是脾的概念并不相同,如果将脾胃病局限于胃和脾的器质或功能性疾病,则将易导致治疗思路的混乱和辨证用药的束缚,从而影响疗效;我认为脾胃病的诊疗,应按中医学脾胃理论,从脾胃的生理、病理及其与其他脏腑的整体关系等各个方面去思考。脾胃共同运化水谷精微,完成“营出于中焦”的作用,使脏腑、肌肉、四肢“皆禀气于脾胃”而为“后天之本”,故凡影响脾胃升、降、纳、泄作用者,不论其为外邪、内因或其他脏腑影响所引起的,是脾胃病的一大类;由脾胃疾病而影响到其他脏腑、肢体的疾病而能通过脾胃进行治疗收效的,亦可视为脾胃病的范围,是脾胃病的另一大类。兹分述如下:

一类如:嗳气、呃逆、呕恶、痞满、脘痛、腹痛、吞酸、吐酸、嘈杂、纳少、纳呆、谷疸(食亦)、消谷善饥(中消)、呕血等。

另一类如:泄泻、便秘、便血、水肿、黄疸、虚劳、崩漏、口疮、口臭、龈肿、脚气、痰饮、痿证等。此类病中,虽有些并不与脾胃直接有关,但在有“清气在下,则生飧泄”的泄泻;“脾不统血”而出现便血、崩漏,“脾不下荫”而便秘,“脾不化湿”而出现水肿、痰饮,“湿热阻滞”而见黄疸、痿证、脚气,脾胃郁热而见口疮、口臭,以及“脾不健运”而致虚劳等病机时均可通过脾胃治疗,或有其特定的通过脾胃治疗之阶段。此类病中,近时仅泄泻之慢性者在脾胃病专业范围,其余病种均大多分散在各

科诊治,此间所以提及,在于扩充脾胃病的相关面及辨证思路。

二、辨治要点

1. 辨病机 首先应辨标本先后,如:脾胃先病而后痰、湿、食阻或痰、湿、食阻而后影响脾胃消化功能;肝旺克脾抑或脾虚肝乘;先气后血则如暴怒动血,先血后气则如血去脾虚;脾病及胃者如脾约,或脾不化湿而水湿伤胃,胃病及脾者如胃痛久而纳少,延及脾虚。他如脾胃病久延及心肺,而肺失宣肃亦可影响脾运;肾阳虚可致脾失温照而运弱,而脾运弱亦可致肾精不足等等。并且在标本先后中,既有虚实先后之分,更有先后重复互为因果及寒热错杂等情。其次是注意情志、体质,如:恚怒可以伤肝,忧思可以伤脾,悲则气消、恐则气下,凡此均可影响脾胃功能而成为致病因素。在体质上,肥人湿胜,湿胜则气易虚;瘦人多火,多火则易肝旺,亦为临床用药所需顾及之点。

2. 辨舌、脉、症 舌色方面:除绛热、紫瘀等之外,要注意嫩红多阴虚津亏,淡红多阳虚气虚。舌体方面:瘦者多热多阴虚,胖者需据舌色而分虚实;舌边齿痕不能一概视为脾虚,其胖而色赤体充、为脾胃之热,惟胖而体软色淡者属脾虚;舌体软弱多虚,充实多实,其痿瘪、卷缩之舌,脾胃病中不易见到,见之则若非精气之耗夺,必经气之欲绝。苔色及厚薄方面:除白湿、黄热等常情外,要注意苔现部位,抽心在中多脾胃阴伤,若苔厚中抽为食滞或痰浊阻滞脾胃气分,舌根大片光剥,多属肾精不足;舌面光而滑润,多为痰饮不化,不能认作阴虚。惟无苔而湿、或光而色绛者为脾胃津液、阴分损伤,其程度远甚于抽心;近时慢性胃炎之舌苔,近30%可于舌中脾胃区见到或

黄、或白、或膩、或糙之紧贴肯苔，且化之甚难。

脉：脉象随证、随情绪而变，其关乎脾胃本病而多见的为滑、弦、软三者，滑主痰、湿、食滞；弦主肝气；软主脾胃本虚。其中弦脉之见于右三部者，往往新有悲怒，脘腹痛之剧者，亦见弦脉。近时所称之胆囊炎，剧时往往右三部见弦细脉，加以丘墟穴压痛明显，常无通形。

脘痛：常规以空腹痛、喜按为虚，夜间痛多虚多瘀，食后面痛多热多实，定时刺痛多瘀，肝气下注可见右少腹掣痛，需慎细区别于阑尾炎。胃溃疡之痛，多见于空腹，十二指肠溃疡则夜间空腹时亦作，两者均得食即缓解，所以可有脾虚之机存乎其间。

吞酸、吐酸、嘈杂：三者多为肝侮脾胃而“曲直作酸”。但有虚实之分，肝旺者酸重；脾虚者酸轻，或竟为口中多液之吞酸；亦有饮病湿郁于胃而来者。证之临床，单纯之胃溃疡多吐酸嘈杂，单纯之十二指肠溃疡则无。

暖气、呃逆：二者之分，在呃逆多虚寒或暴寒阻遏中阳；暖为食滞阻于气机，但有虚有实，实者口气浊，食后多作，虚者口气清而平时亦作。

痞胀满：“浊气在上则生膜胀”，病涉肝胆，胸胁苦满，能食而胀者脾病，日晡满胀者脾病。食后即胀者胃病，纳少或不能纳而胀者脾胃俱病，此均为气滞之证，惟胀而实者为有积滞。慢性胃炎大多食后即胀，稍重者日晡亦满胀殊甚。

大小便：便溏多脾虚，便干或秘多热，先鞭后溏多肠热脾虚，便干而次多亦然，但有脾不下陷之机，若脾胃气滞，往往使虽溏而不爽。常规以溲赤多热，溲清长多虚，而溲浊臭重者，多为湿热或痰滞。

三、常用治法方药(脾胃本病为主)

引起脾胃病的外来因素,多为饮食冷热、五味不调、久饥暴食,内因多为情志失于冲和,或脏腑相易,以致气机失宜,湿热痰食郁滞,本虚标实,寒热错杂,或单见一端,或数端兼见,而以兼见者为多,下述治法方药,不过就其一隅而言。

(一) 治法

和胃利气法:用于脘腹痞满,暖气吐酸等症;常用方如越鞠丸、二陈汤、木香顺气丸等加减。

健脾和胃法:用于脾胃虚弱,纳少便溏,脘腹胀满者;常用香砂六君子汤、中满分消丸加减。

健脾化湿法:用于湿阻气滞、纳呆痞满,暖气吞酸、便溏、苔白腻者;常用苓桂术甘汤、平胃散加减。湿痰用导痰汤,热痰用清气化痰丸加减。

健脾利水法:用于脾虚气不化水,腹胀肢肿瘦短者;宜五苓散、实脾饮出入。

健脾益气法:用于纳少神倦,色萎气短畏寒等症;常用参苓白术散、四君子汤、补中益气汤加减。

疏肝理气法:用于胸脘痞满,胁、肋、少腹胀痛,暖气等症;常用柴胡疏肝散加减,越鞠丸亦佳,兼肝郁血虚用逍遥散出入。

益气补血法:脾胃病延久气血两虚,心脾俱见不足;用当归补血汤、归脾汤、八珍汤。

理气和血法:用于脘痛如刺有瘀血证者;宜丹参饮、逍遥散去术加芍汤出入,瘀重者用复元活血汤加减。

其他如清热止血、化瘀止血、益气止血等法之用于出血,温阳利水之用于脾肾阳虚水肿,及肝阴、胃阴受损时之用酸甘

化阴法等，在脾胃病中亦时可用到。宜注意者是：

1. 脾胃气分病中，初起气机郁滞，可用理气法，迨至气机壅滞不下则用降气之品，破气药多用于壅滞日久，气结不散之时；理、降、破之病情轻重不同，选药之和缓迅猛层次亦不同。若久延至气由不运而虚，则药品多选甘温补气，自与疏散通利之品更有不同，但补散之间，往往相寓使用，所谓“有制之师”，惟当求其主次分明，针对性强。

2. 胃病病机中有胃气滞、胃运弱、胃阴虚之不同；气滞运弱，药多辛通甘温，迨至胃阴不足，则辛燥之品在所不宜，且多相径庭，自当酸甘化阴之品如益胃汤等，若气机仍郁，可选用香而不燥之品，如香橼、佛手、梅花等。

3. 肝气犯脾(胃)中，其脾胃虚而肝来侮者，自宜主治脾胃；其肝郁肝旺者，郁之轻者舒肝、郁之重者疏肝；郁而热者清肝、郁而亢盛者平肝。清肝则如胆草、栀子；平肝则如石决明、龙齿之属；肝阳之亢由肝阴不足者，轻则柔肝、重者养肝，柔养之药多养血补血之品，此盖原于“肝藏血”而来，所藏不足，阳自浮动，此时升疏肝气之品，自宜慎用，用亦当居佐、使之位，否则弊在耗阴；尚有肝气虚寒一种，在脾胃病中常与脾胃虚寒同见，如“吴茱萸汤”证，选药自与阴柔之味迥别。

脾胃病中用药，《素问·脏气法时论》有“脾苦湿，急食苦以燥之”，“脾欲缓，急食甘以缓之，用苦泻之，甘补之”，“肝苦急，急食甘以缓之”，“肝欲散，急食辛以散之，用辛补之，酸泻之”等，此苦、辛、酸之味中用于泻者多峻而重，用于补者多缓而轻；而胃主和降，属阳土燥金，热多而恶寒、恶燥等本质，亦为指导用药原则，故均宜中病即止，太过则寒亦可以化热，甘亦可以中满。

1. 脘痛

- (1) 热：延胡、川楝子。
- (2) 寒：甘草、党参、白术、干姜。
- (3) 虚：党参、黄芪、白芍、甘草。
- (4) 气滞：香附、木香、枳壳、砂仁。
- (5) 血瘀：丹参、三七。

2. 呕吐

- (1) 热：黄连、枳实、黄芩、竹茹、半夏。
 - (2) 寒：干姜、半夏、丁香。
- ## 3. 呃逆：丁香、柿蒂、刀豆、降香。
- ## 4. 伤食：神曲、山楂、麦芽、莱菔子。

5. 便秘

- (1) 燥：麻仁、瓜蒌、郁李仁。
- (2) 实：番泻叶、玄明粉、大黄。
- (3) 虚：苁蓉、柏子仁、生首乌。

6. 泄泻

- (1) 寒：煨姜、肉果、补骨脂。
- (2) 热：黄连、白头翁、秦皮。

7. 吐酸：

- (1) 肝旺：黄连、吴萸、瓦楞子、复花。
- (2) 虚：乌贼骨、白术、茯苓。

8. 虚胖

- (1) 益脾：党参、白术、生黄芪。
- (2) 利水：冬瓜皮、茯苓皮、泽泻、车前草、生姜皮、大腹

皮。

9. 出血

- (1) 热：十灰散、仙鹤草、茅根。
- (2) 瘀：三七粉、云南白药、藕节、失笑散。

(3) 虚：黄芪、阿胶、炮姜炭、血余炭。

脾胃病治疗中，近时以溃疡之愈合、慢性萎缩性胃炎之生复难度较高；苦寒药对幽门弯曲杆菌之作用，益气养血药对免疫功能的提高与对组织的生复，均在国内引起重视，遣方用药中可以参考。笔者于70年代初，参考外科生肌愈合疮口用药原则用黄芪、党参、白芍、生甘草、元胡、白芨、三七、煅瓦楞子、川楝子、象贝母等制成散剂，施治于溃疡病疼痛控制后，观察其愈合溃疡作用：16例能取得复查钡餐患者中，10例愈合，3例溃疡缩小，2例控制，其愈合期最短者27天，最长者6个月（均各1例），绝大多数在2个月左右愈合。数年前于房山中医院按此意商量改组处方，用丹参、生黄芪、川楝子、三七、虎杖等为散剂，用于观察慢性胃炎，1989年由万连元院长总结40例，总有效率达70⁺%，病理切片检验有效率达53⁺%。由此可知中医学中健脾益气，养血生肌理论对溃疡的修复和胃粘膜的生长是有作用的。笔者又据《内经》苦、辛、甘、酸原则，对萎缩性胃炎无重大热滞而胃酸缺乏患者，用仲师乌梅丸方变化，控制临床腹胀，亦每收效而且持久，此方舍开蛔厥、寒厥框架，从另外角度看，具有辛开苦降、酸甘化阴、建中补虚等作用，运用于寒热错杂而正虚之病证，从近代药理论，亦多符合于萎缩性胃炎及胃酸缺乏之机契，惟方中附、桂、姜、椒之辛、连、柏之苦当以适事为度。

四、调护要点

调护是患者配合医疗所必须的措施，但医者又必须主动关切，此中有“治未病”的因素，脾胃病形成的主要因素，不外情志、饮食、起居三方面的违理，而恰又关系到疗效，所以必须谆嘱患者要情绪乐观，忌恚怒、忧思，饮食要有规律，忌暴饮暴

食、久饥过饱，忌酒辣油腻、生冷硬食，起居要寒温适时，生活有序。

(本文压缩后收入《北京医学文库·中医脾胃学说应用研究》。)

表证辨治三要

六淫之邪中人，因四时之异而邪亦不同，春多风而夏暑热，长夏多湿，秋则温燥、寒燥，冬则以寒为主，此系古人论述甚详者，尤以温病学兴起以来，严其区界，详其兼挟，医之处方遣药，当随邪之不同而不同，始克有效。然近十数年来，有执一方以治四时外感者，或则银翘，或则麻杏甘膏，各承一学，不求“必先其所因”，遂至胶柱鼓瑟而效逊，即药肆中之成药亦复如是，往往刊以“治四时感冒”之说明。如午时茶等，此非中医药之不效，学不逮为其故，求多销牟利亦为其故。且邪之中人，尤有须辨之另一层在：虽诸邪各随所旺之季而甚，亦多有相杂相挟者，如风之可挟寒、挟湿，热杂之则可为风热；湿邪之可以挟暑、挟寒、挟热；暑邪固为热、湿相兼而成，然其间有两者之偏重偏轻；燥邪之挟热者为温燥，挟寒者为凉燥、寒燥，如此等等，用药自当先定为主之药，更宜辨其所挟而佐以另药，且即使所感为单一之邪，亦有轻有重，着有兼邪，则主、挟之间有轻重，所挟之邪亦有轻重，于此种种轻重多寡之间，用药配伍尤须随宜酌定矣。

表邪初作时率多恶寒，然恶寒之时有长有短，有重有轻，其恶寒甚而为时久者，始可计其为寒邪，若暑月之寒暑症，虽亦恶寒而微，往往微感毛发耸然、肌肤凛寒即渐发热。另有一

种恶寒，虽在夏末、秋初，而恶寒特甚至战慄，旋壮热，旋汗出热退，是则往往为疟疾，是症近已难见矣。另一种恶寒虽剧烈，迨寒战过而四肢恒寒，畏缩欲暖裹，至一日二日始得解，然其发热则于肢寒时已见矣，此类证多表示病情之重，往往为感冒以外之其它热病或传染病，如伤寒、肺炎、猩红热、麻疹等之初起。至如常人而恒觉肢体不温，背脊四末时有萧索之感，是则气虚阳不足而然，非外邪也。恶寒、恶风之间，可辨寒邪、风邪，然恶寒者大抵都恶风，其区别在于无风而亦寒慄者为恶寒，见风而始寒慄者为恶风，此为就恶寒、恶风之临床界线言；而于患者自身之感觉，则恶风之重者即恶寒，恶寒之轻者即恶风也；它如暑、湿、燥、火诸邪初感时亦多恶风，第轻而短暂；火邪中之中热、中暈，当其夺汗已后，无汗之时、神昏之前，患者亦有恶寒，惟其轻，或不及言而已昏，或不甚留意而忽于口诉，他人固无从知矣。

表邪之有汗无汗情况，大都与恶寒恶风相参差，或见后于恶风恶寒，或恶风时已间有烘热、濺然汗出，汗敛后复见恶风者，此正为桂枝汤证之“发热，汗出，恶风”时之“啬啬恶寒，渐渐恶风，翕翕发热”证也，此盖正与邪争，已渐化热之故，若至阵阵汗出，但热不寒（风）则邪已全离乎卫而入气分矣，惟其当恶寒（风）之初，甚剧之时，则必然无汗；有汗无汗之辨，不宜仅据患者口述，医者必须验之于肤，肤之虽热而润者已属有汗，肤之灼燥者始可定为无汗，且需一日数切，盖濺然汗出与恶风相兼之患者，当其恶风时自是无汗，濺然时始可见汗形或肤润也；又冬日严寒，腠理致密，虽服发汗之药，亦不能必期其汗出淋漓，但得肤润，便属邪已透表，若必欲求其许多，正气势必为伤；夫表邪之与汗否，其用有三：一就病势言，无汗为病邪在卫，有汗则邪在卫、气之间，或邪入气分。二就治法言，汗为治

病泄邪之所求，无汗者在卫，“在卫汗之可也”；有汗已及气，“到气才可清气”；在卫、气之间则汗与清法兼用，自是辛凉轻、平、重剂选择使用之时。然治病之法，不独用汗，亦非邪定得汗而解者，邪轻而在表，自然一汗、二汗可解，邪盛而入阳明，或至燥实，或不入阳明而逆转，尤当分别以下法或清开矣，此则汗法之变化与外延范围，如桂枝加大黄汤、葛根汤、大柴胡、大青龙汤、防风通圣等，无不在审辨运用之列，是医者据患者之体质、病位等宜否汗法之用之三也。

卫气之分用药有别

药过病所，古人以为可引邪深入，虽轻亦病多不除，故常以为戒；叶氏之“在卫汗之可也，到气才可清气”，只一“才”字，已寓戒意，鞠通于辛凉重剂白虎汤后条列“脉浮弦细”、“脉沉”、“不渴”、“汗不出”等证禁用石膏，复于辨中详言：“甚至石膏用之斤余之多，应手而效者固多，应手而毙者亦复不少，皆未真知确见其所以然之故”，是均明言率尔用石膏之误者，50年代末京师治乙脑中用石膏不效之经验，已为众所接受，而于无汗用石膏之误则尚为所忽，兹记一案于后证之：

刘××，男，48岁，工人，因恶寒发热10日不解，高热达40℃而于1984年11月24日急诊入院，患者头痛身乏，微恶寒而无汗，咽痛，渴饮，查脉浮紧而数，舌红、苔薄白少津，扁桃腺Ⅰ度肿大，白细胞 $21 \times 10^9/\text{升}$ 、中性0.90。医以清热解毒、养阴生津剂治之。处方：银花30克，连翘20克，芥穗10克，淡豆豉10克，公英15克，野菊花30克，前胡10克，生地10克，麦冬10克，元参10克，生石膏15克，知母10克，生甘草6克。服2剂，汗不出，热不退，发热仍在39℃以上，时予适在该

院门诊,邀相视,以为邪在卫分未解,当开皮毛,嘱停服原药,将前方改去麦冬、石膏、知母、前胡,加防风 10 克,羌活 10 克,牛蒡子 10 克,薄荷 10 克。一剂得汗,身热退至 37.1℃,翌日午后复升至 38.2℃,继服第二剂,热退净,11 月 27 日诸证俱平,白细胞已恢复为 $8 \times 10^9/\text{升}$,之后转以清养调理出院。

此案之失,在于忽视恶寒、身乏无汗,脉浮紧而数等证,此卫未解,表未开者,亦适合于《条辨》“汗不出者不得与也”之石膏禁例,故不效。此症之法,仿于大青龙汤,则需虑其咽痛,仿于九味羌活汤,则需注意其舌红少津,余则以其已用生地、元参而即就原方增损之,实则当其初时,用银翘散益入元参已可矣,还不必若是之猛而杂也。增损之要着,不过损其凉而增其辛,就其辛凉之配伍调整,求其开表汗解耳,仍用生地、元参者,以咽痛、舌红、津少故也。

溃疡病可参用外科治法

溃疡病因痛在脘部,大都就胃脘痛辨证论治;因其有纳少、脘胀、脘痛、嘈杂、吞酸等症,合而从脏腑论之,重点在胃、脾、肝三脏。究其病因,属于七情者有忧思伤脾、郁怒伤肝等,属于饮食者有饥饱不节,暴食、久饥,酒、辣、硬、冷偏嗜致伤等,两者往往交结为病,或者湿热不化,或者寒湿稽留,或者肝横犯脾胃,或则脾虚受肝侮,致胃腑始而气机失利,继而血随气滞,终致气血俱壅,无论气滞、血滞、气血俱滞中,均可因气血之不通而痛,所以痛是常见的主症,仅有饱时、饥时、日间、夜间或重或轻等随正邪虚实变化而致的时间不同,轻重不同及兼证不同。

正因为气血瘀滞在溃疡病病机中带有贯穿性,可以由此

外延而扩展到与外科肿疡病机相同之处；肿疡的形成、受邪机制中亦有正虚邪实一环，亦有由气滞而血滞而红肿成疡过程；证之近代检查，胃脘痛对应疾病范围中的溃疡病，包括胃炎，就是肿与疡的情况，只有内脏与体表的患部不同（当然形成机制上略有不同，但无妨于中医辨证），所以运用外科治法中的清热消肿、活血化瘀、托里定痛、养血生肌、益气生血等法治疗溃疡病是可行而且有效的；外科药常用于溃疡病者如蒲公英、银花之清热败毒消肿，地、芍、归、芎之类养血和血生肌，乳香、没药、丹参、三七之活血化瘀，黄芪之益气生血生肌等，运用得当，均可收到较好效果，此为笔者临证 40 多年一得之愚，曾遇一延 20 余年之血瘀血热型重症溃疡病患者，业农 40 余岁，舌紫苔黄，面黑，脉弦，遍用脾胃之方痛势不止，憔悴困顿，经用“醒消丸”配合理气清热养血煎剂 3 月余而控制病情，随访未复发。当然，中医是整体辨治，运用外科治法时，还需兼顾兼症、挟证，正邪虚实等情况，才能丝丝入扣，针对性强，而且此法也只是常规治法的延伸及补充，仅是多一思路，可以拓宽辨证论治意境，而此法本身则仍在辨证论治范围之中。

（曾刊《燕山医话》）

“失水”之治应找捷径

中医籍中无“失水”之称，名之自病理者曰“伤津液”，自证者曰“瘪螺”，盖津液耗伤殆尽，不得充乎肌肤而螺始瘪也。人之疾而伤及津液者多端，热病，摄纳不良等疾均可致此证，《内经》的言“骨属屈伸不利”，亦为津液耗伤之证，而“夺血者无汗”之言，又为失血而伤及津液者之机理；是热邪之耗灼，泻、

痢之丢失，及夫失血、伤精等均可殃及津液也，古人“汗多者勿利小便”、“咽喉干燥者不可发汗”、“淋家不可发汗”、“亡血家不可发汗”诸戒，以及“急下存阴”等治则，莫不为津液计也；若其津液伤之暴而极者，则指、趾螺纹俱凹而不丰，清代以来直名之曰瘪螺痧矣，此症较之由渐而耗伤津液者，其程度悬殊殊甚。瘪螺之症，多为时邪秽毒之袭乎中道，上则呕吐频甚，下则暴注泄泻，饮纳之物尽出而继之以水，中道之液尽而夺乎血中之津，半日间津枯、液竭、血滞，遂而心无所主，血无以运，故往往暴死，较之过汗、缓泄等之所伤，虽甚者亦可致昏瞢，然螺瘪者极少，盖螺之所以瘪，在于伤津液之暴而极，周身不及运济之故也；此症多见于夏、秋暑热之时，乡村间农作方殷，用多养少，汗泄气虚，一受秽毒而汨汨乎如堤之溃矣，以其暴而危，闻之而群情惶惶如谈虎，虽城市亦然也。就其症而核之于近代医学，盖所谓螺瘪病者，即“急性胃肠炎”、“霍乱”之后期失水时也。中医学论此症之机理诚是，而治法则不免鞭长莫及焉，是因就医、诊察、处方、购药、煎煮、诸环节之耗时，饮药而后吸收、输布之复格于运化不良之胃肠功能，终属远水近火，如夸父之逐日矣，诚非医理之谬，亦非药石无灵，其咎在于迟也。余执业之初，适逢霍乱流行，死亡枕藉，甚或有阖户而殆，阖村无运枢之人者，视诸前辈或用四逆以运阳，或用辛开以通神，方药合理而成效寥寥，是诚“正虚不运药者死”也，所以目击心伤，不独哀死者，亦哀我中医之有所格而败绩也，余遂采用输液以救失水，待其阳回神复、液敷血行，而后投以芳香醒胃，辟秽化湿之剂，不半日而如死者生，余亦均以患者能与对语而后至他所为期。余于此治，只以“藿香正气”为主方，只一二剂，初煎多于神醒后服，药尽嘱以淡明矾水每晨饮一盞，期村中无此病后停饮，家属及未病之家用此法，盖明矾能降浊而杀弧菌

也，故余经治者之家无相易者；是年猪丹毒亦盛，乡人往往惜病猪而宰食，余严禁之，唯以清淡为要求。余之输液，药必精，以脉之伏绝者起、息回、螺纹起复为期，宁弃余药液，故无恶寒战慄之反应、致不死于病而死于是者；是役也，仅一老妇愈后因食丧户酒食复病、不就医而亡，余均获痊，余是年仅 17 岁，得以获信于乡人而为成医之基础，亦因而重感于中医之需求、有俾于急症之需于捷径者而用之，然后可以人我两利也。

直中三阴症

从医之始方十二龄，是年十月某日，晨起诵读至近午，感形寒，午后竟至战慄，以为疟，乡俗中有逃疟之说，盖以奔跑而求疟之不屈时作也，余为之而不效，复就日晒之亦不解，寒慄益甚，遂裹重被卧，得寐时许，醒而感昏沉发热，时四时许矣，师母将外出，来视余，犹相酬数语，复寐，自是遂一昏不醒者三日夜，如何治、如何服药，父祖、母亲之何时来，陆师之操忧如何，均不得知，第梦登师门前俯河楷树，坠于水，回旋游泳者久，得依南岸，援稚扬而登，张目视，则卧于床，方紧持陆师手不舍，父、母俯视惶惶也，感惫甚，然无大不适，自是渐向愈，然每于日晡微有形寒发热，纳饮俱不甚佳者达近月。闻家人言，昏迷后高热不退，喋不语，翌晨陆师追父、祖来，并为处方药治，然不能入咽，复延西医汪某来注射樟脑等强心药，则躁动不得入，针锋为曲，惶攘者一昼夜，总不苏，第二日涓滴灌饮汤药，亦祀禳，傍昏灌服牛黄丸一，第三日凌晨复灌至宝丹一，是均由牙隙渗入者，午后遂苏。此症始而恶寒战慄，继以高热，旋即见逆传心包而昏迷，是盖所谓直中三阴证之直中手厥阴者，童子无阴虚阳虚之机，所以能直中者；恶寒之初不即回避风寒

之邪，而奔迫日晒，致表卫益闭，邪势鸱张化热，迅从逆传之经入心包络故也，幸“牛黄”、“至宝”之清热开豁，邪得外泄而证退，幸矣，然正气伤，邪不尽撤，故稽留少阳而日晡微寒微热，陆师以小柴胡进退，得俾痊愈。此证鲜见且甚危，余以身验而深悉，幸之尤幸也。

梦 洩 梦 飞

幼时喜群游，奔逐为乐，常夜梦继之，觉惶急欲洩，就蒿蓬处溺焉，惊而觉，则溺遗于床矣，此为喜好之形于梦寐者，后读《内经》至“上盛则梦飞，下盛则梦坠”、“甚饱则梦予，甚饥则梦取”文，思有以验之，尝于卧前含去核枣于口以求“上盛”，已而果梦飞，频为之，亦频应之，惟飞不得高，翔于屋顶树梢耳已；余晚食或不足，或仅饮酒食菜而不餐，亦常梦纳素所嗜物而不得饱，今濒周甲犹然，是知梦之有以，皆事之系于形与思者之错杂综合而后成，《素问·方盛衰论》谓：“脾气虚则梦饮食不足”，盖亦从实务中来者也。

敏于听者多虚

1966年，余在乡，邻村芙蓉桥一患者，久病不愈者已有年，邀余诊；所居五间并列，家属述其病史病情：纳少而神敏，与人语，音亮而思捷，若无病然，人去则惫甚，夜不多寐，双颊红艳而日就消瘦，是以为忧；方互为问答中，语甚低，然患者或遥应之，纠诉述之不甚合者，余问语处与患者卧室盖隔三间之遥，计其听之敏有倍于人者；临榻诊之，脉弦小而数，舌红、苔极少，几于光赤；纳嗜时新时鲜之食，云：一次尚可，数进则无

味而厌矣，溲或赤，便或燥，自以精神不继为苦。余综合症情，以为体少而用多，阴虚而火旺，所谓“壮火食气”之渐也，虽尚有可资之阴，而亢象见矣，询曾否作 X 光胸透，曰，病后曾于安镇医院检视无病变；家人原以怪病目之，有系乎鬼神之意，余告以听之敏者非鬼神，阴渐虚而阳用之旺也，第惜阴、养阴，省其思虑，善为调理，症可为也，第总不能舍结核病之疑，嘱家属宜数数复查，或不在肺而在肺之外。嗣后不复闻消息，4 年后余复执业于东峰医院，其同村有来就诊者，询之，告曰去冬患肠结核，住院治疗 2 月余，今渐平矣。是症之敏听，农村中常以为祟，固执不能剧易其见，而往往忽于药治；医者临之亦不易为功，盖苦寒折火之法虽似正治，而多无效，或有化火之弊者，要之在育阴的潜敛，此旨出于《内经》，然难以旦夕计也，其所以难者，难在于“积精”也。

治虚人呕泄养重于药

无锡杨亭、村东陆茂荣之母，57 岁，患胆囊炎，入市一院用抗生素静点，上腹痛解而肠道霉菌感染，呕泄不得食，发热起伏，久延不愈，渐致浮肿，是年冬，余贬在乡，请师弟永德为介邀治，此时出院已 20 余日，得食则呕，不食亦恶，且泄利频仍，食入即作，口舌光赤，神情怠急殊甚，服出院时所给“制霉菌素”未能控制霉菌感染，且当时此药紧缺而已 10 余日断药；证情虚实复杂，胃之逆而呕，原于胆之过升，加以泄下不食，耗伤胃阴而不得养，处方仿叶氏养胃法，重用石斛、北沙参、麦冬，加枇杷叶降逆，合玉枢丹少许止呕，为维持体液计，仍请永德弟日输液 1000 毫升，1 周后呕止，热渐退，惟泄利仍然，可饮而不可纳；时余以事离乡，3 周后始得复诊，此时舌虽淡而

微有苔，然体惫更甚；中道关闸尽弛，浆粥不得入胃，体无所持，以一农村老妇膺此，既无经济，遑论食养，就情衡之，死因甚众，但固非一无生机可求者，余虽处逆境，难以一己之后顾为虑也，因从《内经》“浆粥入胃则虚者活”之理，用“食养尽之”之法，以避却药物苦寒伤胃之弊，处以“独参汤”，小口频呷，以扶元气而旺胃运，固关闸，另嘱家属为患者备去油鸡汁或瘦猪肉汤代饮，以醒胃气而益胃阴；如是10余日，泄下渐止，可进糜粥，20余日而全复。1985年1月，永德弟来信述及云，患者自后旺健无大恙，今已76岁矣。此症当时处于穷困之境，而以甘寒、甘温之品愈，不特可悟辛燥、苦寒之可伐胃，亦可洞悉“得谷者昌”之理与夫食养之效也。

瘧症之治

疟之但热不寒，日作且剧，始病时亦午夜晨后间略有间歇，渐致热势连绵无已。或则热前稍感洒然，或则汗出而热稍杀，旋即恶风复热，如此循环不已，日一作或竟到日二、三作则人困怠不堪矣，此病之诊治，在于恶风、发热、汗出热退之规律一如少阳证，而寒少热多或但热不寒，汗解后复作则不类少阳而类乎阳明，仲师称之为疟，清以后则以瘧症名行矣。是症夏秋间多，且乡村间尤甚，忆随师临症之初，季入7月，即以此为主诊，日走数村，盖以蚊蚋之盛而相传易也，证亦相仿，脉洪、苔薄、热势早轻暮甚，有汗不解如白虎，治法悉遵陈修园用白虎加减之意，一诊而愈者十之五六，其或舌苔粘腻，挟湿挟滞者，则参用青陈皮、半夏、苍术、藿、佩、黄芩、厚朴等芳化理气、苦辛燥湿之品，截疟药则常为青蒿、常山而不用柴胡，吾师素以治热病著于乡，此其一端也，自1949年以还，此症渐次减

少，即吾乡苏南地区亦不常见，遑论北地，是盖防治之力，亦因知识开化，农村知防蚊矣。

同药不同效其因诸多

治病辨证，须细微入理，且需详嘱煎药法及调护问题，否则药效多受影响，竟或不效者有诸。师执某，学实有素，治同村一热病，予白虎汤不效，当时乡间穷困，一剂不效即更医求速愈，非若今之可叠进三五剂者，翌日能请业师出诊，审证确系白虎证，为求全计，告病家谓此方诚是，并就原方不加味、不更量，抄一过予之，一剂而热退，师执由此而终身不复言医。此事就而析之，因由殊多：药力不速，前剂得后剂而始克奏功为其一，煎不如法为其二，药后未避直接着体之风为其三，其就病机计之：或先日恶风之况尚甚，虽有白虎证之大热、大汗、大渴及脉大等证，而邪尚未离乎卫，此时当于白虎中加达表之品如桂枝白虎意，翌日病随日进，热邪全入阳明经而白虎可得效矣，是则就效之缓捷计功之析，设一方两剂连服，固无不效之可言也。余之自习医迄今而不忘此事者，盖为策已之精进退，于以亦可见当日求于医者严、而业医之艰难也。

药证相符宜守方

业医之2年，7月间治一暑热症，患者为外祖村人，20余壮男陆某，壮热汗出，口渴引饮，微有恶风，脉洪，苔薄白润，予白虎汤加藿、佩、黄芩，一剂热退，翌日午后复燃，证相同，仍用白虎出入，热又退；三诊时患者诉汗甚，日数易衣，虑体力不支，予谓脉大未杀，白虎证在，未可止汗，邪撤汗当自止，毋虑

为，患者不余信，白辍药辄热，遂不敢停药，计服白虎汤六剂而热退不复作，汗亦止，饮食调养而愈。此明是证是药之不可易也，赖当时易辍停药而复热之情，得坚患者意，否则难计效矣；然而，是则是矣，效亦是矣，后而思之，设仿白虎加参法，即得一太子参或北沙参参之，稍益气阴而邪撤或更捷也。

“医者意也”辨

或谓“医者意也”一语，邻乎唯意志论，遂貽中医以不科学之口实者，余谓不然：夫意，思也，事物之有感于人，人因以有对此事物之观念，此意之始也，继之以分析、辨证、推演，追溯其成因、后果，而求其成理成章者，莫非意也，故意者思维过程之谓；古人格物致知者此，“宁静致远”者此，“在明明德”。以至“止于至善”者，亦此，今日之成百业者亦莫不始于意也，其间唯心、唯物，系乎人之用、用之思之符实否耳。《实践论》倡观性认识，是意之始，理性认识，是意之中止，而认识者意，实践后再认识者为意中止后之又一开始，亦为意也，是不可以舍意之终而就意之始以为责也，第于意之终而不符于实则可责矣，设符于实，理得证，事得成，且将崇之，其可责乎。夫医之于治学，非意不能通其理，医之于治疾，运其识于析证、辨因，定方药而计效者，亦非意无以成其功也。由是论之，意固医者之正道也，设反其行，治疾而不细审之、慎思之、明辨之，何异于盲与罔乎？是故余以为“医者意也”之语，不徒不能废，而尤须求其昌明，庶几后之学医得以广于识、明于治、捷于效也。若夫天士于立秋日授疾人子以新坠梧叶为药引，以为得秋之气，是特俗传之说，设或有之，则一梧叶固不足以易方药之效，计天士运医疗心理学于患者耳，是非“医者意也”之原义也。况意之为用，

不独医者之需，其于治事，大而国计民生，小而一时一事均莫可离乎者也。

“长夏”说

《内经》于四时中出一长夏，定其时于夏末秋初，主以脾，主以湿。余在苏南时，殊感与主湿之气候不能类，盖苏南地区于此期暑气未消，流火欲来，虽有雷雨，迅过者多，无湿可以言也，而于四五月间之“黄霉”季节，则阴雨绵霏者多，地湿墙霉之象屡见矣；迨入都后，始知此地六七月间常为雨季，一年中惟此节雨量独多，明显有异于他时者，予以知《内经》各章及于长夏主时之所出，盖本于黄河流域之气候者也。是亦与中国文明之始于此域、先盛于此域有关，而《内经》得以凭藉为言之故。

脾主长夏、脾主湿，类比而及于长夏之多湿，理自可解；就湿论则雨多时必湿重，是亦可以雨多之季而定长夏之主时者，若是而论之，则可与农历中之“霉雨”相对应，旧籍各记“入霉”、“出霉”之日不同，闽、浙以“立夏”节后逢庚日“入霉”，江、淮间则以“芒种”节后逢壬日“入霉”，或有言淮以北无霉者，此种先后不同，实亦为雨季先后之然，古入于此亦申言之矣，如《五杂俎》云：“江南每岁三四月，苦淫雨不止，百物霉腐，谓之梅雨，盖当梅子青黄时也，自徐、淮而北，则春夏常旱，至六七月之交，愁霖不止，物始霉焉，亦谓之梅雨，盖霉与梅同音也”，《月令广义》论《通书》记“芒种”后逢壬日、逢庚日、逢丙日“入霉”之不同与闽人以壬日“进霉”不同之故，直言“天道自南而北，凡物候先于南方，故闽、粤万物早熟，半月始及吴、楚，今验江南霉雨将罢而淮上方霉雨，又踰河北到七月，少有霉气而不

之觉矣，以此言之，壬、丙进霉不必定拟，固当易地而论之耳”；南北霉雨时节之不同为雨季之不司之理如此矣，而霉之多、孤、有、无，实为海洋气候与大陆气候有异之故。自地球纬线38°线言之，适当于济南，而济南以北则气候为大陆性，霉自少矣，之所以少，雨少而风燥故也；济以南之雨多而风湿，湿自多而霉亦多矣，故《内经》以长夏主湿之象，准于大河，而异于江南。尤以此故，后之论脾之主时者，或曰长夏为夏之末，或曰脾旺于四时，各以十八日案之，是主夏之末者，见于大河上下之气候也，主寄旺于四时者，见于大江南北之气候也，于兹可见长夏之主时，亦当“易地而论之”矣；更有可申悟者，六淫病之治，当灵活变化于气候之实际者而后始可言效，毋泥于主时说可矣。尤可于此测《内经》于五方之分划，亦就黄河而规其东、西、南、北者，约其中，当为东魏而西秦之间乎。

冬不藏精说

《内经》“冬不藏精，春必病温”之义，为就气候、生活两者之论：冬应寒，寒则万物收藏，蓄三冬之力以为翌年生发之用，设冬不寒而温，则万物泄而不藏，如桃、李再花，则明年此桃此李必不荣，以精不得藏而泄于前也，于人亦然，惟此之“精”，不独言肾之所藏者，败人体为卫之抗力均此也，此为不藏之义者一，其次则因冬之温而虫虻亦不藏矣，虫不藏则害物，证之近时细菌之繁殖有其气温条件，则人体受病之机缘甚于不温也固然矣，此为不藏之义之二，由此二者综计之，则来春病温者自可众矣；且此所谓“必病”者，概其大况言也，非人人所必也，病之来，邪居其一，体之“藏精”如何又其一，所谓“邪之所凑，其气必虚”者，均此比较而言之意也。余从业之始，客冬温，花

再发，计入春当病众，已而果然，不特春间多温热症，入夏霍乱尤猖獗，死亡枕藉，是年猪亦都先毙于母毒，而民不聊矣。

伏 气 说

《内经》“冬伤于寒，春必病温”、“春伤于风，夏生飧泄”、“夏伤于暑，秋为痄疰”、“秋伤于湿，冬生咳嗽”四节，为后人伏气说之始；余以为此非印定之说，岂有邪伏 3 月而后始病者乎；清代先哲，甚有以冬寒之深伏至肾为言者，凿矣，夫以外邪之入肾，当时岂能绝无病态，必待入春后而始发病乎，既至春而可病，则初感寒时胡不病，感后之 3 个月间胡不病，虽反复揣摩，于理均所不可解者，说亦自难为圆也。盖此四节经文，应与《素问·四气调神大论》连解，“逆之则伤肝，奉长者少”等四时所逆、所伤、所奉者少之义，即“必病”之所以然也，是旨在于正气而不在于邪，是由气候或起居之逆，生、长、收、藏之道伤于本季之邪，弱其正气，致下季所奉者少，或无以奉而病温、病飧泄、病痄疰、病咳嗽也。然即此四病，亦就该季所病之大况者言，非必病此四者者也，夫四时之所奉者，正气也，亦即“精”也，此精藏于前季而奉于后季，四时相递，故能生生不息，故《内经》既曰：“冬伤于寒，春必病温”，以与四时之所伤同言，又独曰：“冬不藏精，春必病温”，而不言他季者，盖赅他季而言之义为其一；而此之“精”亦赅他季而言为其义之二；“精”正气也，精伤则不能奉所生，而所生者弱矣，弱则病易袭矣，故舍正气而言伏邪即谬矣，岂真邪之所伏而病哉。

前人论喉症虚实之治

治病莫不分阴阳、寒热、虚实，苟能明乎此而运之于临诊，固可效者众矣，然实难也。常熟吴半淞，五世之医，曾有论此于喉症者，曰：“夫外科之治喉症，为最上乘之学，传变迅速，必详知咽通于肺，喉通于肾，为阳明胃府之门户之理，然后观夫六淫之气，温、燥之邪，其中人也惟娇藏独当其炎，蔓延阳明，炎热上薰，间里被焚，其势汹汹，如喉痛、喉蛾、烂喉风等，皆病之从表而实者，可苦以泻之，咸以润降之，热炽肿烘其者，虽凉营泄火如犀、羚、连、地，泻腑如生军等亦可酌用，邪亦易解，此虽庸工皆知其治。更有一种症候：其人未感外邪，喉关并不肿而卒然大痛立哑，会厌如闭塞状，须臾难忍者，此少阴肾火上冲，虚极而致，若现颧赤、肢厥，则真阳飞越，难为力矣，此时亟进桂、附回阳，佐以童便引火归原，犹有效者，此症方书虽载，而病则仅见，较之白喉、喉痹之阴虚，更深一筹也。”病之于虚、实间，毫厘千里有若是者，岂可不反复权衡于临症时哉，忆乡先辈严炜候先生治喉症之久不愈者，亦常从少阴法，用细辛、瑶桂而收效者甚多，是知病机之转化层次，先而阴虚，进而阴虚阳浮或阳越，其于阳浮者，与阴虚治法迥然矣。

梅核气

有言梅核气为近代之慢性喉炎而主以半夏厚朴汤者，实不尽然，梅核气之说，原于《金匱·妇人杂病》篇之“咽中如炙脔”句，此为由于痰气郁结之症，原于肝、胃两经之气机，故明白说清咽中如有梅核，吞之吐之俱不能除，是为症之状，而其

原因则为气也，方以半夏燥痰饮，厚朴降气逆，姜、苏之辛散以醒胃解郁，施于初起之症多效，迨至久病气阴受耗，治法、治方还当别论。若以此方施之于慢性喉炎，余固屡见其不效者矣，夫喉炎之证，固有“咽中如炙脔”状可见，尚有或痒或痛之感，喉壁亦有如疹如泡之点可察，较之梅核气之但“咽中介介如哽状”者不同也，考喉症中之“喉痹”、“喉癣”者实与此近，旧时以痒、痛，起红丝、红点，或见如蚁蚀状者为“喉痹”，但肿痛者为“喉癣”，痹者尚有实证，癣则都为阴虚火旺，无论病因、症状，均与梅核气不侔，今以“卫生常识”之名播之，其可以乎（因1978年11月10日江西台广播有感）！

对“溃疡病”辨证论治的管见

“溃疡病”以上腹痛为主症，中医学称之为“胃脘痛”，清代以前医籍多将本病概括在“心痛门”中论述，《内经》中提到的“胃心痛”，可以认为是包括本病的；“心痛”九种辨证中的气痛、血痛、饮痛、冷痛、热痛等均与本病有关。在本病发展到出血的情况下，则又往往概括于“血证门”中。

（一）病因病机

本病的致病因素，涉及到内因、外因、不内外因等全部病因学方面。内因七情恼怒忧思是本病的主因，《素问·六元正纪大论》即有“木郁之发，……民病胃脘当心而痛”的记载，后世称之为“肝横侮脾”。此点，较之近代认为由于精神因素导致植物神经功能紊乱而引起溃疡病的论述，不仅相似，而且在历史上是远远提前了。不内外因中的过食生冷辛辣和过饥暴食等与本病关系密切，虞抟《医学正传》所谓：“原厥初致病之由，多因恣纵口腹，喜好辛辣，恣饮热酒煎炒，复餐寒凉生冷，朝伤

存损，日积月深，自郁成积，自积成痰，痰火煎熬，血亦妄行，痰血相杂，妨碍升降，故胃脘疼痛，吞酸噯气，嘈杂恶心”，即是由饮食失调，致胃气受伤，脾运失司而引起本病的一条很具体的病理记载。外因中的外寒，亦可引起本病的发作。现简述其主要病理如下：

1. 情绪波动

(1) 平素性情暴躁易怒，“肝主怒”、“怒伤肝”，始而肝失条达，横逆犯胃，气滞不舒而致脘痛吐酸。久郁化火，耗伤营血，甚至因久痛入络而见血滞症，临床可见到痛有定时、定处，入夜亦痛或夜甚于昼等症，舌质见色紫或有瘀点；或者因肝火动血而引起吐血、便血。此一病机是由肝及胃及脾，由气及血，实证在前，尔后则虚中挟实。

(2) 由忧思而起的，“思伤脾”，“思则气结”，脾气由结而伤，导致脾胃虚弱，而出现脘痛喜按，得食可缓，纳后脘胀等症。脾虚不复，久之不能统血，亦可见到吐血、便血之症。或者脾虚木乘，亦可见到吞酸嘈杂、脘胁痞满等症。此一病机是由脾及胃及肝，由气及血，多见虚证。如果五志过极，郁而化热，亦可见到本虚标实证。

2. 饮食失调

(1) 始于久饥者：如果素体壮实，往往因饥不得食而胃火亢盛，或与肝火合邪而从火化，可见吐酸、嘈杂、脘痛，脉弦滑，舌赤苔黄等症。若素体衰弱，可因胃气失养而出现寒自内生的虚寒证。

(2) 始于暴食及嗜食生冷辛辣的：由于“饮食自倍，肠胃乃伤”，使运化功能出现“气伤于味”的改变而出现虚证；或者食滞不化，积而化热，这就与前引《医学正传》机理相同。前者属于正虚，后者属于邪实，临证可以兼见。过食辛辣者易见火

化证,过食生冷者易见寒化证;生冷虽可郁而化热,但临床较为少见。之所以寒化、热化、致虚、致实,是取决于患者的体质、性情与食物的性质、数量等因素的综合反映。

(二) 治疗方药

本病治疗以止痛为第一要着,同时兼顾吐酸、吞酸,在出血情况时应以止血为重点,如此可以解除患者的痛苦和恐惧,阻止疾病的发展,同时亦起到了愈合溃疡面的作用,所以愈合溃疡的疗法是贯穿在治疗的全部过程之中的。现分类型举其代表性方药于后。

1. 止痛

疼痛的产生关键是气血不通,但其导致原因有气滞、血瘀、阴(血)虚、气虚之别,具体到本病涉及的脏腑辨证,气滞易见于肝、胃、脾,血瘀易见于肝、胃,阴虚易见于肝,虚寒易见于脾胃。并且可有兼见、互见的变化。

(1) 肝气横逆犯胃,脘痛吐酸,胸肋痞胀不舒,易怒易烦,甚则便干溲赤,脉弦大,舌红,苔或黄腻;用“柴胡疏肝散”(柴胡、枳实、枳壳、白芍、炙草、川芎、香附);偏重于热,舌赤苔黄明显,而且口燥,加用“金铃子散”(金铃子、延胡索);偏重于肝气上逆,胸、肋、脘胀痛明显的,用“加味乌沉汤”(乌药、砂仁、木香、延胡、香附、生姜、甘草);气滞湿留,当脘胀满,纳呆溲少,或则欲恶,脉弦苔腻,用“四七汤”(半夏、厚朴、茯苓、苏叶、生姜、大枣)等方出入加减。

(2) 肝热伤阴,脘痛嘈杂,如饥而不欲食,口渴饮少,神烦易怒,脉弦小,舌红苔少,用“一贯煎”(北沙参、麦冬、归身、生地、枸杞子、川楝子)加佛手、梅花、煨瓦楞等。

(3) 脾胃虚寒,脘痛喜按,痛有定时,得食痛缓而胀,嘈杂纳呆,口淡无味,舌淡苔薄腻,用“香砂六君子汤”(党参、白术、

茯苓、炙草、姜半夏、陈皮、木香、砂仁)；兼见腹拘急畏寒，用“黄芪建中汤”(黄芪、白芍、桂枝、炙草、大枣、生姜、饴糖)加减。

(4) 气血俱滞，脘痛不绝，或痛作如刺，入夜亦痛，脉或弦或涩，舌有紫色，甚则舌边或舌面有紫点紫块，轻者用“丹参饮”(丹参、砂仁、檀香)，甚者加乳香、没药，或用“四物汤”(生地、赤芍、当归、川芎)合“失笑散”(蒲黄、五灵脂)。

2. 制酸

本病之吐酸嘈杂多与胃痛同见，其病理机制，为肝气郁滞而“曲直作酸”。其间尚有二种区别：一为肝经郁热而横逆，往往表现为吐酸，时感灼热而嘈杂；一为脾胃虚寒而肝气来乘，亦可出现嘈杂，或两颊液出唾多而吞酸，其酸性则大逊于肝气横逆的程度。近代则概以胃酸过多视之。其治疗方药：

(1) 肝经郁热、横逆犯胃者，用“左金丸”(川连、吴茱萸)加味；挟有湿痰化热而见苔腻口粘者，合用“温胆汤”(姜半夏、陈皮、茯苓、甘草、生姜、竹茹、枳实、大枣)加山栀、旋复花、黄芩。

(2) 脾胃虚寒、肝气来乘者，用“六君子汤”加吴茱萸、生姜。

还可结合近代药理，选用煅瓦楞、煅牡蛎等以平肝、敛肝、制酸。

3. 止血

本病之出血，以便血为多见，其严重者，则并可出现吐血。此时止血应先止吐血，后止便血，并宜注意到止血与行血的辨证关系，以避免造成血瘀。出血临床常见的有三种类型：

(1) 肝火横逆、胃热壅盛、热伤血络而致者，见症除吐血或便血外与止痛项中第1类型大致相同，用“十灰散”(大蓟、

小蓟、荷叶、侧柏叶、茅根、茜草根、大黄、山栀、棕皮、丹皮——均炒炭研粉服)合“三黄泻心汤”(大黄、黄连、黄芩)或“大黄甘草汤”(大黄、甘草)。

(2) 肝胃阴虚阳亢,口渴不引饮,脘痛作嘈,吐血或便血,舌红,脉弦,用“十灰散”合“甘露饮”(生地、熟地、天冬、麦冬、枳壳、甘草、茵陈、枇杷叶、石斛、黄芩)。

根据笔者对 60 例上消化道出血的总结经验:“十灰散”有明显的止血效果,对非虚寒型的吐、便血均可使用,服药后出现便秘,即为止血先兆,但以散剂冲服为佳,不宜煎服。因证之近代药理,炭剂有吸附凝结作用,可不受消化道出血患者需要禁食的限制。

(3) 脾胃虚寒,不能统摄者:多见便血,伴神倦纳少,形寒气弱,溲清,或便溏,脉软弱或大而虚,舌淡,苔白少等,用“胶艾汤”(阿胶、艾叶)为主方,寒重者合“黄土汤”(灶心土、熟地、白术、附子、阿胶、黄芩、炙草);虚甚者合“归脾汤”(白术、茯神、黄芪、龙眼肉、炒枣仁、党参、木香、炙草、当归、远志、生姜、大枣)。

此外可酌用白芨粉、乌贼骨粉、三七粉等吞服,以加强止血作用;通过三七的化瘀,并可防止瘀血留滞。

4. 愈合溃疡

愈合溃疡是本病治疗的最终目的,其能否愈合,与病者的情绪、饮食、服药恒心,以及溃疡面的大小、部位、药物的当否,均有关系。其治疗过程,实际上是贯穿于止痛、制酸、止血各环节之中,各个治疗环节是愈合的基础;通过各环节的治疗,可抑制溃疡的恶化、改善病灶的营养,在气血调和的基础上,进而通过生血生肌促进溃疡愈合。所以在选药方面要根据古人调和气血、养血生肌的论述,抓住促进机体自生能力去进行。

我们选用了“温三焦，壮脾胃，生血生肌”的黄芪，健脾益气的党参，养血和阴、平肝止痛的白芍，缓急止痛的甘草，止血生肌的白芨，活血散瘀、行气止痛的延胡索，行血止血、消肿止痛的三七，消瘀化结止痛的瓦楞子等，研为散剂，作为本病症状缓解后的较长期用药，临床观察尚有一定效果。在1972~1973的一年中，收集到能够经X线钡餐复查的16个病例中，愈合者10例，溃疡面缩小者3例，症状控制而溃疡面未见改善者3例。10例愈合病例的复查时间：2个月以内者3例，4个月以内者6例，6个月以内者1例。10例愈合病例的年龄分布是：30~40岁者5例，40~50岁者2例，50岁以上者3例。

（三）结语

以上根据脏腑、气血、八纲等辨证方法，结合临床，谈了一些对溃疡病治疗的管见，其中以肝、脾、胃三脏与本病最有关系，三脏中不仅起病有先后和相互有影响，而且还有寒化、热化、互虚、互实的转化情况。临床既要看到其现在症，又要弄清其病史，这是整体观念的问题。推而论之，与环境、习惯嗜好、情绪等也分不开，所以在本病的治疗上，除了重视药物的治疗外，更要劝说患者做到心情愉快，不过饥暴食，避免生冷辛辣食物。如酒类的饮用，原则上是不宜的，上述16例患者中，就有1例因嗜酒而症状虽控制1年但溃疡仍未愈合者。常见有些患者用酒类来控制本病的疼痛，每每当时有效，其后则不仅无效而且溃疡面扩大。又如所治无效1例，因情绪上未能改善，饮食上未很好调理，致经手术截除后6个月又复形成溃疡。所以《内经》提到的“食养尽之”的要求是应该注意的。

（本文曾发表于《北京中医杂志》1982年第2期）

慢性胃炎浅识

中医学对慢性胃炎的诊治,主要是根据症状归入“胃胀”或“痞”的范围;因此病以纳食后胃部胀满为主症,很少作痛而不同于胃脘痛,由于常易兼见胁肋胀满,故亦称之为“肝胃气”,此一病名表示病位在胃,病变主要在气而与情绪有一定关系。当然,由胃可以及脾,由气可以及血,慢性胃炎患者大多数有便溏或先鞭后溏症状,就是脾运不健见证,胁肋胀满或情绪变动时症情加重,就是肝失条达见证;由此可以将本病病机放宽到气血、胃肝脾的范围,影响到肾是极少的;而由于脾胃不健,水湿失化,可有湿、食、痰郁等邪实兼症,则为本病患者中所常见。

引起本病最主要因素是饮食失宜,暴饮暴食是一类,过食辛辣、生冷、油腻又是一类,其间以酒、辣引起者更为多见,部分病例可因一次酗酒食辣而罹病。情志问题于本病,大多为已经患病、复因情志变易而加重或复发,但当恚怒或焦虑之时进食,此时脾胃运化之机紊乱,虽辛辣、生冷、油腻不甚,亦可发病,此情尤易见于女性患者。

本病的治疗,自患者要求言,是消除胀满能进食舒畅;自病机计,应以和胃理气为基本治则并贯穿全程。其间变化:兼见痰湿而苔滑润或腻者,应参化痰湿;兼见食滞苔厚或燥黄者,应参消导;兼见脾虚便溏苔少者,应参健脾;兼见肝气横逆、肋胀神烦易怒者,视其偏热则清疏,偏郁则参辛开,偏于虚亢则参养,至于因脾胃之虚而肝来侮者,则健脾即可。此病后期可见以虚为主之象,证之临床所见,气虚者较多于阴虚,不应一执胃阴虚之见而漫投滋柔;我以为沙参、麦冬、生地、石斛

之属，于胃阴虚者，自可因酸甘化阴而收治效，然须有舌红无苔为据，而六君子之于脾胃气虚，更有好效。

胃镜检查及活检概率中，本病初期多为胃粘膜浅表性炎症，渐次向粘膜萎缩发展，此种粘膜炎症与萎缩互见情况，为期可由几个月到持续十几年以上，迨至萎缩比例渐次增大到占大部分或绝大部分时，则胃酸比例亦渐次减少，粘膜萎缩愈增，胃酸愈少，两者几呈同步反比，个别患者可见无酸；病理活检见到的胃粘膜肠化或增生，多在粘膜萎缩较久后出现，现代医学中提到“恶化”之说是指此类病理的继续发展；此种由炎症→萎缩→肠化的过程，是慢性胃炎的整个病理发展过程，所以如何消除炎症，恢复粘膜萎缩，以至肠化的逆转，是治疗本病时病理方面的要求，此点如何与中医药结合？我以为：

1. 慢性胃炎之炎，与感染性炎症有别，后者菌类作用大，前者理化性多。胃粘膜炎症多为食物滋味刺激，引起肿胀以至随时间推移而形成萎缩，此种炎症并非杀菌消炎药所能解除，而应以通调粘膜之气血求其功能加强而消除炎变；近年来有幽门弯曲杆菌作为慢性胃炎与溃疡病发病因素之说，我以为其能引起发病，必然有控制此菌繁殖机制之人体免疫功能的变易存在；否则有此菌而不发病，有此病而无此菌的现象就难于解释；运用中医学中的气血学说处理免疫功能变易，以通调、强化脾胃气机，扶正祛邪的办法，才能将此类炎症解决得更好。

2. 胃粘膜的萎缩，起始固然由于炎症影响了粘膜细胞的正常功能，但迨其萎缩，必然有自身营养不良的机制存在。因此，恢复其营养供应，就是消除萎缩的方法之一，中医学中的气血学识，于此仍是正治；使胃的气血充足和通调，我认为归芍六君子不失为良方。胃粘膜的肠化，是萎缩的发展，也是一

种替代,所以能形成替代,是气化混乱,不能生化万物而错位,所以同样可用益气、理气为主的方药来求治。

3. 慢性胃炎中缺酸的问题:中医学中以吐酸、嘈杂为酸的表现,此一症状在本病挟有湿热、食滞时仍可见到,此系湿郁、热郁、食郁而来,所以早期慢性胃炎中并非一概缺酸,只是此种酸象为胃被迫性所产生,治疗上除其造成因素就可解除,用制酸药不是正治。发展到胃粘膜萎缩后酸才相应减少,但也有一部分病例在见到胃阴不足证时仍有嘈杂现象,此是肝之虚热引起,亦称“火嘈”,并非酸多而是液少,养胃药中参用白芍、黄连,起育阴、柔肝、泻火之用即可,不应用吴茱萸、瓦楞等药止酸。举例三案如下:

1. 胃阴虚案

金某,女,64岁,满族,教师,1992年7月初诊。

素有慢性萎缩性胃炎已近5年,曾查胃酸为零,常服生山楂水一日达30克生药,伴有束支传导阻滞;近日因腹泻后纳食更少,舌尖灼痛,便素溏日一行,查舌赤无苔、尖起刺,脉弦偶代。主养胃阴兼以理气法。

处方:石斛(先下)20克 麦冬15克 白芍18克 佛手10克 丹参10克 川楝子10克 黄连(后下)6克 生甘草10克 北沙参30克 生山药20克 生苡仁15克 银花30克 六剂。

一周后复诊:舌灼痛减近除,舌红赤退,纳食仍少,脉转滑尚嫌略紧,仍主原法。

处方:石斛(先下)20克 白芍20克 北沙参30克 乌梅10克 丹参15克 黄连(后下)6克 连翘15克 川楝子10克 生甘草6克 生地15克 生药仁15克 川贝10克 六剂。

患者药后舌痛尽除,仍以原法出入连服二月,舌红退,生薄白苔,纳食正常。但屡次动员胃镜复查未成,未能取得胃粘膜、胃酸恢复数据,仅以消除临床症状而止,2年内不断接触中知未复发。

2. 心脾气滞肠化案

邹某,男,51岁,汉族,江苏某县干部,1991年4月余因乡葬母时诊。

纳后脘胀、时时痞满已2年,纳少便溏,梦多寐少,于当地胃镜检查诊为慢性胃炎,粘膜浅表性炎症及萎缩,部分肠化,脉缓而涩,舌苔薄淡。主益心脾为法。

处方:党参15克 白术15克 青陈皮各10克 枳壳10克 川楝子10克 木香(后下)7克 砂仁(后下)6克 丹参20克 猪茯苓各15克 当归14克 焦三仙各12克 桂枝3克 白芍15克 六剂。

上方续服30余剂,于同年5月下旬来电告:脘胀未尽除,仍有梦多寐少、耳鸣头沉等症;改方为:党参18克 白术15克 当归15克 丹参20克 桂枝4克 杞子10克 茯苓18克 枳壳10克 陈皮12克 焦楂曲各12克 山萸肉10克 砂仁(后下)6克 木香(后下)6克 炒枣仁15克。临睡前煎服。

此后续仍原方进退,服药达3个月后于苏州某医院复查胃镜,肠化已消除,浅表性炎症未消。纳食虽可,但一次不能超过二两(100克),继续改方中或加用三七粉分吞2克、黄芪10~15克,或加入生地榆10克、黄连粉(分吞)2克,续服至5个月,病情稳定,改为单服生晒参粉日3克善后。

3. 气阴两虚案

缪某,女,73岁,某部干部,1987年12月初诊。

脘部不适、食纳不振、纳后脘胀已 20 余年,偶有作呃,眠差,便不成形,曾于某院作胃镜确诊为萎缩性胃炎,胃液分析胃酸为零,伴有慢性肾盂肾炎、高脂血症史,今查胆固醇 7.38 毫摩/升, β 脂蛋白 8.76 克/升,舌苔薄白润,脉软滑,左寸搏,两尺俱弱,从心脾气阴两虚论治。

处方:党参 15 克 白芍 15 克 吴萸(后下)2 克 生五味子 6 克 炒枣仁 10 克 白术 10 克 生黄芪 15 克 当归 10 克 炙甘草 6 克 茯苓 18 克 木香(后下)7 克 枳壳 10 克 焦三仙各 15 克 五剂。

药后胃脘胀满大减,仅感眠差梦多,经加减出入原方,或增乌梅,或增夜交藤又连服 18 剂后,诸症平稳,纳食次可 2 两(100 克),但不能增量,增食一二口即脘胀。翌年 4 月再诊时症、舌均平,而脉见弦小,转治高脂血症 3 个月,查血脂复常,但拒做胃镜复查,未取得胃粘膜变化数据。迄今已 7 年随访,症情稳定。

上述案例说明,无论胃粘膜萎缩或肠化,或胃酸缺乏,运用中医药治疗均是可以逆转的;但患者应做到情绪愉快及饮食适宜来配合治疗,因此二种情况既是慢性胃炎的致病因素,又是尔后反复发作的诱因;饮食失宜之害,在于辛辣、生冷、油腻、硬物之直接损害胃粘膜,引起充血水肿、导致粘膜萎缩,《素问·至真要大论》中对五味太过的致病描述是“气增而久,夭之由也”,并且认为治疗正确而病不愈是与饮食有关的,说“不治王而然者”是因“不治五味属也”,意思在指没有调整好饮食。情绪过激之害在于降低机体本身功能,影响抗病抑菌的正常作用,更重要的是可以影响自身修复作用,中医学历来认为悲怒伤肝,忧思伤脾,肝脾间本有相克关系,所以肝旺则克脾,脾(胃)虚则肝来侮,因而情绪激动后引起脾胃发病为临床

所常见,证之现在情绪影响免疫功能之说,可见调节情志的重要性。

健脾益气治疗笔谈

健脾益气法,是临床常用的治疗法则之一,笔者在临床中深感其对消化系慢性疾病,如溃疡病的溃疡愈合,肝炎中后期 TTT, 麝浊等指标的恢复等有明显效果。唯其运用时需以辨证为指导,确审患者有纳呆、厌食、纳后腹胀、形寒怕冷、面色少华、便溏或飧泄,脉像软弱或大而无功,舌质淡、苔薄白润或滑等气虚、脾虚证时才能的对。笔者治疗溃疡病时,常以健脾益气的代表方之一“香砂六君子汤”为主方予以随症加减。此经验的取得,缘于初行医时按中医传统辨证治愈几个胃脘痛患者,其中 1 例,后因其他病手术,证实系在溃疡病濒临穿孔情况下经服此类药而控制并愈合,由此于临床中留意观察,70 年代中曾以本方分别加入“壮脾胃”、益气生肌之黄芪,化瘀止痛之三七,养血之白芍,止痛止酸之乌贼骨、瓦楞子等观察溃疡愈合情况,经复查 16 例中有 10 例愈合,其间 2 个月以内愈合者 3 例,4 个月以内愈合者 6 例,6 个月内愈合者 1 例,其余 6 例临床症状均控制,溃疡范围有收缩等改善,1986 年曾著文发表此一结果。此方重点在于参、术、草之健脾益气,使已经虚怯的脾胃得到壮实,再而旺盛其运化功能,使之发挥后天应有作用,谷纳得运而气血之源充,其余苓、夏、陈之化水,香、砂之畅气,以及加入的白芍、三七之养血和血,均属臣佐部分,参仿外科生肌愈疮治则,益气生血以达到生肌愈合疮口之理组方,本方对溃疡愈合的作用,一如“大势所趋”,由脾胃功能的全面好转而愈合局部的溃疡。

笔者运用本方于肝炎时,常在黄疸型肝炎黄疸消退,转氨酶恢复之后,麝絮、麝浊等延迟未复的情况下使用,以求恢复肝功能之慢性指标,此期病情往往是湿热退后,脾胃功能未复,一方面用此方之健脾益气作用旺运化,另一方面利用运化的得旺而除余湿,在临床使用中深感有效,笔者在继1956年发表“茵陈蒿汤为主治疗黄疸型肝炎”一文后,逐步摸索恢复肝功能慢性指标的方药,参用本方后,曾求得最短28天、最迟50天全部恢复的效果(慢性、无黄疸型肝炎除外)。忆及自然灾害时期,因药源紧缺,压缩党参、白术等药以后,门诊观察中曾有6个月未愈1例肝功能的情况,此后不得不恢复使用后方见效果,此情至今“历劫不磨”,仍深刻于记忆中。中医对黄疸历来认为是由湿热引起,渍于脾,郁于胆,“胆热液泄”而致发黄,而湿热之来,首在于脾,“脾恶湿”而运化水湿,脾不化湿,湿郁化热,从而构成致黄因素,所以治黄时亦首从利湿,湿去则热自退,因而黄疸之湿重于热的,虽初起亦可用术、苓、陈、夏等健脾化湿药,仅益气一类药要考虑于邪盛时暂先不用,迨至黄疸退,湿热基本化除,则多数患者显露脾虚以至气虚之况,此时是六君子使用的时机。在脾虚情况下,虽有余湿,亦可遵扶正以祛邪、健脾以化湿的原则而使用本方;笔者于此证型患者常以之作为善后用药方剂,常在肝功恢复后,仍嘱患者继续服用一段时期,以资巩固,有时则径处以六君子丸或加服丹栀逍遥丸。如患者在病中因热伤脾阴或平素肝旺而致后期肝热血虚等类证型,当然是不宜使用本方药的。

个人于上述病例中使用本组药物及加减药物的常量为:党参15克,白术15克,茯苓15克,甘草6克,姜半夏10克,陈皮10~15克,湿热重加茵陈20~30克,肝气虚滞吐酸加瓦楞子20克,肝脾血虚加白芍或当归10~15克,气血瘀滞作痛

加三七粉(吞服)2克,纳呆加谷麦芽10~15克,腹胀重加枳壳10克。

个人认为气旺则生血,脾为后天之本,脾虚则势必殃及他脏,因而健脾益气药物的治疗范围,不仅是上述病种有效,我曾使用于诸如痰饮、贫血、怔忡、泄泻之慢性者等疾病的某一阶段,均有一定效果,中心问题仍然是要辨清脾虚气虚的证候。

(此文压缩后曾发表于《北京中医杂志》1988年第4期)

河间学说的渊源与成就浅探

刘河间论著“火热”,系统阐述了“六气皆从火化”,药主“寒凉”,突破了“发表不远热”的传统观点,对后世中医学产生了深远影响,成为医学史上的一代大家,以至于可说是划时代的大家,这是众所周知的,被后人称为“寒凉派”、“主火派”。在学习河间学说中间,深感河间学说是中医学历史长河中的一颗明珠,有其继承所自,有其开拓新境之处,兹述管见几点:

(一)主火说源于《内经》

刘河间鉴于当时《局方》用药多温,世医又“多赖祖名,倚约旧方,耻问不学,特无更新之法”的局面,慨乎“患者遇此之徒,十误八九”,因而从25岁就致力于《内经》的研究,晚年写成了《素问病机气宜保命集》、《素问玄机原病式》等论著,从“亢则害、承乃制”的原理,发展成“六气皆从火化”,认为风、热、湿、火、燥、寒六气中只有湿、寒二者属阴,而二者拂郁太过时也可化火、化热,并且这点也正是《内经》中“今夫热病者,皆伤寒之类也”的潜在详细注解,寒之所以能够化热,有“物及必

反”的哲理，是郁之太过而来，是六气本身具有的“兼化”和“胜”、“复”而来，包括“热极似寒”的“热深厥深”和先伤寒而后发热的临床现象均属此一类；河间在《素问玄机原病式》中所述的这一理论，明显的是导源于《内经》而又发展了《内经》之理论的。不仅如此，河间还从《素问·至真要大论》的病机十九条中，用统计学的方式论证了这一“六气皆从火化”的论点，其中属火属热的九条固然已明言属火的范围，属肝、属心、属上、属风亦皆可类于火热，这是河间学说导源于《内经》的又一点。

（二）药主寒凉是对《伤寒论》的发展

河间用药，虽然突破了“发表不远热”的范围，但仔细看去，他只是突破了麻桂的发表，而发展了寒温并用、表里双解的治病发表方法，此一发展仍应该是导源于仲景著作的。下述几点是可以说明此种渊源的。

虽然河间主张寒凉，但并不反对《伤寒论》，相反的是尊重《伤寒论》；他在《素问病机气宜保命集》中说，仲景“辄考古经以述《伤寒杂病论》一十六卷，使后之学者有可依据，虽然所论未备诸病，仍为要道，若能以意推之则思过半矣”。并遵仲景为亚圣，他说：“仲景者，亚圣也，虽仲景之书未备圣人之教，亦几于圣人。”这是医史上首见的遵仲景为医圣之言。正因为他希望医生能学习仲景著作的深奥理论，撰写了《伤寒直格》，就这“直格”两字，不难看出他是以格致之求去学习仲景著作的，其尊重仲景的高度和学习仲景著作的深度于此可见。

从河间的遣方用药方面，亦可看到虽药主寒凉，但并不偏废温热，这点无疑是继承仲景学说的又一明证。如用麻黄汤、羌活散以解利伤寒；对于里证之属寒者，亦用温热之方法，如用紫沉丸（以半夏曲、丁香、砂仁、白豆蔻为主）治中焦寒气食积而致之吐食；厚朴丸（以厚朴、吴茱萸、川乌、蜀椒为主）治寒

气而致之反胃吐逆；理中丸治寒湿霍乱之吐泄；椒术丸（蜀椒、白术）治寒湿泄泻等等。

河间习用仲景之方，不仅麻黄汤、青龙汤、麻黄附子细辛汤等为其常用之方，其自制之羌活散、厚朴丸、椒术丸等亦备具温热之味。可见河间继承仲景之学，适证选方，病寒者不远温热仍为其临床辨证选方之一大特色。

河间擅用寒凉及其创说火热病机，是有其特定的社会背景为依据的。河间生活的年代，战乱频繁，传染病、热性病广为流传。他通过临床实践，体察到很多外感热病是由于外感寒邪，闭郁于表，在里阳热之气不得发越，郁闭而发病；而风从火化，燥与热兼，六气皆可化火，故人之病以火热之病为多见。若对火热病仍用温热则助邪煽火，故创立寒凉之用药规律。提出怫热郁结于表，用石膏、滑石、葱、豉发散郁结，表证兼有里热的，用防风通圣散、双解散等表里双解；表证已解，里热郁结者，用诸承气汤荡涤里热；热毒极深，阳厥阴伤者，则以承气与黄连解毒汤合用泻火通结；大下之后，热势尤甚者，用黄连解毒汤，或凉膈散清解余热等等。河间对这一表里双解、辛凉解表的发展，自己曾说：“余自制双解，通圣辛凉之剂，不遵仲景法桂枝、麻黄发表之药，非余自炫，理在其中矣，故此一时，彼一时，奈五运六气有所更，世态居民有所变，天以常火，人以常动，动则属阳，静则属阴，内外皆扰，故不可峻用辛温火热之剂（《素问病机气宜保命集》）。”对此固然说明了这一发展的社会背景，而如以之对照《伤寒论》方药，如麻杏甘膏汤、大青龙汤、大柴胡汤等之比桔梗散、双解散、防风通圣散等，明显的同样是辛凉解表和表里双解的原则，这是河间继承和发展仲景学说的又一明显之处。仲景书是中医学史上第一部临床方药与论述俱备的著作，河间学说不从此处作为渊源所自，那将是不

可理解的，从河间自述之中也决非如此。

刘河间曾说过：“今人所习，皆近代方论而已，但究其末而不求其本”，“世人所集各异，人情喜温而恶寒”，于此可见河间所要求的，是纠正当时医学界的不究医理而拘于近世方论，纠正当时用药的喜温而恶寒等受《局方》影响而来的流弊，也是要求医者从《内经》、《伤寒论》等古籍中去温故知新，去针对疾病因历史、社会的发展而出现的新情况。

（三）河间方药多寒热并用、调达气机

河间提出火热形成的机理是结滞壅塞而气不通畅，“所谓热甚则腠理闭塞而郁结也。如火热炼灼，热极则相合而不能相离，故热郁则闭塞而不通畅也。”治法当“辛苦寒药下之，热退结散而无郁结也”，“郁结开通而不再结，气和而愈也（《素问玄机原病式·六气为病》）”。故河间无论用温热，还是用寒凉，还是寒热并用，都以调达气机为宗旨。用温热可开散郁结，用寒凉亦在开散郁结，但细析河间诸方之组合，则多为寒热并用，疏调相合。在其选用药方及自制药方如双解散中，石膏与麻黄合用，以解散表邪；大黄与生姜合用，以通利里结，治邪犯表里俱实证；其小续命汤中，桂枝与黄芩合用，以通阳涤热，治中风症；地黄饮子中地黄、石斛与桂附同用治风瘫；羌活汤中，羌活、菊花以散表邪，石膏、细辛以解里郁，治破伤风症；其神效越桃散中，以梔子、高良姜合用，治久痢腹中痛症；其治胸中不利之利膈丸，治痰热咳嗽的水煮金花丸等，均有寒热并用、补泻合方之药物组成，可见河间活用寒热，灵通加减，有其一定之规，即调达气机，以开除郁闭。郁闭得解，则邪可祛除，气可流通，血可复行，津可畅溢，诸症得以解除。

河间学说除主火论述、药主寒凉在医学上留下了重大影响而外，其辛凉解表法的发展，启温病学派的先河，并且刘氏

还初步提到了三焦辨证,在《素问病机气宜保命集》中说:“如身热脉洪无汗多渴者,是热在上焦,积于胸中,宜桔梗散治之”,在《伤寒直格》中说:“风热燥甚,客于下焦……并宜三乙承气汤。”他的这种论述,同样也为温病学派在理论上开了先河,因此后世有人在论述温病史时,将河间作为温病学派的先驱者,是有一定道理的,无疑这也是刘氏在中医学上的重大贡献。

(本文发表于1988年4月刘宁真学术研讨会)

外感热病表证的辨证

外感病是指六淫之邪侵犯人体而引起的疾病。此类病的发病起始,除了《内经》所说的“邪之所凑,其气必虚”的机体因素外,一般表现为自表入里的病变过程,而不是自里出表。由此意义而叫作“外感”。外感病的邪气侵袭途径,大致是二条:一是由皮毛而入,另一是由口鼻而入,二者在临床的多数情况下是兼见的。从古籍看,伤寒论的学说邪由皮毛而入的多,温病学说,邪由口鼻而入的多。古人于此有过较多的争论。个人意见:这是中医学的发展,是中医学的丰富过程。我们应该二者都予以掌握。外感致病因素的“六淫”,是指风、寒、暑、湿、燥、热(火)六种气候。这六种气候对正常人来说叫“六气”,对致病者来说则称之谓“六淫”。这是一个必须辨证认识的问题。致病与不致病,取决于人体正气的旺与衰和邪气的盛与微,从而在人群中可以引起发病或不发病;这点即使从传染病学角度来看,也含有人体免疫功能的问题在内。

六淫之邪各具自身的特性,故起病情况有所不同。但发病

后,在一定程度上,又有相类的转化规律。其特性是:

风邪:“善行而数变”,性浮越。所谓“伤于风者,上先受之”;为“百病之长”。

寒邪:性收引,凝滞;易伤人阳气。

暑邪:性升散。易伤人气阴。

湿邪:性重浊。臃滞、多趋下;易阻遏气机。

燥邪:性燥。《内经》云:“燥胜则干”;易伤阴液。

热邪:“火为热之极”,热火同类,有“炎上”之性,故与风邪同样具有传变迅速、易化火动风、易伤阴血的特性。

六淫共同具有的规律是,致病后绝大多数均可随着病程的发展而化热,所以均可以变成热病。热、暑等邪当然一发病就出现发热,就是寒邪,亦在表证中期后会出现发热,所以《内经》有“今夫热病者,皆伤寒之类也”的论述。后人又有“五气皆能化火”之说。正因为如此,我们在临床上接触到的外感病,大多数是有发热症状的,只是发热的程度有所不同,发热的迟早有所不同而已。

外感病既然都有由表入里的过程,所以初病时,绝大多数会出现表证,只有正虚邪盛的直中三阴型,表证出现极短暂而不易抓住。我们根据表证出现的不同情况,而分别予以不同的治疗方药。这就要运用辨证论治的方法。但总原则是在解表法的范围中进行辨证论治。之所以要用解表法,是因为六淫之邪侵犯人体,对人体来说是“客”。《内经》规定“客者除之”,“除之”的办法应该是找最捷的途径;病邪在表,使之由表排出体外是最佳径路,这就是解表法的使用意义所在。亦可体会为解除体表病邪之义;使病邪排出体表的手段是“发汗”。所以“解表法”亦称为“汗法”。

表证根据病邪、病位、正气的盛衰不同和发病季节的不同

而不同。由于这种不同，在临床表现为合成表证的各个症的不同。所谓辨证，就是分清这种不同的临床症状，而判明其病邪、病位和正气的盛衰状况；至于采取相应的治法和方药，乃是属于论治范围的了。

下面就表证中常见的几个症，以及可以伴发的症，来探讨其病因、病机特征及诊断要点：

（一）恶寒、恶风

恶寒、恶风，虽所恶不同，但历来没有明确的区别。如《伤寒论》12条，桂枝汤证，既提“啬啬恶寒”，又提“淅淅恶风”；13条桂枝汤条，又只提“恶风者”。所以古人只以恶寒的重与轻来区别，即恶风重者为恶寒，恶寒轻者为恶风；亦有以见风而寒者为恶风，不见风而亦寒者为恶寒。至于以孤症恶寒为伤于寒邪，恶风为伤于风邪，那是很难作为定论的，必须结合其它症来考察。如并见汗出，脉浮缓，始可定其为中于风邪；并见无汗，脉浮紧，身痛骨节疼痛等症始可定其为伤于寒邪，并应结合发病季节去考虑。不过临床常见到的是有汗者多恶风，因为有汗之时毛孔开发，风来则必然要收拒而渐渐怕风，若汗出而无恶风，在病机上正是卫强营弱，此时，阳浮于外，就不太可能恶寒；而在无汗脉紧之时，则往往恶寒。因为无汗而感到寒时，往往是病邪侵入皮毛的最初阶段，此时皮毛遇寒而收缩闭拒，卫阳则开始向表聚集以抗邪，是正邪交争之始，尚未达到“阳浮”、“卫强”程度。所以不见风亦寒，见风则更寒。基于病邪的特性，寒邪收引，凝滞，对人体刺激性较强，人体敏感性就强，皮毛的反应亦强；一方面因拒邪而收敛皮肤，一方面因“收引”而使皮毛收敛，加以“凝滞”加重了闭拒的时间和程度，所以恶寒的现象就明显。风邪则本身疏透善动，中人时皮毛收拒不敏感，迨至有感，已经较寒邪深入一层。此时皮毛闭则留邪、开则

汗出，从而出现啬啬恶寒、渐渐恶风、翕翕发热的情况，恶风的感觉就明显于恶寒的感觉。湿、暑、热三邪袭人之时，多数在暮春至初秋一段时间，此时皮毛都因适应气候之温热而开放，加之湿性润滞，暑性本热而多挟湿，以润或温之性入开发之毛窍，闭拒之势自是不显，所以恶寒或恶风的现象均少而轻。若热邪中人则更无恶风寒之象。如中暍证，须至汗出营弱，卫气始欲敛闭以保阴，故如阳暑或中暍症多在汗出后期才能见恶风之象。其初起即有恶风者，则往往挟杂风邪。燥邪本属“次寒”，对人的敏感性当然也次于寒，所以恶风寒之象也次之。暑气未退，凉风初来，人方以汗敛为快，中人于快意之时，人体拒邪性当然是不足的，从而皮毛的收拒力也就少了，因而只有轻微的渐然之感。

（二）汗

六淫中人，有起始无汗的，亦有起始即有汗的。有汗者如热、暑（阳暑）、湿；无汗者如寒、燥（凉燥）；风邪中之始，则可有汗或无汗，但有汗多于无汗，无汗之时亦极短暂。之所以有汗与无汗，取决于邪气的性质，中邪的季节、地域、人体正气抗邪的能力，以及邪气中于表层的深浅。从病位及人体的抗病趋势分析，大凡无汗者，病在表层之表，是皮毛收拒闭塞；有汗者，病在表层之里，是皮毛开发，正气欲驱邪外出。临床还要注意的，有汗时要区别汗的性质及汗多、汗少等情况。

《伤寒论》以无汗为伤于寒，有汗为中于风，以表不解而里热已盛之无汗者为风寒两感。推其原意，是从风邪化热快于寒邪化热之理而来的。证之临床，仍需追问发病期的长短和结合其他症状去判断。因为寒邪化热以后，也可有汗。此种有汗，就不能等同于中风初期之有汗了。从邪性而言，湿邪之汗多粘腻不畅，不见汗珠，风、暑、热之邪汗多清澈。寒邪热化后汗亦

多清澈。从季节言，自春至秋初，平人即易汗；夏季不汗反可致病；冬季严寒，人体本身要求“收拒”、“无泄皮肤”，虽欲求汗解但切肤有润湿感即为有汗。自地域言，北地寒重，无论平人、病人之汗象及发汗等要求，均当小于炎热之地。虚人之汗，阳虚者多，阴虚者无或少。其受邪亦自与平人有异，治法求汗亦当区别，均不能求其汗多。阳虚自汗者，但不闭表窍即可。正是基于这众多情况，所以病之温者、热者，属于阳邪者药多以辛凉、芳化为主；反之则以辛温发汗为主。医者但求其理，正不必为“寒”、“温”之争。

从汗法的最大使用范围看，自太阳病到少阳病，均可涉及。麻黄证无汗，但复方如麻杏石甘汤，即见有续续自汗症；桂枝汤证有汗，汗多濈然时作，作则恶风；葛根汤证可无汗，可有汗，无汗者多，有汗者汗亦少；小柴胡汤证可有汗，可无汗，汗出多在寒而热之后；白虎汤证则都有自汗出症。《温病条辨》中更记述是“大汗”。通过外感表证病程的进退看，大致上到有汗时，邪已经进入气分范围，到不恶风寒时，则邪已经离开卫分。

（三）发热

外感病发热一症，按正邪交争之说是种抗邪现象。开始于恶寒症出现的同时而次于恶寒出现。之所以次于恶风寒，在于抗邪的开始，皮毛收拒在先，形成“皮肤致密、腠理闭塞、玄府不通，卫气不得泄越”遂而先恶寒无汗，继以发热，渐至有汗，当其初有汗时发热是必然出现的。但恶风、恶寒之况尚未尽退，这是正邪相持、寒热交替阶段。所以《伤寒论》太阳篇中，既有“太阳之为病，脉浮头项强痛而恶寒”的记载，又说“太阳病发热汗出恶风”和“太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒”，这是表明表证初起先恶风寒，继而寒热同见，迨至发热而见有汗之时，病程有二种演变：一是邪从汗去（不论其一汗再汗）；一

是邪气盛，化热亦盛，不从汗解而渐入里。在此情况下，就由“或已发热，或未发热”变成“但发热”，同时发热情况也渐由轻重。以上系就风寒之邪而论的发热情况。

暑热之邪中人，初起就多见发热。《内经》说：“因于暑，汗，烦则喘喝，静则多言，体若燔炭。”暑邪是如此。热邪除形成外科痈疖等外，在内科病方面，本身就往往是因高温汗出过多而病，当然起病就可“体若燔炭”。湿邪中人，多“身热不扬”，此词之义，既不是不发热，也不完全是指热不高，而是指接触患者时，不像风寒暑热之邪所病那样热势灼手，实际上就是从目前所谓的“手感”而定的。湿温病就是到了日晡谵语之时，热势也往往不扬，这是决定于湿邪特性的粘腻润泽，阻遏气机，郁蒸于内而不扬于外。外燥之邪中人，不特恶寒轻，发热亦轻，主要症状表现在“清窍”不利，缘于“燥胜则干”，伤人津液，而不似寒邪以郁滞皮毛之为重灾区。由此可知，“汗法”的使用亦需慎重。

（四）其他常见症

大凡邪由皮毛而入者，多见头痛、体痛、骨节疼痛等症，邪由口鼻而入者，多见咽痛、咳嗽等症，但表里之间有相应关系。太阳经主表，而皮毛附于肌腠。是太阳经受病，则皮毛亦必然受病。皮毛内合手太阴肺，所以寒邪、风邪等之由皮毛而入者，未必没有咽痛、咳嗽等症。如《伤寒论》太阳病之有“呕逆”、“鼻鸣干呕”，有“恶风无汗而喘”，有“咽喉干燥”，有“发热而咳……或喘”等表不解时而见的口鼻症状。反之邪由口鼻而入者，亦未必没有皮毛肌肤症状，如《温病条辨》有“太阴之为病，……头痛，微恶风寒”，“太阴风湿、湿热、温疫、冬温，初起恶风寒者”；太阴伏暑病，有“头痛微恶寒”，太阴湿温、寒湿病有“头痛恶寒，身重疼痛”，温疟有“骨节疼烦”，秋燥有“头微痛恶

寒”、“如伤寒太阳证”等症状,这种情况说明二个道理:一是上受之邪,未必不能从皮毛而入,因为人在气交之中,六淫即是六气,人体整个是在此气之中的。二是从皮毛而入之邪,由于“腠理闭塞,玄府不通”,肺的正常宣发作用受到约束,致上焦不通而贲郁,逆于气道则为咳为喘,郁热耗阴则咽干咽痛;肺气贲而上则不降,肺气不降则胃气亦不降,遂而干呕。但临床要区别的是以何为主的问题,及其由于邪气的属性不同而一症中亦有所不同的问题。如头痛,寒邪中人,因其收引,且在太阳之经而痛甚,且痛引项背;风热之中人则因其上越而头为之昏;“中于湿”则“首如裹”而为头胀。又如咳嗽咽痛,燥邪袭人,其咳而咽痛,较风寒之邪为甚,且咳声清亮;湿邪中人,咳声重浊;可以有“声啾啾如室中言”的形象;寒邪中人则因肺胃气热而上逆致咳,热甚则咽干等等。

这些症状的出现,治其本的办法是用相应的“解表法”,但若突出到了主要矛盾,那是患者的痛苦所在,必须重点兼顾,予以解除。

(五)舌与苔

外感初起,设无其他因素,舌色常由正常而趋于红绛;部位亦由舌尖部向中部延伸。良因红色为热,热愈重则红色愈深,面积愈大;舌面的脏腑划分,尖为心肺,中为脾胃,热势由肺而延及胃,所以先见于舌尖,而后延及舌中;其红而起芒刺者热犹甚,热甚则红色转为绛色;又舌色的反应是表示正气的受累。所以外邪初袭,气血尚未达到郁热情况时,舌色可以见到正常。

舌苔要从颜色、湿润度、厚薄三个方面去观察。在外感初起时通常是薄白苔,渐由白而淡黄、向深黄转变,是表示邪渐化热入里。湿度亦随热化程度而相应由润而干而燥,古人说:

“有一分白即有一分表，有一分黄即有一分里”，此语在外感病方面是适用的。如果挟有宿积宿食，舌苔起始即厚而非薄；或起始即黄而非白；虚人则另有变化。舌苔的湿度，与邪性有一定关系，燥邪多干，湿邪多润或腻，甚至水滑；暑热之邪多苔少或干，或润，但若挟有过食生冷、积滞，亦可厚腻或黄燥。

总之，对舌与苔在外感病中的观察，要注意到患者的素体、习嗜和生活起居，并且要四诊合参，才能有较全面的了解。

（六）脉象

外感病常见到的脉象，首先是浮脉。中医学历来认为“浮脉主表”。在此基础上还可见到紧、缓、数、大、濡、涩等。如太阳伤寒“脉浮”、“脉阴阳俱紧”，太阳中风“脉缓”；桂枝汤证“脉浮弱”，麻黄汤证“脉浮紧”、“浮数”；太阴温病“脉不缓不紧而动数，或两寸独大”，或“脉浮洪”，或“浮大而芤”；湿温证脉“细而濡”；中脘“脉微弱”；秋燥“右脉数大”或“脉弦”等等。概言之，外感初起之脉，伤于寒者，多浮紧，伤于风者多浮缓，伤于湿者多濡，伤于暑热者多大或芤，伤于燥者多浮弦或浮涩；其间热渐重则脉渐数而大；无汗者多紧，有汗者多缓，或者称为弱。

有一个问题要搞清的是，中风的脉“缓”。此之缓，并非四至一息的缓，而是弛缓之缓，是与紧脉相对而言的；桂枝汤证的脉浮弱之“弱”，亦与此相类，是与紧脉相比而来的；太阳中风的症状是“发热，汗出、恶风”，“翕翕发热，鼻鸣干呕”。说明发热是肯定的。既有发热，脉如何能出现四至一息的缓呢？而应该至少是略数。《伤寒论》之所以称作缓，是在于此时之脉象已经不是紧，所以不紧是汗出而腠理开造成的。由于脉管已无被迫性的约束而渐舒张、增宽，脉象就变成弛缓，所以与紧脉比较就称之为缓为弱了。实际脉象应该是浮而略大兼数的混

合现象，由此更可推出桂枝汤证“阳浮而阴弱，阳浮者热自发，阴弱者汗自出”的所指。此处之“阳浮而阴弱”既是病理，又是脉象，阳浮是卫阳趋于表以抗邪，阳趋于表则发热而至玄府开，开则汗路以通；卫趋于表，营亦随之，而有汗原，惟其汗出不已，则营气受耗，所以称为阳浮阴弱。此与另条“营弱卫强”义同，阳浮于表则脉浮，腠理开，汗出则阴弱，阴弱则脉缓而弱。

表证之紧脉，一是由于外邪束表，腠理闭塞，肌肤皮毛紧缩，约束脉管而来；一是卫气抗邪，气血俱趋于表，正邪交争于表，脉管张力增加，血流旺盛而为浮为紧。此种情况，由于寒邪收引之性，正气抗邪之盛俱较它邪为著，故伤于寒者为多见：迨其腠理开汗出，则与感受风热之邪者同，而见脉浮大，因风热之邪易开腠理而汗出，故浮大、浮缓之脉为多见。暑热之邪性属阳属热，其中人也于毛窍疏发之时，无玄府不通之况（阴暑不在此例），所以初起即可见脉大。迨其夺汗伤营则脉转芤或微弱。湿邪粘滞，虽卫气亦与邪争于表，然气机阻遏，故脉见濡。濡者浮而鼓搏无力也。燥性收而干，收之甚者，则脉管受收束而如弦；收之轻者，则毛皮紧而为涩。《素问·平人氣象论》“秋胃微毛”之毛，即浮而微涩之义。若以毛等于浮，则与《素问·脉要精微论》之“春日浮，如鱼之游在波”义不相顺矣。迨燥邪热化，或温燥证，因其热而脉可数大。

以上所说脉象，是就六淫之邪初袭于平人而言的，若患者有宿恙，或复感，就另有变化。如动脉硬化症的患者，因其本身脉管就紧张，虽初感于邪，脉象就未必如此了。因而临床仍然要“四诊合参”，谨慎小心，尽可能的全面了解病况。

冬令进补琐谈

冬令进补,在我国已是传统习惯,至少可追溯到清代中后叶。民初清末时期,苏浙民间每到冬至节后,无论老幼均多少要吃点补药,其目的大致有二:一是冬季为“藏蛰之令”,根据《内经》“藏于精者,春不病温”的理论,此期服点补药以增强肾脏的“藏精”作用,使肾气、肾精旺盛,体力增强,提高正气的抗病作用,达到来春不生或少生“温热病”,此即所谓“春不病温”之要求;二是使幼年者加速生长发育,老龄者延年益寿。此种习惯在北方城市中也或多或少存在,不过是以饮食形式出现,或药食并用,如北京冬季吃涮羊肉,羊肉就是一味很好的补肾药食。旧时冬令进补,讲究一点的,要请较有名的中医侯脉察舌后开具体的补药方,再请药店煎炼成膏,称为“膏子药”,此类补药所费较多,煎炼操作也烦,头二三煎,至少要花24小时以上时间,还得加冰糖、大枣、蜂蜜收膏,当然一料药可服用整个冬季,每日早晚各用开水化服二匙,到立春前后才基本服完;一般群众就只能买点补益的中成药,如六味地黄丸、归脾丸、十全大补丸之类服用;亦有以祛伤活血药作为补剂服用的,部分妇女甚至用秋后再生的益母草嫩苗与米粉研和后服用,此药作用类似中药茺蔚子,有祛瘀生新之效,服后可感到身暖、耐寒力强,故常为农村妇女所信任;但有些未经医生对症下药的补剂,容易有副作用,多见的是出现鼻衄、甚至烦躁失眠。综观起来,只有开方煎膏的冬令补药能因人而异,针对性强,是符合中医药“辨证论治”要求的,因此效果亦较好。

上述情况,说明了冬令进补是有道理的,也提示了进补要针对体质的特异性,搞一刀切是无效、甚至是有害的。此类情

况现在仍然存在,笔者除见到鼻衄、烦热而外,还见到服用人参后身体发胖而四肢无力的副作用(当地称之为“参胖”),真所谓是“事与愿违”。究其原因,是因各人禀赋、生活习惯、饮食嗜好和所处的具体环境不同而形成的体质差异之故。在人体的生命活动过程中,从生长到衰老,是一种矛盾变化过程,其间为适应生活、社会和争取事业的成功等活动不断消耗心力、体力,也就是体内的阳气或阴精受到损耗,在人体上就出现阴虚、阳虚、气虚、血虚或阴阳并虚、气血并虚等耗损情况,此种虚损也可因疾病侵袭引起体内的物质或功能的亏损而来。各种虚损,在尚未达到发病程度时,就归之为体质问题,如果达到阴阳失去平衡到不能支持正常工作,就明确称之为“虚证”;此两类情况均是进补的对象,均可用补药来使其康复。但如果所进补药弄错了目标,那就会产生不良结果。近几年来,为适应社会需求,市场上补药多了,多到近乎泛滥,商品宣传上也不很确切,针对性模糊了,出现了一些副作用。如蜂皇浆,本来是比较平和的有效补剂,但有的同志服用了加有人参的蜂皇浆却出现心烦、口燥的感觉,这是因为这些同志并不是气虚体质,或者是气分有热,有补气作用的人参不适用之故;顺便提一提,《本草备要》中记载人参“能回元气于无何有之乡”。临床使用中对休克、血压低者确能起到迅速恢复的抢救作用,近代对人参研究中,认为其主要成分“人参皂甙”对血压有双相调节作用,但临床表明人参对末梢血管的收缩作用比较明显,所以才有确定的抗休克作用。因而以人参作补剂使用时,对形体壮实、红面的高血压患者应该慎重。对进补中其它应该注意的方面尚有:痰湿气虚之体,不宜用滋腻药品,如阿胶、熟地之类;阴虚火旺之体,不宜用辛热燥烈之药,如仙茅、鹿茸之类等等;中医学认为人体阴阳平衡时是最佳状态,不能用反方向补

药，阳亢用补阳药、阴盛用滋阴药，是犯“重阳”、“重阴”之弊的，阴阳中的一方太过，就会破坏平衡而引起疾病。因此，进补时，不是特殊情况需要都应该选用平和王道之品，不宜追求烈性药品，以避免出现太过情况。此外，在进补时要注意脾胃的消化功能，只有在消化吸收功能好时，补药才能为人体所利用而发挥作用，如果消化吸收不好，或者有些药物、食物妨碍了这种功能时，最好最贵的补药对人体来说等于是一堆无用的废品。因而对消化吸收功能不良的同志，应以恢复这种功能为第一要义，这也就是进补了；俗话说：“药补不如食补，食补不如好消化”，是有一定道理的。

以上谈了冬令进补的依据和应予注意的事项，再概括有针对性的补药、药食于后：

气虚：常有神疲乏力，气短懒言，自汗畏寒，头晕尿频和面色淡白无华，舌淡，苔白，脉软弱等症。可选用党参、黄芪、人参、白术等；中成药可选用补中益气丸、四君子丸、六君子丸、参芪膏，生脉饮、人参蜂皇浆等，食品中宜增加山药、莲肉、百合等品，或者用黄芪炖瘦肉吃。

血虚：易常见面、唇、指甲淡白，头晕、眼花，心悸，盗汗，失眠，舌淡，脉细弱等症。可选用当归、熟地、阿胶、白芍等，成药可选用归脾丸、人参养荣丸、十全大补丸、八珍丸、血宝等；食品中宜增加菠菜、动物肝脏、胡萝卜等，也可用当归、生姜炖羊肉（“当归生姜羊肉汤”方）吃，或多吃其它各类瘦肉。

中医学认为气血是相辅相成的，气能生血，血能养气，对气血俱虚的患者，上述二类症状可掺杂见到，进补时可根据偏颇情况在上述二类药中选用，血虚项例举的成药中，已经或多或少含有补气之品在内了，所以以补气药入补血方中，其方义就在于“气能生血”之理。

阴虚：常有虚火上炎，手足心烦热，口燥咽干，盗汗，遗精，多梦，舌红少苔，脉细数或弦数等症；可选用生地、白芍、首乌、山萸肉、生山药、玉竹、麦冬、女贞子等；成药可选用六味地黄丸、二至丸、龟板胶、大补阴丸、杞菊地黄丸、河车大造丸等；食品中宜增加海参、甲鱼、龟、淡菜、胡萝卜、猪蹄等。

阳虚：多见畏寒、自汗、四肢清冷、腰酸膝软、气喘促、身重、小便清长或大便溏薄，舌淡、脉大无力等证；可选用鹿茸、杞子、川断、狗脊、仙茅、杜仲、巴戟、苁蓉、冬虫夏草等；成药可选用桂附地黄丸、全鹿丸、参鹿补胶、鹿角胶、人参鹿茸丸等；食品宜增加羊肉、狗肉、牛骨髓、韭菜、核桃肉等。

在此再介绍一张抗衰老补方，名“首乌延寿丹”，方剂始于清初的董其昌，曾受到历史名医陆九芝，近代的秦伯未先生等推崇，药味较稳妥，对老年人稍劳即感疲乏，易有头晕耳鸣，腰膝酸软，筋骨不舒，易烦，便秘等症有治疗效果；对血压波动、手指麻木等中风先兆有一定的防护作用。但对肥湿之体、痰多、便溏的人不甚相宜，应用时应酌情增减药味。方剂如下：制何首乌 375 克，稀莪草、菟丝子各 500 克，杜仲、牛膝、女贞子各 250 克，忍冬花、生地各 125 克，桑椹子膏、金樱子膏、旱莲草膏、黑芝麻膏各 500 克。以上可研和做成丸药服，每日早晚各服 10~15 克。

对已经服用补药的同志，尚需注意二点，一是要少吃或不吃生冷、过腻的食品，以防影响脾胃功能，妨碍消化吸收；二是在不慎而外感发热或腹泻之时，要停止进补，以防补药敛邪，影响新发病的治愈。并且此期服补也是无效的，应在新病愈后再服。在进补的同时，还希望不要停止日常锻炼，须知抗衰老也好，增强体质也好，均不是仅凭进补能达到的。“流水不腐”，“生命在于运动”，是古语名谚，是有科学性的，并要避免情绪

激动，不心为形役，也是长寿之法；神、形修养与进补并举，可以收到更好的效果。

（本文为1990年北京市政协组稿）

谈外邪发病及其化热

外邪为外来致病因素的总称。就广义讲，应包括三因分症中之全部外因及不内外因中的部分因素，如饮食所伤和虫兽、金属所伤等，其定义在于病非自生而源于外来方面；但中医学传统习惯，只以六淫为其主要内涵，此可以称之为狭义；本文亦就此为言。

六淫即是六气，指风、寒、暑、湿、燥、火，是一年中的气候变化，当其不引起发病时，称之为六气，引起发病时称六淫；在自然现象中，有气候环境相同，而有人发病，有人不发病之象，由此可知，六淫的发病，尚有其它条件存在。

（一）外邪发病的相对性

下述情况，是相对性的要点：

邪 { 太过、不及、非时 → ← 机体抗邪能力大小 }
 { 六淫的属性 → ← 机体抗邪性敏感度 } E

六气的太过、不及和非时出现，构成最基本的致病因素，如冬不寒而暖，可导发冬温；冬令酷寒，可导致伤寒；夏暑太过，可致夺汗而中暑；夏不热而雨多，可致湿困；春暖暴寒，可导致风温等。不论其太过、不及或非时，总起来是邪气暴盛以致引起发病，此系“常”。有人在同此发病气候中不病，是因正气足以抗邪。在正邪斗争方面，人与人的抗邪能力不同，邪胜则病，正胜则不病，故发病或不发病亦是相对的，是邪气的强、

弱，与抗邪的正气的个体差异来决定的；所以说，邪正之间存在着辩证性。

六淫之邪各有属性，风、暑、火属阳，寒、燥、湿属阴，其因兼挟之邪而转化其属性者另当别论。人体对六淫的敏感度亦因个体差异而不同，如湿体、痰体人则易为湿邪所伤，火体则易为火、暑之邪所伤，阴虚者易受风邪、阳虚者易受寒邪等，故邪性与个体敏感度的不同，在发病中亦存在相对性、辩证性。

总之可知，外邪是发病的因素，抗邪能力是发病的条件，《素问·评热病论》说：“邪之所凑，其气必虚”，是就不同程度的正邪对抗中能引起发病这一焦点而言，而《素问·遗篇》所说的“正气存内，邪不可干”，虽似“其气必虚”的反面辞，但实际上无此种绝对性，应相对地去灵活理解。

（二）病发于阴和病发于阳

《伤寒论·太阳篇》云：“病有发热恶寒者，发于阳也，无热恶寒者，发于阴也。发于阳七日愈，发于阴六日愈，以阳数七、阴数六故也”，此节文字是外邪发病初起症状的属性描绘和预后推测，但历来注家对此意见不同：

1. 认为是中风、伤寒之区别。风伤卫，阳邪犯于阳分，故发热；寒伤营，阴邪犯于阴分，故恶寒而不发热。持此说者有《医宗金鉴》、程知、方有执、魏荔彤等，如魏氏言：“发阳发阴之义，不过就风为阳，卫亦阳，寒为阴，营亦阴而言，殊未及于三阴也。”

2. 认为是邪犯阳经、阴经的。寒邪加于阳，阳气郁而为热，寒邪加于阴，阴邪加于阴经，无阳可郁，故但恶寒。持此说者如尤在泾、陶节庵、《外台秘要》等；陶氏、王氏并且认为“发于阳者，可攻其外，发于阴者，可温其内；发表以

桂枝汤，温里宜四逆汤”。是将阴包括到直中三阴经证或三阴兼表证。

三 阴 表 证	{	太阴：“太阴中风，四肢烦疼。”“脉浮者可发汗，宜桂枝汤”。
		少阴：始得之，反发热，脉沉者，麻黄细辛附子汤主之”。按《伤寒·少阴篇》意，用此法的条件应具“二、三日无里证”始可。
		厥阴：“厥阴中风，脉微浮，为欲愈。”

从上引三阴表证《伤寒论》条文中，可推知太、厥二阴之既曰中风，则必有中风之发热见症如桂枝汤条所述者，少阴则已明言“反发热”，是三阴表证均有发热，但脉象不应而矣，不能符合“发于阴”的“无热恶寒”证。

3. 认为“阴阳指寒热”，“无热指初得病时，不是到底无热，发阴指阳证之阴，非直中于阴”，“勿渐分营卫经络”。持此说者有柯韵伯等。

上述三类不同意见，均就症状之发热恶寒、无热恶寒之发阳、发阴而言，对“六日愈”、“七日愈”之说，大都不主张拘泥印定，如尤在泾认为：“七日为阳气来复之日，六日为阴气盛满之候，故其病当愈耳，然六日七日，亦是概言阴阳病愈之法，大都如此，学者勿泥可也”。亦有随文就义，以为“阳行速，故常过经而迟愈一日，阴行迟，故常循经而早愈一日”（程知）。此条经文的解释，以症状为依据而判断其发于阳或发于阴，是通达可信的，从其预后的“发于阳七日愈，发于阴六日愈”的解释中，即使不拘泥于阳七、阴六之期；对发于阳比发于阴迟愈这点精神，不仅不能令人信服，亦未能自圆其说，举析于下：

1. 单就字面的发于阴论，包括到直中之阴，表证中的“阳证之阴”是可以的，但如果病发于阴经，则有卫阳不能抗邪，外

邪长驱直入之机存在,如此则不可能较发于阳者早愈,其直中三阴者更有危殆可能,遑论六日之愈期。

2. 以风伤卫之恶寒发热为“发于阳”,固然附合于临床症状,以寒伤营之无热恶寒为“发于阴”,则寒邪可以化热,《伤寒论》中已有“太阳病,或已发热,或未发热”之词,表明恶寒无热之后,必继之为恶寒发热,进而为但热不寒,几千年来证之临床亦大都如此,如魏荔彤说:“既在太阳,则未有不发热者,但迟速有间耳。至于恶寒则同也”,柯韵伯亦说“不是到底无热”,是古人已见到上种情况,故不论伤卫、伤营,或“阳证之阴”,终难框定发阴早愈于发阳之精神。

疾病之愈否与愈期之迟速,多因受邪轻重、抗邪能力之强弱、治疗当否而不同,故笔者认为:六日七日之愈期必须活看,就其概率之能附合于早愈迟愈精神者,仍应从正邪交争中双方之能量去求解。在正邪交争而发病之后,其正邪之比例,水平层次均极多而杂,其反映之症状亦随之不同,约分如下:

初 发 病 反 映	邪甚(+++) $\rightleftharpoons$ 正弱(++) — 反映迟(恶寒发热轻)
	邪微(-) $\rightleftharpoons$ 正微(+) — 反映轻微(恶寒不甚发热)
	邪甚(+++) $\rightleftharpoons$ 正虚(±) — 反映极微(恶寒无热而见里证)
	邪甚(+++) $\rightleftharpoons$ 正强(+++) — 反映强烈(恶寒发热重)

上述四类初病反映之症状中,只有邪微正亦微一种可有但微恶寒之象而即愈者,亦有在邪虽甚,但正气足以一战而歼之情况下出现微恶寒即愈之况,但就实际言,亦绝非不发热,发热自恶寒之象见即已开始,但有热著热微之别,其轻者但于

手触其肌肤而感知。患者则不甚了了，惟有恶寒畏风之感而矣。似此症状，临床可以遇到，亦确较自感恶寒发热者可以早愈。

（三）外邪化热条件

外邪之来，自肌表入或自口鼻入，邪入则正气起而抗之，于是表证见，表证具体症状之不同，表示着邪的性质、程度和抗邪能力的强弱；《素问·生气通天论》记载：“因于寒，欲如运枢，起居如惊，神气乃浮”、“因于湿，首如裹”、“因于暑，汗，烦则喘喝，静则多言，体若燔炭”等即此，大凡阴邪伤则恶寒重，阳邪伤则发热速；阴邪自下、自表而入，阳邪自上、自口鼻而入，所以寒、燥之邪恶寒重，恶寒而后发热，风、暑之邪病清窍者多，而恶寒轻、发热速。各种外邪发病的症状轻重，系于正气抗邪能力之强弱，强者症烈，弱者症缓而愈迟，有如发阳发阴节中所述者，但须识其症缓者不等于愈速。

邪气之化热，不独系于邪之属性，抗邪力是条件之一，热是正邪交争的产物；机体的本能是逢温暖则舒张，逢寒冷则收敛，故机体对风、暑之邪反应迟钝，对寒、燥之邪反应敏感；寒邪凌厉、使人悚然，其化热之理亦最可思索，有如下述：

寒邪袭入，表卫之阳起而拒之，毛窍、腠理收闭以拒邪，于是毛立肌栗，恶寒、甚则寒战诸症见，然而邪已中入毛窍、腠理之间，非闭户塞牖所可却，于是欲作汗而驱之。此期即阳气闭郁之时，亦即邪在卫分之时，阳气因欲驱邪而趋于表，表窍因拒邪而闭，所以谓之“闭郁”，柯韵伯谓：“斯时头项强疼已见，第阳气闭郁，尚未宣发，其恶寒、体痛、呕逆、脉紧，纯是阴寒为病”，迨其阳气趋表渐多渐旺，由郁闭而宣发，则恶寒渐次向发热转移，以至由无汗而有汗，至此则化热之机程大体备矣。此时为表证可愈之机契时期，治可助汗驱邪，邪从汗解而愈，设

治不得法，或未抓住时机，则病进而见自汗、恶风、发热等症，转入桂枝证。大致寒邪化热阶段，就《伤寒论》记载而言，始于麻黄，终于白虎之前，中间桂枝、葛根、大青龙等证，仍可划入寒化热过程中。迨至化热，则与温病治法雷同，《素问·热论篇》所谓“今夫热病者，皆伤寒之类也”。

风，热外邪化热迅速，既取决于邪性之疏开迅速，又取决于机体之亲和性，且袭自口鼻，故抗邪之现象为鼻塞流涕、咽痛、咳嗽为主，而皮毛之悚慄为轻，正邪之交争于卫分者短，直接争于气分者多，所以与伤寒较之为不见麻黄证，即见桂枝证，即桂枝之期亦甚短，而多以银翘证为主矣。

（四）外邪化热层次之症治

外邪化热，自六经辨证言，始于太阳，至阳明之初而止；自卫、气、营、血辨证言，始于卫而止于气初；自八纲辨证言，始于表实，经过表虚，至里热之前。临床依据者为症状，症状之综合为证，证既表示了发病层次，亦指导了治疗，故辨证论治为必循之法。初起病时之恶寒、体痛、头项强痛、脉浮紧、无汗，为表实证，其间恶寒无汗是要点，据之可用较强烈之发汗剂，如麻黄汤；渐而恶寒发热、汗出恶风，脉转浮大（缓），其中汗出恶风是表虚证要点，可据而用较缓之汗剂，如桂枝汤，此期变证：如无汗恶风而发热甚重，可用大青龙，解表而兼清热；或热甚耗伤津液则用葛根汤，伤津症之出现，有汗后卫强营弱，因卫强而热自发，因汗出而致营弱，仍有啬啬恶寒、淅淅恶风之邪在表证，又有翕翕发热、鼻鸣干呕之热症，后有因汗出营弱而津伤之项背强几几症，用葛根汤时应去麻黄，若因麻黄证热重而见项背强几几之伤津证时，用葛根汤应有麻黄。化热至此而备，过此则入白虎汤证或其它证矣。温邪初病之见证与寒邪有别，邪入清窍之始，轻者但鼻咽不利而微有见风尚啬，可用桑

菊饮,或桑杏汤等辛凉轻剂,渐重而咽痛干咳,发热有汗不解,用辛凉平剂银翘散,热重、汗多、渴饮、脉大用辛凉重剂白虎汤,至此与伤寒化热之治类矣,概而言之,外邪初起至化热之治,均在汗法中,但发汗之轻重有别,口汗、白解肌;麻黄、大青龙为发汗之强者,桂枝发汗之缓者,已属解肌之列,但与辛凉治温之桑菊、银翘比尚较烈,解肌之法终于白虎,故可用表法者亦止于此,此据《素问·热论》“三阳经络皆受其病,而未入于脏者,故可汗而已”之原则为划界,一入阳明腑或逆传途径,便非汗法可治。

(本文曾发表于《北京中医》1992年第2期)

外感热病前期辨治续谈

一、不囿于寒温流派,中病是求

1. 温病学说是《伤寒论》的发展。外感热病是指由外邪入侵而引起发热疾病的总称,《素问·热论》“今夫热病者,皆伤寒之类也”,以及“人之伤于寒也,则为病热”的论述,既表示了伤于寒邪可以发热,又表示了不限于寒邪,其它外邪侵袭而引起的热病,皆可以伤寒一类视之;所以后人推演出了不少病名,如冬温、风温、春温、湿温等都带以伤寒名称,《内经》又言:“凡病伤寒而成温者,先夏至之日者为病温,后夏至之日者为病暑。”这就明确了将各种外感热病统归于伤寒。基于如此,我们在治疗外感热病时,对中医学中寒、温学说及其流派,应该视作是学术的历史发展,而不应受其限制,要以“是证”、“是理”为归依,而定出“是方”、“是药”,其最大目的是疗效,是中

乎病而愈之。

2. 温病是伤寒的发展,其异同是中医发展的历史轨迹,其形成原因是时代、社会、人文、气候和疾病谱的不同。两者间的继承与发扬关系,从《伤寒论》、《温病条辨》二部代表性著作的内容上可以得到证明。

(1) 药物品味的增加:《内经》中用药不超过 15 种,而《伤寒论》中达 78 种,这是《伤寒论》在《内经》基础上的发展,到《温病条辨》中达 203 种,证之与张仲景同期的吴普所著本草记载 231 种(据尚志均辑本,有关书籍记达 441 种)至明代的《本草纲目》记载药品 1892 种的发展情况,《伤寒论》之与《温病条辨》的药品增加,其原因是相同的。《伤寒论》是第一部临床著作,其中有“风温”、“温病”、“湿病”、“痄病”(中暑)等病名的记载和治法,明显是包括了伤寒以外的热病治法,但由于历史,人文条件的限制,用方、用法必然不如后代,药品之少于《温病条辨》者犹是。

(2) 受邪途径的扩展:《伤寒论》中以邪自肌肤而入为论,温病以邪自口鼻而入为主而不排除肌肤而入途径,较之《伤寒论》观点有了新的发展;这与温病多发区的地卑湿重、凛冽之寒邪为少有关,临床上寒邪发病多全身之恶寒,身楚痛重于温病,温病多上呼吸道症状;这一概率至今犹见,由此可以证明,而温病中的“解肌”治法,明示是继承了《伤寒》的邪自肌肤而入观点的。

(3) 辨证方法的继承与扩展:《伤寒论》以六经为辨证方法,由太阳、阳明、少阳而入三阴,是据《素问·热病篇》“伤寒一日巨阳受之”、“二日阳明受之”而来的,但《伤寒论》在此基础上强调了传经与不传经,循经传,越经传和表里同病如太、少等合病、并病等的具体症状和辨治,是对《内经》的发展,是

由表入里的分层辨证方法,是竖式的辨证方法。温病学提出的卫、气、营、血四层辨证法,和三焦辨证法;其中,三焦是由上而下的分层辨证法,是横式的辨证方法,而三层中又各贯穿着卫、气、营、血的四层辨证,四层辨证实际上仍可视作是竖式的。

温病学中提到六经名称是常见的,如叶氏“三时伏气外感篇”春温证中就提到“藏于少阴,入春发于少阳”,风温中提到“失治则入手厥阴”,以及“暑热发于阳明”,“口鼻吸入之寒,即为中寒阴病,治当温里,分三阴见证施治”等,《温病条辨》中亦屡屡提到,如:上焦篇“凡病温者,始于上焦在手太阴”,“太阳之为病,脉不缓,不紧而动数(或两寸独大,尺肤热,头痛微恶风寒,身热自汗,口渴或不渴而咳,午后热甚者,名曰温病)”,中焦篇“阳明温病,下利谵语,阳明脉实或滑疾者,小承气汤主之”,下焦篇“热邪深入,或在少阴,或在厥阴,均宜复脉”。

据此可知,温病辨证方法,是继承了六经辨证法的,是六经辨证的发展,是地理、气候、疾病谱的变动而为了更适合于诊治要求的产物;它较之六经辨证更精细、更明确,但并不是离开六经辨证的凭空产物。

(4) 方剂的继承与发展:《伤寒》与温病的差异,主要在“太阳”与“上焦”的证治方面,到“阳明篇”和“中焦”时雷同之处就明显增加,从中更可看出其继承与发扬关系,现对白虎类及下法二者方剂进行比较如下表:

上述白虎汤类中温病较《伤寒》扩大了3个处方,下法中扩大了7个处方,白虎类主要是增设了挟湿、挟表、挟太阴虚寒之方,承气类中扩大了兼挟症的下法,使肺之痰壅、心包邪闭、小肠郁热漫痛、正虚不运药、津液不足之兼见于下证者各

表5 白虎汤类方与下法方剂比较表

	《伤寒论》	《温病条辨》
白虎汤类	白虎汤 白虎加人参汤	白虎汤 白虎加人参汤 白虎加桂枝汤 白虎加苍术汤 苍术白虎加草果方
下法	大承气汤 小承气汤 调胃承气汤 桃仁承气汤 麻子仁丸 蜜煎导法	大承气汤 小承气汤 调胃承气汤 桃仁承气汤 牛黄承气汤 护胃承气汤 宣白承气汤 导赤承气汤 加减桃仁承气汤 承气合小陷胸汤 增液承气汤 新加黄龙汤 麦冬麻仁汤

有针对性方，而加减桃仁承气为热入血室之实证提出了一个治法，凡此均可通过上表见到其继承《伤寒》而发扬之处。

二、抓住辨治要点

(一) 发病时的自然条件

1. 自然条件：六淫之邪，在季节中各有所胜，自常见者言为春温、夏暑、长夏多湿，秋燥冬寒，此为气交中的当季机体易受之邪。但四时之气候有不齐，或应至而不至，或未至而至；所以春寒重者，风温初起可如冬温，暑热不退，早秋仍可有暑温，

此外尚有伏邪,常见者如冬至前后之伏暑、暑疟。而且南北气候不同,北寒而南温,西燥而东湿,故江以南梅雨早临,春末即有湿温之疾可见;黄河流域雨季多在长夏,夏末始有湿温交阻之疾。由于年、时气候不齐,地区气候有异,应灵活运用《内经》运气学识,知常知变,古人就谈到“二百里外,气候即有不同”(张景岳),总之要以因时因地的具体情况为准。例如:

(1) 60年代初乙脑流行中,石家庄以石膏取效,两型年雨多湿重,京中用石膏多不效,而以芳化收功,是年治12人,无1例死亡,最重者昏迷达半月后始服中药,用小环境、湿箱、输氧等防感染,西药仅输液;中药因脉软而数,舌淡苔薄白,无白虎证可见而有痲疹,只用藿佩、银翘加生地、白芍出入,石膏偶用30克,每日加服安宫半料一丸,至10日后始醒,醒后语言遗忘,两肘内侧因拘挛过久而肌肉腐烂,不能屈伸,经引导发音,按摩敷药而愈,幸无后遗症,翌年入学,智力正常,其余患者亦均以银翘、藿香正气出入收效。此是年与年间暑热与湿气候不同之故。

(2) 1957年冬治交通部公路局一患者,平素有Ⅱ期高血压,血压常持续不降,是年冬寒,得感冒重症,发热恶寒无汗,身楚疼痛,脉浮紧数,舌红苔薄白,一派麻黄汤症,余以其有血压高改用银翘散,倍荆防量,一剂不得汗温度仍在 $T38.9^{\circ}\text{C}$,血压由 $160/100\text{mmHg}$ ($21.3/13.3\text{kPa}$)升至 $165/105\text{mmHg}$ ($22.1/14.0\text{kPa}$),诸症如前,再进2剂,嘱4次1日服完。第三日来复诊,仍无汗,收缩压又升至 200mmHg (26.7kPa),不得已于原方加麻黄5分后下,羌活2钱,嘱服后如有头晕眩时即来医院,翌日上午来电,昨下午药后畅汗,热退,今晨服二煎,血压由医务室复查已降至 $160/96\text{mmHg}$ ($21.3/12.8\text{kPa}$),今日在家休息,明日再来医院,第五日来诊,诸症俱平,仍予银翘

散2剂调理。此患者以与余友好有年，放心委任，配合而收效。于此可见，北地冬寒见麻黄证时，不比南方可以银翘竟事也。

(3) 1991年2月初治一患者，高热50余日，曾用大剂银翘、清营及各种抗生素不效，会诊中因阳明症见，而兼发白痞，诊为伏暑晚发，汗湿郁表，用苦辛芳化解肌，停各种西药，3剂即平。此案为伏邪变法者。

2. 发病时的机体条件

机体的个体差异：中医学所言太阴之人、少阳之人等固然不宜刻板印定，但痰湿之体、火体、体脑劳动之不同，以及情志变化，是与发病有明显关系的，肥人湿胜，瘦人多火，用脑多则五志化火，构成了肥体多挟痰湿，火体易见阴虚的致病机因，外感热病过程中每易见此夹杂之邪。栉风沐雨，所谓藜藿之体之病者其感于邪者，以其筋骨劲强，初起治疗要抓住外邪，若用药准而狠，可一击而溃。如：

(1) 1949年冬已近春节治××，业农，午前恶寒战慄头痛，无汗，脉紧苔白，覆重被仍战慄不止，用九味羌活汤（苏南人畏麻黄，医亦不敢贸然），嘱服后汗出时不得更衣，初煎服后，汗畅热退，因不耐湿衣，更衣而复热，复招视，悉尚未服二煎，嘱继服，遵不更衣戒而愈。

上述患者若非体力劳动者，难于用峻药，亦难于覆杯而得汗，所以对处深室、少活动、用脑力、受微邪而病者，药宜性缓量轻，京中旧称果子药者即此，否则大汗亡阴或亡阳者有之。

(2) 1952年曾有西药房主之子陈×，刚操商业，外感后其父投阿斯匹林2克（4片），汗不止，而气短神萎如迷，就询于我，嘱进浓米饮，加服少量阿托品而安。此种工作体质不同而药不同情况，于中暑症中尤宜留心，所谓阳暑、阴暑之不同，

得之劳作于烈日之下，汗出过度而病者，只宜辛凉育气阴；而高堂大厦，长弄纳凉，浮瓜沉李，生冷内戕而病暑者，自宜从暑为阴邪之说，用“大顺散”之类。由体质之差异而治有不循常理者，虽仅百分之几，但亦不得不留心。

(3) 1988年夏治李×，年已70余，形体不充，纳食不馨，初夏犹穿冬装，畏寒特甚，真属“六月披裘”，外感数月不愈，形寒无汗，鼻灼鼻塞而时流清涕，脉不浮而沉小软，舌瘦硬而苔白中厚，前医已屡进桂枝、银翘、柴胡，病不少解。诊为气虚外感，投补中益气加荆、杏，2剂而脱棉，5剂而卸绒，1周后愈，此后凡有外感即按此法收效。

情志之与外感，病前关系不多，唯沉思致志之时，易受空隙之邪，奔波道途者易受寒暑之袭，此唯体壮者或可免；病后则忧虑恐惧，每有妨于病愈，唯在医者护者导之解之，需用语言、暗示等心理治疗。有一种性僻而又骄娇之人，自以为是，不听医嘱，一意孤行，指名要药，所谓“骄恣不论于理者”，尤需予以说理，求得医患合作。

(二) 表病中的邪正关系及其传变

1. 表证之起，即是邪正相争，外感病中的邪是六淫，即外来的风、寒、暑、湿、燥、火，在通常情况下，本是四时的常规气候，称为六气，当机体因之发病，或反常气候引起发病时，称之为六淫，六气与六淫是辨证性的，其区别在于发病与否，而发病与否，又受机体条件的影响，因此六淫只能对发病而言。当邪侵机体，体内抗病的正气即起而对抗时，就出现症状，恶寒或恶风，是对抗，初期毛窍闭塞，一方面是要拒敌于国门之外，一方面是正气在蓄积能量时调动全身的表现，所以此时多无汗，实际上此时就是发热的开始，当正气蓄积能量上升，热度也就上升，而患者就感到发热，发热是抗病力量旺盛的表示。

正因此理，虚人的发热低，或者时间上要推移；当热量蓄积到超越机体的承受度，就引起体内的调节作用开始，用出汗来散热，故继之以汗出。此期是卫分证向气分证转化之期，也是从麻黄证到桂枝证的用药病机时间，热甚而属温病的患者，此期是从桂枝到银翘，以至到白虎汤的用药病机时间。此期治法总属解表，或辛温、或辛凉，《伤寒论》归之太阳病，无汗用麻黄，有汗用桂枝，多有恶寒或恶风情况，两者在舌质上的区别是红色的轻重。温病因恶寒少而时间短，故恶风时即用桂枝，但仍求舌色正常，若见红舌而如桂枝之渐渐恶风，翕翕发热，汗自出或时汗时不汗者，即是银翘证，《温病条辨》仅一提桂枝汤而即转入银翘者，即在于恶寒之时间短且少之故。

2. 病机过此阶段，自六经传变而言，或入阳明，或入少阳，其虚人之阳虚者直入太阴，阴虚者直入少阴或厥阴。至于直中之阴证则往往太阳病初起后即见。六经传变并不定如《伤寒论》篇章所定顺序，传不以次，始于太阳，此后则视经气之衰者而传之，所以《伤寒论》中六经皆有中风条文，还有合病、并病。

总而言之，三阳病皆可归之于表，都可用解表解肌之法，太阳固无须论，阳明之白虎汤，温病称之为解肌，少阳之小柴胡、大柴胡，亦为枢转邪气外出，所以药性赋中有“疗肌解表干葛先而柴胡次之”之说，《素问·热论》：“三阳经络皆受其病而未入于藏者，故可汗而已。”因此，诊视外感病，总忌用闭塞表窍之药，即使传入到三阳之腑，仍要留此祛邪之路，因为中医治疗是开门驱贼，不是关门打死狗，若不如此，将用5倍、10倍兵力去打歼灭战，机体正气将难于承受。

温病自口鼻受邪之后，分顺传、逆传两途，顺传则入阳明进入中焦，治法与《伤寒论》阳明病篇相类，逆传则入心包而险

症蜂起；风温、温热类病，多此传变之症，湿温之病，在传入中焦前，尚有传膈入胆一层，传膈则亦有继之而入心包者；由膈传胆则见少阳证之往来寒热，进入入肝、入下焦；因其粘腻之邪性，而可见到谵语、神昏、抽搐，但自与直逆逆络者有其不同之处，不能混同论治。

记余初业医时，先外祖于麦秋后病湿温，第二日闻而往诊，午前神清，午后三点钟时见谵语，呼醒后可正确答语一二句，旋即答非所问，不问则鼾睡，肤汗粘腻，面色紫浊，舌苔黄腻满布，脉大而略数，便溏溲赤，此正湿温传膈之证，当时尚未学到菖蒲郁金汤境界，只以苦辛芳化，芩、连、枳、朴、菖、佩、六一之属调治，近2周始痊。设加投开豁，当可缩短病期。

外感热病在三阳经阶段，在卫、气阶段，大体上均属正气足以抗邪之境，若纵论虚实，则“邪之所凑，其气必虚”，各种疾病之正邪虚实，不出此一论断，但正气能否抗邪，则三阳证必然相对为正气盛时，较之三阴证之正虚不足，自有区别。病势在三阳阶段，亦为最亢时期，临床治疗，大都需致力于此一阶段，为医者治疗热病能事之第一大部分。温病三焦及卫气营血辨证划线，较详细于六经分证，上焦逆传中即有卫气营血四层见症之出现，如麻疹、中焦之斑疹，亦为营血证，而发黄症就其胆汁逆入血分观之，虽由湿热薰蒸而来，然亦未始不涉及血，《伤寒论》太阳、阳明之蓄血，虽亦为血分证，但较之《温病学》为疏阔。邪正相争之高下，进退位置亦于此可见。

3. 邪之属性与正邪进退有其特定关系。六淫之邪中，寒性凛冽，易于激起正气抵抗；风邪疏利，起病传变迅速；湿邪粘滞，易于缠绵难解，亦易稽留于卫、气之分；暑邪温散，当其天热汗出时，易中人于无意之间；燥为次寒，每多挟温挟寒而为病，好犯清窍；由此而正气抗邪之见症亦随之而异。其邪散之

势,若治疗及时而正确,大致为暑风之邪易,湿邪最慢,寒燥在二者之间;对医者而言,风邪需防其因传变之速而出现伤阴,阳暑之邪需留心其夺汗而昏厥,湿邪常稽滞表分与中焦,需耐心清化,稳步进退用药,后期内陷阴分亦可有寒化之症,此三者较之寒燥尤宜多留一番心意。

(三) 几个鉴别重点

1. 卫分与气分:卫分证相当于太阳麻黄汤,以恶风寒、无汗发热为主症,可兼见身楚肢厥、头昏痛胀等症状。其划界症状为汗之有无,无汗纯属卫分,一见有汗便是向气分转化,迨至但发热不恶风寒时,则已全入气分境界。其间肢厥冷,或但足厥冷,可提示其后之发热轻重,厥冷之时间越久,则后之发热越高,恶寒亦然;麻疹之起,形同外感,但发热后尚往往有四肢尖、耳尖、鼻尖触之发冷之况,因其邪郁肌肤,故卫分、气分之症同见而稽滞。此种卫气间进退之期,大约为桂枝或银翘之适应期,麻杏甘膏、大青龙、葛根汤,均在此一阶段,其司化热程度,总以舌质红色之深浅为据,而参以天时定用方。六淫之邪中,卫分证之明显者,顺序为寒、风、燥、湿、暑、热之邪,卫分证甚短暂,或一起遂有但热不恶寒者,此期用药,要慎重于发表与清热之主次,有汗热重而用麻黄或桂枝,可有汗漏亡阴以至亡阳之误;无汗而用石膏或配发表之力不足,症多不解。

(1) 1982年春治一外感,恶寒无汗,发热不甚,微有咳嗽,脉但浮小而不数,前医用麻杏甘膏,将重麻轻,再易方,1周不解,恶寒愈甚而腹冷,改投银翘散去芦根、竹叶,重荆芥炭,加防风、陈、枳于其间,2剂即平。此正石膏证不具之故。

(2) 1984年11月间,住院患者柯×,发热恶寒,寒轻热重,身楚咽痛,10日不解,曾用安乃近、复方新诺明及青霉素静点,热高时可达 $T40^{\circ}\text{C}$,入院时热达 $T38.2^{\circ}\text{C}$,经治医因热

势鸱张，咽痛而舌红苔少，虑及热伤津液，而着眼于清热保津，仿银翘加生地、元参方，益入白虎法，用银花 30 克，连翘 20 克，芥穗 10 克，豆豉 10 克，公英 12 克，野菊花 20 克，前胡 10 克，生地 10 克，麦冬 10 克，元参 10 克，石膏（先煎）15 克，知母 10 克，生甘草 6 克。叠进 2 剂，一日 4 次服完，入暮时体温反增至 39℃，就余商酌，审得病后始终无汗，药后亦无汗，明是表闭邪无去路，建议原方去前胡、麦冬、石膏、知母，加羌活 10 克，防风 10 克，牛蒡 10 克，薄荷 10 克。一剂得汗而热退，凌晨体温降至 37.1℃，此后调理 4 日而愈。此亦因表卫未开之故。

汗漏亡阳之训，《伤寒论》桂枝证中已有明文，多为辛温误汗而成。按桂枝条中“阳浮而阴弱，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出”之意，不特可知抗邪时之营卫俱臻于表，且可知汗出为阳浮之力所致，阳强于阴（营），汗多则营伤，故在亡阳之前必有亡阴之实，汗漏是也。此温病学所重视胜于亡阳者。是均为卫气交错期所宜审慎者。

2. 气、营、血分：邪入营分，晚热甚于昼热，但多气营俱燔之证，则日夜俱热，唯营分证有舌绛苔少，入夜神烦识迷之象，若有斑疹，则未出于肤，隐约于肤下而不碍手者属营分，出于肤而碍手者属血分。叶氏言“在卫汗之可也，到气才宜清气，乍入营分犹可透热仍转气分而解”，故邪虽入营，总需留开达治法，清气之药未可全抛，即“至于入血，则恐耗血动血，直需凉血散血”之时，亦当留此病邪出路，此因邪自卫而气而营而血，洞澈四层，虽已入血，气分未必无留邪也。血分病动血而见出血者，叶氏只言“散血”，不云止血者，因止血则留瘀，瘀热结则邪难撤，此语对近时热病之微循环病机可说是卓见先声。

（1）记余弟病湿温伤寒肠出血，上午定连、苓、柏、赤芍、

片交曰：方，不敢自专，下午请太师伯诊，加服紫雪丹，黄昏后狂躁立舞，歌笑，摩父脸，便如柏油，舌苔黄腻中黑，翌日凌晨急请师叔诊视，商定仍服连芩方。一日连进2剂，入晚得神安，嗣后坚守苦寒凉血，得以痊愈，此亦合于凉血散血之意。又有一种由气协营而见斑疹者，完全可用还邪于气之治。

(2) 1990年4月，治××，湿热稽留少阳三焦，发热午后重，汗少而粘，斑疹隐约肤下，热起则见，热退则伏，舌苔黄腻，已投银翘、玉女、清营不效，余以为湿热协营而非入营，用苦辛清气，如：黄芩、连翘、黄连、炒山栀、虎杖、杏仁、蔻仁、苡仁、威灵仙等，3剂而斑疹除，但热势虽日晡仅起1小时而低，仍未除，续以原法变化服至6剂而退。余因参加全国第二屏急诊会议离京，归后热势又起，苔色又见黄腻厚，改投苦寒，用酒军、虎杖等，6剂而退。

3. 经证腑证。三阳经均有经腑证，太阳腑证为蓄水或蓄血，阳明腑证则为三承气证，少阳腑证为胆热发黄，此在温病中涉及面更广，可达到募原、三焦范围；三焦者以湿温病为多见。太阳蓄水证，为热邪传入膀胱，或汗、吐太过而伤及津液引起，例如，服麻黄桂枝汗多后出现“小便不利，微热消渴者”便是，亦有“渴欲饮水”，水入太多，继之而“水入欲吐者，名口水逆”。则为津伤而挟胃中停水所致，甚则可见眩晕。蓄血则太阳、阳明俱可见到，为热邪搏血所致，可见溲清利而少腹硬满，妇女经期前后热病邪入血室，若经血未去而与热结者，证治皆可仿此。三承气证各证条析明而篇幅多，其中唯热结旁流症须着意，症见下利屡欲固，而结粪不下，易于判断不准，误认下利，此情必用腹诊如大承气之摸到左下腹有条块始能确定。少阳腑之发黄很明显，若为湿浊阻滞，则虽不发黄，而有往来寒热，两胁拘痛苦满之象，验之于苔必多黄浊，自此推之，少阳与

肝为表里，肝脉循少腹络阴器，故热入血室之无血可结者，可用刺期门及小柴胡之治，《伤寒论》虽归入太阳篇中，然自其还邪于半表半里而后撤思之，未始与少阳无关。

4. 邪传膈，传心包，传阳明；邪传膈，传心包，与“温邪上受”，是热病病机方面，温病学说在《伤寒论》基础上的发展之处。从症状看，传膈之说仍导源于《伤寒论·太阳篇》“膈内拒痛，胃中空虚，客气动膈，短气躁烦，心中懊侬，阳气内陷，心下因鞕”之结胸证，“心下痞，按之濡”及“心下但满而不痛者”之痞证，以及“反复颠倒，心中懊侬”、“若少气”、“若呕”或“烦热胸中窒”之懊侬烦满证（栀子汤证）均与邪犯膈相类，按邪犯膈之证，发热而外，主要为心中懊侬痞烦或呕，大致如上述之证，结胸条中，已明言“客气动膈”，但大陷胸汤之“膈下拒痛”为热与积滞相结，与叶氏论“一病有不传血分者，邪留三焦”，“三焦不从外解，必致里结”于阳明者，因其为“湿邪内搏，下之宜轻”者有别，叶氏之下，所指为小陷胸或泻心汤，并且慎重提出“必验之于舌，或黄或浊”，“若有不燥（指苔），或黄白相兼，或灰白不渴，慎不可乱投苦泄”，从而区别了大陷胸证与温病犯膈之异。

结胸、痞、懊侬三者，或为误下，或为邪热自入，与邪犯膈之机理同，但结胸、痞、懊侬证无神志症状，温邪犯膈之重者可见谵语，神迷之昏迷前驱症，此种神志症状为温湿之邪蒙蔽心包臣使之路而起，并非邪入心包络，故与风温、温热之邪直入心包者有别。别在于病位：前者在包络之外，后者在包络之内；别在于邪性：前者多温热、湿浊，后者多风温，温热；别在于症状：湿热、湿浊之症，热势之重时在日晡，神志之症亦多见于此时，平时多身热不扬，汗粘腻，舌绛苔多黄腻黄浊，风温、温热之症，多入夜热甚，神情随之不慧，汗多清澈，舌多绛，苔多白

燥或黄燥，且每多兼见阴伤或营分证。

上情较之阳明经证，病邪均未与食滞或燥矢相结；以阳明经证较之湿温犯膈，则湿温多邪性粘滞一层，热蕴湿中，湿为热基，湿不去则热不解，而阳明经证若无兼挟之邪，则大热、大汗、大渴、脉大之四大症具，自与湿热粘滞之热不同，且谵语神迷之象因有汗解之机而极少见，有亦时间甚短暂。

较之阳明腑证，逆传、犯膈及阳明经证均无燥实之腹部症，痞满则与湿热病同，舌苔黄厚之象亦可同，但腑证燥而湿证腻，日晒之热腑证较经证向后延长，且腑证溲多利，湿热证溲多黄赤短，故据症而辅以腹诊之可触及条状、球状结粪，可资鉴别。

《世补斋医书》持病入阳明始有神昏的观点，自有一定之理，但据此而反对逆传心包，反对由犯膈而致之神昏，则未免胶柱鼓瑟。

（本文为1993年讲学稿，其中部分辨治内容曾以《外感初期辨证琐谈》名发表于1985年《中医报创刊号》。）

学习《素问·四气调神大论》

古代学术来源于实践，而往往为历史、社会条件所影响。《内经》是中医学现存的一部最古著作，由于当时还不能完全正确解释疾病、生理等各个方面，就有可能以“形而上者谓之道”的比类联想去解释、填充其不能在实际中求得解决的部分，因而我们在学习《内经》时，要从历史角度去理解其内涵。现就《素问·四气调神大论》篇提出如下见解。

原文：“春三月，此谓发陈。天地俱生，万物以荣；夜卧早

起，广步于庭，被发缓形，以使志生；生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚，此春气之应、养生之道也。逆之则伤肝，夏为寒变，奉长者少。

夏三月，此谓蕃秀。天地气交，万物华实；夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外，此夏气之应，养长之道也。逆之则伤心。秋为痾泄，奉收者少，冬至重病。

秋三月，此谓容平。天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴；使志安宁，以缓秋刑；收敛神气，使秋气平；无外其志，使肺气清，此秋气之应，养收之道也。逆之则伤肺，冬为飧泄，奉藏者少。

冬三月，此为闭藏。水冰地坼，勿扰乎阳；早卧晚起，必待日光；使志若伏若匿，若有私意，若已有得；去寒就温，无泄皮肤，使气亟夺，此冬气之应，养藏之道也。逆之则伤肾，春为痿厥，奉生者少。”

以上一大段、四小节文章，是《素问·四气调神大论》的主要部分，也是其主题所在，以立春、立夏、立秋、立冬以后各3个月为“四气”，根据各气的自然气候来调护人体，就叫“调神”。所谓“气”，大致上相同于现在的“季”。因强调四季温热、凉寒气候对人体的影响而称之为气。

各小节中，均可分作三个部分，如“春三月”至“万物以荣”；“夏三月”至“万物华实”，“秋三月”至“地气以明”，“冬三月”至“勿扰乎阳”是对各季自然气候和自然界生物变化的概括；又如“春三月”节中，自“夜卧早起”至“养生之道也”，是要求根据春季自然情况去“调神”的部分，其间包括形态上的适应和情志上的适应，以作为养生的规律，自“逆之则伤肝”至结束，是谈违反了适应自然所能引起的病变影响。其它各季均是

如此。

根据本段文章可以看出,所谓“调神”,是完全建立在对自然气候的适应基础上的。所以提出了“此春气之应”,“此夏季之应”等等。应该承认,对自然界气候的适应是各种生物所共有的,今天我们仍然可以举目即见。在当时的条件下,古人能够通过对于自然界的观察,来求得适应自然界的方法而避免不必要的疾病产生,是具有进步意义的,如果人类在形成的演变过程中违反了、或者不能适应自然环境的话,那就会象其它已经绝种或停止进化的生物一样,就形成不了人类。由此可见是应该肯定它的进步性的,但并不应该满足于此。适应自然虽然也是从与自然斗争中所获得的知识,但这种被动性适应,充其量只能起到保存自己的作用,并不能改造自然和让自然为人类服务,如果我们满足于这种古代知识和防病措施,那末今天的三班制工作就不可能出现了,人造雨、南树北植和越冬种植等农业上的发展就不能取得,这种古老的防病法,更不能与今天免疫学的成就相比拟,今天所取得的这些进步,不仅说明了人类不曾满足古人的措施,也说明了这一古代措施的局限性。

文章中所提到的适应方法,如春季的“广步于庭,被发缓形”;夏季的既要“无厌于日”,又要“使志无怒”;秋季的“使志安宁”、“收敛神气”;冬季的“早卧晚起,必得日光”,“去寒就温,无泄皮肤”等等,究竟哪些人能够做到?秦以前的奴隶,连人身自由也没有,想都不敢想适应自然气候的方法,而只有被买卖、被迫劳动的份。秦、汉间“黔者”、“薰民”,虽然有了人身自由,但在征赋徭役的重重压迫下,也无闲去用这些方法;要用力就无法“无泄皮肤”,有徭役就无法“早卧晚起,必待日光”,当然也就没有“被发缓形,广步于庭”的可能了,在被奴役、被压迫的劳动人民身上要求做到“使志无怒”、“使志安宁”

更是空话。能够做到“调神”要求的，毫无疑问的只有奴隶主贵族、封建统治者及其以此为基础的上层人员，并且如夏季一节的“无厌于日”和“使气得泄”等提法，正是针对王公贵人的养尊处优、广厦深居的避暑情况的，这些人夏天不出汗，违反了生理常规，才要求“使气得泄，若所爱在外”，劳动人民在夏季没有不出汗的，用不到要求“泄”，而是相反的“泄”得太过，按生理应该要求少“泄”，由此可见，这篇文章是针对当时的统治者而言的。

原文：“天气清浄光明者也，藏德不止，故不下也，大明则日月不明，邪害空窍。阳气者闭塞，地气者冒明，云雾不精，则上应白露不下，交通不表，万物命故不施，不施则名木多死，忘气不发，风雨不节，白露不下，则菡萏不荣。贼风数至，暴雨数起，天地四时不相保，与道相失，则未央绝灭。唯圣人从之，故身无奇病，万物不失，生气不竭。”

本节大体上谈自然气候变化对生物的关系，特别侧重在反常气候对生物的影响方面，而借圣人来作为适应方法的标准。节中认为，天气本身是清浄光明的，但它不能太暴露明，如果太明了，就会使日月不明，天气所以能不暴露明，是因为“藏德不止”。古人对“藏德不止”，都以“天德不露，健运不息”的含义来作解释，但与下文“故不下也”的衔接解释有困难，因为“健运不息”不能构成“不下”的基础，用“藏德不止”来作为不下的原因，只解决了文字组织上的结构问题，而与下文“交通不表”相矛盾，既然“交通”的表现是“地气上为云，天气下为雨”，那就说明天气是应该下的。“不下”等于是“交通不表”的失常现象，而不是天气的应有情况。所以“不下”应与下文“大明则日月不明”的太过现象连看、连解，只能是指太过的，能引起“日月不明”的下而言。

“天明则日月不明”是有辩证性的，当星球形成中，也可能存在过“天明”情况，当此之时，宇宙内的生命是否已经形成是难以想象的，但到太阳系形成后，如果再要“天明”，那对生物来说，“邪害空窍”的情况就是必然的了。

此后各段，分别论述了因天气下降不足、地气上升太多而引起“名木多死”，因天地气交的郁闭而引起了“菟藁不荣”，因天地气交的太过，致暴风雨屡作而引起生物的“未央绝灭”等情况，均是符合于自然界的客观存在的。

至于圣人之说，不过是想象中的偶象，即使真有具备了《素问·古天真论》中所提到的圣人条件的人，做到了“身无奇病”，也只是对疾病的消积防御，当然在自然气候极端反常的情况，注意摄生是应该的，但如果不依靠集体，只依靠个人是不会收到好效果的，因此我们要发动全体人民来防病治病。

原文：“逆春气，则少阳不生，肝气内变；逆夏气，则太阳不长，心气内洞；逆秋气，则太阴不收，肺气焦满；逆冬气，则少阴不藏，肾气独沉。

夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。道者，圣人之行，愚者佩之。”

此段是重述违背了四时气候规律的适应性，可以引起疾病，具有一定的自然科学基础，对人类以外的自然界生物仍然起着作用，对人类也在一定程度上起着作用，只是人类在长期与自然界的斗争中取得了丰富的实践知识，而大大超越了当时的这种被动情况，因此也就不是绝对的“逆之则灾害生”了，在具有条件的情况下，是可逆的了。

至于“肝气内变”、“心气内洞”、“肺气焦满”、“肾气独沉”等说,也是篇首“逆之则伤肝”等的重申,这些只是疾病发生规律之一,而不是全部。自然界气候本身有太过、不及的不同情况,人体机能也有强弱的不同情况,以及违背自然气候的情况也有不同,因而发病也就不会一样。如“逆秋气则太阴不收,肺气焦满”之况,只能在自然界气候过热、人体肺阴不足或肺热太过等特定条件下才会出现,反之则否。

原文:“从阴阳则生,逆之则死,从之则治,逆之则乱。反顺为逆,是谓内格。是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎。”

此节是全篇的总结,申述违背了四时摄生规律,重的可以成为生死问题,轻的可以成为健康与否的问题,再而申述“治未病”(预防)的重要性。

“治未病”的观点,在当时历史条件下,是具有重大进步性的预防观点,直到今天,尚有其现实指导意义,只有预防疾病的发生,才能最大限度地保护劳动力,保护人民健康。医学是为广大劳动人民服务的,《内经》在秦、汉时期提出预防观点的巨大意义是应该肯定的。这里要区别的是,我们不应片面的“不治已病”和“不治已乱”,尽管治已病和治已乱确实比“治未病”和“治未乱”是晚了,但病了不治就不是人道主义,更不是解决矛盾的办法。

《素问·四气调神大论》的全篇宗旨,是在于要求人们能按照自然气候的规律去适应、去养生。《内经》中的天人感应,虽然与董仲舒的将天时去附合政治,将二个不同性质的科学用唯心主义联系在一起的天人感应论有所不同。但《内经》中同样要求绝对的服从天道,要按天行事,否则就“逆之则死”、

“逆之则乱”，这样就失去了在自然界与人类关系上的辩证法。我们应该接受人类要根据自然气候变化来保护健康的观点，并要了解到这决不是绝对性的适应，而是随着社会的进步，对自然气候出现了可逆性。我们应该接受并发扬“治未病”的预防精神，但不是“不治已病”，才能使今后的医学科学发展起到为社会服务的良好作用。

（1976年7月于东泽，本文发表于无锡县学术交流会。）

学习《素问·金匱真言论》

金匱，有“金滕”之义，是一种金属制成的藏物器具，以示所藏物件的珍贵，与《金匱玉函经》的“金匱”义同。真言：表示至精至要的论述。目的是要求后人重视此篇，篇末的“非其人勿教，非其人勿授”之说就是这种表示。

本篇前半篇，通过人体不能适应自然气候的变化而导致发病的情况，强调了“藏精”的重要性；后半篇论述了阴阳五行对人体联系的变化，要求能通过对它们的认识而“视其所在，为施针石也”。

原文：“黄帝问曰：天有八风，经有五风，何谓？岐伯曰：八风发邪，以为经风，触五藏，邪气发病。所谓得四时之胜者：春胜长夏，长夏胜冬，冬胜夏，夏胜秋，秋胜春，所谓得四时之胜也。”

词释：（1）八风——一说为天地八方之风（张志聪）。一说为《灵枢·九宫八风篇》所说的大弱风、谋风、刚风、折风、大刚风、凶风、婴儿风、弱风。两者并无冲突，都是自然界可以致人疾病之风，所以有“八风发邪”之词。

(2) 五风——即心、脾、肝、肾、肺五脏之风；由八风发邪，侵犯五脏之经而致五脏发病时即称五风，或称经风。

(3) 四时之胜——按五行所胜关系而言，五行配五脏始于《内经》本篇，木春、火夏、土长夏、金秋、水冬，引伸而为春肝、夏心、长夏脾、秋肺、冬肾等；按五行相克关系而致病变，如春胜长夏，即长夏季节得东风，实指夏末得春季气候，则脾受病（余节可依此类推），此即八风发邪及邪气发病之一种（另有当季之风太过或不及等等发病，见后文及《素问·气交变大论》等有关运气篇章中）。有人以为自此句起至以下32字为错简（丹波元简），似乎不妥。

体会：古人对病因的理解，比今天更简略，所以将一部分外感或内伤病的病因称之为风，有“风者善行而数变”和“风为百病之长”之说，用以作为病因和症状变化的解释。本节是此种见解的导源，此种见解是有其客观依据的，即自然界的气候变化，当其反常之时而引起疾病者，今天仍屡见不鲜，除开物理性的发病而外，气候对细菌、病毒繁殖的适宜条件，古人也作为是气候的发病来认识的，所以由八风发邪而为五脏之风。根据自然气候与发病的关系去理解本节“四时所胜”的发病论述，可以认为并非玄学空谈了。

原文：“东风生于春，病在肝，俞在颈项；南风生于夏，病在心，俞在胸胁；西风生于秋，病在肺，俞在肩背；北风生于冬，病在肾，俞在腰股；中央为土，病在脾，俞在脊。”

故春气者，病在头；夏气者，病在脏；秋气者，病在肩背；冬气者，病在四肢。

故春善病鼽衄，仲夏善病胸胁，长夏善病洞泄寒中，秋善病风疟，冬善病痹厥。

故冬不按蹻，春不鼽衄，春不病颈项，仲夏不病胸胁，长夏

不病洞泄寒中，秋不病风疟，冬不病痺厥，飧泄而汗出也。

夫精者，身之本也，故藏于精者，春不病温；夏暑汗不出者，秋成风疟。此平人脉法也。”

词释：(1)东风生于春——此句连南风、西风、北风等四风，均系对自然现象总结而来，现在在我国东部地区，长江、黄河等流域，均可见到春多东风、夏多南风、秋多西风、冬多北风的现象；经文交叉其间而为“东风生于春”等，亦并非东风必生于春，系就其大致而言，谓或其它季节出现东风，是一种反常现象，若其程度太过，则不独人可以致病，连种植物亦将蒙其不利，这就是前文“四时所胜”的情况了。就经文看，本节之风，可有二义，一为正常程度，则不致病；一为超过常度，则致病，后者之义为本节主要思想，以“东风生于春”一小段为例，可释为：春天之东风过度，则病在肝，因肝有俞穴在颈项，故病亦自颈项入。余可类推。

(2)病在肝——此由五脏主季节而来，五脏主季节，为由类比而来，如《白虎通德论》云：“肝，木之精也，东方者阳也，万物始生，故肝象木，色青而有枝叶。”本节云此者亦然，但中医学中五行类比学说，不免有牵强附会处，可以视为可然，不能视为必然。

(3)俞——经穴的总称，与“输”、“腧”同，有转输之义。用来比喻气血在经络运行中的转输点，内可连脏，因为脏气实则邪不能入而病仅在经（亦曰病在气），下文“病在颈项”、“头”、“肩背”、“四肢”均在经这一范围。脏气虚，则邪气由俞入脏而“病在脏”矣。

(4)腰股——股、大腿，引伸为整个下肢，“腰为肾之府”。四肢为腰股之末（马师），所以此处言“俞在腰股”而下文言“病在四肢”。

(5) 春气——此与其它之气，均指自然界各季气候，与上述“东风”等同，本节中亦有指能引起疾病的意思。

(6) 春善病鼽衄——鼽，鼻塞之病，衄，鼻血之病。此为上文“病在头”及下文“病颈项”的举例。“善病”即容易病，非必定之词，所以“春善病鼽衄”之义，既有“病在颈”的意思，亦有春季容易“病在头”而又不必定“病在头”的意思。下文各季“善病”之义类此。

(7) 洞泄寒中——洞泄为泄泻之饮食入口即泄的形容，以状胃肠道犹如“洞”，饮食不能留驻之况，后人称为“关闸尽弛”，此病多为里寒病，故曰“寒中”。长夏病此，为脾阳虚寒而来。

(8) 秋善病风疟——风疟，疟之一种，从《素问·刺疟篇》说：“风疟，疟发则汗出恶风”，并且《素问·疟论》认为“夫风之为疟也，相似同类”。中医学对疟疾成因的理解，见于《素问·疟论》，认为是“此皆得之夏伤于暑，热气盛，藏于皮肤之内，肠胃之外”，“此令人汗空疏，腠理开，因得秋气，汗出遇风，及得之以浴，水气舍于皮肤之内”而起，故曰“秋善病风疟”，实则此种病因及病理见解，并不完善，但秋天多疟病这一点是正确的。这是古人没有条件见到疟原虫之故。

(9) 痹厥——痹，气血失利，使肢体活动不便，感觉麻木的病。厥，四肢逆冷的病，由阳气不达而引起。

(10) 按蹠——按，按摩之义，主用手操作；蹠，与矫字通，使曲者直为矫，主用脚踩，今山东地区尚有用脚踩的治病法。《史记扁鹊传》“鑱石桥引”，《说苑》“子游矫摩”，《灵枢·病传篇》“乔摩灸熨”等的记载，都为“蹠”的通用字。按蹠是一种治病法，如果自动做的话就叫作“导引术”，马王堆三号汉墓出土的导引图，是我国现有导引按蹠的最早图画记录，就其年代论

(汉文帝十二年),与《内经》的“按蹠”肯定有所关系。“按蹠”既是治病方法和强身法,则本节的“冬不按蹠”之义,不能说是“按蹠”后使各季均发病,而应该是“按蹠”太过,致皮肤过泄而不藏于精,才引起疾病。

(11) 飧泄——泄泻病的一种,大便中多不消化物质。有人认为本句是剩文,有一定道理,因为不仅与文中所述冬季的“不病”不对称,而且飧泄而汗出之病,与前文“冬气者,病在四肢”之说也不相呼应。本句若作气泄而汗出也,或阳泄而汗出也句,则可作“按蹠出汗太过,损及阳气而发病”解,以作本节小结,似较通顺,亦或经文有此讹误可能。

(12) 精——包括饮食所化、父母所予、生殖之原三种,经文“肾者,受五脏六腑之精而藏之”,可见这三种不同内容的精是可以相互转化的,亦在人体中广泛运用着。张志聪认为“神气血脉,皆生于精”,则其涉及面不仅是指思考、活动、生殖能力等,如此处更包括到抗病能力,所以才能“春不病温”。

(13) 病温——温:热性病的总称,即温病。病:罹患之意。

(14) 夏暑汗不出,秋成风疟——《素问·生气通天论》“魄汗未尽,口渴而气燥,穴俞以闭,发为风疟”似与此句“汗不出”矛盾,实则指夏暑时出汗未收而感于风,暑汗为风凉之气所折而“汗不出”,则可成风疟。汗不出应为汗出不彻之义,暑可因汗出而解,汗出不彻,暑不为解,郁于体内,而到秋发为风疟矣。

(15) 此平人脉法也——脉法,此处为论断方法的代义词,不作狭义的诊脉法解。平人:此处作通常讲,不作正常人讲。亦有人疑为句下有阙文或系剩词,似可不必。

体会:本节共五小段,前三小段为继上节所胜发病而谈的应季太过气候的发病,及其应病脏腑,病初入侵俞穴,病的部

位和种类。根据四季气候与人体适应情况和发病关系的情况来看,经文所言情况是存在的,尤其是“病在”、“善病”方面的记载情况更为常见,是四季发病的一般规律。

后两小段论述了“按蹠”适当与否对发病的关系,既强调了“藏精”的重要性,文中又提出“夏暑汗不出者,秋成风疟”,似乎是相互矛盾的,实际此句是说明违反四时常规气候,夏热应出汗而汗出不彻,暑不为解也可导致疾病,与《素问·四气调神大论》要求冬天“无泄皮肤”,夏天“使气得泄,若所爱在外”之义相一致。由此可见,“冬不按蹠”中的“不”字是或义字。不是说冬天不能按蹠,而是说不能按蹠太过,致因汗出过多而伤“精”。但若认为通过“冬不按蹠”而可四时不病,是太绝对化了,丢弃了阳(精)气自身修复的内涵因素,所以实际中并非如此。这点只能归之于文字上的毛病,因为古文中类此者甚多,不独内经如此;其目的是要强调其主旨的重要性,而不是强调绝对性。

原文:“故曰:阴中有阴,阳中有阳。平旦至日中,天之阳,阳中之阳也;日中至黄昏,天之阳,阳中之阴也;合夜至鸡鸣,天之阴,阴中之阴也;鸡鸣至平旦,天之阴,阴中之阳也。故人亦应之。”

夫言人之阴阳,则外为阳,内为阴;言人身之阴阳,则背为阳,腹为阴,言人身之脏腑中阴阳,则脏者为阴,腑者为阳,肝、心、脾、肺、肾五脏皆为阴,胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦六腑皆为阳。所以欲知阴中之阴、阳中之阳者何也?为冬病在阴,夏病在阳,春病在阴,秋病在阳,皆视其所在,为施针石也。

故背为阳,阳中之阳,心也;背为阳,阳中之阴,肺也;腹为阴,阴中之阴,肾也;腹为阴,阴中之阳,肝也;腹为阴,阴中之至阴,脾也。此皆阴阳表里内外雌雄相输应也,故以应天之阴

阳也。”

词释：(1)平旦——即平明，早晨日初出时，《说文》“旦，明也，从日见一上，一，地也。”据此可知，“平”即此“一”之义。犹今人称之为地平线处，日如见于此之时为平旦，为昼夜平分之意。

(2)日中——太阳正中时，即中午；中，以日出与日没之度较之，得二者之中。

(3)黄昏——日没而天光尚未黑时，《月令广义》“日落，天地之色玄黄而昏昏然也”，天全黑后即为“合夜”范围。合，六合之意，六合俱黑，故曰合夜。亦即天地俱暝之义。

(4)鸡鸣——鸡鸣于一日中无定时，此指鸡之报晓而鸣时，四季中亦无定时，十月间半夜即鸣，乡谚有“十月鸡，半夜啼”之说。故古人对平旦、黄昏等时间观念上的划分，是以自然界现象而定，可以随四季日夜长短的变动而变动，正不必强定其为某一时辰、某一钟点，这样更可以符合于阴阳原旨。

(5)冬病在阴……秋病在阳——此为据五脏阴阳相配关系及“阴中有阳”等辨证关系而来，实即春肝、夏心、秋肺、冬肾。如肺为阳中之阴，故曰“秋病在阳”；“阳中之阳心也”；故曰“夏病在阳”，此为就“背为阳”与“腹为阴”的对比而言，并非就脏腑分阴阳而言。

(6)针石——针，针刺；石，砭石，后来引伸到药物，作为治疗方法的代名词，如“药石”。

(7)输应——输，输送；应，相应。即交相授受之意。

体会：本节从时间、人体、脏腑，作了阴阳的划分，并且指出了阴阳的相对性和辩证性，说明由于事物的比类不同，阴阳可转化，但以昼夜、四时同人体脏腑的对比，只应从“视其所在，为施针石”方面而作为一种说理方法，只能学习其相对性，

不能学习其绝对性。

原文：“帝曰：五脏应四时，各有收受乎？岐伯曰：有。东方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝，其病发惊骇，其味酸，其类草木，其畜鸡，其谷麦，其应四时，上为岁星，是以春气在头也，其音角，其数八，是以知病之在筋也，其气臊。

南方赤色，入通于心，开窍于耳，藏精于心，故病在五脏；其味苦，其类火，其畜羊，其谷黍，其应四时，上为荧惑星，是以知病之在脉也，其音征，其数七，其臭焦。

中央黄色，入通于脾，开窍于口，藏精于脾，故病在舌本，其味甘，其类土，其畜牛，其谷稷，其应四时，上为镇星，是以知病之在肉也，其音宫，其数五，其臭香。

西方白色，入通于肺，开窍于鼻，藏精于肺，故病在背，其味辛，其类金，其畜马，其谷稻，其应四时，上为太白星，是以知病之在皮毛也，其音商，其数九，其臭腥。

北方黑色，入通于肾，开窍于二阴，藏精于肾，故病在谿，其味咸，其类水，其畜彘，其谷豆，其应四时，上为辰星，是以知病之在骨也，其音羽，其数六，其臭腐。

故善为脉者，谨察五脏六腑，一逆一从，阴阳表里，雌雄之纪，藏之心意，合心于精，非其人勿教，非其真勿授，是谓得道。”

词译：《内经》中最明显的五行学说，自本篇始，五行学说中的分隶各种事物，由取类比象而来，有不少是牵强附会的，或者进入了玄学境地。词译中如取不到新解的，仍用古人之说，以见原来的比类方法。

(1) 收受——收，接收；受，接受。义为五藏接受四时之气而藏其精。

(2) 东方青色，入通于肝——《白虎通德论》：“东方者阳

也，万物始生。“生的表现以草本为著，草本色青，故曰“青色”，曰“其类草木”。又云：“肝象木色青而有枝叶”，此由肝的生发作用及色的类似而加以类比而来。

(3) 开窍于目——《白虎通德论》云：“肝，目为之候何？目能出泪，而不能纳物，木亦能出枝叶，不能有所内也。”

(4) 惊骇——《素问·阴阳应象大论》“东方生风条下，有“在声为呼，在变动为握”之说，惊骇，呼与握之态也，如今时之惊风病之惊呼与抽搐，为动风之象。应与恐之属于肾者相区别。

(5) 其味酸——《尚书·洪范》：“曲直作酸”，曲直，木之状态，状其枝条曲直。木实多酸（《洪范》郑注），故曰其味酸。

(6) 其畜鸡——“此取其将旦而鸣近寅木，故又振羽翼，有阳性也”（《五行大义》郑玄）。五行分类中对五谷、五畜的分隶，在《内经》中是不统一的，此即牵强附会之证，亦予以想见《内经》非出一手。故后文从略。

(7) 其谷麦——《礼记·月令》郑注：麦实有孚甲，属木。

(8) 岁星——即木星，位在东方。《五行大义》云：“岁星，木之精”，“以其主岁，故名岁星”。

(9) 其音角——角、徵、宫、商、羽，是古代音乐中的五音，其在五行的比类上，按《汉书·律历志》说是：“角者触也，阳气蠢动，万物触地而生也”，“徵者祉也，万物太盛蕃祉也”，“宫者中也，居中央，畅四方，唱始施生，为四声之经”，“商者章也，物成章明也”，“羽者字也，物藏聚萃，字复之也”。据此，则为由物象定五音，而类比于五行了。

(10) 其数八——五行对数字的分隶是：木八，火七，土五，金九，水六。所以如此，是按《尚书·洪范》的提出次序，“一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土”对这五个数字，称作

“生数”，等于孤阴或孤阳，各得上数（五）而为“成数”，即需有配耦才能变化，才能有五行的作用；经文中“其数”的“数”：木、火、金、水均是“生数”加五的“成数”，独土数不言“成数”而言“生数”，因木、火、金、水四行均需得土而成，土则更无所得，所以只言“生数”。

（11）其臭臊——臭，得之于鼻者，同嗅义；臊：兽肉腥膻之气，《礼记·月令》作“其臭膻”，臊与膻同，《说文》：“膻，羊气也”，《五行大义》云：“春物气与羊相类”。

（12）南方赤色，入通于心——火色赤而热，我国南方亦热，《白虎通德论》云：“心象火，色赤而锐也”，因而比类在一起。

（13）开窍于耳——心开窍于舌，此云开窍于耳，耳为肾窍，汪昂云：“舌无窍，故心亦寄窍于耳。”本篇肾不言开窍于耳，而说是开窍于二阴，是本篇按九窍分配，按《白虎通德论》，心条：“耳为之候何？耳能遍内外，别音语。”是耳可为心用，故云“开窍于耳”。

（14）其味苦——《尚书·洪范》“炎上作苦”，凡火焚物则焦，食物之焦者多味苦。

（15）其谷黍——《五行大义》云：“黍，色赤性热”，“舒散属火”。

（16）荧惑星——即火星，位南方，色赤，《五行大义》云：“以其出入无常，故名荧惑。”据此则色赤而明为荧，出入无常为惑。

（17）中央黄色，入通于脾——《白虎通德论》：“脾象土，色黄也”，土色黄，脾色亦黄，故相类；四行皆得土而后成，脾主“迎粮”，全身营养来于此，故以之比作土，同有“万物土中生”之义。

(18) 病在舌本——经文：“太阳之脉系舌本”，“是动则病舌本强”，故脾病亦可见于舌本，但多痰盛舌蹇之症，与心开窍于舌的火热症，如舌糜、重舌等有所区别。

(19) 其味甘——《尚书·洪范》：“土爰稼穡，稼穡作甘”，是粮食作物之味多甘，臭亦多香，故下文言“其臭香”。又《元命苞》云：“香者，土之乡气，香为主也。”

(20) 其谷稷——即小米，一称谷子，色黄，古为五谷之长（《礼记·月令》郑注），其单数称为“粟”，是度量衡的起源。

(21) 镇星——即土星，位在中央，《五行大义》云：“以其镇宿不移，故名镇星。”

(22) 西方白色，入通于肺——《白虎通德论》：“肺象金，色白也。”肺色白，金色亦白，西方地高，肺亦居藏府之高处，故相类。

(23) 开窍于鼻——肺司呼吸，鼻通出纳之气。《白虎通德论》云：“鼻为之候何？鼻出入气，高而有窍，山亦有金石累积，亦有孔穴，出云布雨，以润天下。”故相类比。

(24) 其味辛——《尚书·洪范》“金曰从革，从革作辛”，革，变革，金之变革须得火，成器之金味辛，可以舌试而知。《白虎通德论》云：“金味以辛何？西方煞伤成物，辛所以煞伤之也。”《说文》云：“未熟之气腥也（引自《素问识》——丹波元简著），是以煞伤，煞伤而未熟之气腥，故下文曰“其臭腥”。

(25) 其谷稻——稻色白而秋成，故为肺之谷（张志聪）

(26) 太白星——即金星，位西方，《五行大义》云：“金色白，故曰太白。”

(27) 北方黑色，入通于肾——北方气寒，水亦寒，水深则色如黑，肾主水道，故相类。

(28) 开窍于二阴——《白虎通德论》：“水阴，故肾双，窍

为之候何？窍能泻水，亦能流濡。”据此，则在于排泄之故，故窍二阴；又有肾数双，故开窍为二之意。

(29) 其味咸——《尚书·洪范》：“润下作咸”，水受润下之水卤与垢浊，故味咸而嗅腐。

(30) 其谷豆——《礼记·月令》郑注：“菽（菽，豆的总称）发，孚甲坚合，属水”，是有收藏之意。

(31) 辰星——即水星，位在北方，《五行大义》云：“是大之执正，出入平时，故曰辰星。”（《白虎通德论》作“虚、危”星）。

(32) 善为脉者——脉，亦作诊察疾病讲，与上文“平人脉法”之“脉”义同。与近人就诊，称“摸脉”、“号脉”、“把脉”相同。

(33) 一逆一从——指脏腑、经络、气血等生理间的逆从：逆为非正常情况，即是病理情况，此处包括与四时气候的适应与否之意在內。

(34) 合心于精——义为熟悉到得心应手。合，联也；精，精通。

(35) 是谓得道——此处是指符合处理要求讲。

体会：本节是以五行为中心，对四时，方位、气候、星、生成数及畜、谷、音、色、味、臭等作了类比，并联系了人体脏腑功能与自然气候发病的变化。目的是在于要医者在诊病时“谨察”。仍然是前节“视其所在，为施针石”的要求。

《内经》中明显提出五行是从本篇始。五行的起源，是人类对物质的认识，有其唯物依据，但自战国以后，逐渐流向玄学，最明显的是《春秋繁露》和《白虎通德论》二书的五行记述。《内经》中的五行记述，在很大程度上是相同于上述两书的，存在着对物的唯心运用情况，有些类比，如本节的星辰、畜、谷、臭等，不仅牵强附会，而且与《内经》的其他篇幅所述有不统一情况，因此我们在学习时，应该吸取的是：

第一,通过对自然界气候变化的论述,掌握自然气候变化对人体生理变化的关系和发病关系,从而认识季节性疾病的内在机制。

第二,通过五行学说对人体脏腑的生克制化论述,认识人体的整体性和疾病机制中的脏腑相互关系,从而找出主要矛盾面,指导治疗方法和药物运用。

应该避免和扬弃的是五行类比中的机械性和唯心性。在本篇词译中有些仍然沿用此类解释的目的,并不是认为这些说法是有用的。而是为了“探源”,以便于更好的分析五行学说的精华和糟粕所在。

学习《素问·灵兰秘典论》

本篇以封建王朝的政府体制作为比喻,说明十二脏腑的各自作用和相互间的关系,使脏腑成为统一的整体。古人囿于君主时代的条件,故强调了君主(心)的作用。篇中并强调了要注意初起微小的变化,有防患于未然的意思。灵是灵台,兰是兰室。灵台、兰室,相传是黄帝藏书之处,由于强调本篇的重要性,有如不能轻易给人看的篇章,必须藏之于灵台、兰室,所以叫《灵兰秘典论》。

原文:黄帝曰,愿闻十二脏之相使,贵贱如何?岐伯对曰:悉乎哉问也,请遂言之;心者君主之官,神明出焉;肺者相傅之官,治节出焉;肝者将军之官,谋虑出焉;胆者中正之官,决断出焉;膻中者臣使之官,喜乐出焉;脾胃者仓廪之官,五味出焉;大肠者传导之官,变化出焉;小肠者受盛之官,化物出焉;肾者作强之官,伎巧出焉;三焦者决渎之官,水道出焉;膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。凡此十二官者,不得

相失也。故主明则下安，以此养生则寿，殁世不殆；以为天下则大昌，主不明则十二官危，使道闭塞而不通，形乃大伤，以此养生则殃；以为天下者，其宗大危，戒之戒之。”

词释：(1)十二脏——即六脏六腑。脏腑均可称脏，如下篇《素问·六节脏象论》之“十一脏”等，均包括腑言，因为从阴阳分，则曰脏曰腑，统言之则均称为脏。藏：有收藏之意，此处与“藏精气而不泻”的藏稍有区别，因为包括六腑对水谷的传化在内。“十二藏”是就藏的统一作用说的，经文就“十二藏”的分别职能说，就叫作“官”，官是官能之意，故称“十二官”。

(2)相使——相互使用，有相辅相成之义。

(3)贵贱——此使彼，则此贵彼贱；彼使此，则彼贵此贱。经文有“更贵更贱”之说，所以不宜作“清者贵，浊者贱”或“君臣上下之分（景岳）”看待；若以贵贱有定分，便失去“相使”作用了。故此处可作主要、次要性理解。

(4)遂言之——遂，尽也；遂言之即尽言之（王注《素问·六节脏象论》）。

(5)君主、神明——变化莫测而又明白无误，叫作神明。此处喻作心的作用表现，用以说明其职能胜过其它脏器。与今之“神经”之“神”同义。将心和其它脏器的职能用封建政府的组织职称来比喻，是古人囿于君主时代的见闻条件而来。君，大君，皇帝之类；主，主宰。将心比作君主，谓其能如君主之主宰全身。从心脏供应全身器官的血液的角度来说，这种比喻是有一定理由的，但古人囿于不认识大脑皮层和神经的作用，而将今天的皮层和神经的作用分赋于五脏。

(6)相傅、治节——相，宰相、丞相之类；傅，保傅之类，如太傅、少傅、太保、少保等职。以况肺协助心起到治节作用。治，治理；节，节制，肺主气、朝百脉，气调则营卫调而脏腑无所不

治，故曰治节；朝百脉，使心用有所节，故比为相傅，此就血液供应而言。

(7) 将军——武官的称谓。古有前、中、后左、右等军之称，指挥一军的称作将，将即领导之意，故称将军。自战国以后，始以将军作官称。用以喻肝的气急而志怒的情况。此种“将军”的作用，实亦系神经和内分泌的一部分。

(8) 中正，决断——中正，不偏不倚之意；决断即决定判断，亦有果断之意。胆以中正去决断肝的谋虑，以况肝胆的协作相使。中正之官，如古时大夫、御史之类。

(9) 膻中——即心包络。包络居于膈肉之中，故曰膻中。膻即今之横膈膜。古人有以膻中与心包络为两者（薛雪），以膻与包络不同则可，以膻中与包络不同则不可，此义见于经文十二经相表里有包络而无膻中，于本篇则有膻中而无包络，自可体及。

(10) 臣使——臣，臣子，帝制时凡食俸者均对皇帝自称臣；使，使者，行人之属，义即使令，故可传心主之喜乐外出。

(11) 仓廪——即仓库，《荀子·富国篇》杨倞注：“谷藏曰仓，米藏曰廪”。脾主运化主迎粮，故以脾为仓廪之官而出五味以养身。

(12) 传道——传，转输；道，通道。大肠为糟粕传送之道路，结束对饮食的最后吸收，所以称传导之官而变化出焉。

(13) 受盛，化物——小肠居胃之后，受盛胃中水谷而分清浊，水液由此渗于前，糟粕归于后，先化后变，故曰受盛之官，化物出焉（高士宗，张景岳）。

(14) 作强，伎巧——作强，作用强也；伎，多能也；巧，精巧也。此种作用强大，多能而且精巧，包括智力、精力，以至于生殖能力在内。故以之比喻肾的作用。

(15) 决渎——决，开也；渎，水道。三焦有司水道启闭的作用，故为决渎之官。

(16) 州都、津液——州，州、府之类；都，都会之意；州都为一种地区划分建制，为积聚、转输货物之处，用以况膀胱藏精液的情况。津液，按中医学中的津液是指对人体有用的液体（见《灵枢·决气篇》）。但此处是指膀胱所藏的水液，因为未排出体内，所以统称之为津液。

(17) 气化则能出矣——水液在膀胱，不能自出，需赖气机转化，始能排出。气化作用相当于今之逼尿肌及膀胱括约肌作用，中医学认为其原动力在于肾阳。

(18) 殁世不殆——殁，尽也，死亡亦曰殁；世，一代为一世，即终生；殆，危险、覆灭，意为终生不致危殆。

(19) 以为天下——为，治理；天下，国家的代义词。此处用治理国家之意来比喻各脏腑发挥正常职能时可以身体强健。

(20) 使道——各脏器之间相使的通道。

(21) 殃——祸殃。

(22) 宗——宗族、宗社，氏族制中的一种系统，泛指同姓氏及其上代自始祖以下各家。

体会：本节借封建政府体制，来说明脏腑的各自功能，并强调了“相使”作用的“不得相失”，这是带有个性与共性的辩证性的，但其中如胆的决断作用，膻中的臣使作用等虽与其它脏器一样，更多的是表现为神经和内分泌系统的作用；然而较之其它脏器的作用，意测的成分多一些，有待于今后验证。以封建政府体制的官职作比喻，是古人囿于条件，今天已有更好的解释，应该不再受其影响。

原文：“至道在微，变化无穷，孰知其原，窘乎哉！消者瞿

瞿，孰知其要！闵闵之当，孰者为良！恍惚之数，生于毫厘，毫厘之数，起于度量，千之万之，可以益大，推之大之，其形乃制。

黄帝曰：善哉！余闻精光之道，大圣之业，而宣明大道，非斋戒择吉日，不敢受也。黄帝乃择吉日良兆，而藏灵兰之室，以传保焉。”

词释：(1)消者瞿瞿——消，消散、消亡之意，瞿瞿，惊顾而不知所措之意，《诗经·东方未明篇》“狂夫瞿瞿”；传，“无守之貌”。因十二官失于“相使”虽惊愕其精神日消而不知所措，故下文言“孰知其要”，所以谓其不知要害所在也。

(2) 闵闵——深远之意，闵同瞑。盖续上文，既不知消亡之要害所在，而于暗中摸索办法以阻当之，而不知何法为佳，故下文言“孰者为良”。以上五句，有“盲人瞎马，前途无凭”之意在。

(3) 恍惚之数——恍惚，似有似无；数，体积之赖以计算者。此谓体积初起而似有似无也。

(4) 毫厘——计算的单位值。《孙子·算经》：“蚕吐丝为忽，十忽为一丝，十丝为一毫，十毫为一厘。”

(5) 度量——尺度计量，即度量衡之度量，作计算讲。

(6) 其形乃制——马蒨说：“有以别其形耳。”由于有了计算，不论其“推之大之”，均可弄清情况。

(7) 斋戒——张景岳：“洗心曰斋，远欲曰戒，后人以之称吃素独宿，以表示诚心诚意”。

(8) 良兆——好时辰。

(9) 传保——传于后世而保守勿失。

体会：本节两段，前段有两个意思，先是谈在未得要领时，对精神、健康以及衰弱状况不知所措，徒然疑惧，后是谈取得推算办法后可以弄清情况。这里主要强调的是弄清十二官的

“相使”情况而去推测发病道理，并强调了不是不可知的。后段是谈黄帝对此种论述的尊重，实质上就是借以强调了本篇的重要性。

此节论述，与医学学识关系不大，是词藻敷设性质。

学医读书之道

识字为读书之初，读书为明理之始。学医尤然，不读书明理，顾何以为司命，故涉中医者，应以《内经》、《伤寒》、《金匱》、《温病条辨》为必读之书，外而猎及四大家，此犹尚就窥豹而论，然可以略知其概而明理之迳矣。医案、医话之类，可以博变化，可以达细末，是操业时所需浏览者，可与百家之学同时学之。至于歌诀等工具之书，系便诵便记之籍，宜于初学时为入门之熟诵。

中医之籍如汗牛，势不能一一熟诵，必读之籍与夫工具之籍，则非熟诵不足以记数十年，且其间宜每隔数年一复温习，以强记忆，余籍则记其概义、记其警段可矣。

勿以小籍而忽之，宁阅而后定取舍，如清时之《医林改错》、《笔花医镜》，明时之《医学心悟》等，尽多可取之处，专长独到，理效相发、明辨者不少；而如子和之吐法，有不可泛施于近人者，是未可以大小论也，求其足用可矣。

方药之书，另为一途，药性药效及佐使配伍之义自当诵求，聚类为籍者则备为索骥可矣，要之尚需以辨证为驭御，知方药之正效，更需知方药之弊害，着本末倒置，按定格而治活病，天下无是理，亦未有不殆者也；所以贵于明理，理之明，明于辨也。

《内经》成书时期说

《内经》文字，曩日以为可上溯于春秋，而成于汉刘向校书之前，以其见于《汉书·艺文志》也。嗣得武威出土东汉初医简，复得马王堆出土西汉简、帛医书核之，则《内经》如此长篇系统之文，似又非刘向时可成者矣，或言：“贵人之名，始于东汉，光武妃丽华始封贵人”，是则《内经》中“贵人”词，亦非西汉以前者，此均可思可议之情。是有故焉：就文体言，老子、孔、孟之言无长者，不伦于《内经》，而荀、韩之作近乎矣，是春秋之下及于战国后期文章，渐就乎《内经》者，迨于长之《史记》，仲舒之《繁露》则几于相侔，是《内经》成于刘向校书之说未可废也。自士气言，春秋以后，诸国求强而纳言，士大夫求用而呈技，百家争雄，技理发皇，迨战国方盛，如孔氏之有乙丑卯，墨氏之与公输般，竞之烈矣，迨乎秦之同文，以至汉之独尊儒，争议以之渐落，征之《汉书·艺文志》记白氏、韩氏、黄帝之《内经》之论而今失其二，或由此而左右也，而今本《内经》之集说于秦前，系统于秦汉间者可以想见，其间弃、取、遗漏，各有其所自，亦各有其所格；以其采集诸说，而文气词风不一，《内经》中《素》、《灵》二类见绪矣，以其有所弃，故《内经》记“七损八益”之名而不及其内涵，而马王堆竹简《天下至道谈》则有之；他如五行之说，《管子》、《墨子》、《孙子》诸集均散而不统，《内经》则体系之，且较《繁露》尤详，是以知《内经》集诸家之说也明矣，成于汉之初，仲舒之同期也明矣。马王堆、武威之简帛，文体有异，字多通假，其为未烧之书或其传抄者，当为《内经》成书前诸说之类，故文简节短，赅属于弃、漏之例者也。“贵人”之词，凡两见于《内经·素问》，一为“则为肥贵人之疾也”，一为“太一天

符为贵人”；“肥贵人”词，可知为泛指处尊养优者言，其可以名词指者为“太一天符为贵人”之“贵人”，其上文，则为“天符为执法，岁会为行令，太一天符为贵人”，可知其与“执法”、“行令”同属权力之代词而高于“执法”、“行令”之称谓也；“贵人”之词，始见于《礼记·仪礼·丧服》，连同“太一”之见于《庄子·天下》、《礼记·礼运》，且义有同指，知二者均非东汉始有，是丽华之“贵人”，妃嫔之职名也，《内经》之“贵人”，权力之名、抑或尊称也，与“执法”、“行令”参之，犹有泛指之义在。

若是而综言之，知《内经》成书之期，不能移于东汉，当在秦焚之后，刘校之前，而与《史记》、《繁露》相同期者也。

通过反鬼神观点看《内经》的唯物思想

《内经》是中医学第一部书籍，是先秦时期劳动人民在医学创造方面的总结，是初步从实践上升到理论的书籍。它反映了人类与自然斗争、与疾病斗争的经验，但由于社会历史的限制，不免泥沙俱下而夹杂着不正确的部分。

医学的起源和发展，是人类与疾病斗争的历史，应该导源到人类的起源时期。在奴隶社会时期，因为人类对自然界某些事物的出现不能理解而归之于“神”，继而产生了“巫”，此期在医学上就存在了唯物与唯心两个内涵的实质。先秦时期及其以前的奴隶起义，表现了不“畏天命”，既推动了社会发展，也是《内经》中唯物观点的产生渊源。

历来的奴隶主都是相信鬼神的，殷商甲骨文中就有许多“卜辞”如“帝令雨足年”、“帝令雨弗其足年”、“五封邑，帝若（古诺字）”等，其中的帝，是指天帝，是至上的神，而“卜”与“巫”，是奴隶主假以沟通天、人的工具和人员，奴隶主用天帝

来欺骗自己的同时，也欺骗奴隶和其它较小的统治者，把自己说成是天帝的儿子，如殷、周的统治者都把自己的统治说成是“受命于天”。但奴隶们却不“畏天命”，敢于抢走祭祀天帝的牛、猪、羊等祭品（见《尚书·商书·微子》），敢于起来造反，《尚书·盘庚》有“众弗靖”的记载，是奴隶造反的最早记录。微子运用事物发展关系的“五行”来表示周、商统治的替代关系（《尚书·洪范·答武王问》），而《内经》同样运用“阴阳”、“五行”学说来对抗鬼神，《素问·五脏别论》中明确说“拘于鬼神者不可与言至德”，更明确的说疾病不是鬼神所加的，《灵枢·贼风第五十八》记载黄帝与岐伯的问答说：“其母（同无）所遇邪，又母怵惕之所志，卒然而病者，其故何也，唯因鬼神之事乎？岐伯曰：此亦有故，邪留而未发，因而志有所恶；及有所慕，气血内乱，两气相搏，其所从来者微，视之不见，听之不闻，故似鬼神。”这说明了有些发病原因不明显的病，是因为先有病邪在身体内，由于轻微而未被发觉，当情志变动而削弱了抵抗力时，病就乘机而发，并不是鬼神加病于人的。通过这一论述，也表示了疾病是要通过实践的认识和分析才能弄清的主张。这种对疾病的唯物认识观，使医学从“巫”的影响下解放出来，把医学发展提到了新的高度。

《内经》以唯物观点提出了疾病的产生是有其一定原因的，不是“获罪于天”的另一节记载，是《灵枢·玉版篇》“夫痈疽之生、脓血之成也，不从天下，不从地生，积微之所生也。”这说明对疾病的认识，在于弄清它的“积微”的原因和发展，进而就可找到治疗办法；所以《灵枢·九针十二原第一》又说：“今夫五脏之有疾也，譬犹刺也，犹污也，犹结也，犹闭也，刺虽久，犹可拔也；污虽久，犹可雪也；结虽久，犹可解也；闭虽久，犹可决也。或言久疾之不可取者，非其说也。夫善用针者，取其疾

也，犹拔刺也，犹雪污也，犹解结也，犹决闭也，疾虽久，犹可毕也，言不可治者，未得其术也。”这种治疗久病的积极观点，正是医务人员对患者尽力治疗的高尚医风要求。

《内经》明确提出了当时的疾病是“祝由不能已也”（《素问·移精变气论》，而要用“毒药治其内，针石治其外”，并且也对“祝由”作用在于“移精变气”，对病邪深入的疾病所以“不能已”的内涵解释，这种近乎医疗心理学的论述，是《内经》反对鬼神的另一个侧面，是反映《内经》不同于“巫”的另一个证明。有些人抹杀医与“巫”的区别，抹杀医与“巫”的斗争，说“灵、素之渊源，实本巫祝”，从而攻击《内经》用以对抗“巫”的、唯物辩证性质的“阴阳”、“五行”学说，说“宜其笃守阴阳、五行之说而不敢畔也”（两引均见《余氏医述·灵素商兑》）等等，无非在于“废医存药”的崇洋偏见。

《内经》的唯物主义思想，从其反鬼神的论述上是可以清楚看出的，这是我们通过分析而应该吸收、发扬的部分，而对一些如“人之肢节以应天地”和五畜五谷对应四时、而又在不同篇章中自相矛盾、不能统一的论述部分，应予扬弃，只有在前人合理的基础上发展，才能使医学不断进步。

（本文初稿于1974年10月，用于县学术交流，收入时作了删节。）

“若火熏之”我识

“若火熏之”句，见《伤寒论·辨太阳病脉证并治》，原文为：“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。若发汗已，身灼热者，名风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出，若被下者，小便不利，直视失溲。若被火者，微发黄色；剧则如惊痫，时瘈瘲，若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期”。中医研究院语译本，1971年3月第二版中，以“若火熏之”与“时瘈瘲”句断开，归入“一逆尚引日，再逆促命期”节，从而形成与“被下”、“被火”合为三种误治，余以为非是。

原文第一节示：太阳病之发热而口渴、不恶寒者为温病；第二节示：温病之发汗而身仍灼热者为温病中之风温病；第三节示：上述症状外之风温症状；第四节示：风温误下后见症；第五节示：风温误火后见症；第六节总结前言误治之危害。条明理畅原已可见，其所以以为火熏为另一逆者，盖因仲景文中尚有言火熏之病，然火熏之症状，大都为“发黄”，本条之“微发黄色”已赅之于“被火”段中，而于“若火熏之”下未再重列症状，是从文字上已可见其未作另一逆治提出。进而就症状分析：皮肤发黄为火熏者固然，若火熏之甚而灼痛，则可见惊、搐之状，于此可知此句为“剧则如惊痫，时瘈瘲”之续文；夫“若”字之义，一为如果，一为相仿，原文“若被下”、“若被火”之若字为前者之义，“若火熏”之若则为后者之义。又夫“被火”之范围，赅及烧针、火灼、薰烤，是均见之《伤寒》条文者；故此处之“火熏”实为“被火”症状之形容词而以之况“惊痫”、“瘈瘲”之状也者，且“被下”者之于风温，为伤津液，“被火”之于风温为以热治热，亦为伤及阴液，第重点表现于身之下与身之表耳；于“剧则如

惊痫,时瘈瘲”诸症前,而重以火薰治“被火”之疾,岂可以医之常理解哉。

世之于此句之解,《伤寒贯珠集》与语译本同,余则与成都中医学院《伤寒论释义》见同,盖认其常情之通达,未须多一枝节而可直连后文之“一逆”、“再逆”耳。

小议暑症“汗出而散”

《素问·生气通天论》“因于暑,汗,烦则喘喝,静则多言,体若燔炭,汗出而散”一节,注家见解历来不一,尤其对因汗出过多而引起的“喘喝”、“多言”、高热等症须“汗出而散”为费解,或有认为系错简者,以余临床所见言之,此节经文有其病机内涵。

暑病有两类,一为夏月贪凉饮冷,深屋避热而起之阴暑,此症无汗,故苏南农村名之为“闭汗”,其重者亦可发热喘烦,以其无汗或汗少之症见,固可用“汗出而散”之法愈之。另一为劳作于高温、烈日之下,始而汗出过度,继则无汗发热,再则喘喝、多言、体若燔炭等症俱见,名曰阳暑,《伤寒论》中称为“中喝”,自工业兴起以来,有于高温环境如高炉操作而病如此症者,虽非烈日之曝,且亦非病于夏季,以其病因病机相同,故亦以中暑名之,第冠以“高温”以示区别,治法亦同阳暑;此类暑病之机,在于高热耗津(西医称失水),由津耗而阳热独盛,神明浮动,因阳热甚而发热高,因伤心肺之阴而喘喝烦躁,设不烦躁而仍多言如谵,此时之“喝”、“多言”均为高热引起之神志症状,而“烦”与“静”则仅为体态活动情况,二者均有伤津、伤阴之情,在治疗上自不能用汗法,而需以生津清暑热为原则。然而求其治愈,就病机转化而言,必需达到阴津来复和能够还

津于表；就症状而言，高热无汗时之肌肤干灼，将转而为柔润或黎润，始能解“体若燔炭”之高热，此种柔润或黎润，有如服桂枝汤后所要求之“遍身黎黎微似有汗者益佳”状态，此为津还于表后津液“充身泽毛”、“若雾露之溉”之明证，设或不然，则热不能解或解而不尽，故阳暑之治，仍有“汗出而散”之机理存在，但治法用药有别，阴暑则直为发汗，阳暑则需“养汗”以求汗耳。

从仲景条文谈“热入血室”的辨治

“热入血室”一证，始见于仲景《金匱·妇人杂病脉证并治第二十二》中，共集中了四条条文，而这四条又散见于《伤寒论》“太阳”、“阳明”二篇，其中“太阳篇”三条，“阳明篇”一条，此证未见于仲景以前医籍中，只有在仲景著作中才有本证的名称、症状、机理和治疗原则及方药，所以要谈“热入血室”证，就必须以仲景著作中的记载内容为其资。

从本证的症状看，在寒热方面有：无热（脉迟身凉）、发热、寒热发作时如疟状三种不同类型，其它不同见的症状有胸胁下满；状如结胸；有谵语或但暮则谵语如见鬼状；有下血；有但头汗出等，其中只有谵语一症提出较多，有三条，占 3/4，下血只有一条提到，但加上“经水适来”的内涵看，也是较集中的症状之一。总之，此证的症状是很不一致的，临床追溯要点是经水适来或适断，及其前病史，从而才可理解其症状出现的不同之理。

本证的治疗方法，仲景条文中提出了刺期门二条，服小柴胡汤一条，并提出了“治之无犯胃气及上二焦”和“随其实而泻之”的治疗原则，这点是极重要的，它提示后人勿囿于刺期门、

服小柴胡汤的灵活治则。中医学的辨证论治告诉我们，治疗方法是根据病因、病理演变、临床症状的不同而决定的，我们在探讨本证的治疗方法时，也必须与其病变关系一起进行；本病的引起原因，总到一点是“热入血室”和“其血必结”，进入血室的热，仲景标明了有“伤寒”、“中风”两大类所引起的热，按照《内经》“今夫热病者皆伤寒之类也”的意义来理解，可以意味着包括到其它外感发热性疾病的热，这种热在妇女月经情况的因素下，如“经水适来”、“经水适断”等而入于血室，热与血结遂致出现本证；从“刺期门”、“小柴胡汤主之”和“随其实而泻之”的不同处理上，可以证明病的程度有轻重，亦从而知“热入血室”是必定的，而“其血必结”就有结轻、结重的或然性而需要加以区别的，可作如下条析：

一、刺期门二条

1. “妇人中风，发热恶寒，经水适来，得七八日，热除，脉迟、身凉和，胸胁满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也，当刺期门，随其实而取之”。本条主症热已退，但胸胁满如结胸状，有谵语，这是热与血结而不重的，主要是热在血分，由于“肝藏血”，所以刺肝的募穴，并用泻法以解肝经血热，使血室之邪热得随肝血之热解而解。所以能用治肝经之法而治血室之热者，除“肝藏血”关系而外，“肝脉络阴器”的“随经”关系也是一个因素。仲景文二条提到刺期门，都是同一关系，本条之刺期门，着眼点在于“胸胁满，如结胸状”和“谵语”之间的相互关系，谵语的出现是热与血结之故。“胸胁满，状如结胸状”句中的“如”字，告诉我们不是真正的结胸，结胸的主症是“膈内拒痛”、“心下痛，按之石硬”或“从心下至少腹硬满而痛不可近”，即使小结胸症亦“正在心下，按之则痛”，而本证是“胸胁满”。

在病位上有明显的不同，在“痛”与“满”的症状上也有明显的不同，热结血室而出现胸胁满，既是表明了血室与肝的关系，也表明了病势有向上之机或部分病邪有在上之况，而未全结于下，所以可以因势利导，用刺期门泻肝经血分之热以治之；病邪未全结于下而又见外症已“热除、脉迟、身凉和”，所以可以认为此一症情是较为轻的一种。

在本条中尚应留心的是“经水适来，得之七八日”句的内涵，是经行七八日后已净了呢还是未净？仲景没有讲明，此处大约可分为已净、未净，未净中又有量多、量少几种情况，从“热除、脉迟、身凉和”来反证，已净或即使未净而量少的，都可属于上节所释之意，只是余邪留于血室，热在血分而致谵语，可用刺期门法泻肝经血分之热以治之，其未净中的量多者，一是血热盛，另一病机是血已虚而热仍扰血行，仅用刺期门是不够的，必需辅以凉血止血之治。

2. “阳明病，下血，谵语者，此为热入血室，但头汗出，当刺期门，随其实而泻之，濈然汗出者愈”。本条亦用刺期门法，但症情与前条不同。回顾一下，《伤寒论》中条文的分列情况，可知前条是从太阳病延伸而来，本条则明确说是阳明病；仲景书中对太阳病和阳明病有个基本区别是：太阳病都有表证。阳明病都但热不寒，这个区别也是为很多伤寒论家所沿用的规律，所以本症应为高热、下血、谵语、头汗出，此处所云的“下血”，从“此为热入血室”句看，是指月经多于正常量的情况，由于月经量多而且谵语，肯定了热入血室；由于高热，血热程度就重于前条所涵程度，但只是热与血结，没有发展到热与血结而瘀的程度，其区别就在于月经量之能够多，也因为如此，加上“但头汗出”，仍表示是阳经热甚而有上趋的病机，所以仍可用刺期门泻肝经血热的治法，但于此症应注意到“濈然汗出者

愈”之句的反面义，意思是用刺期门法后，如果澹然全身得汗的就好了，若不能全身出汗就不一定能愈，这是因为“但头汗出”不足以散发阳经之热邪，必需求得全身出汗，热邪之去路才能通达。这里可以悟出两个道理，一是后来的温病学大家叶天士有“透营转气”治则的创立，这正是由伤寒学识中继承出来的，二是告诉我们此症除了刺期门外，还需考虑别的治法，仅刺期门是不够的，区别就在于能否取得“澹然汗出”。

二、小柴胡汤一条

“妇人中风七八日，续来寒热，发作有时，经水适断，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之”。本条的主症是“续来寒热”、“如疟状，发作有时”，不一定没有“胸胁苦满”，“或胁下痞硬”等其它少阳病症，此中有一条伏线是与刺期门第一条的相关联处，本条“七八日”而“经水适断”。刺期门第一条是“经水适来，得七八日”，它在发病日程和月经情况方面是基本相同的，不同的是前条为“热除，脉迟，身凉和”。本条则为“续得寒热发作有时”。恰是半表半里的少阳病热型。此种热型即使没有月经情况的夹杂，在临床辨证中也是小柴胡汤的主症，本条没有谵语；表明“其血必结”的程度更逊于有谵语的，仅仅是血受热邪之扰未尽恢复，已经近乎营卫不和之况了，加上血室之热邪表现为半表半里的寒热如疟，明显表明了是病邪趋表之势，所以用小柴胡汤主之可愈。小柴胡不单是和解其气血，亦有透达余邪之义，《药性赋》中明确提到“疗肌解表，干葛先而柴胡次之”，只是柴胡不致于发大汗罢了。由此可知，小柴胡较之刺期门之治在病位上更浅一层，期门是肝经，小柴胡是胆经，肝是厥阴，胆是少阳，深浅自有区别，此一深浅之间还存在着表里关系，所以亦可想到血室至胆

经的病理联线中，肝是个中间点，离开了相表里这层关系，血室之病是不可能表现为寒热如疟的。

三、有治则无治法一条

“妇人伤寒发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语如见鬼状，此为热入血室，治之无犯胃气及上二焦，必自愈”。文中提到伤寒发热而未提恶寒，表明是种高热，即使兼有恶寒恶风，也是极微的，所以本条主症是：高热，日暮谵语。其必具因素是“经水适来”，由于有经行的存在，所以可以诊断是热入血室，也可知主症还有一个“下血”，这一组症状，与刺期门的阳明证条是相同的，所以要把“经水适来”作为必具因素，除了用以作为诊断“热入血室”的依据外，还要以之作为与其它相关症的鉴别依据。高热谵语，不独热入血室有，阳明经证有，腑证也有，蓄血证亦有类似的狂症，当然要与这些病鉴别，还要注意到大小便情况的变化和痞、满、燥、实等情况，所以要作出这种鉴别，正是文中告诫的“治之无犯胃气及上二焦”的原则治要所在。

本条的具体治法应该是多方面的，要点在月经情况上：

①因为症状与阳明病热入血室条相同，所以只要经水顺利，刺期门的治法仍是可用的。②如果经行过多，则是血与热结，热迫血行之况，要用凉血止血。③如果经行不利或挟有瘀结，是血与热结、热灼血瘀之况，就要在凉血基础上加用化瘀，止血药就不应用，或者只能作为佐药来用了。至于“无犯胃气及上二焦”之忌，是因为不是阳明经、腑实证，不宜用汗、吐、泻下等法，也提示了本证的主要病位是在下焦，这就要靠在临床上有明确的鉴别。

要作为第④点提出出来的是，在上述各条之外，热入血室证

当有另外一种类型,就是在热病中或热病初退时月经应期不行而出现日暮谵语如见鬼状的症状,此种热入血室的热与血结而瘀的程度之重,是超过条文中所可分析到的程度的,达到了瘀结不行的地步,此一类型应与蓄血证并看,《伤寒论》蓄血条文中提到“太阳随经”,“热在下焦,少腹当硬满,小便通利者,下血乃愈”,又规定“外已解,但少腹急结者,乃可攻之”,这种症状及病史,在男子是膀胱蓄血,在妇女而月经及期不行就是热入血室。其中“少腹硬满”一症是相同的诊断要点,在治疗上也同样要求要“下血乃愈”。同样,在此型热入血室证的发热方面,可以有热,也可以无热。笔者就曾在临床遇到过无热的此型热入血室证,用桃核承气汤为主方通经而愈。

提出热入血室可与蓄血证并看,有下述几个因素:

1. 病机上都属于“太阳随经”,而至“热在下焦”,在此一线上又可分为三者:与水结者为蓄水证,与血结者,男子则为蓄血证,女子涉及月经情况时则为热入血室。

2. 治则上都是“随其实而泻之”和“无犯胃气及上二焦”。这一治则又可分为:①随其水、血的不同而不同。②随其实的程度不同而不同。③随“其血必结”的程度不同而不同;热与血结之热入血室用刺期门法是泻,热与血结到瘀结不行的蓄血证用“下血乃愈”之法也是泻。

3. 临床症状在热入血室之瘀结时与蓄血是相同的,即“少腹急结”或“少腹硬满”,临床治疗证实,可以用“桃核承气”或“抵挡汤”之类破瘀方剂治愈。

对血室的探讨,古人对此之注解大致有“肝”、“冲脉”、“女子胞”等见解,如何对此求得明晰的认识,我以为应从中医学的整体观和仲景原文去分析:仲景热入血室条文中三条提到了妇人,只有阳明病一条未提,对此我认为是省文而未提,从

血室与经水适来、适断相关的密切情况看,明指血室就是《内经》所说的“女子胞”的异名,从反证角度言之,肝和冲脉是男女均有的,而男子是没有经水适来、适断可言的,准此,在临床时又如何体现男子的热入血室呢。

仲景用刺肝经的期门穴以及治半表半里或少阳经的小柴胡汤来治热入血室,这大概是引起前人想到血室是肝、是冲脉的起因,从中医学学术历来强调整体观这点看,《内经》中提及的“肝藏血”、“肝脉过阴器,抵少腹”。肝病:是动则“妇人少腹肿”,“冲为十二经之海(血海)”、“太冲脉盛,月事以时下”、“太冲脉衰少,天癸竭”等记载,也都说明了肝、冲脉与女子胞的关系,尤其是体现在月经方面,仲景正是依据这种整体关系,按疾病趋势的向上、向外而采用刺期门或小柴胡汤来治疗热入血室的,其病势不向上、向外,而只是瘀结在下焦,那就只能用“下血乃愈”的方法。仲景在热入血室刺期门法下提到的“随其其实而泻之”,其广义的涵义应该是不限于刺期门一法;正因为如此,中医界后来出现了“隔一”、“隔二”和“实则泻其子”等的治法,所有这些都并不妨碍对病位的肯定,相反倒是依据了病位的肯定才建立起不同的治则、治法,正是这样才给我们留下了丰富多采而又疗效卓著的、合乎科学哲理的理论和方药。据此,我们可以从血室与冲脉、与肝的关系来认定它就是女子胞。

(1986年8月稿)

注:[1] 本文所引条文为中医研究院编《伤寒论》及《金匮要略》诸译本。

[2] 本文为北京中医学院医疗系讲稿。

论麻杏甘膏汤证

《伤寒论·太阳篇》第63条：“发汗后，不可更行桂枝汤；汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。”此条文有两处应予深思，一为“不可更行桂枝汤”，一为“无大热者”；中医研究院本以“汗后余热迫肺”释“无大热”，而临床或有据“无大热”而投本方于外感咳嗽之微热者，遂尔相缪不愈。此证较之桂枝加厚朴杏子汤条之“头痛发热，汗出恶风，鼻鸣干呕”之桂枝汤证加喘者易相混淆，本证有其中之发热、汗出、喘三者，而鼻鸣、干呕为可有可无之或见症，其不同者在于无头痛、恶风。然揣其于未有汗前，亦或有诸，即经汗而后亦未必尽无恶风也；此外，汗后而喘与桂枝加厚朴杏之“喘家”之素有喘病者有其不同点，桂枝加厚朴杏之不用麻黄，为其不欲大汗，而本证则曰“发汗后”，则知或可为本桂枝证而误汗，亦可为本麻黄证而汗后病未除，自“不可更行桂枝汤”意扩而思之，设麻黄证用麻黄汤得汗，则头痛恶寒等之表实证已解，今但见“汗出”且加以“喘”，则病未为汗解可知，热势内迫于肺亦可知，以后计前，汗之甚而伤津之机可以想见，所以不可更行桂枝汤者为不欲重弱其营也；设证本桂枝而汗之不解，其过汗也可知，其热迫于肺与伤津之机与麻黄证汗后不解同，是正为“喘”之所以然也，仲师于汗多亡阳屡有言矣，此盖必先亡津液而后始得亡阳也，本条之“汗出”实“漏不止”也，设进一步则邻于亡阳矣，此于仲师救误治法用药中可见其层次，故本条亦亡阳前之亡津液时期也，据此则“无大热者”之“热”，岂真为无热哉，其实际为热于内而肌肤间扪之不著，盖续续之汗解之而热得以不炽，设汗一止，则势壮如焚矣，惟其汗，故可亡津液，惟其热于内，故可

迫肺而为喘，所以方中设石膏以清其热，用杏仁利肺气，麻黄于此为宣开之味，与石膏合成辛凉以入肺，盖此时阴伤不得再汗，而不汗则邪无去路，所以用石膏之清、之解肌而伍以麻黄也。

麻杏甘膏汤实为麻黄汤方重以石膏易桂枝耳，故余于其前证不敢必其非麻黄证，复以本条之“不可更行桂枝”文，故亦不敢必其非桂枝证也，无论其为麻黄或桂枝，其病机至此，证之焦点同矣。盖本条之喘，较之麻黄汤之喘，以头痛、无汗、恶风或恶寒为不同，予以知麻黄汤之喘，桂枝朴杏之喘与麻黄甘膏之喘，虽同在太阳之分，而层次之深浅不同，热之内犯轻重亦不同。麻黄汤之喘，邪闭表气、肺不得宣也；桂枝朴杏之喘，素所有而上气也；麻杏甘膏之喘，邪热内迫于肺矣，岂可以膏杏之喘用先于麻黄哉，岂可以为膏杏之真无大热哉。

论邪犯之深浅，本方与大青龙类，故大青龙汤中全用本方，其不同者，大青龙无汗同麻黄，而本方有汗，有汗则表气已开，故不得重以汗，无汗则表犹闭而须汗解，故大青龙用桂枝配麻黄以发汗；又大青龙有烦躁，本方则无，烦躁者热重故也，证之无汗情况，大青龙之烦躁与麻黄汤之喘同源，故大青龙未可必其无气息喘促，而其热有甚于麻杏甘膏者，而大青龙证之束肺之机亦同于麻黄，予以知大青龙汤之位置在麻黄汤与本方之间，深乎麻黄而浅乎本方，然其证势之热盛或有甚于本方矣。于此深浅层次中，有更近于本方者，桂枝二越婢一汤是也；本方不得重大汗，桂二越一亦然，其热多寒少之热势近乎本方，其寒而无汗近于大青龙，故桂二越一与本方之区别在于无汗与有汗耳；无汗而阳微，故不得大汗，汗之则亡阳，然亦不得决然不汗，不汗则表证不解，故桂二越一，用桂配麻黄如大青龙，而小其量以求解表，用药之义同桂枝汤，不用杏在于阳微

不束肺，非若本方与大青龙汤之喘或烦躁也。就求还邪于表以解而言，麻黄、大青龙、桂二越一与本方均然；就汗而言，麻黄、大青龙为一类，桂二越一与本方为又一类而同为不得多汗也。就位置言，桂二越一如麻黄、大青龙，然而有阳微、阳微之不同。就热势言，桂二越一逊于大青龙而近乎本方也。

以上泛论所及，在于求用药之层次进退，与夫病机之深浅故也。

大青龙汤多面观

大青龙汤与大柴胡汤相较，其同者为均涉乎阳明，其不同者：大青龙为太阳表实，证具麻黄，外不解而热及于阳明之经，大柴胡证本少阳，误下而邪与滞结，涉乎阳明之府，故大青龙方实为麻黄汤与麻杏甘膏汤之合方，而大柴胡则有承气之半也。引而伸之，大青龙证邪在太阳，表实而热甚迫乎里，其机向外，仍可以汗解为治，用石膏盖为清热，其主攻方向仍同麻黄汤，故见证同麻黄之“脉浮紧，头痛，身疼，发热恶寒，无汗而喘”，其不同于麻黄汤者为“烦躁”一症，此症亦即大青龙之要着，所以然者即热之甚而迫于里也；设各证具而脉不浮紧，反为微弱，不恶寒无汗而汗出恶风，则仲师明言“不得与大青龙”，盖脉微弱为无阳，谓其表闭不如麻黄证，卫强亦不如麻黄证，恶风汗出如桂枝，是近乎桂枝二越婢一汤方证矣，仲师于是言“太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此无阳也不可发汗”者也，于以可知，“不可发汗”为禁如麻黄汤之发汗也。仲师于大青龙汤证尚言：“脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者”，亦可用“大青龙汤发之”，此处之着眼点在“无少阴证”句及“脉浮缓”句，谓无“脉微细，但欲寐”之虚寒证，而为

“脉浮缓，身不疼但重”之如桂枝证；“身不疼但重”为邪入里，此证以意逆之，当尚有无汗、烦躁在，故可用大青龙，若有汗，则犹桂二越一证矣；盖此之“脉缓”，与桂枝证之脉缓同，非一息四至之缓，言脉不紧而大、宽缓之缓也，亦非不数之谓，是病仍在表而化热欲入里，故可用大青龙；此证设转而为有汗恶风，脉由缓大而洪大，则白虎汤矣。简言之，大青龙之证为表里同病，为表实而烦躁，为麻黄证之热重者，患者之体质当实，苔色当参见黄，此证设见表虚证，浅者则桂二越一汤，深者则白虎汤或白虎加入参汤，是介于麻、桂、石膏进退之间之方也。

宗《内经》三阳经病均可从表而解之义言之，表里双解为大青龙与大柴胡之同一义处，然其病程不同，大青龙可汗，以其在太阳之表而涉乎里，大柴胡不求汗，以其在三阳之里而涉乎腑，大柴胡之所谓表，在于“少阳如枢”，求其枢转而出之也，疏表气以透邪耳；然而有腑滞，故其双解之关乎里者下之也，求其能下，故用大黄之清腑，枳实之推逐；但与承气较之则有轻重之别，大柴胡证具柴胡，误下而柴胡证仍在，兼见“心下急”、“郁郁微烦”，此“烦”与大青龙有相类处，热而气郁也，当胸、脘俱感而轻于大青龙，此于经文“微烦”之“微”字可见其义，故用黄芩配大黄而不以石膏；其可下点在“心下急”，心下，古人指胸下中心处也，非近时心脏部位之下，实为上、中脘处，“急”者腹胀之谓，是胃腑之有滞也，然不如承气之实，故但予芩、军之清降气分，而不予芒硝之咸软，所以小其制也；近时用大黄以治胆、胰病之湿热壅滞者，义取乎此，非真有“燥矢”者，故但求其清降耳，是则虽非承气之比，而下义存矣，故大柴胡之表里双解：外则为枢转邪气至表，内则为清降胃腑气分；此证之来，仲师但言误下而致，实则误下固可内陷而成此证，而疾病自身之发展亦每可见，当内有湿热食滞未化之患者

而外邪犯乎少阳，或自太阳来，或自阳明来，如前及之胆、胰病者，固非必定为误下而然也，是又与大青龙之自表及里者同矣，且此证患者之体实、苔黄，当亦与大青龙相睽，但苔之赋厚当甚于大青龙耳。

少阳丛谈

（一）少阳之名义

少阳之名出《内经》，其义盖就人体阴阳两者之多孤为言，以体之阴阳论，二者充身而参杂同存，相辅相成，不得截然分离，离则为“阴阳离决，精气乃绝”而生者死，然其间各因部位、时节而有多孤，其阳多于阴者统命之为阳，反是则称之为阴，阳中复依多孤而区划为三，而太阳、阳明、少阳之名出矣，少阳为阳生而尚不盛之境也，犹阳之处于少儿期者，非盛壮之年，及其盛壮，则称之为阳明、为太阳，所以《内经》言：“太阳者巨阳也”，“阳明者两阳合明也”。应之于经络脏腑，则胆、三焦也，胆以生发之用而况之为少阳，三焦以生化之原始力量而况之为少阳，均从“少火生气”着眼。迨其经络发病，则称之为少阳病或少阳证，如《灵枢·经脉第十》之列有少阳病症，《伤寒论·辨少阳病脉证并治》所列各证等者是。《素问·阴阳离合论》之“少阳为枢”，为就三阳之相互关系而言，所谓“枢”，谓其有转枢太阳之“开”、阳明之“阖”之用也，无枢则开阖不得，而太阳、阳明之用息矣，《灵枢·根结第五》之开阖枢中，复系以病症，是合“经脉”、“阴阳离合”之义者也。

以上少阳、少阳经、少阳病三者，均赅于《内经》之文，后之论少阳者不出此畴，然须明其有三之不同，少阳就用言，少阳经、腑就体言，少阳病则临床辨证之境矣。

（二）《伤寒论·少阳篇》与《内经》之异同

《伤寒论·辨少阳病脉证并治》篇，侧重继承《内经》少阳经、少阳病而略于少阳之义，其间更以论病为主，又因《伤寒论》为外感热病之论，故发挥“脉解”篇、“缪刺”篇及“经脉”篇“是动”之病等方面，而略于“是主骨所生病”及《根结》篇之“骨繇”论述方面，然虽略于文，而实则未尽无也，夫病热者自是主于寒热，而寒热时之筋骨痠楚痿弱自可同见，当为主之寒热除而楚者亦解矣，此足与“骨繇”症状同，但未及于无热者之以筋骨为主症者耳；《伤寒论》中虽未明白多涉论少阳经络，但仲师治法中已可窥见，如“刺期门”法，小柴胡汤之用于热入血室等；至于太少合病，少阳阳明合病等则犹有“枢”之为义。

（三）半表半里之探索

少阳为半表半里之说，未见于《内经》，故或有主废者，余以为既不可废，尽可探索。盖此词之来，缘于邪之为病部位者多，《素问·热病篇》“一日巨阳受之”、“二日阳明受之”、“三日少阳受之”之文，已明言少阳为受邪之第三层次，此时已逾太阳、阳明（至少已过太阳），邪不在表，尚未入里，虽不在表而尚属于阳经，若以阳为表、阴为里较之，则此犹表之末，是所以称半表，尚未入于阴而已邻于阴，此所以称半里（亦可因其虽属于阳而已居阳之里层故称半里），《伤寒论》各篇之次第编次，据《素问·热病》之次而以少阳篇列阳明之后，同属此意，此为不可废之所以然之一。世之理论创于人，论之有理与否则视乎其确否，确者称之为真理或正理，医论之确否则验之于临床疗效，据此论而治病确有效，则犹真理也，真理固不可废者。忆1976年余在锡，学生二人受主废之说于邻县，归而语余。事有可济，适有二患者外感三月余而日晡寒热，虽不甚而不除，少阳症具，余决为余邪留少阳未撤，告以此即半表半里证，可以

外透达邪而愈，嘱验之于药后，因予小柴胡汤原方略加透表，均2剂而愈，《伤寒论·辨太阳病脉证并治》有文云：“伤寒五、六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，脉细者，此为阳微结，必有表，复有里也；脉沉亦在里也，汗出为阳微，……此为半在里半在外也。脉虽沉紧，不得为少阴病，所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非少阴也，可与小柴胡汤”，两患者每日晡如之，但日延久耳；此节经文，即半表半里之出处，言邪之所在者也，此之所谓里，邪入于里而未及于阴也，所谓表，邪虽入里而未离于表也（据三阳皆为表言），既以指邪犯之畔界，亦症状之一大类，临床治病用之，理效俱在，是又不可废者之一；且夫邪之由表之里，里之表，邪之袭与气之布，无不由此出入，存此一席境地，名之曰半，虽或词称有可易，然此境界不易也。徒翻新名，无益于后来，混视听，不如不废之为佳。

其须探索者：《素问·热论》、《伤寒论》既以少阳为第三层，而《素问·阴阳离合论》又以“少阳为枢”，夫枢、枢转也，枢转于太阳之开、阳明之阖之间，无少阳之枢，则开阖不得，张注、高注均持此说，若是则少阳似居太阳、阳明之间，复以《伤寒论》中之太少合病证之，则少阳非定居于阴阳经间之半表半里者，将可以为居于太阳阳明间之半表半里矣。余于此有二说：其一，少阳之曰枢，当更深求一层，夫言开阖枢者，言阳气之用也，少阳既为生发之气，设无此生发之气为之转枢，则阳气不昌而开与阖皆无权，言枢之与开阖关系，各注均然，如高注言：“枢者所以转动之微”，张注言：“少阳为枢，谓阳气在表里之间（张以太阳为表、阳明为里），可出可入，如机枢也”，设移此“可出可入”、“转动之微”之气于阴阳之间，则由阴生阳之初生阳气，实即少阳生发之义，以之输转于二阳、巨阳，则不特

三阳开阖枢得以同用，所谓“搏而勿浮，命曰一阳”之义亦见矣，而且于阴生阳长之义亦可“不相失”也；夫阴阳固不可离决者，余以为如上解，庶几少阳之用全而《内经》之蕴义出矣。故半表半里之位，当以阴阳间为是，而非太阳、阳明间也。至于太少合病之理，与前说有异焉，前者言生之常也，《伤寒论》及《素问·热论》则言病也，故说之二曰：《内经》言“邪之所凑，其气必虚”，伤寒之传经系乎此，虚而后可传入，不虚则邪不能入，故六经之传有不以次者，有太阳阳明，有太阳少阳，有太阳少阴（后世有宗《素问·热论》“两感于寒”之义而称之为直中者），是则病人与不病者之间，有常、变之不同，是不能相侔者也，可以其常而诊病，不能以病而为常也；少阳之位于以定矣。夫阴阳之转化推移，有其道而无其决然绝然之界，三阴三阳之名原为测道而设，理有必然，可以区而分之，不可以刻着为求，所谓可定者在此，事物之消长皆然也。

（四）少阳之病证

少阳病证，当合“少阳篇”之“少阳之为病，口苦咽干目眩也”，“太阳中篇”之“伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸、小便不利，或不渴，身有微热，或咳者”两条条文所记为是，仲师复有言：“但见一二症便是，不必悉具”。综上各条申述之，余以为往来寒热或发热微恶寒微恶风一组症，当系主症之一方面，以其为表证未罢之表示，亦为邪未离阳经之表示，当不在“不必悉具”之列，另为胸胁苦满、烦一组症状，此为邪入于里而未及于阴之表示，为少阳主症之又一方面，亦当不在“不必悉具”之列，盖有此二组症状而始得合成半表半里证也，是为投小柴胡汤之不可少者，其余各症，可因邪涉之经、腑不同而现为或见症，虽同可用柴胡系方出入而

自可“不必悉具”矣。上述之见，为综合《伤寒论》有关小柴胡汤、少阳之条文所得出，舍此则为它经病症矣。余所以不以“口苦咽干目眩”为少阳主症者，在于少阳病固可见此症，而少阳之外成因尚多，可以遍涉阴阳，外则六淫之邪，内则正虚甚或穷极而涉乎肾与脑髓之病，自非柴胡系方之可赅而为治者矣。

（五）少阳之治在还表外透

《素问·热论》言：“三阳经络皆受其病，而未入于脏者，故可汗而已”，是明确包括少阳而言者，是少阳病亦可用汗法也；且《药性赋·寒性》云：“疗肌解表，干葛先而柴胡次之”，是明言柴胡为表药。总此二者之论，均为治法中之汗法畴也，惟其层次有不同，发汗之缓烈甚微有不同；言解表，麻黄与桂枝之汗已异其烈度，是尚同属辛温类者，迨辛凉之银翘、桑菊，则尤异于麻、桂矣，辛凉重剂之白虎汤，吴鞠通尚以之为解肌之剂，仲师亦然，且不独白虎，即青龙辈亦未尚离表法；总其区分，在热轻、热重，有汗、无汗间耳；病邪传经中，少阳既可在阳明之前之后，且少阳为阳经，自当可表，但不得以无汗高热为的，亦不得以大汗为求，就《伤寒论》之麻、桂、葛、柴、白虎诸汤而论，当为由表及里之层次，而可概之于表法者，第名称不同；曰汗，曰解肌，曰和解，仲师于桂枝汤重有明文禁大汗，以别于麻黄，违之则“病必不除”，甚或“亡阳”，于少阳亦禁汗，所谓“少阳不可发汗，发汗则谵语”，鞠通于银翘亦有别于桂枝，然此皆透表之剂，驱邪还之于表而解者，故亦不得令无汗也，第禁大汗汗多耳，是则各方之所宜有别也。柴胡汤之热，或微发热，或热不甚而微恶风寒，所谓寒热往来者是，于汗则或但头汗、阵汗，或微有汗，而不得常无汗，邻于桂枝而恶风症轻，偏于石膏而汗与热均小。此就热病之外感者言，就热病病程较之而为然者也。若恶症之恶寒战慄，高热大汗，虽或可用柴胡者不在此列，

以柴胡效微，必兼他药而治故也。亦非少阳畴故也。

（六）小柴胡之和解

柴胡世以和解称，所以曰和解者，和少阳经气也，非和解少阳正邪之气，夫正邪不两立，邪为在所必除者，不得容而和之；邪干少阳，则少阳之气不和，不和则少阳症见，欲和少阳之气，必解乎少阳之邪，邪之去路所在，为还之于表而外出也；此义与桂枝汤之“调和营卫”同，营卫不和为卫强而营弱，卫之所以强，为邪干而然，盖卫外之阳气抗邪而为强也，《伤寒论·太阳篇》有文言：“太阳病，发热汗出者，此为营弱卫强，故使汗出”，“病人脏无他病，时发热、自汗出，而不愈者，此卫气不和也”，“病常自汗出者，此为营气和，营气和者外不谐，以卫气不共营气和谐故耳”，明此“营气和”而“卫气不和”，则可知矛盾之主要者为卫受邪干，故仲师用桂枝汤微发汗而逐其邪，邪去则卫强平而得和谐于营矣；桂枝汤之和谐营卫为此理，则少阳之和解亦此理，同曰和而实同有逐邪之义，故和解者，和少阳经之正气，解少阳经之邪气明矣。

（七）少阳还表外透之引伸

少阳之邪还表外透，不独本经然，凡邪之由里出表既必经少阳，故邪之可由阴透阳者亦可自小柴胡之义扩而治之，如《伤寒论·太阳篇》之“热入血室”于热未与瘀血相结者可用小柴胡，是为由下由血还经少阳而透邪；《伤寒论·少阴篇》四逆证之用四逆散，亦为由阴还经少阳而解，《伤寒贯珠集》言其机曰：“少阴为三阴之枢，犹少阳为三阳之枢也，其进入入则在阴，退而出则就阳，邪气居之，有可进可退，时上时下之势”，言四逆散方则曰：“其制方大义亦与小柴胡相似，四逆之柴胡枳实，犹小柴胡之柴胡黄芩也，四逆之芍药甘草，犹小柴胡之人参甘草也，且枳实兼擅涤饮之长，芍药亦备营卫两和之任，特

以为病有阴阳之异，故用药亦分气血之殊，而其辅正逐邪，和解表里，则两方如一方也”，此诚洞识表里，机枢在握之言：复如《温病条辨·中焦篇》“暮热早凉，汗解渴饮，少阳疟之偏于热重者”之用青蒿鳖甲汤，下焦温病之“夜热早凉，热退无汗，热自阴来者”亦用青蒿鳖甲汤，盖一为解少阳本经之邪，一为搜阴分之热经少阳而外透，与四逆散义同，但以温邪伤阴浅深之不同，而育养阴分之味分上花粉、下细生地，同以青蒿为柴胡之用，是其着眼点也。它如少阳病之证如《伤寒论》所述者，《温病条辨》亦治之小柴胡，其透本经之邪义同也。

（八）少阳禁汗、吐、下之探讨

《伤寒论》注多言少阳禁汗、吐、下，盖源于“伤寒脉弦细，头痛发热者，属少阳，少阳不可发汗，发汗则谵语”，及“少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐下，吐下则悸而惊”等条文而来，是固有其理在，之所以不可发汗，因邪在少阳，无表实表虚之可汗证，且脉弦细，阴不足以为汗源，若汗则阴更伤而热入阳明，故条文言“谵语”为“此属胃”，之所以不可吐下，因中风热在少阳，故见耳聋、目赤、胸中烦满之症，而内无阳明燥实之可吐下证，吐则伤阳明之气而为悸，下则伤阳明之阴、热甚而为惊也；然而少阳非绝不可汗、绝不可下者，仲师于柴胡证下后而不罢者，言“复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热汗出而解”，是下后尚可用汗解之一（亦正明示柴胡为表剂），于太少合病之“伤寒六七日，发热微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结”之“外症未去者”，仍合桂枝之解肌而用“柴胡桂枝汤主之”，是可汗之又一条文也，它如柴胡桂枝干姜汤之“复服，汗出愈”之方下所列文，亦为以汗出为祛邪之路者；其于言下之条文，则有柴胡加芒硝汤、大柴胡汤等，是均次于柴胡证误下之后而复用下法者，仲师均“先与小柴胡汤”，“解其外”，症

不尽除，里有结热燥矢而复用者，是先表后里，为班序之法，谨慎之至也；此之所以可下，以均为少阳阳明之证；柴胡加芒硝汤证，原为大柴胡适应证，析其条文有二段情况，自“伤寒十二日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利”一节，不仅可见少阳阳明两经之证，且可见大、小柴胡汤证之不同，“胸胁满而呕”、就“伤寒十三日不解”之病程而见此症言之，为小柴胡证，而邪入阳明之见症则为“日晡所发潮热，已而微利”，此处所云之潮热，非指结核、体质耗弱之虚性发热，为邪入阳明后出现之日晡发热，此热之高者可达谵语程度，余随师临证中，常以之为热病阳明证之判定指标，此时在经证则白虎辈，在腑证则下法矣。此条经文复言“已而微利”，此实误下所引起之症，当热邪初入阳明，尚未与积滞结为燥矢，此时正可用大柴胡汤清下少阳阳明之热，而医反以丸药峻下，至出现“微利”症；此一节为柴胡加芒硝汤之证，自“此本柴胡证，下之而不得利，今反利者，知医以丸药下之”一节，不独明示病程中之误治，亦明示由大柴胡之如何转为柴胡加芒硝汤，此处需明析前后二处“下之”，及“不得利”与“反利”，第一处“下之”指用大柴胡汤下之之下，此为正常者，故连文而言“而不得利”，谓用大柴胡不致引起“反利”也；后一处“下之”，指误下，正由于误下，故见“反利”症，亦即指上段之“微利”，意为大柴胡汤证无“微利”，今见“微利”，为误下而出现，故称“反利”；此种“反利”之出现，为猛下气陷而热邪不去，使邪与矢结而燥实，肠蠕动陡然亢进而结矢不行，但下肠液耳，温病中之“热结旁流”机制，与此雷同。此时病机之另一面为：赖患者之正气，尚未使邪尽入阳明或转为太阴虚利，“胸胁满而呕”之少阳症仍在，“日晡所发潮热”与“反利”亦同在，故先予小柴胡解少阳之邪，继加芒硝以解阳明之燥结，此时不再用大柴胡者，盖大黄虽有清下

之力而不能软化燥矢以润下,且此时气已下陷而“旁流”,若再予降下之治,非正气所能支者,故以芒硝之为愈也。大柴胡条“太阳病,过经十余日,反二三下之”,是与柴胡加芒硝汤之义同,云“柴胡证仍在者”,必指“胸胁满而呕”之症仍在,但不具“日晡所发热,已而微利”之症,是为小柴胡汤证;但服小柴胡后“呕不止”,复加以“心下急,郁郁微烦”,是因“反二三下之”后热邪内结于阳明而来,故再予大柴胡清下之;此等处临床时当虑及“胸胁苦满”之进一步即为“心下急,郁郁微烦”,审其脉弦有力,舌苔黄厚或黄腻时,即可径予大柴胡也,盖病之来,固可因误下而热入阳明,亦可不因下而发展至阳明少阳并病也。《伤寒论》中所云“心下”之在何处,则系需明确者,此非解剖学之心,当然亦非心脏之下,盖中心之心下也,古人以指剑突下、胃脘部位之上中脘间也。

综上所述可知:①少阳非绝对不可汗吐下者,其不可者为小柴胡汤本证,若兼表证或里证者自可汗下,证之二太并病之有“大实痛”者,尚用桂枝大黄汤,理自明矣,况乎三阳可汗而解为《内经》之旨乎;至于吐法,少阳病本有呕恶之苦,且为患者所畏,临床自宜审慎,但若热病中不慎口腹,少阳症与食滞新邪症同见,而能一蹴而解其痛苦者,亦未始不可慎而用之也。凡此均职在辨证而治耳。②由此而推悟,知大黄芒硝于下法中各有所宜,进而可探仲师之承气汤变化之义,亦以知大黄之用不尽为攻下,第变化其量,可以收清热之效也。

脉学管见

脉学在中医诊断方法中占有重要位置,但由于没有客观上的标准度,使记载上有纷纭情况,学习时也就只能“按图索

骥”，各自领会，自不免“心中了了，指下难明”；加上一些人为的因素，如用以推测寿、夭、贫、富，以及“病家不用开口”等的江湖术，给脉学蒙上了神秘色彩，数千年来，使一种在唯物基础上建立起来的诊断方法，“行不由迳”而沦于玄学边缘。剔除这种因素，是我们负有的历史责任，既要求在说理上得到解决，又要求有实质上的依据，困难是大的，但近来脉搏描绘器等科学性强的方法已经出现，最后总是可以克服的。现就数十年的临床摸索，谈点管见。

（一）构成脉的因素

不同脉象的出现，受心力因素、血管因素、血液因素、血管外因素等的综合支配而来。

1. 心力因素方面：包括频率的快慢，振幅的大小二种情况，就频率而言，表现为迟、数、动、促、结、代等脉象；就振幅而言，表现为浮、沉、洪、微、濡、弱、伏、散等脉象。心力因素又受心肌、心脏瓣膜、支配心脏的神经（如左、右束支，窦房结、房室结）等的影响，上而可追溯至大脑、神经反射弧，以及神经功能变异的因素，这些因素均可影响心力，构成心脏节奏、振幅的变异，从而出现不同的脉象，如束支传导阻滞患者的脉代、心肌梗塞患者的脉散等。

2. 血管因素方面：主要为血管紧张度的问题，血管紧张度的变异是取决于血管神经的支配功能和血管壁的传导功能的，传导功能又受血管壁的厚薄和心力振幅的大小的影响，血管壁的厚薄又受血液成份的影响。例如，血三脂的长期增高，可以形成过量的胆固醇，当胆固醇不断沉淀，附着于血管时，就可使血管壁不断增厚而降低传导度。所以，当血管神经受某种刺激而使血管紧张度增加时，就可出现紧脉；反之，血管舒张，而且容量不足时，就可出现芤、革等脉；当血管壁增厚到一

定程度,也可出现紧脉、弦脉或滑脉,如果在血管壁增厚的基础上,加上血管收缩、心搏增强时,就可现牢脉。弦、紧、牢等脉,在高血压中、后期患者身上是极容易见到的,由此我们可以从滑到弦到紧到牢这一线脉象的变化,去测知血管的硬化程度。

3. 血液因素方面:可分血容量和血液粘稠度(包括血液成分变异)两类。血容量的多少,受心脏搏出量的影响,也受心脏瓣膜,尤其是主动脉瓣的影响;如果心搏弱或主动脉瓣不能阻挡回流,搏出血量就少,血容量少,可以形成涩、细等脉;在血容量突然减少,而血管尚不能适应缩小时,可见到芤、革等脉,而在血管适应以后,就可见到细脉;血容量饱和于血管腔,而且管壁柔软适应时,就出现滑脉,如果加上肌肤舒张因素,就可出现洪、大等脉。所以中医学以细、涩脉主血虚,芤、革脉亦主血虚,而以洪、大脉主热、主气盛,洪、大脉的出现,是含有心搏出量增加的因素的。滑脉主孕,是因其气血旺盛,主蓄血是因其血之有余,主痰食积滞是因其郁而热,实际上均与心搏出量有关。血液的粘稠度不足,可以出现弱脉,往往表现在失血、血虚患者;粘稠度高可以出现涩脉,所以涩脉主血痹,但粘稠度高,尚可表现为滑脉,这是兼有血管的张力柔和之故,这也是滑脉主蓄血的理由所在。

以上三大因素,与心脏关系密切,中医学中亦经常提到,《内经》“心主血脉”一语扼其总要(脉包括脉动与血管二者),脉连于心,心推动血液循环,舍此三者,无以形成循环系统,也形成不了脉搏。当心脏一收缩,脉冲由血管壁传导而出,由心搏出的血液,亦随之而出,而且靠脉冲被血管壁的传导为动力而继续受推动前进。今天这一生理现象,证明古人“心主血”、“心主血脉”之说,不是空谈,而是有其物质基础的;证之中毒

性休克患者,由于脉冲和搏出血量的不足,可以出现微、弱脉,以至于无脉,血压亦随之低落或难以测知的情况,更可说明“心主血脉”的物质性。中医学认为脉的搏动是靠“气”,以近代生理衡量,这一气的含义,应该是包括了心的动力、脉冲、血管传导功能三者的。

4. 血管外因素方面:除开机械性质者而外,通常是包括肌肉和皮肤张力两种,此种张力,受末梢神经支配,进而推测,外界气候的变化,内在饮食的刺激性,以及使体温增高或降低的起居运动,都可通过神经使肌肤张力受到影响。如果肌肤收缩,使脉管受到压力,可以出现紧、伏、牢、弦、沉、涩等脉象,当然这些脉的出现,还有其它因素,如血管张力亢进时,即使肌肤松弛,也可出现紧、弦等脉,而当血管肌肤同时舒缓,又有心搏量大的情况,那就必然见到洪大脉了。中医脉学中提到的“肤涩脉涩”、“肤滑脉滑”之说,是有一定条件的,是单就皮肤的滑、涩情况面言的,在临症诊视肤涩肤滑的同时,还应注意肤涩的原因,是由于全身营养不良所引起的,抑或由有生而来的或长期接触强酸强碱引起的,更有的是由于得不到浣洗的肤涩,总之要处处贯彻辨证分析,避免为假象所蒙蔽。

由于气候变化,影响肌肤张力而导致脉象变化的情况,《素问·脉要精微论》中有这样一段记载:“春日浮,如鱼之游在波;夏日在肤,泛泛乎万物有余;秋日下肤,蛰虫将去;冬日在骨,蛰虫周密。”它将四季的正常脉象,分别以日常可见景象作了比喻,我们可由此探索到肌张力和皮肤张力对脉象变异的关系;《素问·平人气象论》有:“春胃微弦,夏胃微钩,秋胃微毛,冬胃微石”的平人四时脉象记载,其成因在于:春季气候初暖,肌肤欲弛而尚受轻寒约束,所以出现“如鱼之游在波”的柔软而带弦的脉,弦即由寒约束肌肤,血管肌肤均未尽弛张而

来；夏季天热，肌肤完全松弛，脉波可完全反应到体表来，而成来盛去衰的钩脉，应指时，尚感有一层皮肤相隔，故称“在肤”和用“泛泛乎万物有余”来比状，秋季气候渐寒，皮肤开始收缩，而肌肉则尚未出现这种变化，故出现浮而涩的毛脉，浮是肌肉、血管舒张而来，涩是皮肤收缩而来，由于脉象开始了内向性和皮肤的收缩，所以称之为“下肤”，冬季则肌肤因抗寒而完全收缩，脉亦因之内伏“在骨”，如“蛰虫周密”深藏，变为沉而滑的石脉（此处之石，与真藏脉中的“辟辟如弹石”的“石”不同）。四时平脉的构成，不仅是肌肤、血管对气候的反应，与心力对气候的适应也有关系，如果在运动、饮酒等改变了血液循环活动的情况下，四时平脉也就可以改变其常度，甚至可以冬见洪、大之象。

上述四种因素所导致的脉象，大致上是从其单方面谈的，实际每一种脉象的构成，是与四者均有关系的，因为这四种因素在每一次脉波中是同时存在的，不过有其一定的侧重性。导致四种因素的变异，是整个机体的变异，所以一种脉可有不同的成因，如肤涩可见涩脉，血虚也可见涩脉，气血流利可见滑脉，瘀滞也可见滑脉等，这就不仅要联合四种因素去分析脉，还要综合四诊去找出引起四种因素改变的原因。此外，由于四种因素本身的相互代偿或拮抗作用，也可引起脉象的变异，如阳虚之见大脉，阴虚之见散脉，里证之见浮脉，瘀滞之见滑脉等，都说明一种脉的出现不是很单纯的，要考虑到四种因素后面的因素和四种因素的相互作用方面，中医学用脉诊作为诊断全身性情况的机理也在于此。

（二）四种因素对脉象形成的交叉关系

下述各脉，按《濒湖脉诀》所列少虚、实两脉而多一大脉。因洪、牢、紧、长等脉皆可类于实，微、细、芤、革、弱、散等脉皆

可类于虚，故不再列，而大脉为近代书中所经常提及，且既可主实，又可主虚，所以增入；其它如疾、速脉已可概于数脉，且此等脉名，原系用至数以区别数的程度而设，故略去。

1. 浮脉

由于振幅的增强，血容量、血管紧张度的适应，以及肌张力的松弛而出现。在热性病初起时，由于机体的抗病能力，促使心搏增强搏出量增加，肌肤因散热排汗机能增强而呈松弛状态，由此而见浮脉；如肌肤因寒邪侵犯而尚未对抗至发热程度，仍在紧束状态时则为浮紧脉，所以前者主风热，后者主风寒，而均属于热病初起阶段出现的脉，故历来都以浮脉主表证。在久病或慢性病中，无表证可言而见浮脉者，则往往为病退或殆危之前，构成原因之一，为肌张力的减退或消失，（与血容量无关），或为自律神经失常所引起，此时心搏虽低而血管亦渐减退其紧张度，故可见于病人的临危前，此种浮脉多兼有软弱无力，甚至可达散脉状态（如釜沸、泉涌状态），脉象达此种境界时即为常说的“无根脉”；慢性病中出现浮脉的另一原因是心搏的代偿性增大，由于全身营养不良等病的需血量增大而来，所以多出现于如重度贫血、占位性病变等的全身营养不良时期，此一情况不同于前一原因引起的浮脉，应指较有力而无散象。

2. 沉脉

由于心振幅低、肌张力相对加强而形成，部分沉脉也有血容量减少的因素。此种三因俱全的沉脉，就是古人以沉脉主里证、主虚证的由来；如血管紧张、血容量亦不减少，则表现为沉实脉如牢脉等，多因积滞而气血失于通利，心力及血量出现反射性增强以求强行通畅而来，此时又须从其至数的迟、数去分别其积滞的寒性或热性，表邪而见沉脉，为肌肤受外寒约束而

紧缩,心力在短期内处于积蓄力量情况下而来,但多兼紧脉,为时亦短暂,一待热化,沉脉即消失。

3. 迟脉

迟数两脉,均关系于心搏频率,频率慢构成迟脉,反之则为数脉。心搏频率所以慢,与支配心搏的神经是否受抑制有关。属于衰退性抑制而出现的迟脉为“虚寒”,属于被迫性抑制的为“沉寒”、“痼疾”、“积聚”等引起,后者必兼有力,前者必兼无力;所以有力或无力,除与血管紧张度有关外,无力而沉之脉,必然有心搏振幅减退的因素。

4. 数脉

由于心搏频率的增加而成。频率的增加,一为体温增高,周围血管需求量增加,神经反射促使心搏加速,此一因素引起者,必然搏出的血容量亦大,故脉象可兼见大、洪等象,故数脉多主热,兼浮则病在表为表热,不浮或兼沉则主病在里为里热;另一种则由机体所消耗的物质不足以济功能,心力起而代偿,加速搏动以期弥补,但搏出量仍少,如机器之“空转”,所谓“虚大”情况,故主虚,兼无力者为气虚、阳虚,兼细者为血虚、阴虚。

5. 滑脉

构成因素为血管张力适中,而血容量或血液粘稠度稍有增加,与皮肤滑利缓和亦有关系。此种因素在中医学中称为“热”或“气盛”;如由于血管外张力增加,而心搏血液强行通过,如肌肉丰富,心力需相对增强而形成的滑脉,则称为“疾盛”,李濒湖说滑脉主“元气衰”,其因即在心力的代偿方面;怀孕期,以及蓄血病之初期,由于积聚而引起热量增加,使心搏出量增加,所以也可见到滑脉;孕妇由于气血养胎而常旺盛之故,所以滑脉始终存在,蓄血证虽始而心力增进,继则因瘀血

留而不去,循环量受到影响,所以继之可出现涩脉。

6. 涩脉

由血容量减少,血液粘稠度相对增高,心振幅降低,或血管张力改变及皮肤枯涩等所引起。由于血容量减少,所以主血少、伤精;汗多后所以见涩脉,是因血液中水分被夺而稠度增加之故;寒湿痹所以见涩脉,是因阻碍气血正常运行或较长时间消耗气血而来。脉学中认为涩脉有细、迟、短、散及一止复来等象,似难况涩脉的本义,而有“胶柱鼓瑟”之弊,其中一止复来之象,已属于代、结、促等脉,而细、迟、短、散,亦各已另有分列,且散、细二脉,往往不能同见,故此种对涩脉的形容难于与其它脉分界,只有“往来难”及“叁伍不调”(至数不整齐)二种形容比较合理。

7. 长脉

长短二脉均为就部位而言,长为超过三指,即尺后还可触及脉动,甚至可再达三指距离之外。长脉常见于平人,尤其是瘦人更为多见,因此只要兼见脉象柔和,就不能作为有病看,主病长脉常兼见弦、数等象,所以主“阳毒、癰疽”和“阳明热盛”,其构成因素与弦脉同,有血管紧张和肌肉张力相对减弱的关系,由于血管紧张度的增加,所以可见于高血压、动脉硬化的患者。

8. 短脉

脉象不及三指,甚至可仅见于关部。构成此脉的因素:心搏无力加上肌张力相对增加是其一,也兼有血管神经功能紊乱的因素,由此而称短脉,主气血虚少,此种短脉必兼弱象;如短而兼滑,是被迫性的心搏加大,是由于循环系的外围有气塞、痰阻、积滞和湿热等壅滞气机的因素,尤其是短脉仅见于关部时,可见于儿童食积、蛔积证。短脉虽主积滞,但毕竟以气

血不足者为多见。

9. 洪脉、大脉

洪脉与大脉的构成原因大致相同，都由心振幅大、血容量多、血管舒张和肌肤张力相对减退而来。但洪较大为更甚，且大脉有血容量并不增加的可能，所以此两脉均可主热，而大脉则由于血容量并不增加之故而又主虚火。脉象上的区别是：大脉边幅阔大，洪脉在大脉的基础上加之指下有力，应指丰满欲溢的现象，这是由于心振幅和血容量均超过大脉程度之故。

10. 微脉、细脉

以心振幅的减弱为主因，也有血容量减少的因素。偏于前者的，表现为上下无力的微脉；偏重于后者的，表现为边幅细小的细脉。微脉可以兼见细象，亦可不见细象，而以上下无力为主，此为与细脉区别处；心振幅的强弱，可以比之于中医学中的“气”，振幅小相当于气弱，所以微脉主要主气虚；《濒湖脉学·主病诗》中有“关脉微时胀满形”之句，好象是指实证，实际是指脾胃气虚所致的虚胀，是运化功能低下而心振幅不足以搏出所需热量的血源而来的“胀满”，所以脉象见微。细脉主要是血容量减少，加以血管收缩而来，所以应指细小，《脉经》称“若丝线之应指”，由于物质减少，所以主血少、精少。微细两脉往往同见，所以然者，微脉反映气虚，细脉反映血少、精少，气血相互影响，气虚可以少生血，血少可以难增气之故，但其间二者之别是应该注意的。

11. 紧脉

主要由血管紧张度增加而形成，与肌肤张力的增加而约束血管也有关。其紧张度较弦脉更进一步，所以《脉经》说“如切绳”，但并不象“真弦脉”的“如循刀刃”。由外寒而来的紧脉，是机体对寒的对抗防御而使交感神经兴奋，促使肌肤血管紧

张所引起,故出现于热病初期无汗时期;由内寒而起的紧脉,是血管收缩拘挛而来,所以在寒性胸、腹痛时可以见到。血管神经性头痛及其它原因引起血管拘挛时亦可见到。紧脉在机体蓄积热力而后开始抗拒寒性因素时,可向数、大等脉转化,在机体本身趋向虚惫时则可向虚性脉转化;如果由血管紧张,加以血稠度增加而来的紧脉,往往挟有滑象,多为郁热引起,可见于肥人而血管硬化患者。

12. 缓脉

缓脉有二种意义,一是至数上的缓,一息四至,一是和缓之缓。此脉是在四种因素互相配合最好的情况下出现的,心搏频率不快不慢,振幅不强不弱,血液在血管中处于饱和状态,血管和肌肤张力缓和,既不约束,亦不松弛,所以出现“一息四至”、“应指和缓,往来甚匀”的现象,是健康人的脉象。其“从容和缓”现象出现在其它脉中,就是脉的“神气”,就不是“真藏脉”,此种“从容和缓”,不能作不大、不小、不快、不慢解释,而是指柔和现象。缓脉在脉学中也谈到主病,但主病的缓脉必兼见其它脉,如主风必兼浮大,主虚必兼软弱,主表湿兼濡,主里湿兼沉等;应按其它脉分析,不属缓脉本义。

13. 芤脉

主因是在血容量减少情况下,而血管张力尚未适应而缩小,出现了“中空旁实”之状。多易见于精血暴脱之时,迨至血管渐趋适应,则由芤而革、而小、而细,如心振幅不受影响,而且血管不出现代偿性收缩,则可能转向虚大脉象。

14. 弦脉

主要由血管张力增加而来,指下“如按琴瑟弦”,所以称作弦。脉学中主肝胆病,或肝胆病引及其它脏器或其它脏器病涉及肝胆时也可出现弦脉,如胃痛吐酸,可在右关部出现弦脉,

症疾病的脉多弦等,但此类病的弦脉多兼见别种脉。从肝病与弦脉的关系,再从弦脉的出现与血管神经紧张的关系,可以测知中医学中所说的肝与现代说的神经有密切关系。体内有疼痛时也可见到弦脉,此亦为血管拘挛收缩而来,与紧脉理同,痢疾脉弦的原因就由于此。

15. 革脉

为合弦、芤两脉的成因而来,即血管的紧张度较芤增加而如弦,但血容量仍如芤之少,遂而指下“如按鼓皮”,鼓皮为革做,故称革,是血管张力适应血容量少的过程中的产物,所以与芤同样主暴失精血,或者兼有寒性疼痛。

16. 牢脉

是沉、长、紧三脉的合并,指下有坚牢之象,所以称牢。《脉经》认为“似沉似伏,实大而长,微弦”,其实“实大”加“弦”,即是紧脉。牢脉由血管紧张度、血液粘稠度、心振幅均有增加而来,亦与肌张力增加有关,因此历来都主里实证;由于阴寒凝积,血管挛紧,心振幅因要求改善血流量以对抗寒积而增加,但又受血管紧缩的约束而出现牢脉,所以牢脉主“腹心寒痛”、“疝瘕癥瘕”。在血管硬化到一定程度时亦可见到牢脉,此为血液稠度增加,血管壁增厚,心搏传导必须增强而来,但此种脉中、沉取时均可见,不象牢脉只有沉取可得,而脉的成因有相同之处。

17. 濡脉

为微、细、浮的兼合脉,《脉经》称:“如绵在水,轻手可得,按之无有”,李濒湖说:“濡形浮细按须轻”;此由心振幅弱,血容量少,肌肤张力亦不足而来,所以主气血俱虚,由“亡血阴虚”、盗汗、血崩、脾湿而致的气血俱虚到一定程度时可见此脉。有人以濡脉主伤湿,要由伤湿导致气虚而后始可见,即使

是表湿证也要到表气虚时才见，李濒湖有“平人若见是无根”之说，如果不虚，就不致以无根脉作比，而且心振幅不弱也不出现濡脉，心振幅的弱，就是虚象，所以濡脉可由微脉来，也可由细脉来，而不能以为伤湿脉必濡。

18. 弱脉

缘于心振幅低，血容量少，也有粘稠度降低的可能，而血管则因适应血容量而变细，由此而产生沉、软、细合并的弱脉。振幅弱，是中医学中的阳虚或气虚，血容量少或粘稠度不够，是阴虚或血虚，因此弱脉与濡脉同样主气血俱虚，所不同的是濡在浮取而得，弱在沉取而得，其间有阴虚而后阳虚、阴虚而后阳浮的不同；濡脉阴虚而阳浮，故有无根之比，弱脉则阴虚阳弱，两者肌肤张力有小、大之别，心振幅减弱程度也不同，濡脉的振幅较弱脉尤低，而肌肤张力则处于松弛状态。

19. 散脉

散是散漫之义，包括频率、振幅、血容量的散漫或涣散，以及血管张力的涣散在内。由于频率的散，所以“至数不齐”；由于振幅的散，所以“来多去少或去多来少”；由于血管张力的散，所以“有表无里”；此种频率、振幅、张力的失掉规律，总起来是功能上的紊乱，与自律神经功能的紊乱有很大关系，所以散脉总的是元气虚损的表现，所主的怔忡、自汗、溢饮、胎前肿等，均是由于心阳、脾阳的虚衰而引起的。此脉的出现，机体已濒于险境，实际上与无根脉同，类于“虾游”、“鱼翔”、“波合”等脉，所以古人有以之作为死脉的。

20. 伏脉

由血管紧张拘挛度增加，使心振幅小而有力，但不能鼓至肌表而来，与肌肤张力亦有关。血管拘挛为机体对抗宿食、老痰、积聚的反射，心振幅小而有力，是外受壅遏（包括血管紧缩

因素在内)所促成,欲求满足全身需血量之故,亦为欲求通过此种调整而排除积滞之故,所以阳明腑证中可见到伏脉,伤寒战汗前也可见到伏脉。在中医学中,伏脉多数是寒伤阳气,阳气暂时处于蓄积力量时期出现的,伤寒战汗前即属此种情况,故一旦阳气足以抗寒即战汗而热解,则伏脉消失。伏、牢二脉相近,其区别是牢脉的血管紧张度与心搏力均较伏脉为甚。

21. 动脉

由于心搏频率加快,支配血管的神经功能紊乱、紧张度与舒张度不统一而来。《脉学》中说:“专司痛与惊”,痛是引起血管痉挛的原因,也是心搏加快的原因,中间有神经的关系,心搏加快与对抗血管痉挛也有关系。“泄痢”、“拘挛”、“男子亡精女子崩”等,均要通过血管痉挛而后才导致动脉的出现;不导致血管痉挛的“男子亡精女子崩”,就只能出现其它脉象,所以上述几种动脉的主病,只是在出现动脉患者身上可能有这些病,而并非这些病必见动脉。动脉的血管痉挛程度要超过革、紧、牢脉的程度,致支配血管的神经在过于紧张情况下出现紊乱状态而表现为动脉,此种紊乱,不可能固定在某一部位,所以旧说动脉只见于关部是不确切的。应该其他部位也可以见到,此点正是与短脉的区别处。动脉本身尚属病机由实转虚过程中的表现,如果处理不及时,病情就可进入虚途。

22. 促脉、结脉、代脉

此三脉均由心搏频率的改变而来,频率加快而兼有传导不良,出现数中一止者为促脉;频率慢而传导不良,出现迟中一止者为结脉;频率改变不表现在快慢方面而因传导不良,脉动间歇出现在固定至数中的为代脉。故此三脉可见于传导阻滞、期前收缩等心律失常患者。促脉由热性因素使心力被遏制而起,凡痰、食等积滞化热,以及毒热入营,或其它高热引起心

刀波返时可以见到此脉。在热性病出现促脉之前，常可见到后一脉波与前一脉波接近的重复脉，此种脉象亦属促脉范围，《伤寒论·太阳篇》的促脉属于此一范围。热病至循环衰竭开始时，亦往往见到促脉，《伤寒论·少阴篇》的促脉属于此一范围。《伤寒论》中二类促脉，虽同属于热病引起，但有虚实之分，故促脉虽主热，但由于已经引起传导不良，就不能不考虑到心力不全的一面。结脉在脉学中主阴盛和正虚二种病性；心搏减慢和心搏歇止，是功能上的不全，所以主虚，虚证除了由真正的物质不足或功能低下所引起者外，还可由老痰、积滞、肿块、疝、癭等阻滞气血而来，由于未能引起发热，所以此类积滞称为“阴盛”，如冠心病的因痰滞血瘀而见结脉，就是如此。代脉主病与结脉相类，有虚有实，但代脉虚多实少。《针灸甲乙经·经脉篇》提到“五十动而一代者，五脏皆受气”，所以歇止在五十动以外的代脉，中医历来认为无病。所以有此看法，是因为见此脉时，短期中不出现危险之故，但实际总离不开传导不良的因素，包括呼吸歇止在内，所以总是有虚的内在情况，正如《素问·脉要精微论》所说的“代则气衰”；孕后出现代脉，是由于胎儿逐渐形成，气血暂时有积聚之势，迨其逐渐适应，代脉也随之消失，于此等代脉，就不能单作虚看，而应与结脉同样理解为虚中有实。促脉要注意热中有虚，结脉要注意寒中有实；虚实之区别是应指有力与否，这又关系到心振幅的强弱，搏出量的多少，促、结、代三脉中，如心振幅和搏出量均小，则属虚，否则应指都兼有脉幅宽、脉波滑的现象，则为虚中有实，如有积滞的结脉和怀孕三月而见的代脉，应指必兼有力或带滑象。

（本文1979年1月发表于无锡县学术交流会，1980年将总论部分发表于《北京中医杂志》。）

脉诊记识

脉诊为四诊之大者，治病所必据，为医所必参，舍此无以察病能、定治法；然其有不可以今之仪器测验者甚多，不就实践求之，不特无所把握，亦难于语析，余亲医之初，伦于人云亦云、书云亦云之境，尝窃疑三部连于一脉，一动皆动，此方寸间何可以察滑、大、沉、小等异，迨数十年朝夕于斯，而觉其确有可分者。可异者在，而测之于疾，又有可验者在，兹略叙于后，以待来哲。

一、孕脉

记脉之书，均谓滑为孕脉。夫滑，肥人湿胜者有之、痰盛者有之、发热者亦有之，何以为别乎！盖孕脉之滑，确乎如珠走盘，搏指圆利而续续以来，三指不移而指下如循琅玕；他疾之滑，或滑而大，或滑而数，或滑而浮，可与外证之不同而分见、兼见，且必无孕脉之圆利分明、断续均匀之感。

《内经》谓妇人“少阴脉动甚者妊子也”，夫少阴有心肾两者，指心乎抑指肾乎？心则在寸，肾则在尺，究宗何部，历来注家，多谓少阴为肾，以余察之则不然；妇人肾脉动甚之见于孕，多在七十至九十日后，此时已寸关尺三指俱见矣，不独肾也。妇人之肾脉独滑者，多主疾，或为带下赤白，或为月经量、期不调等，孕脉之动，初见一指时往往在寸，或在左，或在右，此时早则停经后四十二、三日，迟则不逾六十日，逾六十日则兼见于关，七十至九十日后，则兼见于尺而三指俱见矣，此余曾反复证之于蛙检孕检者，蛙检仅可于停经后四十五日至六十日间测得阳性，过此亦多转阴者，余以四十三日见寸脉之动甚而

决其为孕者甚多，间有蛙检阴性者亦确。忆1979年返京之初，京中故友郑某之子妻，停经四十五日，市某医院作蛙检阴性，余以为孕，然彼不甚留意，终至流产，一年后复孕时，四十三日复蛙检于该院，仍阴性，余察脉决为孕，其家人重护之，得足月产一女；是知旧注以为肾者，盖只可概言于七十日至三月者也，旧时以三月而判孕否，已属不易，盖风气闭塞故也。求其所以先见于寸之故，窃以为为胞宫因月经初停而盛，心以生血之故而应之，肺朝百脉，脉盛则肺气必亦盛而后始可副之，拟之近代生理，则心肺功能之适应初孕需养乎，是以左、右寸之或先，俱可以卜孕也。

孕脉之滑，如珠走盘者是矣，而迨至三月左右，则往往兼有盛象，尤以壮健之孕妇为然。此种圆利之脉，亦可见于非孕之平健妇女，当其经潮前一二日间，亦所必见者，是又不可断然概以为孕也，其理则与初孕者同。

二、滑 脉

妇人非孕而右尺滑大，其在月经之疾，多为由肾热而致不调，而带下者十之七，求其因则或为湿热下注，或伤于丈夫，或命火过盛，是可于余症求证之；其不滑而大者，则虚矣。

寸脉搏指，滑而大，或者上入鱼际，往往为近代之心脏瓣膜病变所引起之心脏增大，亦可为高心病之心脏增大，然非必见者，需分乎病之深浅，浅则见者少，而迨至心气不副体需而衰，则见者亦少且并滑象亦邈矣。

男子滑见于右尺，往往为阳痿早泄，或无子等，亦往往兼见大脉，其于嗜酒而湿热下注者尤易见。

三、弦 脉

弦脉不得见于右三部，右手为肺、胃与脾、大肠与命门之位，为气息出入、化物传输之用者多；弦见于寸，肝热、肝火扰肺；见于关，为肝气横逆干乎脾胃；见于尺，为肾阳之亢而烁阴，盖肝火亦相火之属也，凡此均非佳象。尤以弦之见于关者，多情绪暴躁，心情不畅，不有新怒，心有久郁，此况尤以妇女为多见；寸弦可见咯血，上气；尺弦可见性动过多。

弦脉兼紧或兼沉紧，多动脉硬化，如按之不绝者尤甚，此即类于《内经》所云之真弦脉也。有痛者亦见弦脉，此均属血管之紧张度增加而来；惟血少而见弦脉兼小兼细者，则为血管适应血容量之少而收缩之故。

古云疟、痢脉多弦，诚然，第热重者不在此例，如疟疟发作时之脉多洪大，痢而身热者脉亦兼大也。

四、长 脉

脉长有长寿之说，此近乎太素之谈，实则不然者多，平人之瘦者脉多弦长，非定为长寿之征，如结核病之消瘦者脉可长达尺后甚远，岂定寿长者乎？

五、濡脉主表湿

濡脉属浮纲，其体象为浮而无力，微细两象兼备，《三指禅》等脉籍中况以“如水飘衣”，主气虚伤湿之疾，循古训之理绎之，明为表气不足，湿邪外袭之义，故见于夏秋外感湿邪，或暑病之湿胜于热者等病。夫濡，沾濡也，水面飘衣，衣沾濡而软矣，故亦以浮而软或微为主象，细象不予也，惟素体脉细者可兼见耳；近时见有标此脉于中、下焦湿病者，盖第知濡为伤湿

之脉而不详其属于浮纲故也；夫浮主表，浮而无力，表气伤于湿也明矣，若里湿，自有虚、软等脉可见，此犹从气虚一线为言；若湿而寒化，则沉迟、沉紧之脉见，若湿而热化，则滑数之脉可见，脉随症变，表里自有区分，未可印定心目，以为湿病脉必濡也。古籍中亦有言沉濡之脉者，是正古者软、细两脉不分（统于弱脉），而以濡赅软赅细也，是需学者推之于理，体之于症，使二十八脉条分缕析、通盘比较而分明其区界者矣。

六、芤、革脉之异同

芤、革之脉，多为血容量与血管调节两种情况共同构成，芤为血容量少而血管尚未及收缩或无力收缩，此时血管有一定之紧张度，故按之如葱管，葱管固有一定强度而重按则中空也，革则血管已开始收缩而紧张度增加，故两脉均可见于失血。然此二脉之一过性强，芤脉尤甚，盖见之于人体本能之调节过程者，不能持久，否则心力不足以济矣，迨其血管适应于血容量少时，则脉转为弦或细矣，是故芤、革二脉见于临床者少也。革脉如按鼓皮，鼓蒙革而中空，言其血管强度之胜于葱管者，中空则同也，其有区别于紧脉者，在中空与否耳。

七、无根脉

古籍言无根脉，约可分为三类：一指两尺为根，盖以“肾为先天”故也；一指胃气，因“人以胃气为本”故也；一指飘浮，稍按即无之脉象，是直指来去至止之无根矣。此三者证之临床，有不死者，有可死者，有即死者，故无根之脉，不可概以为即死之兆也，且此脉就广义言之，则涉及其它脉象者亦多，兹分言之。

以两尺为根之无根脉，谓两尺脉绝，此种脉象平人亦可或

见，如经绝初之妇女，可见右尺无脉，只可反映肾气衰而地道不通之故，若此而延年得寿者固可数年、数十年也，迨其经闭数月或年余之后，又可右尺复现者，是固不当以死脉视之。其有尺脉绝之见于病而不必死者，如《难经·十四难》云：“上部有脉，下部无脉，其人当吐，不吐者死”，是明言尺脉绝之可见于病吐之甚者，固不定死也；盖气壅于上而然，迨乎其吐后则气下而尺脉复矣，惟非吐病而于它病中见之，当另论。妇女经绝尺绝之况，非人尽见者，如动脉硬化者于经绝时尺脉常仍可见，是尤不宜一概论也。

以胃气为本之无根脉，为指脉无胃气而言，此种脉即《内经》之真脏脉，怪脉中之“弹石”等脉亦属之。《内经》于此虽云死，然非即死及必死者，舍怪脉之心力衰竭者外，真肝、真心、真肾等脉，均多见于动脉硬化之后期，此类患者固可因本病及其衍生之病而死，亦可死于非本病之病者，且能先而防治之，固可以延寿者也，故虽有可死之因，而非必死于此及即死者。

着指飘浮，稍按即无之无根脉，实亦可赅于胃气之绝为言，第较之上节为重，前者多为不续不继，此则或散或绝矣。统及脉书中之散脉，怪脉中之“雀啄”、“釜沸”、“虾游”、“鱼翔”、“屋漏”等均属之，《内经》有“如以毛羽中人肤”之况，见此脉者，短则10余分钟，久则亦在一昼夜内死矣，此盖心之动力、血管之张力，及夫血流量均渐次涣散故也。余在锡时曾有一肝硬化患者沈某，会诊时尚神清语言甚敏，而脉竟飘浮无根，余急嘱其家属速运枢来备后事，未出刻而逝矣；又1985年7月15日晚间会诊某院校一外语教授，腹部手术后已昏迷2日，脉见无根，内科主任询予可否用安宫牛黄、至宝之属，余云：“命且不保，何云治昏迷，如明晨无他时再考虑。”患者中夜亡矣。故余以为无根脉之即死者唯此，就人之常解：以无根脉为

死脉论，亦唯此脉当之为是也，其余备论备参可矣。

着指飘浮之无根脉，有如浮沤，着指即无，其来如沸泡上涌者曰釜沸，久而一来者为虾游，虾游之脉虽应指较釜沸稍清，然亦有至无去。此脉之始也多如浮脉，渐软，渐虚，渐至去、止不清，迨至指下模糊则危在旋踵间矣；余屡见此于菌血、毒血、肝昏迷及垂死之症；菌、毒血症之外证多形寒发热如疟而一日数作，设脉见浮而不实，去、止不清则昏迷欲作矣，肝昏迷前驱之脉亦然。

八、来去至止

脉有来去至止之说，此以一脉波为言而分之四段者，自一波始起至应指最盛之间曰来，其应指最盛时曰至，自应指最盛时下趋至尽之间曰去，去尽而歇曰止，此后则新波又来，又复见来、至、去、止之象。其来、去之间有盛有衰，至、止之间亦有盛有衰，由其盛衰强弱之不同于来、至、去、止之间而各脉以分，如洪脉，来盛而去衰（速），按之如循古衣钩，故《内经》称为“钩”脉，弦脉则来、去均盛，紧脉则来弱去盛，濡、大、芤、革脉均止弱，洪、弦、革、紧脉均至盛，微、软脉则至、止俱弱，凡此均就动力言也，七怪脉中此况尤著，如虾游脉之有来而无去，有至而无止，釜沸脉之有至而无来，应指即散如浮沤上涌等，均可就其动力推循以分。

九、辨脉在于习

脉之成因千丝万缕，各脉之辨别亦诚难，计惟久久习之于临床，孜孜思索于脉籍而后始有所会，其可较速成者有二，一为师之所云，而生察之，察之久则可辨矣，然此为仅可得所师者之辨脉法耳，设师亦梭模，自难了事；一为就各脉象之间求

其区别，务令各有其相对独立性，进而求其各脉转变之由，如外邪脉之由浮而数、而大、而洪，虚人之或由小而细，或由大而软、而微等，按籍之所记而推理之，贯通之；此法较可全而，然总不能舍乎临症之对悟、而较其区分于实际也，如局于谈兵纸上，则指下诚难明矣。

十、浮中沉定脉法及举按寻

脉之别于浮、中、沉者，以浮取而得、中取而得、沉取而得为限，此古之定法，原无可议之处，然有就诊于临床而贸然以复取式诊脉者，是不得不致数言，夫取浮纲之脉，以三指贴紧患者腕肤为准，稍加指力则为中取，若迫近筋骨则为沉取矣；且人体之脉，于浮、中、沉三层中非独见于一层者，以浮脉例言之，贴肤得其最盛之势，中取则减，沉取亦减，非中取、沉取无搏动可见也，若以中取、沉取俱无脉动之谓浮则甚谬，盖若是即无根脉矣。中取浮取中，亦各以何层脉势最盛为定则，若沉取最盛而中、浮势减，则为沉纲之脉，故诊脉古有举、按、寻三序，按序中已有浮、中、沉三层，盖自浮逐层按至沉为“按”，后复逐层返于浮为“举”，所谓举者，指之逐层上抬也，象者也，若以浮取为“举”，则无举之象矣；此自“按”至“举”中已含“寻”义，盖寻其何层之脉势最盛，以定浮纲、沉纲之脉，复寻其迟、数、大、小、长、短、滑、涩、革、芤、牢、紧、弦、洪等诸脉象，与夫着骨推筋以寻沉、伏之脉，莫不寻而得之者也，即《内经》尺内、尺外、内候、外候之所求者，亦属之于寻也；于此复有申说者，所谓内候、外候者，是以指之宛转于脉管之两侧以测脉体也，自内侧测之为内候，反之则为外候，临床于此内、外候中，确有迥然不同之脉象可见，未可便以为内、外候所列脏腑之不同而混视者也，惜乎不讲求者久矣！脉之浮、沉两纲，与夫举、按、寻

间有如是之不同，则知仰、复之不可倒也矣，盖仰、复之间，浮、沉适为相反，仰取之脉沉，则复取可以为浮，为血行脉中，血犹水也，水性就下，仰、复之间，血之重性易位矣，人尽知浮、沉惑乱之不可，故常诊不得用复式，古人只以复式取沉微欲绝之脉，或沉取不得而后复取之，所以利用血之重性可显示于指之程度，以测心气帅血之力存否程度也。

十一、寸关尺之据

自《内经》诊法各节言寸口、尺肤以来，脉诊中历以寸口分寸、关、尺三部，其命名之由，注家多以寸口为寸之据，而以自肘至此一尺之说以解释，按《孔子家语》云：“孔子曰：布手知尺，布指知寸，舒肱知寻”，此盖原于周尺之度者，今时木工用尺，尚为周之遗度，以八寸当一尺，是实周一尺当今七寸七分之大概也，《碧里杂存》云：“用拇指与中指一叉相距，谓之一尺，两臂引长刚得八尺，谓之一寻，中指中节上一纹谓之一寸”，是亦约于周之度者，虽人之修短各异，而以自身之中指端与拇指端一叉之度，自肘横纹约至腕，则适当尺部，脉诊之“尺”部盖原于此，此之长度虽不尽恰如七寸七分周尺长度，要亦可概约之者；准此则脉诊之“尺”部，进而可知为原于周之尺度也。由“中指中节上一纹谓之一寸”推之，实亦“同身寸”之度也，以此量腕横纹后之距，是“寸口”之所自也；今诊法布指自腕横纹后一指为寸，而第三指适当尺部，前者为寸而后者为尺，盖均据周度而来者明矣，尺寸之间，当腕后高骨者曰关，关者分界之义，谓此处分别寸与尺也。《孔子家语》出于汉，较《内经》成于汉哀、平之世稍早，两书均记秦前后论，义同者多，相离自不远也。

十二、脉之神气、胃气

东垣以“脉中有力即有神矣”，景岳复伸之曰：“脉中有力即为有神，夫有力者非强健谓，谓中和之力也，大抵有力中不失和缓，柔软中不失有力，此方是脉中之神，若其不及，即微弱脱绝之无力也，若其太过，即弦强真脏之有力也，二者均属无神。”

《内经》以“脉弱以滑，是有胃气”，高阳生以“阿阿软若春杨柳”为脾家脉，即胃气之谓也，景岳以为“但于邪脉中得兼缓滑徐和之象者，便是五脏中俱有胃气”；《内经》又以脉之无胃气者为真脏脉，滑寿亦以“中按得之，脉见和缓”为胃脉，后之诸家俱以和缓为脉之胃气，周梦觉更颂之曰：“缓字医家第一功。”

综上述之情观之，所谓神气、胃气者，均为柔软和缓之象，两者二名而一义也，自均以怪脉、真脏脉之为无胃气、无神气，足以反证之者，所以有二者者，为《内经》两言之，而后人亦遂两名之耳。然就《内经》“得神者昌，失神者亡”之义核之，则神气之义不独仅指脉象中者，四诊中莫不皆有神气在也；即仅就脉而言：一时脉动之象中需求有神气，而于晨之至夕、昨之至今之脉象变化而较其进退，亦有神存乎其间，及夫脉与形证之相合、相违变化中，亦莫非神之畴也，此种广义之神气，自又与胃气不尽同义矣。

色诊琐谈

五色之见于面，旧以五脏配之，夫《内经》既以心额、肾颐、左肝、右肺、鼻脾为分，又有面王、鼻、水沟直中线分配脏腑之

记,可见其不拘泥乎一法也,亦明乎拘于一法之不可必也。如肺结核之颧赤,往往两颧俱见,未必左肝而右肺矣;又如二尖瓣膜病之颧色紫赤,亦未必以颧为肝、肺矣。且临床之间,又有越于古人之说者,忆60年代北京中医学院刘祥同学曾以经络测定器测面部黑斑之经络定区,其结果为两眶下为胆经,颊车上为大肠经,颊中为胃经,耳前多肝经等发病,以经络及其相表里之分区计之,尚符合古籍所载,然而不尽同于右肺左肝之说。就临床疾患而证之,水沟之黑,确多为膀胱子处之疾,包括部分内分泌疾患,自口角至耳垂下一线、上黑下白截然划分其色者,则多为近代肝炎、肝大之属,此况虽交臂而过者亦可睹,且多为病之久者。

三阴皆令人面黑,或黑而挟赤,或黑而油垢,或黑如蒙尘,是心、脾、肾、肺皆可见而黑矣,第此类面黑均见于久病之后,初病则未必耳;其挟赤及如蒙尘者,有热化、寒化、实证、虚证之分,油垢则为挟浊,而瘀郁之况则各种面黑皆有之;惟肺之虚者,色多如蒙尘面不甚黑,泽失而气伏故也。

眶周黑,有三端;倦甚者黑,患“雅司”之属者黑,失眠者黑,眠之不足于5小时者,往往一宵即见;然三者之分,需参余况而后定也。

耳门前指许宽色甚白,耳亦白,审其分界前之黄或黑色非毛发浓密使然者,其在肾病患者言,往往为肾实质变,宜检查肾功能以求证。

曾见二妇女,当额黑如指,自发际来,上大而下锐,数年垂延愈长,几及鼻部,然无不适,且黑眶陷落如凹;两妇均40左右年龄,其一为叔岳母,以无不适,亦不就诊,无从得其详情,若就色克义言,甚不佳,然叔岳母20余年健在,或局部皮肤之疾乎,仅此存记以俟识者。

蝴蝶脸多见于孕妇，以鼻直为体，两颧下为羽，正如展翅之蝶，亦有产后终不消者，今时以内分泌不调或黑色素沉积释之，然多无他证可据，中医以化瘀法治之，亦只效十之五，是瘀之立论亦未尽然也，以肝、肾为治，亦或有效有无效，其捷法又待俟乎来者矣。

1966年前阅一小册，记小儿诊断各法，其间有以睛白（气轮）上所显黑点、黑线诊虫症者，云从上睑或下睑走向风轮之黑线，其端缀云片状而色带蓝者为钩虫，如点而黑者为蛔虫。证之临床化验：虫则可必，钩蛔之分则未必，且往往相反。又云上唇系带见小白粒为痔疮，且以所在部位示痔疮位，均以时钟点位为据，试之诚然，第仅以内痔为准，其于肛线以外之痔则不反映，其于肛裂之重者，则系带可见切痕；余曾于一直肠癌患者见此颗粒于系带，且甚大，此法似亦可用于该疾矣。

舌 诊 记 要

舌诊之要有四：①苔之色及其厚、薄，②舌色，③舌形，④苔舌之燥、湿度。就燥、湿言，湿属湿，合苔色而别其寒、热，其间有腻、粘、垢、滑之分，燥为津少或津伤，至其轻重难辨处，需以手指扪察之；滑为湿之最盛者，递次而腻而粘，为其湿与热合或湿化热之不同程度，自燥而反递，则为湿向寒化或湿轻重之程度，但轻与重之分，需参苔之厚、薄而后始可定。

苔色以白、黄、灰三者为主，白寒而黄热，白表而黄里；苔色之灰者，进而可为酱色、黑色，兼察其燥、湿度而分其热或寒，灰、酱均属寒湿或痰瘀，第深浅有不同耳；黑色主病则有大相迥庭者，燥而黑者热之极，滑而黑者寒之极也。各色苔之厚、薄，为邪之重与轻，或邪与有形者结否也，厚者挟滞而薄则否

也。

舌色淡嫩与苍老，分属虚与热，淡而少华者虚，苍而坚者热也；舌形之瘦、敛坚者，热而或阴虚，萎软而薄者，虚之在脾或气也；此均就常情言，或有不尽者在。舌边齿痕，多云为脾虚，此说自 60 年代以还为盛，按脾虚固有此象，然必舌形之萎软或薄，及色淡者始为脾虚，否则有不虚者在，设舌形胖大而色赤，则脾之热矣，兼坚则心、肝之热矣；以胖大之舌，塞于齿侧，则见齿痕也必矣，岂必其为虚也哉。

舌光红，籍载多定为阴虚或热伤血、伤营，而不知痰饮之盛者亦见此舌，要在痰饮者必润滑耳；盖痰饮之在脾、胃，气、血不得滋生，胃欠于受禀而故舌光也，况乎痰饮之成于津液，津液不溥而舌光且红矣，此犹水盛于胃而反口渴、渴不引饮，同为胃中失养之故也。惟反渴不引饮者兼见光红而润之舌则病深矣。

舌红刺之在尖者，为心肺之热，其或满布于舌面者，在时症则三焦之蕴热，在内伤则肝经与心之热也，亦有脾热入营、元气化火者，则多挟白润之苔；苔白腻而厚、中见有红点夹于其间者，则属湿火矣。

舌边之黑，肝病居其首，月经痛者亦可见，心脏病、跌仆亦然，曾见一小肠痉挛患者亦见此舌，是总属于挟瘀之故，第需注意者为非上述病必见舌边黑，见舌边黑者上述病居多耳。舌边黑之轻者为淡紫或略见紫色，江南医称紫气，其瘀之甚者黑矣，1979 年曾见一多发性血栓患者，腹腔、心血管、脑系均有，下肢不能行，腹痛、心区痛，舌侧舌面均散布紫块紫点，经服大量化瘀药后，舌黑渐退而腹痛得解，下肢亦渐能活动；科中一护士，肝区痛，经痛，舌黑满布，1966 年前治半年不减，1979 年余返后续服化瘀药 4 个月，舌黑退而症除，是知此类舌黑之瘀

非数日数剂之能解者。

舌诊之重要，于时病为尤甚，有不可或忽者，在绛舌、苔燥或光无苔时，决不可投温热之品，余见有贻事者矣，然须于苍老与淡嫩间辨之，盖红嫩者伤及营血，红绛者热之盛也，温热之邪在气分而盛时，热迫营而营热，然邪未入营，舌色多绛而苔见燥或黄，迨邪入营，则苔渐退，舌色始犹绛，及其阴伤则嫩红而光矣，然其无论入营与否，绛、嫩与否，忌温燥则一也。

苔之黄润无根，未可便作热看，当兼求于虚；苔之白润微罩黄，亦未可便作热看，湿邪久郁气分而不化者多此苔，当以温化为治也。

以茵陈蒿汤为主治疗黄疸的 疗效观察和体会

用茵陈蒿汤或以茵陈为主处方治疗黄疸，自《金匮》有记载后，有不少中医著作有述及，特别是在诠注仲景书籍的著作中，如《医宗金鉴》、《陈修园医书 72 种》，在《喻嘉言全集》中，除茵陈蒿汤本方外，其他 34 方中有 8 方列有茵陈，《景岳全书》中除本方外，其他 39 方中有 9 方有茵陈；他如《医学正传》、《张氏医通》等医籍，均述及本方及以茵陈来组成治疗黄疸的处方。民间方药如《种福堂公选良方》，卷八中的“治疸神饮”之单用茵陈蒿，《丹方精华》（朱振声编，民国 26 年上海幸福书店出版）中治酒疸用茵陈等，可见以此类药方治疗黄疸的记录是很广泛的。我科在会诊中以茵陈蒿汤为主治疗 4 例住院及 1 例门诊黄疸患者（其中 4 例为传染性肝炎，1 例为胆囊疾患），效果满意，兹将观察结果报告于下：

(一) 病案简介

例 1, 马××, 1956 年 1 月 28 日初次会诊。当时肝大 1 横指, 脾肿 3 横指, 巩膜皮肤轻度黄染, 食欲不振, 肝功能: 血胆红素定量 2.0 毫克/分升, 黄疸指数 20, 凡登白反应直接(+)、间接(+), 麝香草酚浊度 12, 尿胆元阳性, 粪胆红素阴性。经服中药 16 剂后, 食欲正常, 巩膜、皮肤黄染退除, 肝功能复查: 黄疸指数 15, 麝香草酚浊度 9, 凡登白反应直接(+)尚迟缓, 血胆红素定量微量; 肝可疑触及, 脾未触及; 无自觉不适; 继续服药至 31 剂后停药出院。

例 2, 刘××, 1955 年 12 月 7 日初次会诊。当时皮肤、巩膜黄染, 左侧卧位时脾可触及, 肝区有轻度压痛, 肝未触及, 肝功检查: 黄疸指数 30, 麝香草酚浊度 4, 尿胆元(+), 尿胆素正常, 血胆红素定量(-), 饮食正常。经服中药 22 剂后, 黄疸指数降至 10, 皮肤、巩膜黄染消退, 于 1956 年 1 月 14 日出院, 以后在门诊继续服中药至 60 剂后黄疸指数降至 9, 服至 71 剂后黄疸指数降至 7, 此后恢复半天工作。

例 3, 秦××, 皮肤黄染一年多, 厌吃脂肪性食物, 胃中常有不快感, 曾于 1955 年 2 月 1 日查得黄疸指数 20, 其他检查正常, 同年 1 月末起在本科门诊 3 次, 以后中断, 于同年 10 月 18 日重来门诊, 因黄疸指数高达 30 而转西医内科住院, 入院后于 11 月 10 日会诊。当时皮肤、巩膜仍轻度黄染, 肝区有自觉性轻痛, 饮食仍厌脂肪, 肝功能黄疸指数 17, 麝香草酚浊度 4; 服中药 10 剂后(包括门诊时带入院 5 剂), 黄疸指数降至 12, 马尿酸排出量 4.8 克, 凡登白反应直接(-), 胆红素定量 1.7 毫克/分升, 服药至 27 剂后, 黄疸指数降至 9, 食欲增进, 服药至 37 剂后出院。

例 4, 范××, 1955 年 9 月 17 日会诊, 同月 16 日入院。自

觉自2月来饮食减退,喜食刺激性食物,近2周小便色黄,巩膜轻度黄染,右上腹于身体震动时偶有隐痛,化验黄疸指数15,凡登白反应直接(+)而迅速,胆红素定量2.0毫克/分升,高田反应(-),麝香草酚浊度4,尿胆元(+),尿胆素(-);服茵陈蒿汤原方18剂后,黄疸指数降至12,凡登白反应直接(-),胆红素定量1.1毫克/分升,尿胆素及尿胆元均(+),巩膜黄染已浅,此后改用茵陈蒿汤加味处方,服至38剂后黄疸指数降至6,凡登白反应直接(-),胆红素定量微量,马尿酸排出量3.57毫克,麝浊,尿胆素及尿胆元均正常,10月26日出院后恢复半天工作。

例5,徐×,1955年2月24日因肝炎住院,当时合并神经衰弱症状,同年5月23日查尿胆红素正常,马尿酸排出量3.96克,血白蛋白32.2克/升,球蛋白22.2克/升,黄疸指数12,麝香草酚浊度4,饮食等情况好转而出院。8月10日来中医门诊1次,给予茵陈蒿汤3剂,11月16日始再复诊,当时饮食较差,精神不振,有轻咳,皮肤、巩膜黄染不显,肝脾不大,血白蛋白44克/升,球蛋白25克/升,黄疸指数12,于服茵陈蒿汤加味方5剂后,饮食好转,黄疸指数降至7。此后因神经衰弱症状明显而改用其它药物(本例为门诊患者)。

各病例治疗前后病况对比如表6。

各病例主要用药及其用量如表7。

表6 各病例治疗前后的病况对比

患 者	西医诊断	对自觉症状		体 征		肝 功 能										转			
		食欲不振	胸膈不适	肝区痛及压痛	肝脾肿大	脾肿大	皮肤黄染	巩膜黄染	血清胆红素	血清白蛋白	血清球蛋白	尿胆元	尿胆素	麝香草酚反应	门静脉排出	凡登白直接反应	凡登白间接反应	归 咎	
马××	肝炎	治前	+	-	+	++	-	+	2.0毫克			+	12			-	+	出院后去中	医研究院门诊
		治后	-	-	-				12微量				5						
刘××	肝炎	治前	-	+	±	-	+	+	30	-		+	4					十天工作	门诊治疗
		治后	-	-	-	-	-	-	17				4						
秦××	胆囊神经性患	治前	+	+	-	-	+	+	30				4					回家休养	
		治后	±	-	-	-	-	-	9	1.7毫克			4	4.8克	-				
范××	肝炎	治前	+	±	-	-	-	+	15	2.0毫克		+	4	-		+		半天工作	
		治后	-	-	-	-	-	-	6微量			-	1	3.57克	-	(迅速)			
徐××	肝炎	治前	+	-	-	-	-	-	12	44%	25%	-	4					出院后全日	天工作,现在半天工作
		治后	-	-	-	-	-	-	7				5						

注:体征,肝脾肿大项中之++符号,表示三横指;+,表示一横指;±,表示可疑。

表7 各患者主要用药及其所用剂量

药名	茵陈蒿	黄连	白术	郁金	赤芍	丹皮	茯苓	人苡	木通	黄芩	黄柏	山栀
医疗效用	解胆热、利尿、消炎、利	消炎、解热、解毒、止	健胃、理肠、强壮、利	健胃、镇痉、利尿	镇痉、缓痛、活血调经、	活血调经、消炎、清血	解毒、滋养、健胃、利尿	泻下通便、活血通经、	消炎解毒、	活血、利尿、消炎、通	消炎、解热、解毒、止	解血热、消炎、利尿、止
用量 (钱为单位)	五— 一〇	一	三— 五	二— 三	二— 三	二— 三	二— 五	—	—	二— 三	—	—

(二) 体会

如上所述,可见茵陈蒿汤为主的处方,对黄疸指数的降低有很好的疗效。对尿异常、食欲、黄染等症状,一般能在10~20天中恢复,这对缩短疗程有一定帮助。

食糖的问题:根据4例住院患者的情况,在采用高糖饮食和服用有色糖块时,在不同时期中有一个共同现象,出现灰色舌苔,从而食欲降低,胸中烦闷,当时曾考虑药物的苦寒和甜食两个问题,结果在停服有色糖块后,此种灰舌苔便在2~3天中消失,因此在用糖过多及糖块色素问题上值得注意;糖类虽对肝脏具有保护作用,对肝炎引起黄疸病亦具有一定好处,但服用过多则甜腻生湿,于治疗不甚相宜。

便秘,是住院病例中的共有现象,仅是时间上有不同,一般在服用有生大黄配伍处方达10~15剂时出现,但对病的治疗并未见有妨碍,其导致原因就药物上说,大黄和茵陈蒿的作

用较大,由于茵陈蒿是处方的主药,所以只改用制熟大黄或降低大黄用量,观察的结果是用此种方法可以控制便溏现象。

根据4例住院患者和1例门诊患者的疗程比较,及例2患者的住院时期和门诊时期的情况比较,休息对本病是重要的。休息后病情好转较快,中西医看法是一致的。

过去中医书籍中,对黄疸的治疗均以消除症状为目的,现在我们依据化验检查,在临床症状消失后仍能进一步观察黄疸指数等的变化,这是中西医相互结合的好处。但在中医的用药方法上,当症候消失后便没有依据了,我们在此期内,是以加用白术、茯苓为主,而将黄芩、黄连、黄柏、丹皮等减量或个别除去,此法尚未发现有何不利治疗之处。此点请同道共同进一步研究。

(本文发表于《中华医学杂志》1956年第10号。因系参加工作后发表的第一篇文,故虽例少而仍收入。)

82例传染性肝炎疗效观察

中医古籍中无传染性肝炎名称,就其症状而言,应包括于中医黄疸门中。兹就西医诊断为传染性肝炎及其转成慢性肝炎而用中药治疗的患者82例,总结其经治、疗效等情况如下。

一、治疗中的中医理论依据

《金匱》:“风寒相搏,食谷即眩,谷气不消,胃中苦浊,浊气下流,小便不通,阴被其寒,身体尽黄,名曰谷疸。”“心中懊侬而热,不能食,时欲吐,名曰酒疸。”

《巢氏病源》:“黄疸之病,由于酒食过度,脏腑不和,水谷

相并，积于脾胃，复为风湿所搏，瘀结不散，热气郁蒸，故食已如饥，令身体面目及爪甲小便尽黄而欲安卧”。“人若饮酒多，进谷少，则胃内生热，因大醉当风入水，则身目发黄，心中懊侬，足胫满，小便黄”。“谷疸之状：食毕头眩，心怀怫郁不安而发黄，由大饥大食，胃气冲薰所致。”

《医宗金鉴》：“面目黄，但欲安卧，小便黄浑，此黄疸病已成……得之于胃有湿热，大饥过食也……此皆湿热而成，惟阴黄则属湿寒”。“黄、土色也，土病则见之，土属脾胃，脾为阴、主湿，胃为阳、主热，故凡病疸，皆湿瘀热郁也。行于外，则必四肢苦烦，身面发黄也。盖其人素有湿热，外被风寒相搏，内为女劳所伤，及食谷饮酒，或与湿瘀，或与热郁，皆能为是病也；若胃脉数，是热胜于湿，则从胃阳热化，热则消谷，故能食而谓之阳黄，若胃脉缓，是湿胜于热，则从脾阴寒化，寒则不能食，故食即满而谓之阴黄；阳黄则为热疸、酒疸，阴黄则为女劳，谷疸也。”

由上述引述可知，传染性肝炎的黄疸症状是符合中医学的疸病的；黄疸的主要病因是湿热，主要的受病脏腑是脾胃，此与西说有不同，迨湿热薰蒸、胆热液泄之说出，始于受病脏腑中增加了胆；其发病原因，与饮酒有较大关系，饮食、劳倦等亦为诱因。据此而用清热利湿的茵陈蒿汤、栀子柏皮汤为主，加以扶脾胃药品来治疗本病。

二、82例治疗情况分析

(1) 男性 60 例，女性 22 例。

(2) 1 岁以下 1 例，10 岁以下 15 例；20 岁以下 5 例，30 岁以下 38 例；40 岁以下 15 例，50 岁以下 5 例；60 岁以下 2 例。

(3) 82 例中,初诊时为慢性者 15 例,梅毒性者 1 例,其余均为传染性肝炎。

(4) 服药总剂数为 2830 剂,平均例服 $33\frac{1}{3}$,其中服 10 剂以下者 7 例,20 剂以下者 20 例,30 剂以下者 20 例,40 剂以下者 15 例,50 剂以下者 8 例,60 剂以下者 4 例,70 剂以下者 3 例,80 剂以下者 3 例,90~100 剂者 1 例,100 剂以上者 1 例。

(5) 合用葡萄糖,维生素 B、C,肝精,酵母者 50 例。

(6) 发病至服中药相距天数:最少者 3 天,最长者 4 年又 3 个月,绝大多数在 10~20 天内。

(7) 疗效:82 例中有 1 例(梅毒性肝炎查出后即中断)不明,其余 81 例肝功能检查在住院期恢复者 63 例,出院后门诊复查恢复者 6 例,接近正常值者 12 例。在住院期间未复查肝功能的 18 例中,未复指标为:黄疸指数 6 例,麝浊 4 例,血胆红质 11 例,麝絮 13 例,凡登白 12 例,尿三胆 1 例。肝功能恢复正常的 69 例中,其所需日期均少于服药剂数 2~3 天。81 例有效患者中,包括早期肝昏迷 1 例;1 年后复发而再入院者 2 例。

三、主方及加减

主方:茵陈 15~45 克,栀子 10 克,熟军或生军 3 克,丹皮 10 克,赤芍 10 克,黄柏 10 克,茯苓 10 克,郁金 10 克,木通 6 克。

食欲不振,胸腹痞满加白术、鸡内金、大豆卷、陈皮、青皮。
胸肋胁窜痛、胀痛加逍遥散方、香附、川芎。

肝脾肿大,黄疸色淡加鳖甲、柴胡、丹参,重者加桃仁、红花、乳香、没药。

麝浊高，黄疸已退，加入八珍汤。

黄疸指数高而同时小便赤短，舌苔白腻加入五苓散。

四、案 例

例 1，王维久，男，39 岁，工人，住院号 3558，1959 年 4 月 15 日，因肝炎 1 周住入内科，17 日邀请会诊：已查肝功，黄疸指数 30，凡登白阳性双相反应，麝浊 4，麝絮（—），胆红素 3 毫克/分升，白蛋白 40.6 克/升，球蛋白 23.5 克/升，食欲不振，巩膜及全身黄染，肝大肋下一指、有压痛，脉弦，舌淡苔白。处方：茵陈 30 克 熟军 3 克 茯苓 15 克 生山栀 10 克 赤芍 10 克 连翘 15 克 黄柏 10 克 郁金 10 克 木通 6 克 薏仁 3 克 丹皮 10 克 滑石 10 克。三剂，煎服。

4 月 21 日复诊：无自觉不适，脉大，舌苔灰白，肝仍稍大有轻压痛。原方去熟军，加：苍术 12 克 猪苓 10 克 姜半夏 10 克。三剂。

4 月 22 日复查肝功：黄疸指数 7，凡登白双相反应，麝浊 4，麝絮（—），胆红素 0.55 毫克/分升，白蛋白 38.4 克/升，球蛋白 21.1 克/升。

4 月 24 日三诊：头昏鼻干，溲多，便日污，黄染退尽，脉软，舌苔淡白而腻。处方：茵陈 30 克 熟军 2 克 赤猪苓各 10 克 苍术 15 克 生山栀 10 克 赤芍 10 克 丹皮 10 克 黄柏 10 克 郁金 10 克 木通 6 克 滑石 15 克 薏仁 3 克 法半夏 6 克 连翘 15 克。四剂。

4 月 25 日，因患者临床症状消除，肝功近于正常而出院。

例 2，马正德，男，22 岁，工人，住院号 4907。患者因半月来乏力，4 日来巩膜、皮肤发黄，食欲不振，恶心呕吐，经单位医务室诊为肝炎，而于 1959 年 6 月 7 日住入中医科病房。经

查肝大肋下 2 厘米,肝功能:黄疸指数 12,凡登白阳性双相反应,麝浊 4,麝絮(-),血胆红素 1.2 毫克/分升,白蛋白 46.9 克/升,球蛋白 31.8 克/升。时有盗汗,后背自感灼热,脉滑而紧,舌淡苔薄。处方:茵陈 24 克 梔子 10 克 黄柏 6 克 当归 12 克 赤芍 12 克 郁金 10 克 枳壳 10 克 赤苓 10 克 丹皮 10 克 白术 10 克 泽泻 12 克 猪苓 12 克 桂枝 6 克 牡蛎 10 克 胆草 6 克。二剂煎服。

6 月 9 日复诊:盗汗背热除,潮黄退,肤黄减。原方继服七剂。

6 月 16 日三诊:巩膜、皮肤黄染近退,无自感不适,但倦怠,脉弦缓,舌苔薄白。处方:茵陈 18 克 黄柏 6 克 生山梔 10 克 甘草 6 克 白术 10 克 茯苓 10 克 泽泻 10 克 桂枝 2.5 克 郁金 7 克 丹皮 6 克。二剂煎服。今日复查肝功能:黄疸指数 7,凡登白双相反应,麝浊 4,麝絮(-),血胆红素 0.5 毫克/分升,白球蛋白比例正常。

6 月 18 日四诊:巩膜尚有微黄,左肋稍有胀感,脉弦。舌苔淡白。处方:白术 10 克 茯苓 10 克 泽泻 10 克 猪苓 10 克 郁金 10 克 枳壳 10 克 丹参 15 克 桂枝 4.5 克 胆草 10 克 白芍 10 克 丹皮 10 克 山梔 4.5 克 茵陈 30 克。三剂煎服。

6 月 21 日,原方去胆草,加当归 10 克,川芎 10 克,又服八剂。6 月 25 日复查肝功全部正常,而于 6 月 28 日出院。

例 3,许福荣,女,1957 年 8 月 7 日,因肝炎由小儿科转来门诊。患儿出生后即患鸡胸,常易感冒,1955 年 8 月患过泄泻,本年 5 月患过麻疹。近二周来发热,尿色深黄,大便色白,恶心,腹胀,饮食尚可;在小儿科查:扁桃体稍充血红肿,心肺阴性,肝于肋下四指,脾肋下一指,肝功能:黄疸指数 7,胆红

素微量, 麝浊 18, 凡登白直接反应(-)、间接反应(+), 尿胆元(+), 尿胆素(+), 白细胞总数 11.7×10^9 /升、中性 0.72、淋巴 0.26、单核 0.02。巩膜皮肤黄染不明显。处方: 茵陈 10 克 郁金 6 克 山梔 6 克 茯苓 6 克, 黄柏 4.5 克 桂心 1.5 克(后下) 六一散 12 克(包)。三剂, 水煎服。

8 月 11 复诊: 发热退, 余症如前。处方: 茵陈 10 克 郁金 4.5 克 山梔 6 克 茯苓 6 克 桂心 1.5 克(后下) 白术 10 克 黄柏 3 克 泽泻 6 克 柴胡 1.5 克。四剂。

8 月 18 日之诊: 大、小便正常, 腹胀、恶心均除。原方继服四剂。

8 月 24 日四诊: 症情平定, 肝脾同调。处方: 茵陈 10 克 郁金 5 克 生山梔 6 克 茯苓 10 克 柴胡 1.5 克 厚朴 1.5 克 白术 6 克 桂心 1.5 克(后下) 砂仁 1.5 克(后下)。四剂煎服。

8 月 30 五诊: 处方: 茵陈 6 克 白术 6 克 台党参 6 克 山梔 6 克 郁金 3 克 桂心 1 克(后下) 茯苓 10 克 甘草 1.5 克 黄芪 5 克。四剂。复查肝功, 尿均正常而停药。

五、几点经验体会

(1) 在病邪方面须分清湿重于热, 或热重于湿; 在邪正方面需注意病邪与脾胃正气强弱程度。初期黄疸重、湿热盛时可以用重用苦寒, 黄疸退后要留意脾胃气机, 或多或少的要加用扶正药物。

(2) 本资料统计病例的早期患者中, 曾有 6 例在服药至 5 剂左右时出现灰苔、纳呆、腹痛、便溏次多等情况, 经禁止服用有色糖果、控制食糖量及改用熟军之后, 上述各症解除, 由此提示了: ①苦寒药要针对体质及湿热程度; ②进糖量过多对本

病不宜。按中医药论述：糖属湿性，于湿胜者不利，因而我们限定患者月进糖量不超过 2 市斤(1000 克)，在此后的观察中未见到对本病治疗有妨碍，此情与西医认为糖养肝论点不同。

(3) 根据中医学论述“辣伤肝”和油腻厚味、生冷伤脾胃的认识，予以禁食；在观察中多数患者厌油，或进食油腻后胃部不适而或胀满加重等情况言，中医学的观点是正确的。

(4) 肝功恢复的迟速与其有关因素：观察中发现，肝功能的恢复，住院患者较门诊患者为快，儿童较成人为快，黄疸肝炎较无黄疸者为快，并且与休息的好坏有关，资料中有 3 例儿童患者的磨浊、磨絮恢复迟缓，经与家长协同控制患儿活动量后，一周即正常。

(5) 化验肝功能是进一步验证中医疗效的标尺。中医治疗在解放以前，均以临床症状的消除为目标，此点固然是必需的，但就本病而论，当黄疸消退后并不等于本病的痊愈，而当其中医指标不很明确时，就需以化验指标作为标尺，一方面而是为了患者的进一步治疗，另一方面可视为中医药疗效的新发展。本资料 1959 年病例中，有 6 例 20 天左右恢复肝功，其中最快的 1 例仅 7 天即正常，此为 1958 年以前所没有的情况，其原因尚未清晰，但似与注意加用扶脾运、助胃化及养血、养肝药物有一定关系，此点当于今后不断求索。

(本文初稿于 1957 年底，补充修改于 1959 年 8 月，此次收集旧稿时作了章节上的合并和调整，为保持原文面貌，未作文字上的太多改动。)

柿胃石病案报告

关于柿胃石的治疗,目前国内已有不少报道,多采用手术法,或伍用碱性药物、梨等治疗,少数病例曾用中药治愈,但对有并发症及结石较大而用中药治疗者,目前国内尚少报道,因介绍经治1例于下。

王立都,男,43岁,本院职工。

患者于1962年10月8日晚间,吃硬柿子5枚,有2枚带皮,当晚即感腹胀,胃部不适,继之腹痛恶心、呕吐腹泻,内容多为不消化之渣滓样物,无脓血;经院医室多次治疗无效,于1962年12月12日检查时,发现左上腹有鸭蛋大之肿物,圆形,向四围活动窜痛,不向腰肩背部放射;于1962年12月14日腹部照片,右上腹有圆形不透明肿物,印象:胃石;于1962年12月14日收住外科病房。

患者既往于1949年因胃溃疡病而行迷走神经切除术,胃、空肠吻合术,1950年患颈淋巴腺结核,浸润性肺结核,视网膜剥离而视力不佳,1960年患有风湿性关节炎等病史。

入院后检查:患者体格瘦弱,有贫血征,左上腹可扪到圆形 $8\times 9\times 7\text{cm}$ 之肿物,活动性大,稍硬,压痛不著;再次钡餐造影:“胃体部有较大之充盈缺损,钡剂通过时有明显之分流现象,可见明显之活动”;其它体征及实验室检查均无异常。

外科曾于入院后用中药通下剂(大承气汤合保和丸)治疗,共服5剂,结石未见缩小而腹泻日8~9次,因准备手术,经请示院长,指示暂用中药治疗,而于1962年12月24日邀请会诊。

一、经治经过

初诊：脉大而软，舌苔淡白微腻，左腕癥块可移；昔年因胃病而行手术，运化之机不足；此次食硬柿之后，结成癥块，引起呕吐腹泻，腕中不适；显系酸涩伤胃，生冷不化而然；以运脾温通为治。方用：于术 15 克，党参 10 克，郁金 10 克，沉香曲 10 克，陈皮 10 克，枳实炭 10 克，姜半夏 6 克，柿蒂炭 6 克，金钱草 30 克，檀香 3 克；4 剂，日 1 剂。

12 月 28 日复诊：脉、舌、症情如前，无呕泻。处方：炙内金 15 克，金钱草 30 克，檀香 3 克，甘草 4.5 克，厚朴 6 克，枳实 6 克，官桂 3 克；5 剂，每日 1 剂；另每日用芒硝 6 克，胶囊分装，匀作 24 小时服完，连服 5 日。

1963 年 1 月 2 日三诊：脉、舌仍如前，服上药后大便稀溏，日 3~4 行，腕部癥块由初诊之鸭蛋大缩为乒乓球大。就原方去枳实，加焦白术 9 克，鱼枕骨 15 克；15 剂，口服 1 剂。

1 月 3 日下午 3 时，突然全腹阵性作痛，恶心呕吐；检查：腹软，脐左侧压痛，胃部肿块消失，肠鸣音亢进不著，无肌紧张及反跳痛，无肠型；腹部透视：“可见有多数水平液面，肠管胀气明显”，估计为胃石被化后由肠道排出而引起之肠梗阻，暂用保守疗法，禁食、输液；晚间大便二次而腹痛消失。因患者视力不佳，未辨粪中有否结石，仅嗅到极浓之柿子气味。翌日全腹柔软，无压痛，进流食后未再腹痛。以后转用扶脾中药调理。

1 月 10 日，第三次钡餐造影：“胃体部肿物已消失，粘膜完整，通过顺利，小肠观查未见有充盈缺损，通过顺利，粘膜整齐；印象：胃石经中医服药治疗后已消失”。于 1 月 12 日出院。

二、经 治 意 见

柿胃石病名，不见于中医典籍，在中医学术中相类者有积、聚、癥、瘕之类，特别是“食癥、果积”两病更为接近。《中国医学大辞典》在食癥条下说：“此证因食生冷粘滞之物，脾胃虚弱，不能消化，胶滞其间，遂与血气相搏，积聚成块，日渐长大”，“按之应手”。对本病的治疗，古人是以健脾、磨积为原则，泻下对虚人是有禁忌的，从本例患者的发病和治疗经过来看，正符合于上述记载。本例患者素有胃病，曾经胃肠道手术，运化之机不足，平时体质亦弱，且有肺结核，故视力渐渐低落。以致仅见物体轮廓，此种体弱脾虚，为本病发作之内因方面；患者发病之前，食硬柿子5枚，且皮未去尽，酸涩伤胃，生冷不化，遂使所进之食，积聚裹结，为本病发作之外因方面。基于上述二种因素，故治疗中一贯以扶正消导为原则；初诊之时，摸到肿物极大，估计不能由肠道排出，故未重用荡积药物，只用扶脾利气消导为主；二诊用鸡内金、金钱草，磨积化石；因结石在胃不在肠，故仿调胃承气汤意，用芒硝软坚，甘草留中；所以不用大黄者，就因为石块太大，非一荡可去，和素体脾虚，不宜苦寒之故；芒硝之小量多次服，亦为不欲药过病所，以发挥其最大的软坚作用而设；三诊中结石已见缩小，恐其突下肠道，故去枳实之降下，加白术之益气，鱼枕骨之化石，以期结石速消而不致在肠间阻塞，然此点事实上未达理想。

患者之结石，能够于9剂药中被粉碎，从处方中看，可能与重用金钱草和二诊中加入芒硝、鸡内金有关，此点较之古人在治疗食癥中攻补药分期使用，计月而后收效的情况，是既有利、又有弊的，有待于今后来解决其弊的一面。

60例上消化道出血的临床观察

上消化道出血,主要是由于溃疡病及门脉高压症所引起;一般临床情况:门脉高压症以吐血为常见,溃疡病以便血为多见;溃疡病中,又以胃部溃疡出血易表现为吐血,十二指肠溃疡出血易表现为便血;三种不同部位的出血,同样在出血量多时多表现为吐血,在出血量少时多表现为便血,甚至仅能于大便检查时始能发现有潜血存在;并且不论何种部位之出血,如果以吐血现象出现之后,也必然都要继之出现便血情况。在大量出血情况下,往往可以引起休克或肝性昏迷而导致死亡。本病在西医治疗上,通常是卧床休息,饮食控制,注射或口服止血药物、输液、输血,严重时则采用外科手术疗法,门脉高压之出血,尚有气囊压迫止血法。以上各种疗法,依据有关统计:溃疡病因大量出血而死亡者占8.5%~14.1%(《中华内科杂志》1960年,钱氏、潘氏等报告),溃疡病手术死亡率占8.75%(1959年10月,《中华外科杂志》),门脉高压症出血内科治疗之死亡率为42.3%,手术治疗之死亡率为16%(《中华内科杂志》1960年3期)。据此可见,不论保守疗法或外科手术疗法,均有一定的死亡率;且手术疗法又往往为患者所拒绝,因而必须寻找更好的止血方法,改善患者全身情况,即使不可避免手术治疗,亦可在全身情况的改善下而降低其死亡率。

市立第六医院在采用中西医结合治疗本病后,取得了一定进步的疗效,兹将几年来治疗的60例病历加以分析:

一、病例分析

60例病历中,诊断溃疡病者52例,其中有6例为再次出血者,实为46例,诊断门脉高压症者8例,其中有2例为再次出血,实为6例。

52例溃疡病之诊断,大部分有X光证实,一部分因当时缺乏钡剂而未能及时进行X检查,但均有典型的胃痛、恶心、吐酸或出血的溃疡病症状,及上腹部压痛之体征;门脉高压8例中有1例为斑替综合征,其他7例均为肝硬化引起。60例病历中,年龄最高者70岁,最低者16岁。病程最长者20年,最短者1天(以前未发现,出血后始检查出有溃疡病)。在治疗上,西药方面一般用维生素K、仙鹤草素、凝血质等注射,一部分病人因血压及血色素过低而行输液、输血,个别病人合用垂体后叶素静脉滴入;中药方面大部分用十灰散、甘草乌贼骨粉作常规用药,全部病人在辨证论治基础上给予汤药。效果方面:全部病例中有1例因反复出血而转外科手术,手术后诊断为胃癌。另1例因合并幽门狭窄,于出血制止后尚有恶心、呕吐、呕逆不止而转外科行胃肠减压(未行手术,保守疗法而愈)。其余58例,均及时取得效果,其有关情况,列表说明如下:

表8 胃病史及肝病史

患 病 史		1 年 以 上	2 年 以 上	3 年 以 上	5 年 以 上	8 年 以 上	10 年 以 上	15 年 以 上	20 年 以 上	未 查 清
例 数	肝		2	1	2					3
	胃	3	2	5	8	4	4	1	3	22

注:胃癌1例在内。

表 9 出血史和症状

既往 出血 数	出 血 史					无 出 血 史	症 状			
	1 次	2 次	3 次	4 次	多 次 出 血		出 血 表 现	吐 血	便 血	吐 便 血
例数	11	6	1	4	9	29	例数	13	29	17

表 10 出血总量

量	200~300 毫升	300~400 毫升	400~500 毫升	800~900 毫升	1000 毫升	3000 毫升	无法统计 或未统计
例数	2	2	4	2	2	1	47

注：① 无法统计项中指病人未述便吐血多少或仅有大便潜血情况，内出血患者在内。

② 3000 毫升出血量为分次出血的总量。

③ 表中出血总量，均为合治或就治前所出者。

表 11 出血部位

部 位	食 道	胃	十二指肠	不肯定
例 数	8	9	18	15

注：不肯定项中，包括未做 X 光造影检查及胃与十二指肠有似重溃疡者二种情况。

表 12 分型统计

类 型	肝胃郁热	肝旺脾虚 或 脾虚肝旺	脾不统血	阴虚阳亢	气虚血脱	未定型
例数	14	21	19	3	2	1

注：未定型为内出血患者。

表 13 临床止血天数

天 数	1 天	2 天	3 天	5 天	6 天	7 天	8 天	10 天	13 天	32 天
例数	20	9	6	7	4	5	3	2	1	1

注：不包括内出血患者及胃癌患者在內。

表 14 潜血消失天数

天 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	65	52	未 见 潜 血	未 查	化 验 单 丢 失
例数	2	3	2	2	5	5	6	6	2	9	2	3	3		1	1	2	1	3

注：①未见潜血项中，包括内出血患者。

②胃癌患者不在本表之内。

二、讨 论

(一) 上消化道出血的治疗依据

上消化道出血，由于它的重点和紧急症状是出血，因而必然要赅括在血证范围中来认识。血的生理概况，《内经》有“中焦受气取汁，变化而赤，是谓血”、“心生血”，“肝藏血”等等记载。血证的治疗，最早见于《金匱》的血证篇中，后世各家均有论及，中间葛可久的《十药神书》，唐容川的《血证论》等，尤为专著。《金匱》：“心气不足，吐血、衄血者，泻心汤主之”。“吐血不止者，柏叶汤主之”。前者应为邪热炽盛，迫血妄行之吐衄；后者应为血得寒而不与气俱行，亦即阳虚不摄之吐血，故用温摄之剂（据《仁斋直指》解释）。此两条可以适用于消化道出血之吐血方面。《金匱》又谓：“先便后血，此远血也，黄土汤主之”。此条则直指便血而言。唐容川说：“先便后血为远血，谓

其血在胃中，去肝门远，故便始始下”（《血证论》）。上消化道出血，虽然不一定先便后血，但其出血部位是与古人之意一致的，因而此条就适用于本病的便血方面。《血证论·吐血篇》中提到：“吐血其病在胃，呕血其病在肝”，又在《血证论·阴阳水火气血论》中强调“治血者必治脾为主”等说，合《内经》生血、藏血、统血诸义观之，则可知肝、脾、胃、心等脏器在上消化道出血中的密切关系，特别是肝、脾、胃三者尤为有关。由于肝藏血，故肝气郁逆，可使失于所藏而迫血妄行，并且横肆侮脾，而使脾失于统；若移热于胃，而伤阳络，肝火一起，心火亦亢，两火相炽，血无以宁，故张景岳说：“动者多由于火，火盛则迫血妄行”。脾统血，故可由脾之“气虚挟寒，阴阳不相为守，荣气虚散”，而失于统（《仁斋直指》）；亦可由肝气来乘或心火之亢而使失统。胃虽无统藏之权，但与脾为表里，脾可以移病及之，“少阳升清之气，又寄于胃中”，“况血之归宿，在于血海，冲为血海，其脉隶于阳明，未有冲气不逆上而血逆上者也”（《血证论》）。此外肝之移热，亦可及之，故血之吐出，实不能离乎胃也。根据临床观察，溃疡病多数有肝脾不和、肝胃不和之机；门脉高压症多数有肝气郁结，肝脾俱郁之机。故肝、脾、胃三者之在上消化道出血的辨证施治中，实占重要地位，并且又是互相关连，互相影响而不可分割的。通过临床观察，肝气逆而热者，多表现为吐血；脾气虚而寒者，多表现为便血；胃则因两者之影响而转移，单独的胃热吐血或胃寒便血的病例并不多见。此外肾虚亦与本病有关，肾阴虚则可由水不涵木，通过肝阳上亢而不藏；肾阳虚则可由火不生土（命火生土）使脾胃虚寒而不统，但此类病例亦较少见。兹将临床所见几种情况，分别举例说明于下。

(二) 临床所见的几种类型

1. 肝胃郁热(肝不藏血)

由于肝热或肝气郁结而化热,热伤胃络,同时肝木横逆克土,使胃气上逆而引起吐血,根据《素问·调经篇》:“始受热中,末传寒中”的意义,故此一类型只见之于肝木克土之始,若脾土受克已久,或血去脾虚之后,也可转为脾不统血类型的。此种肝胃郁热类型,在临床上往往出现两胁痛、脘痛、噯酸、恶心、呕吐、吐血、舌红、脉象兼弦或滑数等症,是属实属热性质的,治疗上以平肝清热,凉血止血为主。

附病例:梁继同,男,20岁,住院号18434,西医诊断:溃疡病出血。

素有胃脘痛,噯气、反酸已半年,近2天来加重,入院当天有恶心、呕吐、吐血400毫升,无黑便,感全身无力,头晕,口干欲饮,溲黄,脉象滑数,舌红,苔黄。辨证为肝胃郁热,肝不藏血。治疗用泻心汤加味。处方:熟军3克,黄芩9克,黄连6克,白芍12克,石决明15克,藕节30克,茜草10克,仙鹤草15克,蒲黄炭9克,山栀9克,茅根30克,另用十灰散3克,口服3次。服上药二剂,无恶心呕吐,出血止。仍有头晕,无力,胃脘不舒,精神较前好转,脉滑,舌红,苔薄白;再以平肝清热治之,症状渐消失,潜血阴性,共住院5天即出院。

2. 阴虚肝热

此类型由于肝肾阴虚,水不涵木,木火腾灼而伤胃络,或侮脾土而引起出血,基本上与肝胃郁热之机制相同,但多一阴虚因素,往往见于阴虚体质之患者。治疗上在平肝清热的同时,需加用滋阴之品。

附病例:张荫昌,男,33岁,住院号15911,西医诊断:①溃疡病合并出血。②高血压症。

素有头晕,胃脘痛,嗳酸,近日来黑便日行2~3次,脉来弦细数,舌红有刺,苔白。辨证为阴虚肝热,热移于胃。治疗用清热止血,平肝育阴法。处方,略。

3. 肝旺脾虚(或脾虚肝旺)

此类型可由于肝木乘脾、脾失统血功能而来,脾虚则升降失职,气虚不统,而引起出血。此一类型虽然有时也可出现吐血,但以便血为多见。临床上除便血或吐血之外,往往虚实互见,如既见腹胀、便溏、苔腻、纳少等脾虚症状,又可见舌红、吞酸、嘈杂、脉象兼弦等肝旺症状,并且可以因病程等其他因素而出现肝旺为主或脾虚为主之不同情况。治疗上要随时调整针对肝旺及脾虚两组药物的比重。

附病例:崔文富,男,37岁,住院号16066,西医诊断:上消化道出血。

胃脘及脐周作痛,黑便800~900克,纳减,气短,头昏,乏力,曾昏倒一次,口干而不欲饮,脉象右关软细,左关弦数,舌淡,苔白而干。辨证为脾阳不足,肝木来乘。治疗用补虚止血,双调肝脾。处方:当归9克,生地12克,白芍12克,党参15克,白术10克,山梔炭10克,荷叶炭10克,藕节10克,山药10克,炙甘草3克,三七粉2克(分冲)。本患者8天潜血转为阴性,但体虚症状恢复较慢,共住院28天始出院。

4. 脾不统血

此型在临床上较为多见,常见有便稀,腹胀,脉软无力,舌淡,苔薄白或白腻,或腹鸣而痛等症,出血的主要表现为便血,除脾脏本身的虚寒引起外,亦可由木旺克土,血去脾虚而转成,故多有气血两虚之表现。治疗上不宜过用寒凉,原则上要补气为主,兼用补血。

附病例:吴冀骏,男,30岁,住院号15656,西医诊断:溃疡

病合并出血。

素有胃病史，入院当天感头晕，心慌，无力，有黑便2次，伴有腹胀，肠鸣，形寒喜暖，舌苔淡白，脉象左弦弱，右弦软，辨证为脾不统血。处方：人参3克，白术15克，黄芪15克，当归10克，炙草5克，茯神10克，炒枣仁12克，灶心土10克，阿胶10克，炒黄芩6克，熟地12克，艾叶炭10克。服药12天，潜血转阴性，共住院19天。

5. 气虚血脱

此是血去过多，脾阳无统而致于虚，继则气分亦虚，而后更不能统，遂而呈气虚血脱之状。此时之病机，已由阴虚而转为阳虚；或为脾脏素属虚寒，平日气分不足而来，为脾不统血之进一步重症，有濒于脱绝之机。临床一般结合西医输血、输液、用升压药物等合治，在中药上须以抢救阳气为务。

附病例：（轻型）赵海，男，45岁，住院号15989，西医诊断：溃疡病引起上消化道出血，慢性气管炎。

胃脘痛4~5天，黑便2次，量极多，面色微黄微熏，脉软弱，兼虚大，舌淡，苔腻而灰，声息低微，平素咳嗽已久，痰多白粘，屡患喘息。辨证为阳虚脾失于运，湿痰不化，血失于统。初诊用香砂六君子汤加味，方用：台党15克，白术15克，茯苓15克，甘草3克，姜半夏6克，陈皮10克，木香3克，薏仁3克，吴萸3克，杏仁泥10克，艾叶10克。服药期间仍有黑便3次，且血压下降，曾先后输血800毫升，二诊时改理中汤合六君子，方用：台党15克，白术15克，甘草3克，炮姜3克，茯苓15克，半夏6克，陈皮10克，薏仁3克，苏子3克，肉蔻3克，艾叶10克。服药2剂，大便转灰色，潜血于第3天呈阴性。

以上几种类型的区别，是依据患者当时的主要矛盾所在而定的，由于病情随时可以转化，因而需要根据具体情况灵活

运用,才能收效。

(三)治疗中的几点体验

1. 止血

《十药神书》中第1方十灰散,用于止血,第2方花蕊石散,用于化瘀,第3方独参汤,用于补虚,提示了治疗血证的规律。《血证论》中亦要求首先止血,继而消瘀、宁血、补虚等四个步骤。两书均将止血置于第一位,这是因为血系水谷精微之所化,生命之所依赖,能少出一滴血,即多留一分正气,确是出血情况下的当务之急,是《内经》“急则治标”的原则。我们依据这个原则,将止血作为首要要求,通常采用十灰散和甘草乌贼骨粉为常规用药,再加上辨证论治的汤药,在临床上取得了良好效果。

十灰散是大蓟、小蓟、大黄、栀子、茅根、茜草根、侧柏叶、荷叶、棕榈皮、丹皮等10种药物烧炭存性而成,炭起止血作用,存性则尚有原药的力量,且方中寒凉之药过半,因而同时起到凉血、止血的双重作用,但正是因为凉血之故,在虚寒病例上就有所限制。我们在60例患者中有12例未用此药,只用甘草乌贼骨粉,在使用此药的48例中,有39例出现便秘现象,此种便秘现象,是炭剂的收涩作用所引起,可以认为是血止的先兆,虽然以后大便中尚可见到1~2次陈旧性潜血,但很快可以转为阴性。我们使用的剂量,通常是3~6克,1天3次,大量出血时用9克,1天3次。

甘草乌贼骨粉是乌贝散的复方(因当时贝母紧张而减去),根据各种本草记载,甘草能“通经络,利气血”(《别录》),“主腹中冷痛”(甄权),“五脏六腑寒热”(《本经》),“止痛”(李时珍)。乌贼骨能治,“卒然吐血”(《圣惠方》),“大肠下血”(《直指》),“吐血,下血”(李时珍);在现代药理学上看,乌贼骨含有

碳酸钙、磷酸钙、胶质及有机物质，可以中和胃酸，保护溃疡面而止血、止痛；甘草含有甘草糖、辛烈性软脂、纤维、胶质等，有类似激素的作用，近代用它来治疗溃疡病的报道，已屡见于文献，因此，不独可以用甘草乌贼骨粉来止血，也可对溃疡病起到治疗作用，在止血方面可以普遍使用，但亦有便秘情况出现，惟不若十灰散之明显。

2. 降气

降气是吐血证治疗中的一个重点，气之上逆，始能载血而越，而气之不降，重点在于肝、胃二脏，所以《金匱》中有泻心汤之设，《血证论》吐血、呕血篇中，也极重视降胃、降肝的治则。我们在临床中，除了止血之外，采用了旋复花、枳壳、枇杷叶、沉香、石决明之类平肝；降胃药物，在吐血剧烈时，根据《金匱》泻心汤的意思，加用了大黄，唐容川说：“大黄一味，推陈致新，以损阳和阴，非徒下胃中之气也”。“凡属气逆于血分之中，致血有不利之处，大黄之性，亦无不达”。“大黄一味，既是气药，又是血药，止血而不留瘀”。我们在临床上有6例试用大黄，除1例胃癌有反复出血而转外科外，都取得效果。但此药主要用实证、热证，虚寒者应在禁例，不能以不足之阳而更损之也。

3. 辛温

在脾不统血情况下，用归脾、四君、补中益气等方出入，一般可以收效，但在重型的虚寒患者身上是不够的，需要参用辛温药物来振奋脾肾阳气，如黄土汤中之附子，理中汤中之炮姜等，我们在赵海病例中（见前气虚血脱型举例），遇到了这个问题，第1次未用炮姜而血不止，第2次加入之后就收到了效果。然而血是逢热则行、逢寒则止的，在运用此类药物时，一定要确是虚寒之体，如炮姜虽有其止血的一面，但对热证总属不宜，除非是夹在大队凉血清热药中使用，使其有制而后可。

4. 预防瘀血

根据葛可久、唐容川的意见,消瘀是治疗的第二步,可见瘀血是出血停止后易于出现的症情,从而也是用凉血清热药时必须注意之点。我们根据《内经》、《金匱》治未病的意思,在临床上预防了这一点。一面尽力使寒凉药恰如其分,另一方面选用如当归、大、小蓟、丹皮、乳香、没药等既可止血、又可活血消瘀的药物,来避免瘀血的形成,这样使 58 例患者无一例有血瘀症状出现,从而缩短了病程。

5. 善后调理

根据临床观察,血止之后,在善后调理方面,需要分别采用下列三种办法:第一是补气养血,健脾运胃;其次是调和肝脾气分;第三对阴虚肝旺之人,需以滋阴柔肝为主。此外在饮食和精神方面,也极为重要,本文中 8 例第 2 次出血之患者,其因多半由此而起,如张荫昌之因饮食不慎,靳尚恕之因恚怒,何英夫之因过饥暴食等,故《内经》有“饮食自倍,肠胃乃伤”,“怒伤肝”,“忧思伤脾”等的记载,唐容川有“每十剂之功,败于一怒”的经验之谈,均足说明其害。此处非药力之所及,须要劝告患者,勿暴饮暴食,辛辣太过及愤恚动怒,以便未雨绸缪,防患于未然。

(本文曾发表于《江苏中医》1964 年第 4 期)

9 例破伤风治疗小结

破伤风之治疗,西医同道经常采用破伤风血清注射,及投予镇静剂、抗生素等,在疗效上尚难达到理想;据北京市立第六医院所治疗患者统计,死亡率达 40% (15 例中死亡 6 例),

与刘氏综合国外文献单纯用西药治疗之死亡率达40%符合(1955年3月中华外科杂志141页)。自1959年该院在西医检查、论断、治疗、护理基础上配合中药以来,全部住院就治患者9例中,除1例因牛奶逆流至呼吸道形成梗阻,抢救无效而窒息死亡外,其余8例均痊愈,疗效较以前有明显提高,兹将其小结如下:

(一) 病案分析

1. 性别:男7例,女2例。
2. 年龄:最高64岁,最小7岁。
3. 破伤源:金属伤者5例,跌挫伤者2例,电伤1例,手术后引起者1例。
4. 破伤至发病间隔日期:7天者2例,9天者3例,10、11、12、17天者各1例。
5. 主症:9例均有张口困难、苦笑面容、颈项强直等症,其中有角弓反张者6例,上肢或下肢强直者8例。
6. 脉、舌情况:脉弦者8例、滑者1例;舌质红绛者9例,有白苔者2例。
7. 并发症:合并外伤感染者1例,中毒性休克者1例。
8. 合用西药:TAT9例,镇静剂7例,抗生素6例。
9. 所用中药:羌活、秦艽、川芎、当归、防风、钩藤、防己、桑寄生、全虫、生地、蝉衣、天麻、南星、芍药、白芷、黄芩、僵蚕、菊花、银花、连翘、灵仙、荆芥、石决明、木通、白术、川断、桂枝、黄柏、羚羊角、黄连、木瓜、丹皮、酒军、菖蒲,仅使用1次者有山栀、生石膏、吴茱萸、半夏、郁金及牛黄丸、苏合香丸、紫雪丹等。
10. 服中药剂数:最多者31剂,最少者3剂,平均18剂。
11. 8例治愈患者的症状控制日数:5、8、9天者各2例。

12、14天者各1例。

12. 住院日期:最长39天,最短9天,平均20天强。

(二) 病案举例

吴小奔,男,7岁,住院号14344号,1960年8月2日入院。

主诉:张口困难3~4天。

病史:14天前玩耍时跌破右侧头皮,经抹药打针后伤口已愈合;3~4日来感觉张口不利,进食需填塞,饮水时呛咳,2日来下肢强直,不能行走,后颈部已发硬,无寒热、呼吸困难及抽搐。

检查:神清,苦笑面容,轻度角弓反张,齿裂相距0.8~1厘米,舌可伸至唇下2厘米,颈部轻度强直、有抵抗感,鸡胸,有串珠肋,余正常。

诊断:破伤风,佝偻病。

处置:TAT注射,中医合治。

中医治疗经过:8月2日初诊,除上情而外,瘦赤少,多汗,脉弦,舌红,审为伤口受风,风邪伤血。处方:当归9克,川芎9克,生赤、白芍各9克,生地9克,秦艽9克,防风9克,天麻6克,全虫3个,钩藤12克,蝉衣6克,连翘12克,银花12克,羌活9克,生甘草3克。8月3日能张口1.5厘米,翌日能张口至2厘米,8月5日患者已可下床行走,惟腿仍不太灵活,可张口至3厘米,上方共服5剂。至8月8日,脉象缓和,下肢灵活,舌转淡,苔薄白,改用轻剂善后;处方:当归9克,川芎9克,秦艽9克,防己6克,桑寄生9克,川断6克,白术9克,羌活6克。4剂之后,痊愈出院。

(三) 讨论

破伤风在中西医之间的诊断名称是一致的(古人亦有名

之为金疮痉者),均认为是由于肌肤破伤而后引起的疾患;在病因方面,现代认为是菌类感染,而古人则归之于风,如《诸病源候论·金疮中风痉候》说:夫金疮痉者,此由……“荣卫穿伤,风气得入五脏,受寒则痉,其状口急背直,摇头马鸣,腰为反折,须臾下发,气急如绝,汗出如雨”。《证治准绳》谓:“疮眼小合,而风邪入之,为破伤风之候”,《沈氏尊生》谓:惟跌打损伤,疮口未合,灌风而成,乃为真破伤风”。《外科正宗》谓:“破伤风因皮肉损破,复被外风袭入经络,渐传入里;其患发作,口噤咬牙,角弓反张,口吐涎沫,入阴则身凉自汗,伤处反为平陷如故,其毒内攻矣”等等;古人所谓风,是包括现代多种致病因素的,这是历史条件的不同而然,而在古人的认证分析方面,以本文9例患者的临床情况来对照,可以确认有确切的科学记录和丰富的治疗经验遗留给我们的。’

按照古人记录,可以知道本病的邪气是风,所损伤的是气血,特别是血的受伤,这是正邪两个对立面的辨证基础,由于风邪伤血,血虚不能濡养筋脉,致筋脉拘急,而口紧、背直、腰为反折等痉的症状出现,也就是这些症状,古人是作为风来认识的,《内经》即有“诸暴强直,皆属于风”的描述:风邪对筋脉的影响而出现的症状,是通过血的机转而来的,所以风和血的邪正两种因素,在本病的临床上是不可分割的,在9例患者的临床症状上,均见红绛舌,这是血分受邪的明证,有8例脉见弦象,这是风象的明证,《金匱》:“夫痉脉,按之紧如弦,直上下行”,从而也可想到本病的弦脉,是血少而筋脉拘急的反应。

据上所述,我们在治疗中采用了针对血虚和风邪两个方面的方药,作为治疗基础,区别血虚重于风邪,抑或风邪甚于血虚的情况,而分别调整药物的比重;血药方面:采用四物汤为主方,以养血行血,求其达到“血行风自灭”的要求。风药方

面,由于此为外来之风,与内风不同,所以多采用疏散外风的药物,以玉真散、五虎追风散、木半夏汤等为主,综合出入。同时依据临床情况,以止痉、清热、祛痰、开窍等药配合运用,但牛黄丸及苏合丸等开窍药究竟是少用的,9例患者中,只用于1例合并中毒性休克的病例,并非为破伤风病而设。

从9例病人情况看,有几点值得注意:2例重症患者中,1例为腹膜炎手术后所起,并出现中毒性休克,服药最多,计31剂。另1例合并外伤感染,服药占第2位,达18剂。于此可以想到前1例患者,与其他金属伤、跌挫伤的破伤不同,而病情严重。后1例患者有合并症,而症情亦重,这里不能排除正气损伤的程度问题:合并外伤感染,行腹膜炎手术而合并中毒性休克,均是重伤于邪的情况,从而正气较其他病例为弱,病情也就重笃了。

(四) 小结

本文分析了9例患者的发病和病情。

通过温习古人对破伤风发病及病因的论点,论述了血(正气)、风(邪气)在本病的发生发展过程中的相互关系,而确定两者在临床上是不可分割的;同时,相应提出了针对血和风两者的基本治疗方针,及其辨证论治方面的结合运用。

从2例重笃患者的致病原因、并发病等情况方面,说明正气的重伤于邪是其重要因素。

本文9例中,除1例因喉间异物阻塞致死而不应归入疗效统计之列者外,其他8例均痊愈,治愈率达100%,但因4年来(1959.3~1963.3)所积累之资料仅此9例,不能从更广泛的面来分析,从而有其不可避免的局限性。

(本文曾发表于《江苏中医》1964年第7期)

医案三则

一、健脾益气法治愈十二指肠溃疡案

冷××，男，35岁，农业生产队长。

初诊：1975年9月3日。

主诉：患胃痛已1年多，痛有定时，饥时为甚，得纳则缓，纳食减少，神倦乏力，大便或干或溏，干则日一行，溏则日二行。曾在无锡县张泾地区医院胃钡透检查，诊断为十二指肠球部溃疡。平素嗜酒，每日必饮，患胃痛后饮次更多，初则饮之可以止痛，半年来已无效。

诊查：面色少华，舌苔薄白，舌质有紫点，脉来弦软，腹诊无明显压痛。

辨证：嗜酒而饥饱不时，脾胃受伤，气滞湿困而脘痛作，脾胃虚而饥时作痛、得纳可缓、便溏等症见。肝木来乘而脉弦软，总以脾胃之虚而气滞为主，肝贼湿困为次。

治法：宜健脾和胃、理气化湿为法，异功散加味。

处方：党参12克，白术10克，陈皮10克，生甘草3克，茯苓12克，延胡粉6克（分吞），煅瓦楞15克，乌贼骨粉8克（分吞），大白芍12克，川楝子10克，焦山楂10克，滑石15克，黄芩6克，砂仁3克（后入）。5剂，水煎服。

医嘱：禁酒辣，要求饮食有序。

二诊：1975年9月10日。

诸症俱减，脘痛仅晚间偶感，脉弦转滑，舌苔薄白，拟仍原法出入，并予药粉方继服。

处方一：党参15克，白术12克，当归10克，生甘草3克，

煅瓦楞 15 克,滑石 15 克,延胡粉 6 克(分吞),白芨粉 3 克(分吞),白芍 12 克,川楝子 10 克,陈皮 10 克,木香 3 克(后下),5 剂,水煎服。

处方二:党参 30 克,白术 30 克,白芍 30 克,象贝 24 克,当归 24 克,生甘草 45 克,白芨 30 克,煅瓦楞 30 克,延胡 24 克,乌鲗骨 45 克,黄芪 30 克。同打细末,过 80 目筛,早、午、晚各服 5 克,温开水送服。

三诊:1975 年 10 月 6 日。

症状消除,24 日张泾医院复查胃钡透:十二指肠球部龛影消失,脉滑,舌苔薄白,舌边紫点未除,再以调理气血以图巩固。

处方:党参 30 克,白术、芍各 30 克,黄芪 30 克,当归 21 克,田七 10 克,生甘草 45 克,乌鲗骨 45 克,象贝 24 克,白芨 30 克,煅瓦楞 30 克,共研成细粉如上方服法。

按:患者平素嗜酒,饮食不调,酒湿伤脾,辛辣伤胃,气滞湿停,久则脾胃失于健运,渐致虚弱,肝气来乘,此在痛有定时、得食可缓、纳少、面色少华、神倦乏力及便溏等症状上可证,而脉见弦象,是肝气之乘所致;脾胃之气虚滞、肝木之气横乘,所以痛作不释而在饥时,占云:“不通则痛”,是气血之郁滞而来也,亦因此而舌质可见紫点;然本证以气滞为主,血郁为次,脾虚为主,肝乘、湿阻为次,其轻重所在,合参诸症之多孤自可得悉,故用异功散健脾理气、化湿和胃为主,而以白芍之柔肝利血,瓦楞之化痰制酸,川楝之清肝止痛,为肝经一线用药;其间又以延胡之理气以配川楝、山楂化痰,用乌鲗骨止血止酸,以配芍药、瓦楞理血分,滑石佐茯苓之利湿,而矫瓦楞、乌鲗骨之涩,使涩而不滞、补而不壅、气血双调、君佐得宜而主次攸分,二诊之当归亦为调血而设,粉方之黄芪则仿外科生

血生肌之意，合白芨、象贝以求愈合溃疡。赖年事尚壮，气血尚盛，故得短期收效。余以六君子汤为主，或合乌贝散、或合金铃子散，参外科生肌收口之义愈合溃疡病，如心情、饮食得宜，似无不效，此例不过举例之案，服药后至锁透复查愈合，仅隔21日，是溃疡愈合时间最短者。

二、肝硬化腹水案

沈××，男，65岁，退休工人，无锡县东峰乡人。

初诊：1975年11月2日。

主诉：因髌股关节作痛，购服虎骨酒2周，近1周来渐见足肿腿重，腹胀膨大，纳少，瘦量尚可。素日亦常饮酒，每次一二两（约50~100克），已成习惯。

诊查：足胫肿，按之凹陷不起，腹大如鼓；脉象滑数，舌苔薄白，舌质红；昨查肝功能：谷丙转氨酶120，麝絮（+++），麝浊14，锌浊16，白蛋白23克/升，球蛋白35.7克/升；A型超声结果：肝肋下二指，剑下三指，脾侧位肋下二指，肝脏较密微小波、部分密集波。

辨证：酒热酒湿伤乎肝脾，肝气郁结、归藏失司，脾胃气滞、水湿停留，遂致水泛而成腹胀之疾。

治法：健脾利水，清肝达络。

处方：党参10克，白术10克，陈皮10克，茯苓25克，生赤、白芍各12克，酒木瓜10克，牛膝10克，大腹皮、子各10克，炮山甲10克，半边枝、莲各45克，蜀羊泉30克，冬瓜皮、子各30克，车前子、草各30克，焦谷、麦芽各15克。3剂，水煎服，日1剂，早晚各服一煎。

二诊：同年11月6日。

药后瘦量大增，腹胀渐平，近因外感致咽干作痛，音嘶，咳

嗽痰少而粘，喉壁有赤疹，两蛾红肿，脉滑有力，舌苔微黄，拟前法加入清解之品。

处方：生丹皮 10 克，连翘 15 克，黄芩 6 克，威灵仙 10 克，僵蚕 10 克，生赤、白芍各 12 克，马勃（包）10 克，茯苓皮 15 克，陈皮 10 克，紫地丁 15 克，炮山甲 10 克，炙鳖甲 10 克，桑寄生 24 克，半边枝、莲各 30 克，板蓝根 10 克。5 剂，煎服法同前。

三诊：同年 11 月 12 日。

腹水尽消，咽痛亦除，纳食已馨，原有之右足麻木仍在；面色郁，脉滑，舌苔薄少、舌质红；肝经气血郁滞之况尚在。

处方：半边枝、莲各 30 克，当归 12 克，生赤、白芍各 12 克，生丹皮 10 克，牛膝 10 克，车前子（包）15 克，田七粉（分吞）3 克，石见川 30 克，胎盘粉（分吞）3 克。5 剂，煎服法同前。

四诊：同年 11 月 18 日。

鼻衄、口干、咽下；舌苔薄少微黄、根中部略见花剥，舌质红，脉滑大；肝郁化热，营阴不足；治以清养两兼。

处方：生赤、白芍各 15 克，丹皮 10 克，太子参 15 克，炮山甲 10 克，炙鳖甲 10 克，黄芩 10 克，仙鹤草 30 克，胎盘粉（分吞）3 克，僵蚕 10 克，黑山栀 10 克，半边枝、莲各 30 克，郁金 10 克，当归 10 克，白术 10 克，茵陈 30 克。5 剂，煎服法同前。

五诊：同年 11 月 24 日。

略有鼻衄口干；脉右大而数，左弦而数，舌苔白，舌边尖赤；复查肝功能及白球蛋白均已正常；仍以清养进退。

处方：生赤、白芍各 12 克，丹皮 10 克，黄芩 6 克，太子参 15 克，龙胆草 10 克，半边枝、莲各 30 克，郁金 10 克，蜀羊泉 30 克，生山栀 10 克，桑寄生 30 克，白花蛇舌草 10 克，白术 12 克，炙鳖甲 10 克，胎盘粉（分吞）30 克，茵陈 30 克，仙鹤草 30

克,三七粉(分吞)2克。5剂,煎服法同前。

按:患者平素有饮酒习惯,无肝病历史,直至就诊前出现腹水而查得肝功能失常,蛋白倒置等情况,从而确诊为肝硬化腹水,究其原因,凉由长期饮酒,湿热耗灼肝血肝阴,遂致肝脾气血由郁而滞,由滞而瘀,气既不行,水亦随之留阻泛溢,故初诊以扶脾逐水、疏肝清热为法,使其气血通利而水邪以消;二诊有外感之邪挟入,但并无恶风恶寒等表卫证,仅为热扰清窍,故只参清气清咽之品,仍以逐水凉血为主,疗效得以续进;三诊腹水已消,咽痛亦止,去清上之品,守清通肝血原法,益入牡蛎以软坚缩肝,三七以活血化瘀,胎盘粉以益肾养肝,目的在于纠正蛋白倒置;四诊虽见鼻衄,仍属肝血瘀热,病机未变,故药亦不变;五诊时肝功、蛋白俱已正常,且连宿恙之髌股关节痛亦解,计就诊以还,不足一月,所以能此者,除药物外,患者深悟饮酒与本证有关,从而严禁亦为一助。四诊中所见之衄,其原系气血瘀滞不得疏泄,郁久化火,加之瘀血不去血不归经而致。与虚寒之脾不统血、或血虚而热之出血不同;此种气血俱见瘀热证,为肝硬化腹水类型之一,正由于此案例之属实属热属瘀,所以获效较快。如为虚证则未必能有捷效。

三、补气摄血法治愈过敏性紫癜案

华永梅,女,8岁,住院号2999。

初诊:1977年8月13日。

主诉:患儿于35日前两下肢出现散发性针尖大小皮疹,1周后愈见增加,并有融合成片之紫斑,上肢及胸、腹部亦有出现,尤以伸侧为多,伴有腹痛、呕恶阵作,吐物为胃内容物,稍有发热,多次就诊于当地医院,服用驱虫药、强的松、安络血、扑尔敏、路丁等药无明显好转,7月23日又增腰痛而转来我

院，经门诊诊断为过敏性紫癜收入病房治疗，住院后经用强的松、ACTH、葡萄糖酸钙、维生素C、路通、丹参液等口服或注射，并予驱虫及对症治疗，腹痛停止；8月1日作发腮腺炎、耳下脓肿，持续7天后始消；紫斑时退时现，经20日未能控制，儿科嘱家属至苏州进一步诊断，家属转而进行中医治疗。

诊查：患儿近1日来有低热，胃纳不馨已久，两下肢紫斑散布，面色苍白，舌质淡，苔薄白少，舌边有齿痕，脉细小而数。

辨证：始因热邪扰营血而为疹为斑，延久血伤及气，生化不足以济，而纳呆、面白、舌淡齿痕等症见，元气化为阴火而低热，中气不足而腹痛等则义同“建中”，气血两亏，统摄无权而致斑疹时隐时现。

治法：仿归脾意，益入滋阴凉血。

处方：黄芪9克，党参9克，白芍9克，当归9克，炙草3克，茅根15克，阿胶9克（化服），紫草9克，仙鹤草12克，红枣7枚。

二诊：8月18日上方连服5剂，紫斑渐消，未再有新鲜出血点，亦无其它不适，原方续服5剂。

药后斑疹退尽而出院。8月26日门诊复查：下肢偶有极少疹点，又续服原方10剂，而未再复发。

按：紫癜之辨治，可约为三期，初起热邪在营血，疹斑多而鲜者，以凉血为主治；中期伤及气分，脾运不健，斑疹或起或伏，色淡而散，以益气摄血为主治。本案即属此类。迨后脾肾两虚，阳气匮乏而形寒肢冷，斑疹隐约而紫黯，直可仿阴斑例治矣。此案延宕20日而用中医治疗，由血耗及气分，后天不足以济而见纳少纳呆，面色不华，斑疹起伏而色淡，然脉细数，细为血虚，数为血热，又不独脾与气之不足矣，故益入茅根、紫草以凉营，阿胶、仙鹤草以养血，白芍则凉养俱备，遂而一方收

效，是又宗归脾而变之也。又此方寓有甘温清热之义，参、芪、草之设者在此，但当仿东垣原意、小量投之，重则气有余便是火，热将不除，是又为余于组方时进一层之所思也。

（以上三案均在无锡时由学生李坚报刊江苏省某医学期物）

阑尾脓肿 9 例小结

在对外科急腹症阑尾穿孔引起局限性腹膜炎的病房会诊中，2 年多来，共治了近 20 例，但由于病历散失，仅能查到 9 份，现小结如下。

9 例病历中，均由外科作出诊断，在进行抗生素药物保守治疗的基础上，进行中药治疗。因此，在诊断上是肯定的，治疗的效果均属治愈或接近治愈，其中不到半数的病例，在腹痛消除或肿块减小后出院，出院后又在门诊中服过中药，其最后转归亦肿块消失而治愈。

这一组病例中，效果均较单用中药者为快，多数在 10 剂左右得到控制，有的已达腹部包块消失，既往单用中药者均在 2 月左右始能消失。

由于病例不多，现将病房阶段情况，列表说明如下。

表 15 治疗情况总结表

姓名	年龄	性别	初诊时症状	剂数	方 药
惠 ×	50	女	转移性右下腹痛 2 周,扪及拳大肿块,质软,有反跳痛, T38.2℃ ③有鼻塞流涕上感症	7	①当归尾 10 克,败酱草 20 克,银花 20 克,丹参 12 克,生地榆 12 克,桃仁 15 克,焦楂肉 12 克,丹皮 10 克,冬瓜仁 12 克,红藤 30 克,生苡仁 20 克,赤芍 10 克 ②蒲公英 20 克,连翘 12 克 ③苍耳子 6 克,辛夷 15 克,猪、茯苓各 12 克
周 ×	49	女	右下腹痛 3 天,有肿块 6×4cm, T39.2℃,右脚屈伸不利	7	①生苡仁 30 克,败酱草 25 克,当归 10 克,红藤 30 克,冬瓜仁 25 克,赤、白芍各 12 克,延胡 10 克,乌药 6 克,丹皮 10 克,连翘 20 克,紫地丁 20 克,黄花地丁 20 克 ②桃仁 10 克,忍冬藤 20 克 ③木香 10 克
吴 ×	67	女	腹部疼痛 5 天,右下腹有鸡蛋大包块, T39.3℃	5	①忍冬藤 15 克,赤芍 10 克,冬瓜仁 12 克,红藤 30 克,瓜蒌 30 克,连翘 12 克,桃仁 10 克,生苡仁 18 克,广木香 15 克,清宁丸(包)12 克,归尾 10 克,丹皮 10 克,败酱草 30 克,枳壳、实各 15 克 ②银花 12 克,苦桔梗 6 克

(待续)

(续表 15)

姓名	年龄	性别	初诊时症状	剂数	方 药
周 ×	66	女	腹痛 2 天, 右下腹有拳大包块, T38.4℃, 大便艰涩		①酒军 3 克, 生苡仁 30 克, 败酱草 25 克, 红藤 30 克, 冬瓜仁 22 克, 银花 22 克, 连翘 22 克, 蒲公英 22 克, 紫地丁 22 克, 赤芍 10 克, 生丹皮 10 克, 元明粉(克)6 克 ②麻仁 10 克
宣 ×	68	女	右下腹疼痛 2 天, 可及包块, T38.4℃	4	①归尾 10 克, 丹皮 10 克, 川楝子 15 克, 赤芍 10 克, 冬瓜仁 12 克, 延胡 10 克, 桃仁 10 克, 生苡仁 30 克, 红藤 30 克, 败酱草 30 克, 银花 12 克, 连翘 10 克, 清宁丸(包)10 克 ②鲜石斛 12 克, 天花粉 12 克
周 ×	28	女	右下腹痛 7 天, 有拳大包块, T39.2℃	2	①当归 10 克, 连翘 10 克, 丹皮 10 克, 赤芍 10 克, 银花 12 克, 冬瓜仁 12 克, 败酱草 30 克, 生苡仁 20 克, 红藤 30 克, 桃仁 10 克, 清宁丸(包)10 克
宋 ×	56	女	右下腹痛 2 天, 有包块, T39.5℃。胸痞满, 纳少, 便不畅, 肩背痛, 恶心	9	①生苡仁 30 克, 丹皮 10 克, 当归 10 克, 生赤芍 10 克, 冬瓜仁 25 克, 败酱草 25 克, 红藤 30 克, 连翘 22 克, 公英 22 克, 紫地丁 22 克, 忍冬藤 30 克, 生草 15 克, 生地榆 10 克 ②银花 12 克, 焦楂曲各 12 克, 木香 15 克, 枳壳 6 克, 清宁丸(包)15 克, 番泻叶(后下)12 克 ③生白芍 12 克, 乌药 6 克 ④紫地丁 22 克

(续表 15)

姓名	年龄	性别	初诊时症状	剂数	方药
周 ×	17	男	右下腹痛 3 天, 有包块, T39.6℃	6	①败酱草 30 克, 生苡仁 25 克, 丹皮 10 克, 醋柴胡 6 克, 冬瓜仁 22 克, 桃仁 6 克, 酒军 6 克, 红藤 30 克, 连翘 22 克, 忍冬藤 30 克, 公英 22 克 ②生赤芍 10 克
侯 ×	40	女	右下腹痛 3 天, 有包块, 如拳大, 痛引右腿根, T39.9℃	11	①生苡仁 25 克, 红藤 30 克, 丹皮 10 克, 败酱草 25 克, 忍冬藤 30 克, 公英 12 克, 紫地丁 22 克, 连翘 22 克, 苦桔梗 10 克, 冬瓜仁 25 克, 生草 3 克 ②香附 10 克, 枳壳 6 克, 延胡 10 克, 乳没各 6 克

注: (1) 方药项中药味, 为病房用药的总和, 具体使用中有所加减, 其中①为初诊时所用药味, ②为二诊时加用药, ③为三诊时加用药。

(2) 症状项中的③, 为三诊时所见的新症状。

体会

本组病例均有发热、右下腹疼痛, 并见到肌卫和不等大的包块, 此系阑尾脓肿的主症, 也是中医肠痈的主症, 符合于《金匱·疮痍肠痈浸淫病脉证并治第十八》第三条中所载的“肠痈之为病……腹皮急, 按之濡, 如肿状……此为肠内有痈肿”, 以及第四条的“肠痈者, 少腹肿痞, 按之即痛如淋……时时发热, 自汗出……脉洪数者, 脓已成”的记载。因此, 我们用薏苡附子败酱散、大黄牡丹皮汤, 以及张石顽的清肠饮、张景岳的肠痈单方, 综合加减治疗。

阑尾脓肿的病理, 历代医家均认为是由于不同的因素, 引起“肠内气血凝滞、郁结为热, 留积不散, 肉血腐败”(《中医内

科学讲义》)而成,如陈实功说“夫肠痈者,皆湿热瘀血,入小肠而成也。”《冯氏锦囊》说:“肠痈是音梁积热所致”。本组病例,均属脓已成者,因此在治疗原则上必然是清热、化瘀、排脓三个方面,9例用药也就是依据这个原则,根据具体情况、分别缓急的运用这三个方面。

中医历来有肠痈脓已成用薏苡附子败酱散、脓未成用大黄牡丹皮汤的看法,但这个看法很早前已打破了,60年代初协和医院就曾分别用大黄1~4两(30~120克)来作为由轻到重的阑尾炎固定治疗处方,而并未见到泻下,亦无付种危害性。本组病例中有6例使用了大黄,我个人认为大黄能起到清热化瘀的作用,它的泻下要看使用量和轻重煎法来决定,一般在1~2钱(约3~6克)间,或煎煮超过半小时时,泻下作用并不明显,在阑尾脓肿的治疗中并不禁忌。《金匱》在大黄牡丹皮汤方下,注有“有脓当下”,在本组病例中,这种“有脓当下”的现象,仅有1例出现(表中第5例),此患者在服药后第三天出现大便下脓甚多的情况,随之右下腹包块也就很快消失了。其余病例均未有此现象,包块的消失也就较为缓慢。个人认为包块的消失主要要依靠机体自身的吸收排出,这里关系到脓液多与少的情况。消失的慢,是属于正常范围的情况。当然,快是医患双方共同的要求,但那种便秘的情况有潜在的危险,因为只有肠外脓肿向肠内溃破才能出现便秘,而此种恰巧是向肠内溃破而不向其他方面溃破的机会是不易遇到的,并且此时的肠壁受累的程度也必然加重,因此临床时很难恰如理想的达到这一“有脓当下”而又安全的要求,要解决这一矛盾而求得脓肿的迅速消除,尚须在今后工作中不断加以探索。

(本文发表于1976年无锡县中医学术交流会,1987年据

此资料压缩制成幻灯,用《阑尾脓肿的非手术治疗》名称,参加国际自然医学会学术交流。)

慢性腹泻的治疗

本病多数由急性腹泻、痢疾失于及时治疗、过敏或其它疾病转移而来,包括了现代医学中的肠功能紊乱、痢疾后结肠炎、肠结核、溃疡性结肠炎、结肠过敏、慢性肠炎、特异性或非特异性肠道感染等疾患。是比较顽固的疾病,可以拖延数月甚至数年,经常反复发作,尤以体力不佳、饮食失宜、情绪波动时发作明显(肠结核除外),临床上往往听到患者口诉因进食肉类而发作。本病的诊断,以病史、临床反复发作的症状、肠道检查三者为依据,肠道检查以乙状结肠镜较钡剂透视为可靠,因为钡透对肠壁水肿或血管模糊情况往往不能发现,但即使是乙状结肠镜和钡透结合检查,在鉴别上仍有一定困难,因为结肠过敏、肠功能紊乱等病,同样与慢性肠炎、痢疾后结肠炎一样,会出现肠壁水肿或血管模糊情况,也难于区别来源于急性肠炎或痢疾,只有肠结核和肿瘤较易区别,但肠结核与肿瘤间的区别尚需靠其它检查。由于确诊上存在条件限制,因而治疗效果在针对性不强的情况下也就不甚理想。现就中医部分,谈点意见。

(一) 病因病机

本病相当于中医学中泄泻病的“久泻”范围。中医学认为本病的病邪方面有湿热、积滞、痰浊、情绪等;受病的脏器有胃、脾、肠、肝、肾等,其发病过程,大致有下述几种方式:

1. 急性期由于感受湿热之邪或饮食积滞,削弱脾胃的腐熟、运化功能,致湿热、积滞不能得到分解而俱下于肠,肠道受

病,此时如治疗及时而得当,就可得以痊愈,由于某种关系未达到此疗效,致湿热、积滞久不得解,脾胃功能愈形低弱,遂致经年累月不愈而为本病;或者在病邪初解时,脾胃功能未复,复感于邪,形成反复发作;或者病邪大势虽去,残余部分未得肃清,一遇体力低落、或情绪波动,即趁机复发。所以湿热、积滞之邪,既是本病的致病因素,又可为诱发因素。这一类型是本病患者中最多见的。

2. 在运化力量被削弱的基础上,影响到营养的吸取,致气无所俾,可以导致气虚下陷,而于腹泻同时可出现腹坠、肛坠感,甚至出现脱肛,并且同时具有脾虚、气虚二组症状,此为由脾阳虚进一步病机之一。或者由于脾阳虚而累及肾阳,此种情况,同样是由于营养不足的影响扩大,不过是机制径路不同,前者累及气,此则累及肾;肾主二阴,命门是一身阳气的根蒂,此间阳气不作,可使小肠不能成聚,膀胱气化不佳而致水与糟粕俱下于大肠而为泄,并可影响大肠的传导功能,不能节制便次;此种情况称为“脾肾阳虚”,临床具有脾阳虚、肾阳虚的症状,并往往凌晨即泻。

3. 导源于情绪的泄泻,其来有二,一为由脾阳虚而肝气乘脾,即由于运化不佳,营养不足,体质虚怯致神经功能虚亢,情绪易于波动的情况;此种情况称作“肝脾不和”,亦可因肝气流注于肠,走窜失其常度而致肠鸣切痛特甚的症状,称为“肝气下注”或称“痛泻”,此症急、慢性泻均可见到。另一为直接由精神情绪所起,如多怒伤肝、久思伤脾之类,使气机郁滞,运化功能低落,再而引起上述二种机制性的腹泻;此种情况区别于前者的,不仅是主动或被动的关系。其共同症状是稍有悲怒即泻,或者泄泻随情绪的郁畅与激动而变化。此中又有阴阳之别,视其肝气虚亢与否而区分为“脾阳虚”为主或“肝气虚亢”

为主,临床兼证亦随之不同。

4. 由于痰浊而起者,临床比较少见,且易见于女性,或因体质有痰浊,如“肥人湿胜”之类,或嗜于肥食,痰浊阻滞运化或运化不足以化浊,造成“湿胜气虚”局面,脾、胃、肠功能低下而成泻,临床多见于肥胖体质或食肉即泻的患者。此间亦有脾虚甚于痰浊,或痰浊甚于脾虚之别。

概而言之,当病邪入侵之后,或胃不能腐熟,或脾不能运化而肠以受病,或因脾虚而气下陷,或因脾虚而累及肾阳,或因脾虚而肝气来侮,或直接由肝郁侮脾,致肠病久不得复,因日久泻的病位在肠,而其原则可涉及肝、脾、肾三脏,其因脾阳不足情况则是必然的,但有相对与绝对的区别;所以本病的病机,大多数是“虚”,唯有脾虚、气虚、肾虚之别,其间又常多互见。间有余邪未尽、虚中挟实情况,所以临床要关关分析,环环扣紧。

(二) 主要症状

本病的主要症状是:便次增多,粪稀,间或有脓血粘冻,腹痛肠鸣,长期迁延不愈或反复发作。此种症状,在病理上是由于肠道炎症或溃疡引起功能异常,吸收差,分泌增加,蠕动亢进或痉挛而来,其损伤血管者则见血便。中医学则认为:

1. 便次增多,为肠道气机不利,传导失职而来。

2. 粪稀,由于小肠“泌别汁”功能低下,水津俱下于大肠而来。

3. 脓血粘冻,由于气血俱郁于大肠,伤及血分则见血便,在气分则见粘冻脓便,亦可由湿热、痰浊稽留大肠面来。

4. 肠鸣腹痛,由于气分郁滞不利,或肝气走窜肠间,“不通则痛”,而鸣响。其所以气分郁滞,则寒、热、湿、痰均可引起。

(三) 对本病的治疗

在病邪一面,总是分消驱逐,但不是本病治疗的单一方面。在正气一面是重点,要由脾虚而上溯到肾、肝之虚、实情况及虚中挟实情况。以上属求本治疗方面,有扶脾益气、温肾、和肝以及利湿、清热、消痰化滞等法。此外,由于便秘之因“小肠不得成聚”而用分利法,因大肠滑脱而用敛涩或升举法,因便血而用止血法,以及因腹痛而用利气止痛药等,此为治标方面。

根据上述见解,以及1966年前北京某医院用10%大蒜液灌肠治疗效果的不甚理想,笔者认为治疗本病应按中医传统,要对不同的具体患者找出不同的主要矛盾所在,不是一方一药所能概括。但由于本病治疗期较长,要照顾患者的服药、就诊的方便问题,因此采用了在辨证论治的基础上,开始时以煎剂为主,后期配用“参苓白术散”和自定药粉处方,或者就以丸药、药粉为主的治疗方法。药粉处方是依据肾阳不足,可以影响到脾主运化、小肠成聚、大肠传导功能的理论而用“四神丸”成分再依据过去对石榴皮、五味子的灭菌作用实验研究和古籍对该两药作用的论述而配用(五味子“四神丸”中即有)。

自采用上述治法后,自1977年底起至1978年5月,收集了一些病例,加上回忆所及的共25例,其间求得乙状结肠镜检查有肠壁粘膜水肿或血管模糊者12例。能得到追踪结果者17例,其中13例基本痊愈,3例好转,其余8例均仅一次就诊,后果不明。此8例中,1例有子宫癌史,进行过放射治疗。治疗例中,服药最少者5剂,服药最多者50剂。

治疗例中,有1例病情较复杂,简述于下:徐××,男,2岁,养路队家属,起始以急性肠炎在本院住院治疗,转市二院。前后共住院3个月,热退、便次减少后出院,出院后因调护失

宜，饮食不节而且不洁，渐又便次增多至泄泻无度，而嗜食特甚，饮食不能离口，随食随泄。延迟半月来诊。时患儿消瘦甚，唇赤舌赤无苔，脉细数，腹中不断鸣响，便泄大半完谷。此诚“下焦关闸尽弛”，中焦津枯火炎，消谷求食以自救之况，此时健脾碍于助热，苦寒碍于化火，养阴碍于滑泄，因以白芍、生草、石斛、生山药、太子参救脾胃之阴。五味子、石榴皮固大肠滑泄，另嘱禁食糕饼之类，以车前子炒研成粉，配1:3参苓白术散，糖水调服，以代患儿之食，间服苹果浆。三日后复诊，嗜食及泄泻无度已减半，仍用原法。三诊时适值外出，易医用健脾、消导药，症情未再进步，此因胃阴未复，故健脾无效。此后复用原法服1周，诸症尽退，舌苔渐生，因转健脾养胃法，1周后单用参苓白术散及炒车前粉巩固。前后计月余而痊。服炒车前子粉至5斤(2500克)。去年其6岁之兄，亦病泄泻月余，审为饮食失宜，积滞阻碍运化，以健脾化滞合五味子、石榴皮一诊即愈。

对“热入血室”的虚实辨治

热入血室的记载，始见于张仲景著作，《伤寒论·太阳篇》及《金匮·妇人杂病脉证并治》篇的记载基本相同。在仅有的四条条文中，表明了本证是热性病；其症状有轻重两种，三个类型；轻症是寒热往来如疟，重症是发热、暮则谵语，或无热而日暮谵语，谵语而兼发热者更重；其治法有小柴胡汤和刺期门等。四条条文中有三条提到了本证见于妇女及其与月经的关系。由于条文未谈清血室的所指，以及由于古文的简要等情况，随着时代的发展，使后来医家对本证的看法产生了分歧，但也因而带来了治疗方法上的丰富；如钱潢提出小柴胡汤加

牛膝、桃仁、丹皮等；许叔微提出小柴胡加地黄；张璧提出小柴胡加丹皮，杨士瀛提出小柴胡加五灵脂等等，总之是在小柴胡汤的基础上加入了凉血或化瘀之品。在分歧方面，主要是血室问题；认为血室是女子胞或胞门子户的，有陈自明、巢元方、程式、张介宾及《卫生宝鉴》等；认为血室是冲脉、血海的有方有执；认为血室是肝的有柯韵伯。实际这种争论是在一条连线上，都是中医学中所说的月经生理这条连线，即月经形成所涉及到的肝的藏血、冲（任）的汇聚旺盛、胞宫的排出等几个方面。有人认为由于血室是冲脉或肝，所以男子亦有热入血室之证，关于此点，个人认为男子热病而见下血，当然有热邪入血之理，但如有瘀血，可以归之于“蓄血证”，如无瘀血，可以归之于“动血”范围，不用再在血室上纠缠。

在本病的临床认症方面，最主要的是要分清热入血室中的虚实及其形成原因。如何区分虚实，要依靠月经的具体情况，不能单着眼于“经水适来”或“适断”一点上；下述几点是应该注意的：

1. 经水适来而畅，虽有发热，亦可不形成热入血室；即使出现了热入血室症状，也可不成为瘀实证，而仅是热邪进入血室。若经水适来而不畅，或者及期不行，此时如出现热入血室症状，就有热与血结可能，而成瘀阻实证。

2. 经水适断时，如果按正常经期而断的，虽有发热，可以不成热入血室证，即有热入血室症状，程度上也较轻。

3. 经水已行，因发热而突然中断，则往往可形成瘀阻实证。

归结起来，是要分清：①热邪是否进入血室。②热邪虽已进入血室，但是否与血相结，其间能否与血相结，是以血室有否经血为转移的。现将虚实两种情况的经治病例举于下：

例 1, 沈月娟, 女, 30 岁, 农民。

1978 年 5 月上旬, 因发热达 39.5°C , 而住无锡县东峰中心医院内科, 入院诊断为上呼吸道感染, 除发热外, 伴有咳嗽咽痛等症, 白细胞总数 8.3×10^9 克/升, 经用抗生素、补液等治疗二日, 热退, 能进饮食, 原拟观察二天后出院, 但于热退翌日下午, 突然神昏谵语, 如见鬼状, 至晚间 8 时许神智自行恢复, 谵语时体温正常, 内科检查无特殊情况, 因于 5 月 8 日请中医会诊。会诊时已下午 3 时许, 正值患者谵语之时, 不独语无伦次, 亦不容诊察, 请其爱人强制后, 始诊得脉弦小, 舌红, 苔薄白, 腹诊则完全拒绝, 当时因四诊不全, 深感为难, 经向其爱人详问经过, 悉热退当日适值经期而未潮, 且有少腹作胀, 此正合《金匱》“妇人中风……得七八日, 热除脉迟, 身凉和”, 及“经水适来, 昼日明了, 暮则谵语, 如见鬼状”等热入血室病情, 但此为经水及期而不行, 必未尽之邪与经血瘀结在里, 因拟“随其实而取之”之法, 用桃核承气汤以通瘀滞之血, 合小柴胡汤以清内恋之热, 方用:

桃仁 10 克, 生甘草 5 克, 元明粉 10 克(兑服), 制大黄 7 克, 桂枝 7 克, 炒柴胡 9 克, 黄芩 7 克, 法半夏 10 克, 生姜 2 片, 大枣 7 枚。1 剂。

嘱将头二煎分别于晚 8 时及午夜 2 次服完, 服后如经行即相告; 并告知经行后病始可解。

翌晨患者家属来告, 经已行, 但量极少。计尚不足以解日暮之谵语, 因嘱再服 1 剂。日晡时复诊; 经量渐多, 稍可作答, 但尚不欲多言。第二日经行正常, 谵语未作, 但神情萎弱, 因处小柴胡汤方 2 剂而出院。

例 2, 辛云生, 女, 27 岁, 已婚, 工人。

患者于 1979 年 8 月 18 日发热 39°C 左右, 但无形寒, 咳

嗽、流涕及明显咽痛，于某医院诊断为病毒性感冒，经用“安痛定”，转为下午低热，在 $37.4 \sim 37.6^{\circ}\text{C}$ 左右，于 8 月 22 日再次就诊，因患者素有慢性扁桃腺炎，经常咽痛而诊断为化脓性扁桃腺炎，用“卡那霉素”、“含碘喉片”等药，患者坚持工作，未卧床休息，至 24 日晚间，又突作高热 39.3°C ，伴有恶寒头痛，医至本院就诊。入院后经“红、链霉素”及输液治疗，27 日上午一度热退，下午又起，28 日热至 38.2°C ，因请中医会诊：

8 月 29 日初诊，时适无热，经迫询：患者于 24 日复热以来，时有形寒烘热，汗出则热退之况，平素有扁桃腺慢性炎症，此次发热后未见加重，病中适值经行，自 8 月 20 日至 24 日在潮，素有痛经甚剧，需经尽始止，但此次经行竟然未腹痛，行量亦畅，经尽当晚即复作恶寒高热，诊得脉静而弦软，舌苔微白，症情与《金匱》“妇人中风，七八日，续得寒热，发作有时，经水适断，此为热入血室”之况相合，但经行尚畅，未必“其血必结”，而寒热“如疟状，发作有时”之况尚在，因予小柴胡汤加味，以清留恋于血室之余邪。方用：

炒柴胡 10 克，生黄芩 10 克，姜半夏 10 克，薄荷 3 克，太子参 15 克，连翘 15 克，丹皮 10 克，赤、白芍各 10 克，银花 15 克，板蓝根 10 克。2 剂。

9 月 1 日复诊：自 29 日以来，午后低热仅 $37.1^{\circ}\text{C} \sim 37.3^{\circ}\text{C}$ ，已无形寒烘热之况，惟便溏瘦赤腰痛，脉转滑，苔转薄黄，因以原方去薄荷、赤芍、白芍，加黄柏调治。患者于翌日出院。

从上举 2 例情况看，证虽有虚实之分，但均与月经有关系，此种情况，医病双方均易忽略，往往以发热为重点，如不进行详细的问诊，就难于掌握病情，于此可知，古人《十问歌》中“妇人尤必问经期”的要求，在本病治疗中可以说是具有决定性

的作用的。

(本文 1980 年收入《北京市老中医经验选编》第二集)

术后呃逆病案二则

例 1, 李××, 男, 58 岁。患者于 1950 年发现十二指肠球部溃疡, 经常于饥饿时上腹疼痛, 1965、1970、1972 的 3 年中, 曾反复呕血、便血数次, 经治而愈。近半个月来又感上腹疼痛, 并有黑便 8 次, 于 1980 年 8 月 27 日收入内科住院, 经治疗止血后, 于 1980 年 10 月 3 日转外科手术。

主症: 患者于胃次全切后翌日即出现呃逆频频, 纳食不馨, 已经 10 日, 大便通畅, 舌苔薄白而腻, 脉滑而大。

辨证: 脾胃职司运化, 有升清降浊之用, 患者胃痛 30 年, 其脾胃之虚可知, 胃次全切术后, 脾胃运化之力更为削弱, 水湿不能运化, 进而阻聚中焦, 致使胃气不降, 转而上逆, 遂出现呃逆频作, 纳食不甘, 舌苔润腻等湿聚气逆之证。

立法: 此证正虚邪实、虚实夹杂, 治之宜扶正气以助脾运, 降胃逆以化湿邪, 方用旋复代赭汤加减。

方药: 党参 15 克, 代赭石 18 克, 旋复花 9 克(包), 厚朴 18 克, 枳壳 10 克, 姜半夏 9 克, 大腹皮 10 克, 香附 10 克, 刀豆子 10 克, 川楝子 10 克, 陈皮 10 克, 沉香粉 2 克(分吞)。3 剂, 水煎服。

方解: 方中重用党参补脾胃之虚, 助脾胃之运, 合重镇降逆之代赭石为主药, 辅以厚朴、枳壳、旋复花、沉香之温降, 佐以半夏、陈皮之燥湿降逆, 香附、刀豆子之理气下行, 腹皮、川楝子之由中达下, 共奏降逆和中之效。进药 3 剂, 呃逆遂除。

例2,李××,男,51岁。患晚期贲门癌,不能进食已2月余,3日前经外科行探查手术,术中因发现牵涉面广泛而未能切除,改做空肠造瘘术以供给养。

主症:术后呃逆频作,便少,溲利,贲门肿块胀实,舌苔前半光赤,脉来滑软。

辨证:气行则血行,气滞则血滞,气血积滞日久,结聚上脘,有形可证,致不能进食已2月余,后天水谷之源绝,脾胃失于所秉,此胃阴渐耗之所由来也。近则术后胃气暴夺,遂失其和降之用,故见脉软,舌红、呃逆频作等象。

立法:此证气血积滞,阻碍气机不得下降为其主因。治宜理气化瘀,降逆止呃,以图救急。

方药:旋复花10克(包),代赭石30克,党参15克,槟榔10克,三七粉3克(分吞),血竭粉2克(分吞),石见穿20克,赤、白芍各10克,沉香粉3克(分吞),枳实10克。2剂,水煎服。

方解:方中三七、血竭、石见穿、赤芍为活血化瘀而设。旋复花、代赭石、枳实、槟榔、沉香为降逆止呃而用。党参、白芍以调胃之阴阳。1剂后呃逆即止。

按语:呃逆多为近代之膈肌痉挛,古称嘔,属于内科疾患,其成因在中医学中有寒、热、虚、实之分,而总的关键是胃气上逆。上述二案,均出现于外科手术后,就其病史、病情而论,既有其相同处,又有其不同处,其相同处,在于二案均为胃气上逆。故同用重镇降逆之药;其不同处,在于虽同有虚证,而有阳虚、阴虚之不同,虽同有挟实,而有挟湿、挟瘀之异,故在辅助配伍药物上亦随证而用。第一案重在肺胃素虚,又复行手术,更伤中气,出现虚中挟实之象,其虚者乃脾胃阳运之气,故选党参以扶正,合以重镇之代赭为主药,其挟实者为湿,故辅

以燥湿健脾之品。第二案重在气血凝滞结聚，已成瘕积，呃逆之来，显系结聚不解而起，症见标本俱急，与第一案之由虚而聚湿不同，故用重镇之旋复代赭以降逆，与三七、血竭、赤芍以活血化瘀，为标本兼顾之治，由于瘀血不化，兼之不能进食，新血不生而伤及胃阴，是又与第一案之虚不同，此虚在阴，彼虚在阳，此虚之来为瘀血，瘀不化则阴不复，此不同于彼之先虚而后湿聚，故以党参之助气，白芍之和阴，双扶阴阳，且使之居于臣、佐之位。

二案症情不同，选方用药随之有别，必须于通融兼顾中突出重点，既要抓住主症，又要抓住主因，方不失时机，立除病痛。

石淋虚实辨证

石淋的成因，和其它淋病一样，总的是湿热蓄于下焦，形成“肾虚膀胱热”的机制而来的，其不同之处，在于石淋要经过湿热受到煎熬而结成砂石；如《丹溪心法》说：“淋症所感不一，或因房劳，或因忿怒，或因醇酒，或因厚味。盖房劳者阴虚火动，忿怒者气动生火，醇酒厚味者酿成湿热，积热既久，热结下焦，所以淋漓作痛，初则热淋、血淋，久则煎熬水液，稠浊如膏，如砂石。”

《医宗必读》和《张氏至通》也有相同的记载说：“正如汤瓶久受煎熬，底成白碱。”

“积热既久，热结下焦”阶段，相类于近代医学中的由于输尿管疾患引起尿液郁滞，出血、粘液增多，上皮细胞多量脱落、菌团形成的一个过程。水液久受煎熬情况，相类于近代医学中由脱落的上皮细胞片、菌团、血块、粘液为核心，不断结合尿液

中的磷酸、鞣酸、盐类等而成为砂石的过程。

石淋的治疗,由于有湿热结于下焦,所以要用清利湿热的药,由于久受煎熬,结成砂石,所以要用通淋排石的药。这是一种针对性很强的治则,古人也多数认为石淋离不开热的情况。《素问·六元正纪大论》中“其病中热,胀……小便黄赤,甚则淋”,“不远热则热至……热至则身热……淋闭之病作矣”等的记载,肯定了淋病有热;陈修园也说“五淋病,皆热结”,所以近代大多数治疗石淋的报道中,均用大队清热利湿排石的药物,如金钱草、瞿麦、葵子、牛膝、虎杖、大黄等,也确实收到了良好效果。此外古人还提出了淋病忌汗、忌补之说,忌汗出自《金匱》“淋家不可发汗,发汗则必便血”,忌补则是多数古人的看法,如张路玉说:“最不可用补气之药,气得补而愈胀,血得补而愈涩,热得补而愈盛,水渍不行,加之谷道闭塞,未见其能生者也。”刘完素甚至认为在冷淋的治疗中用热药也是“使气液宣通,热散而愈”,他在《素问玄机原病式》中说:“世传方论虽曰冷淋,复用榆皮、瞿麦、茯苓、通草、鸡苏、郁李仁、梔子之类寒药治之而已,其说虽妄,其方乃是,……或谓患淋而服茴香、益智、滑石、醇酒温药而愈者,然则冷软,殊不知此皆利小便之药也,盖醇酒、益智之性虽热,而茴香之性温,滑石之性寒,所以能开发郁结,使气液宣通,热散而愈也。”忌汗,因为病不在表而在里。确无发汗之理,而究竟忌补与否,此中有辨证的问题,要根据病人的具体情况而定,下面举2个病例来说明。

举例案一:

吕××,男,52岁,公安人员。门诊病历号5803。初诊日期1982年10月28日。

患者于1982年10月26日,突发右侧腰痛,并向右腹放射,10月27日来我院西医内科就诊,检查:右肾区叩击痛

(一)、尿常规:白血球 0~1,红血球 1~2,诊断:腰痛待查(泌尿系结石?)。同时转北京市第六医院,诊断相同。

28日下午由同单位同志陪同就诊,仍诉右侧腰痛如刺,小便无频痛情况而少腹迫逼,神情烦躁,右肾区叩痛仍在,右侧下腹部亦有痛感,脉象沉弦而紧,舌红、苔白根腻。此属湿热久蓄下焦,气化不利,郁而化热,煎炼成为砂石壅塞所致,以清化湿热、开利下焦为治。

处方:大金钱草 30 克,黄柏 10 克,瞿麦 30 克,石韦 30 克,冬葵子 18 克,丹皮 10 克,香附 10 克,炒枳壳 10 克,石菖蒲 9 克,青皮 12 克,乌药 10 克,牛膝 15 克,生甘草梢 4 克,滑石 15 克。3 剂。

嘱患者:①即去六院摄腹部平片,以求确诊。

②服药后如症状不缓解或于排石时疼痛剧烈及有出血情况时,可速来住院治疗。当日傍晚同单位同志持六院 X 片来,发现第五腰椎右侧有 $0.4 \times 0.3 \times 0.3$ 厘米半圆形阴影一块,但因 X 光片未全定影,水痕不少,未敢认定即是结石。第二天患者未来。傍晚时适该单位有人来院办理其它事情,请其带信患者来复诊。

10 月 30 日复诊:

患者诉:28 日因腰痛甚,六院摄片后,即于 6 时许服头煎,1 小时后又服二煎,当晚腹部窘迫特甚,屡次溲便不得,凌晨 4 点时,溲出绿豆大半圆形结石一枚,遂而诸症如失,并出示结石及六院平片,两者形态相同,石色深褐质坚,自云 29 日已近平复,故未来院,今但腰腹间小有不舒之感,余以六院 X 光片,请 X 光科同志同观,并再为摄片复查,片示结石阴影已消失,因再以原方出入,小其制,调理善后。

举例案二:

姓名张×,男,47岁,干部,住院病历号3750。

患者于1982年7月15日,突然右腹部疼痛,未经治疗而缓解,之后常反复发作。曾在平谷县某医院住院治疗,经肾盂造影,诊断为“右侧输尿管结石”于1982年8月31日转入我院中医病房住院治疗。

入院后拍X光片,示第四、第五腰椎右侧可见 0.5×0.5 厘米大小密度增高阴影;肾盂造影,右侧肾盂轻度积水。

病人纳食一般,大便溏,小便顺,腰腹疼痛不甚明显,舌苔白,舌质红,脉沉细。

诊断:石淋(西医诊断:泌尿系结石)。当时主管大夫辨证为湿热久蓄膀胱、煎炼尿液为石,给予清热利湿排石通淋。

处方:金钱草30克,海金沙20克,车前子30克,枳壳10克,鸡内金15克,滑石20克,扁蓄15克,瞿麦15克,丹参30克,双花10克,生龙、牡各30克,海浮石15克。并用金钱草每日40克代茶饮。

服上方9剂后,于1982年9月9日X光拍腹部平片复查,结石与入院时相比下降1.5厘米。仍服上方每日1剂,合金钱草代茶饮。1982年9月17日、23日两次X光腹部平片复查:右侧输尿管结石,无下降趋势,仍在第五腰椎与腰骶之间。

1982年9月25日查房时主管医师邀看患者,见患者面色黄白,自汗不断,便溏日行5次,舌淡红,苔白根腻,脉沉软。此乃气虚失运,外则卫阳不固,内则气化不利,肾气不得主二阴,而致湿热之邪郁滞下焦,久而煎灼结为砂石室塞,因嘱加用益气之治,与前方交替服用,每三剂一更换。

处方:生黄芪30克,党参15克,炒白术10克,云苓10克,炙甘草6克,怀牛膝10克,当归10克,猪苓10克,升麻3

克。

两方各服3剂后,X光拍片:结石已进入输尿管,位于输尿管末端。自汗渐敛,三日后患者曾感尿道刺痛,尿顿或夹血丝,此系结石进入膀胱时,刺伤血管而来,为求消石,嘱患者自备胡桃仁、香油、红糖各1斤(500克),捣细捣和,共熬成膏,分作4天服完,连服二料后于10月20日、23日两次X光拍片均未见结石而痊愈出院。

上述2个病案,从不同方面肯定了石淋的治法,例一是用清利湿热,排石通淋原则收效的,例二是用补气药、补肾药起到作用的。通过这两案的治疗效果,使我们体会到辨证的重要性,通过患者所表现的临床症状抓住病因病机中邪正虚实的变化,才能机圆法活。

形成本病的“肾虚、膀胱热”这一矛盾,已说明存在正虚邪实情况,邪实是湿热煎结而成的砂石,正虚是肾不足以主二阴。初病多邪实,治疗重点在荡涤湿热砂石方面,“五淋病,皆热结”(陈修圆),“诸淋皆属于热”(楼全善),以及《素问玄机原病式》中提到的冷淋之治,均是针对初期症情的,也是必需忌用补气之药之时,这就是第一个患者所处的情况,此时如用补气之药,自然要“气得补而愈胀”、“热得补而愈盛”,甚至可以“窒塞其间,令人闷绝”;久病则正虚,就不能泥于忌补之说,要根据患者所现的肾虚气虚等不同虚证用药,张景岳说:“淋之初病,则无不由乎热剧……淋久不止,及痛涩皆去而膏液不已,淋则白浊者,此惟中气下陷及命门不固之证也。”这是概括了本病的全面变化而言的,张路玉也提到气虚、劳倦、思虑伤脾等能引起淋病,这种情况就是例二患者的情况,开始只用排石清湿热,就没有加用补气益肾药后的效果好,关键在于通过扶助正气,恢复肾主二阴的功能,增强下焦气化而促进机体

排石消石的作用。

总的来说,两案的辨证,在于区别了病程的前期与后期,区别了邪实与正虚的不同,而据以进行辨别的则是患者的临床体征。

(本文删节论述部分后发表于《北京中医学院学报》1981年第2期。)

中药配合动脉导管结扎治愈巨块型肝癌 1 例

侯×,男,41岁,病历史:0602。

患者有慢性肝炎史18年,1976年急性复发后经常发生腹胀、腹泻。1988年1月因受凉,突然发热38℃左右,伴肝区剧烈刺痛,恶心、呕吐,用解热镇痛药无效。进一步经邢台某医院、石家庄某医院及北京解放军某医院做B超及肝CT检查,确诊为:肝右叶原发性肝癌,巨块型(9×9.7厘米),按1987年国际抗癌联盟(UICC)对肝癌进行TNM分类,属于T₂N₀M₀,按我国1977年全国肝癌防治会议分型为炎症型Ⅰ期。于2月26日行右肝动脉结扎术(HAL),伤口Ⅱ级愈合,于3月17日出院。4月开始坚持气功锻炼。1988年6月1日到北京某医院治疗。同年6月4日邀请会诊。症见:肝区隐痛,大便稀溏,日行4~5次,时有小便频数,食可,眠好。脉滑数,舌苔润,舌下静脉较长。证属:脾不得木疏而湿滞。处方:

党参20克,生芪25克,苍术12克,青、陈皮各10克,半边枝、莲各30克,猪、茯苓各25克,枳壳10克,郁金10克,丹参20克,龙葵30克,炒山药10克,车前子包15克,肉苁蓉7克,佩兰10克,生麦芽20克。5剂。

服后仍腹痛,腹胀,大便溏日2行,纳香,依上方随证加减。至1988年7月检查肝功已正常,胎甲球蛋白阴转,B超:肝右叶强回声团由 6.8×7.0 厘米缩至 6.0×7.0 厘米,腹水减为少量,脾厚4.3厘米。于1988年8月1日出院休养,仍继续依上方随证加减,服至1989年7月21日再次入院复查。7月22日诊查:体重明显增加,肝区疼痛消失,偶有恶心,便溏,日1~2行。舌暗红,苔白略干,证属:肝脾失调,瘀毒内结,继予健脾益气,养肝解毒法。处方:

生芪30克,党参15克,白术15克,茯苓12克,生地15克,当归15克,麦冬12克,五味子6克,竹茹15克,玉竹12克,丹参10克,丹皮15克,龙葵30克,白花蛇舌草30克,枳壳15克,每日1剂。

至1989年8月5日出院时,病人大便溏日1~3行,轻微下坠,便后缓解,下肢酸软,口腔易溃烂,口干苦,尿略黄,饮食好,睡眠佳。脉滑软,舌苔薄少。法主益气化瘀,处方:

生芪30克,党参15克,血竭粉(分吞)2克,龙葵30克,白花蛇舌草30克,半枝莲30克,生苡仁15克,生地15克,丹参20克,猪苓20克,当归10克,水红花子15克,郁金10克,石见穿12克,赤芍15克。10剂。

以后加重活血化瘀用药。至1990年症状全面改善,体重增加,4月4日第三次入院复查,B超:肝右叶呈 3.0×3.3 厘米不均回声团,界限欠清晰,脾厚3.8厘米,腹水消失,仍用原法加减服中药至同月17日出院。带回中药续服至1990年12月3日在当地某医院作肝CT:肝形状大小正常,被膜光滑,肝右叶可见一小低密度灶,CT值47HU,与原片比较为手术遗留所致。为慎重起见,同年12月25日到北京两处部队医院复查B超均未见肝内占位病变。此后继续服用中药至1992年

10月全面体检,病人肝癌无复发。自此恢复全日正常工作。存活已5年零1个月。

讨论:肝癌血供主要来源于肝动脉系统及门脉系统。当肝动脉结扎时,使肝动脉血流减少90%~95%,而正常肝实质仅减少35%,故有可能导致肝癌坏死,缩小。但4周后侧支循环很快建立,使残余的癌组织细胞又获血供而继续生长,因而疗效仅是暂时的。

HAL术后,可以出现肝实质损害,或肝功能衰竭,表现血清转氨酶暂时升高,血清胆红素轻度升高;体温升高,有时达39℃;血糖异常升高,易继发感染,肾功损害及上消化道出血等症,小于或等于30天术后死亡率达3.1%。¹据上海中山医院临床31年统计资料:1958~1977年,HAL术15例生存率1年为20%,3年为0。1978~1989年,HAL术36例,1年生存率为39%,3年为0[†]。据此统计,HAL术后病人死亡率是高的。

我们应用中药治疗HAL术后病人的理论是:肝藏血,主疏泄,喜条达,而脾主运化,为气血生化之源而统血。当机体感受六淫,受毒邪侵袭而内蕴;或饮食不当,损伤脾胃;或情志不遂,使肝郁不疏,则气滞血瘀,肝郁克脾,使脾气不运,聚湿生痰。反过来更加重肝血瘀滞而成恶性循环,渐至形成癥瘕积聚,进而造成脏腑气血功能失调。²尽管肝癌病人可以有各种复杂的临床表现,我们紧抓住“欲治肝,先实脾”的治则,贯穿健脾益气,疏肝解郁,辅以活血化瘀,清热解毒,据具体证进行辨证施治。益气可达健脾祛湿,以四君子汤为基本方加减,可用党参、生芪、太子参、苍白术、猪茯苓、生苡仁、佩兰、陈皮等药。养血即柔肝,以四物汤为基本方加减,还可加丹参、三七、山甲、水红花子、刘寄奴、石见穿等化瘀理血药,使气血相

生,使肿块化消。加清热解毒药龙葵、半枝莲、白花蛇舌草等,清肝脾湿热阻滞,此类药据近代药理研究可起到抗癌作用^①。从而调整了机体的脏腑功能及气血功能,全面增强了机体的免疫功能,提高了抗癌能力^②,打破单纯西医治疗 HAL 术 3 年存活率为零的先例。此患者已存活 5 年零 1 个月,肿块消失 2 年余,恢复工作 2 年。中药配合 HAL 术后治疗,使病人的生命得到了延长。

参 考 文 献

- ① 周信达.不能切除肝癌的外科治疗,见:汤钊猷、杨秉辉主编,原发性肝癌的研究与进展,上海医科大学出版社,1990:225-227.
- ② 郁仁存.中医肿瘤学,北京,科学出版社,1983:22-25.
- ③ 唐辰龙.肝癌中医中药治疗的研究进展,见:汤钊猷、杨秉辉主编,原发性肝癌的研究与进展,上海医科大学出版社,1990:297-300.
- ④ 丁尔辛.中医治疗肝癌的科学基础,见:汤钊猷、杨秉辉主编,原发性肝癌的研究与进展,上海医科大学出版社,1990:302-308.

(本文发表予《北京中医》1993 年第 2 期)

肺癌诊治管见

肺癌为恶性肿瘤疾患中较多见者,据众多国家统计,其死亡率居各种癌症前列,且发病率逐年上升。西医于此病多采用手术治疗,配合放疗、化疗以杀灭肿瘤细胞,其弊在于有同时杀伤人体对抗肿瘤之吞噬细胞等副作用;中医辨证论治之于本病,客观上可起到调节并提高机体免疫功能,从而提高人体对抗、抑制癌细胞的功能,对放、化疗患者,可以通过对脏腑功能的调护而对抗放、化疗的副作用,由此两种作用而达到改善

患者症状、提高生存质量、使生存期延长的目的。

中医文献中无肺癌之称，证之于临床症状，有或咳或不咳，或痰多，或胸痛胀满，或咳痰挟血，甚而有导致脾胃失健而纳呆、泛恶者，有耗及气阴而见阴虚、阳虚或气阴俱虚者，加以X线下可见肺野结块，则其病机大要为病位在肺，由肺而脾或由肺而肾为主要机转；自邪正而言，则犯肺之毒，滞肺之痰，结滞之瘀，俱可视为邪实；肺气之不利，脾运之不健，气血之不达，以及盗伤肾阴、肾阳等俱可视为正虚。邪毒犯肺，始而肺气郁滞，滞久则伤气，化热则伤阴；痰热壅结，往往肺脾同病或肺肾同病，寒化多累脾阳，热化多累肾阴，此又为继肺本病而见之证。就其三脏腑关系析之：脾为生痰之源，肺为贮痰之器，肺癌多以痰邪结聚气血为患，宣肃之道壅，脾不能上输于肺，则津液代谢障碍，水液停滞则聚而生痰成饮，痰愈壅则肺之结聚者愈多；且脾为后天之本，生化之源，脾气失运或虚损，则又可导致肺失禀受而致肺气不足。肾为主水之脏，肺为水之上源，两者相互为用，肺之宣肃及通调水道，有赖于肾之蒸腾气化，肾之气化以出，纳精五脏，亦有赖于肺之肃降下输，若肺失肃降、通调，则肾无所气化藏纳；而肺津不足，则下烁肾阴，所谓“子来救母”，故肺阴虚可损及肾阴，肾阴虚则不能上滋肺阴；而气化之间，肺为气主，肾为气根，若肺气不下，不特水湿之道壅，精津之源亦虚，精无所藏，伤及肾气，精气不足则摄纳无权，气浮、气壅之机现而为喘为满，甚则动作即喘如息奔。

肺癌整个临床过程，大都以痰、热、瘀、虚为病理环节，多见者有下述各候：

痰热壅肺，多见咳嗽痰多，或白或黄而稠，胸膈闷胀或痛，纳呆、便粘，舌红胖，苔白腻或黄腻，脉滑或数。

热毒灼肺，多见干咳痰少，咯吐不爽，痰中带血，胸痞痛，

气短咽干,甚则声哑,心烦,便干,舌红苔黄,脉滑数或弦数。伤及肾阴,则干咳、音哑,日晡所发热,腰膝酸软,骨蒸盗汗,脉细弦,舌红苔少等症可兼见。

气血瘀滞,多见胸闷作痛,或咳或不咳,痰少咯血,口干,低热,舌边、舌下瘀点、瘀络,苔多薄少,舌、唇色黯,脉弦涩或细涩。

脾虚痰阻,多见纳少、纳呆,或有泛恶,神倦乏力,痰白或多或少,便溏,色萎黄,胸闷气短,舌淡、苔白腻,脉软滑或软大。

气阴两虚,多见气短神乏,动作喘息,自汗便溏,腰酸膝软,面色苍白或易潮红,舌淡或嫩,苔薄少或白或润,脉弦细或软细。

临床所见近百例肺癌患者,大多虚实夹杂,早期邪实为主,多见痰热壅盛、毒邪化热及气血瘀滞者,后期毒邪未除而正气渐虚,多挟见气阴两虚、脾虚痰阻或肺肾两虚者,临证侧重照顾正气,尤以运脾为重,但求后天之本不败,能进饮食,则祛邪攻坚、消痰化滞自有可措手处,故常于攻痰清毒化坚中伍入健脾、益气阴之味。兹举例如下。

例1,××,女,68岁,河北省离休干部。

自1990年3月起经常干咳,曾突然咳血而于当地医院拍断层胸片,诊断为右上肺中心型肺癌,合并肺不张及支气管隆突部淋巴结转移,气管镜病理片为:小细胞癌,于1990年8月来京就治,住某医院后会诊。

初诊(1990年10月21日):患者精神尚佳,无咳嗽吐痰,微有头痛头晕,睡眠欠佳,便干溲顺,纳食亦可,舌红苔中白肯,脉滑软。痰滞气滞,以清化为法。处方:

白花蛇舌草30克,夏枯草12克,龙葵30克,土茯苓25

克,车前草 20 克,焦楂曲各 10 克,陈皮 12 克,枳壳 10 克,白英 15 克,前胡 10 克,川贝 10 克,上方 1 周服 6 剂,连服。

二诊(1990 年 11 月 5 日):药后头痛、头晕已除,睡眠亦安,舌苔根腻,脉滑小数,治宗原法。原方去夏枯草,加黄芩 10 克、桑白皮 15 克、瓜蒌 20 克、北沙参 30 克。继服 6 剂。

三诊(1990 年 11 月 12 日):近有胃脘胀满,泛酸、乏力,余情尚佳,舌苔薄白,脉弦,肝横之象;原法参用平肝。处方:

太子参 30 克,白花蛇舌草 30 克,土茯苓 30 克,焦三仙各 10 克,瓜蒌 30 克,桑白皮 10 克,旋复花(包煎)10 克,陈皮 10 克,白英 20 克,川贝 10 克,天花粉 10 克。

患者于服中药期间,同时进行化疗及气功治疗,病情稳定,于同年 12 月底出院,1991 年 5 月又来京复查并住院 1 月余,病情亦稳定。

例 2,××,女,68 岁,×部离休干部。

1984 年因检查心脏拍胸片,发现肺中有阴影,续行多次胸片及 CT 扫描,证明两肺下野有大小不等之致密阴影,以右肺下部靠后为多,诊断肺部转移癌,但未查到原发病灶。患者有高血压、心脏病史,心电图示:右束支传导阻滞;经查医生向患者家属交待,病人已属肺癌晚期,不能手术,不能化疗,因结节太多,亦不能做气管镜检查;当时患者心率仅 40 次/分左右,建议安心脏起搏器,但患者拒绝;痰中带血丝或血块已达半年,就诊于中医研究院广安门医院,服中药配合气功治疗,自觉体力好转,痰血亦得到控制。1990 年 1 月,因外感发热咳嗽痰中又见血丝,经治后热退而痰血时起时止。

初诊于 1990 年 9 月初,当时患者心悸气短,登楼时喘促,痰中带血而咳嗽尚不频繁,纳食不馨而少于平时;脉沉微、数,舌红苔薄少,一派心肺气阴两虚之象。处方:

西洋参(另煎服)6克,生地25克,麦冬20克,北沙参30克,当归12克,茅根30克,五味子7克,仙鹤草30克,山萸肉12克,三七粉(分吞)3克。5剂,水煎服,日1剂。

患者常服西黄丸,嘱仍继用而改为日服1瓶。

1990年12月再诊,告药后血痰即止,因久病厌药,煎药服完后即日服西洋参及西黄丸,近于305医院复查心脏为病窦综合征,心率快慢不等。查:气短,略有作咳,脉沉缓、涩;息四至,舌苔薄白、根部略厚而涩;仍属气阴虚滞,心肺同病。处方:

党参15克,太子参30克,麦冬20克,五味子6克,枳实10克,山萸肉10克,茯苓20克,仙鹤草30克,白花蛇舌草30克,当归15克,生地25克,石菖蒲8克,川芎8克。10剂,水煎服,仍另服西洋参及西黄丸。

1991年1月再诊:心慌气短易汗等情或缓或作,纳、便尚顺,舌苔根仍略厚,脉沉、滑、缓;仍就原法益气阴而清肺。处方:

西洋参(另煎服)6克,党参20克,麦冬25克,五味子7克,枳壳12克,山萸肉15克,川芎10克,当归15克,茯苓20克,生地30克,石见穿15克,白花蛇舌草30克,石菖蒲8克,龙葵35克。12剂,水煎服。

患者此后断续服煎药,每于病情略波动或受外感或纳呆时来诊,平时则服西洋参及西黄丸,于不能作手术、化疗及不安心脏起搏器情况下,单用中药,病情一直稳定,精神体力逐渐好转,1992、1993年中曾数次出京旅游,体重增加,形体渐充,1993年6月就诊时,告:经肺部复查,病灶有缩小,最大者减缩近1厘米。近日仍在断续就诊中,药味变化总不离生脉原议、或伍运脾、或伍清肺则视病情进退。自发病至今,已达10

年,且生存质量达常人水平。

肺癌因古无此名称而中医学中遂亦无成法可依,但以辨证论治为临床治疗要务;然痰滞之辨,不在于咳嗽吐痰之有无,而在于舌苔之厚薄腻滑,因肺癌患者之咳嗽非始终必见症,如余亲戚、熟人中有2例,1例确诊服药已2年,1例亦1年余,均无咳嗽吐痰,前者并胸痞亦无,起居如常人,后者但略有胸闷膈胀;又1977年治一患者,确诊而无何症状,但有神倦,经治一年余至余调动而止,始终无咳嗽吐痰。痰热及热毒之辨,白有黄苔、红舌、面赤、胸痞胀痛等症,辨认较易。脾运之强弱,辨之于纳食之多少,大便之溏否,凡纳少泛恶、便溏或日二行者,均为脾运之弱,于各兼挟症中当重点留意,所谓有一分胃气便有一分生机也。近时此病之住院者,均事输液,故气阴两虚者舌色未必有大变,亦难必见咽干、易汗等象,但见神倦、色萎、舌淡少苔、脉软者便是。本病血瘀之证,大逊于肝癌或胃癌,多见气壅、痰滞、痰热及气阴两虚证,脾弱以阳虚为常见,耗肾以阴虚多于肾阳不足,均可以常法辨之。

近时免疫之说昌,中药中经实验有提高免疫功能而可抗癌之品比比,尤以补益药品为最,诸如滋阴、补气、壮阳之品均具此作用,但总以辨明脏腑虚实而后用之为宜,否则脾虚而用二地、肺气壅滞而用百合、阴虚而用过用黄芪则未免偏颇;具有抑制癌细胞、杀灭癌细胞作用之品,或则偏于寒凉,或则偏于克伐,亦均需量体质而用,过则伤正。在医生之审慎而外,患者之精神因素尤为重要,本病之疗效,虽较前时为进步,然尚难于十全,必需有患者之信任、治愈之信心,以及顽强之毅力配合始可延长存活时间,其间尤以情绪愉快,心情乐观,有助于自身免疫功能之提高。

(本文由贾桂琴同志整理后发表于全国中医第四届疑难病学术研讨会,收入前作了病案删减和论述补充。)

越鞠丸义解

越鞠丸之所以名“越鞠”,在于解郁。所谓“越”,发越也;所谓“鞠”,弯曲也;用以况阳运之不伸,亦即所以况郁也,发越阳运之不伸,而使舒达,所以名“越鞠”。夫六郁之来,未有不由于阳运之不伸者,阳运舒达,湿、食、痰、火、血无由以为郁积,阳运者气之用也,郁之始于气,于以可见矣。

越婢义解

曾见报载谓“越婢汤”出自古越国婢女,是未可以为然也。夫“越婢汤”治风水之身肿、恶风、自汗、脉浮、口渴而身无大热者;身肿为水气,脉浮为病在表,恶风、自汗为表虚,口渴为里热,身无大热为自汗而然,其所以若然,为气之不化湿,气者阳气也,不化湿而郁于内,故里热而口渴,郁于内而不卫外,故表虚而自汗,其脉浮,病尚在表而自汗不足以言减其水,此时如得阳气自里出表,则邪可由表而解,夫脾主水湿,主肌肉,此阳气之郁者,是脾之阳郁也,故以石膏清里热以解阳之内郁,麻黄领阳气外达而除表之水湿,以姜、甘、枣助运脾气,是标本兼顾、虚实互治之方,而其关捩则在于阳气也;就此理言之,则“越”者发越脾之阳气也,婢者阳气之卑弱也,故古文“卑”、“婢”可通,又:“婢”于义为女之卑者也,古人以脾为主者,土固低卑者也,《白虎通德论》曰:“卑者亲事”,是犹婢之亲事也,故“越婢”者,设发越卑微之脾阳也。方出于越国婢女之说,不仅

仲景无此例，亦无可征于古者，或曰越国之婢善治水故名，然则苏婢、广婢不善治水矣？越男亦不善治水矣？而必曰越、必曰婢，有是理乎！

治痢用血药

治痢有“调气行血”之箴，余初时于湿热两盛之赤白痢怯用血分药，第以清化湿热为务，于气分药虽所方必用，然亦第为止痛而设，未解为后重计也。忆执业之第三年夏末初秋间，远戚陆某患痢，陆业木工，年、体方壮盛，素常喜饮，痢日夜二三十行，里急后重，下赤白如冻，壮热纳呆，脉滑数大，舌苔黄腻满布于舌，舌质红绛，一派湿热薰迫之象，余投芍药汤去当归、桂、大黄，加枳壳，一剂不效，二、三剂益入大黄亦不效，痢次不减，体力渐惫，余以戚故，逐日一诊，以为大队清热化湿之治，药证相符而不效者何，四诊前就商前辈冯祖璜处，冯氏悉症情后问投何方，曰芍药汤，冯良久复问曰，予当归否？曰：恐血药助湿热，未敢，曰：试用之或可效，是日遂于原方中益入当归三钱（9克），二剂，嘱日夜四次服尽，翌日午后余自往诊询，陆告：自午夜以来，痢次，窘迫已减十之六，今午亦已稍进稀食，1周来无此快也，诊得身热、脉数、苔黄腻等况均减，遂复略增醒胃之品，投方二剂而愈。于以知“调气”之必合“行血”也；后阅四明名医裘氏笔记，治痢之久不愈者有用当归、芍药各一两（30克）之方，余试之亦验，于以知古训之不可不究，要在用之当耳。当日乡间之习，延医治病二剂不效即易医，设陆氏于余非戚故，当无三诊四诊之可言，而古训之理亦无可体矣，故余于此三致意焉，且前辈提携尤有不可忘者，惜冯氏于1970年以忧患殁于胃癌，高风不可再接矣。

治痢用涩药一得

痢之初起而挟表证，可以用表法，如“桂枝”、“葛根”、“防风通圣”之属，古人于此往往禁用兜涩，诚然矣，其于湿热两盛而致之身热亦禁兜涩则未必尽然。60年代初，北京市第六医院化验室曾用石榴皮、五味子作对痢疾杆菌滴定实验，其杀灭之功甚著，且不限于痢菌，余于是稍稍用之于痢之非表证者，虽壮热亦有效，1970年以还，又扩用于慢性肠炎，收效均佳，第邪盛者常伍用于苦寒药中，病轻、病久者则反以苦寒为佐耳，迨一、二诊后，其病久者则合健脾及益肾为用矣。

黄连阿胶汤治肠溃疡

“文革”前，余所在医院小儿科一勤杂人员患久痢，纯下白冻如涕，已之四年，形色少华，经直肠镜检查得知直肠有溃疡，收住内科，服灭菌及B族维生素等西药，一月不少衰，会诊时查得脉尚大而中不足，体尚丰而面皤白，苔白而润，中厚边薄，纳饮尚可，便前略里急后重，痢次日三四作，思“香连”所素用而不效，且重用则碍尚可支持之胃气，血药固可针对面色少华之血弱，而碍于纯下白冻之湿重，投以健脾化湿剂，三日不效，忽思得仲师“黄连阿胶鸡子黄汤”，遂益入术、芍，连投10余剂而白冻除，便复见粪条。当时嘱白加鸡子一枚，卵黄入煎，鸡子白则滤出另作菜服。记此以为久痢疑难一得。

狗肉治疟

疟之治，非药亦可。据何炳文同志言，长征中患疟无药，以狗肉食之甚效，其故盖体虚也，得狗肉之养，正气暴充而疟邪为制，此与“何人饮”之用“首乌”义同。又：乡间旧传疟可逃，临发前狂奔之，或竟不作，是亦使周身气血迅速循环，红、白细胞激增而改变疟虫环境而然，要之在于正气之充否为基础，故有效、有无效；此与“桃枝”、“蜘蛛”治疟之意亦有同处，《内经》所谓“移精变气”耳，变为机契，气为基础，有气而又能变则效，能变而气弱、或有气弱不能变则不效矣；近日之气功治疗犹似之，盖心理与情志之可以影响于气血，及夫血象之变化，思维之与物质互为变化者也。古之“祝由”，岂一无所稽哉，特人事日烦，耗神多思亦日繁，神不足以主思，思不足以变气，故竟然不可以效言矣。

南北用药异同

余执业以来，自南而北，北而南复北者三，往复于吴燕间，深感于外感病之治未可以一概同药，盖南北之气候不同，物产、食嗜不同，居处之习异而人之腠理亦有疏密，北地气寒，人之腠理密于南人，外邪袭后，恶寒无汗之势重而期长，于冬令尤然，若以南人之治以辛凉从事，效不桴鼓，必也参用辛温始可，此为余 1954、1956 年间所得成败之训也。余产于温病流行之地，温病学发皇之区，治热病悉宗温病法刻期取效，1954 年北来之初，沿此法治外感，往往三、四剂不得汗解，于以溯寒温之辨，下逮河间辛温合苦寒之法而应手矣，于以知《素问·异

法方宜论》区五方分治之训不可忽而良有以也，河间原系北产，为一代宗匠，创温病学先河于“主火”之间，盖亦发原乎《伤寒论》者，私崇其“防风通圣”、“表里双解”等法，犹“大青龙”、“葛根”、“葛根芩连”等方义推而扩之，余固曾仿之以麻黄入“银翘”，治表寒不解，内热已盛而血压高之患者，竟得一服而解“银翘”大剂三服不解之症；浮想所及，则张介宾二百里外客气即异之说，可知其所指矣。

“异法方宜”新证

地域之异，上者在寒、温、燥、湿，下者在物产、水、土之不同，其于人则影响于嗜欲习俗，故《内经》有“异法方宜”之论述，昭医以悉其因时、因地、因人而治不同之故也，余以所见、所遇较之，是固不可以违也，六气之因地而偏盛者无庸论矣，其于嗜食之偏习而及于病者，记数则于下：

自江以上，江西、湖南、四川等地嗜辣成习，求其所自，盖地处盛于雾雨，湿邪困人，非辣不足以开驱，固非然不可者，然嗜之甚则伤人胃肠，故凡此之地，痔疾之患比然，是肠道缘辣而充血故也，亦由是而此处为痔医者之经验亦较它处为愈，解放后京中首聘人中医院之医痔者即川人，迄今自“枯痔”、“挂线”，而至“消痔灵”等效用达国际者，无非此一线之延展进步而来；所以然者，多习熟见故也。痔之来，固非独辛辣过甚一端，其“饮食自倍，肠胃乃伤”及饱食负重而致血注于下者，亦其因也，故他处非无是疾，第较少耳。

嗜辛辣椒、酒之弊，不独为痔，亦伤胃，故凡嗜饮之乡，往往病脘痛，临床可见者如表浅性胃炎、慢性胃炎，甚或糜烂者，溃疡者，莫不与酒辣有关；此类病因，亦有暴食、多食生冷、硬

食之故，而酒辣、肥油之过摄为多见也，尤以青年之患此者，大半有酗酒史。

嗜酒而量巨者，可致麻醉阈高。余在东峰，县商业局领导，余友也，患阑尾炎、手术，始而局麻不应，再而腰麻不应，终以全麻且倍麻醉药量始得竟术，主是者甚惶惑，究之，始知固能顿饮烧刀二斤之巨酒量也，以其素不知此情，未能一次倍量得麻醉，三易其法，其麻醉药量不啻常人之三倍，职是，术后竟致肠麻痹，余以针刺、煎药并进，针入而肠鸣可得矢气，针去1小时复胀，以不能一日十数次针，故改而为日针2次，余以艾灸代，日4次，药则益气、理气并方，益多于疏，黄芪用至2两(60克)一剂，而以养血之归、芍为佐，盖以手术之故也，如此者1周始复。

天气之燥者，易致鼻炎，润之者少故也；嗅含毒之气体多者，易患咽炎；是均证之于人矣。其事喷洒杀虫农药而不谨于防护者，必病咽矣，非独可中毒之毙人，盖亦中毒之轻者也，是则易地言然矣。

灵芝五色变化为其生化过程

余在东峰之初，数入鼋渚后山采药，甚或宿于山村，尝两次得野生灵芝，得以知一芝可变五色，初得一芝于嵒嶂峰下栢树朽根，赤泽如漆，再次于漆塘山北坡，一区得之十余株，五色皆俱，均生于伐株后欲朽之松根，逐一验之，盖初生之芝色黄，渐长渐赤，赤者可如漆之泽，再而色深泽老，而紫而黑，凡是三色者，芝体均坚实，有一株如云重叠欲起，上磐赤黑而下层色黄，其柄亦赤，赤黑者光泽如漆，黄者则光泽不足，芝色过此渐青，终而白，其色青时泽亦退，迨色白则朽不禁触，触则碎散为

块粉矣。余读《本草纲目》时见记五色之芝，以为奇，迄采集审察，而后知所谓五色者，芝之生长过程变化也，非真芝之分五色也，每当芝之赤、黑有泽时为其盛时，药用亦当以此期为功，青则衰而白向灭矣。明代太山道士年进芝数千百本于嘉靖者，当亦此类，不过分期为类而进以神之耳。其有散生于杨、桑、柏之色白者，虽同属真菌之属，然无光泽，不得以灵芝列之，灵芝得其适，则成片区以生，所以可有千百本之集，然而以野生之集，究较近时人培为难也。

三七可行血

三七可止血，诚然，跌、挫、金疮之初患时，以其根或叶捣烂外敷，效胜于内服，顾鲜者难得，得其根之下粉掺敷亦佳；若以内服言，则不宜执止血之一见，本草言三七性温、味甘苦，能止血行血，不独以止血为言，盖其止血之用长于因血瘀而致之出血，故跌、挫、击、仆者以“金不换”名之，是行瘀之用明矣，是正本草行血之谓也；曾于 1970 年春遇一妇暴崩，示余前医方，于止涩中入三七三钱（9 克），组方之理有繆，而余计其不效，询之果三剂而血量不衰也，所以然者，三七量过，此妇崩已 5 日，无瘀可言也，为去三七，重用地黄而愈；中医研究院之《中药学简编》三七条禁忌中，以“血虚无瘀者慎用”为言，得之矣。近时动物实验证实“三七根块流浸膏，能缩短家兔血液凝固时间”，是正三七止血之用，“三七皂甙给猴等动物静注，有溶血作用”，是正三七化瘀之用，亦“行血”之义也。甚矣药性之不可不格者如此，忆故友艾润之戒余之言曰：“知药之利，尤当知药之害”，不禁追念逝者。

地黄膩膈种种

生、熟地黄膩膈，故胃呆者忌用，湿滯者忌用，前人为纠此弊，常以砂仁拌地黄为胃留地，伍苍术之“苍术地黄汤”为脾留地，余于1963年随杨济生师在友谊医院时，论及此，杨师用生、熟地量极重，为言地黄之用，在3~5钱(9~15克)者固然膩膈，迨及8~10钱(24~30克)，则直过中道至下焦，无可留膈而致膩者矣，故于苔之膩或黄膩者，但阴虚亦用。余试之于苔膩而抽心者，确亦无碍于纳食，然人或有于初服时便溏而次多者，熟虑而得其故，盖脾胃之摄纳有度，过其量则自胃移于肠者亦迅，设肠亦不能摄化，则如伤食之便泄而排之矣，迨其得便，则因胃肠互为虚实之机，胃之容复得迅以下移，而无复致膩于中脘也，其所以致膩者，缘用量适当欲化不化，欲移而不能移之时，胃气壅滯所致也。由此而证之于丹参、首乌之属，用量高时莫不皆有便泄者，同此机也。然而便之泄，二、三日后可自停，且不腹痛，是则因人之耐受性提高故也，所以不腹痛者，原非有形不化之品，无可涩迟难下，故但鸣响耳矣；故余于用此类药之量高时，均囑患者毋惧初二、三日之便泄。余之用是药，君之则两(30克)为度，臣之则5~8钱(15~24克)，未尝见弊，然用之有则，必见阴伤、阴虚征为的，验之舌，光红、光绛、抽心或苔之剥于根、中毒等，其伤于胃者佐沙参、石斛，涉乎肺者佐元参、麦冬，挟湿之重于胃者佐砂、蔻，重于脾者佐苍术、茯苓，重于下焦者佐分利，涉乎肝胆，则仿“龙胆泻肝”成法而易地为君；其辨乎经、脏者在于证，辨乎轻、重者在于苔之厚、薄、粘、膩，迨乎舌光而滑润欠华，是湿固然而阳不足化，非阴虚疇矣，为地黄之所当忌或慎用者也。

药品之效因产地异

药求道地，盖水土之不同而药效亦异故也。记北京市药材公司于大跃进时，引淮熟地种三十亩于昌平山坡，一年长甚茂，二年挖视大儿如卵，计三年后当可用矣，时京畿方缺此药，得此讯甚欣慰，詎知三年后挖而切之，晒干仅如薄纸片，无以为熟地矣；旧《密云县志》载，淮庆地黄苗自冀东移去，有予人以利之感，然数千年来竟不闻一密人业地黄者，得此事可以明其所以然矣，药既若是，其效用亦可想见。又“文革”后各地兴引植，以解中药不敷之求，胜于无固为其可取之理，然药效一端，尚宜有以克服，1978年虞山种黄芪，量甚丰，然计效不及口芪十之二三，是均因水土之不同故也。

《本经》各药下均有产地，自均为汉时地名计，知《本经》断非汉以前书，然亦非必此地有此药，余处亦有产者也，第异在效用耳，如余乡苏南，即有紫苏、藿香、薄荷、桔梗、沙参、泽兰、川芎、黄芪、麦冬等200余种，其中木本类者似尚可通用，草本类则惟紫苏、薄荷、藿香可销于全国而为名药，余则鲜者尚可用，干则效减矣，故当地中药均鲜用或晒干即用为宜，效亦可计也；当今药物不敷，药物之引种为势之所必然，难于强求道地，第种者宜于水土间求其所宜，如土壤成分之类之配合等，其在医者，则惟量情配药，或指示患者自采，或医者自采，求投剂之得效者庶几！

药性有新效

药籍之记药性、药效，间有不尽、不然者，条述所亲知者于

后。

葶苈子素以泻肺利水为用，禁用于虚人，然近时化验，竟有强心作用，乡前辈孙硯乎记之于《诊余集》，用量可至 5 钱（15 克）、8 钱（24 克），见其效未见其碍也，不独孙氏如是，余亦常以治喘而不禁用虚者也。

蒺藜，锡地称灰菜，野生之可食者，《本草纲目》云其可解毒，然余于京见其中毒者矣，作病时日照处皮色紫黑，西医称之为“日晒病”，为灰菜过敏所致，治后紫褪皮脱而痒，均费 10 余日，十数例均然。他如水菖蒲之不特行气止痛，竟于肠炎、痢疾有好效，金钱草之可治湿热黄疸等，余于本集已有记矣。

60 年代初会诊一糖尿病患者于内科病房，尿糖检查极不稳定，或竟二日连检为阴转，而第三日则又见（卅）或（卅），其先因患者为十数年之久病者，且体力不佳，故于中医会诊之同时，并会诊于协和医院，患者尚可行动自如，故去协和时均日行就诊于门诊，而协和之尿检均无尿糖，此后第二日检尿亦无糖，怪之甚，因询其就诊前有所服食否，曰：为求能午前返病房，去协和时均晨起空腹即乘车，下车后腹饥，然不敢多进米、面等制品，于院旁小店中进豆浆一碗，余则仅食滴杏仁一盘约 2 两许，每次均然，于是疑杏仁或有关，嘱量食杏仁二次以核之，竟然当日近午之尿检均能无糖，是则杏仁非竟化痰、润肺、止咳之用矣，于糖尿亦有其用也。

“雪上一枝蒿”中毒例

1971 年在东峰医院，抢救一误服草药中毒者，药为干根，淡黑色，粗才不足一公分之三（约 1.3 厘米），家属云来自云南，可治关节痛，以 2 寸（约 6.7 厘米）长者浸白酒 4 两（200

克)服之,初不虞有他,患者年方壮,能饮,服3两(150克)而竟昏矣;入院时心率二联律、三联律,紊乱殊甚,内科以不知何药而邀余,然余亦不识为何药,第以强心解毒剂治之,进生脉散加生地、生甘草、银花,重用麦、地、草,2周后心率始复,于3年前有一农服此药3寸(10厘米)之浸酒4两(200克)而死。后于门诊询一云南工作之患者,云此名“雪上一枝蒿”,治关节痛有速效,然毒甚,3寸(10厘米)之根即不可救;嗣后全国中草药汇而为《全国中草药汇编》,记有关此药之鉴定为作用如乌头,毒亦如乌头碱,然则其效盖麻醉性之止痛,解其毒者亦可仿之矣。

“白常山”无截疟之功

“白常山”不知为何物,或以为常山之枝苗,即蜀漆,确否不可知,无锡地区以之充常山,作正式饮片,供应药肆,色白如桑枝斜切片,生药形态亦如桑枝条,然以之截疟则竟无功可言。1947年治高圩村一日日疟症,用截疟七宝加减,一方二剂,常时均克奏肤功,此患者二日后又来复诊,云初剂服后,翌日疟即未作,而二剂之翌日则又作矣,同一方而有效有无效,病者与余均疑虑不得其解,返市告之药肆主人,云:此或有故,患者撮药时适“鸡骨常山”不足,仅一剂,另剂用白常山,余遂恍然悉其故,问今日有鸡骨常山否?曰:昨已来,遂复为患者处二剂而愈。是亦伪劣之类也,当时风气群情,均不作伪药论,非若今之有明文也,近日此风复起,虽抽查频行,而于品种之缺短系于货源,难以为力,业医者其为巧妇乎。

煎药宜讲求

药之用，约言之唯气、味两者，气清而味重，煎煮之时，气随汽腾而味留于液；举凡发汗、清热、化湿、止痛等之求效于气之用者，无一不需留气不使蒸发而后可，设气随汽散，则效且半或竟无效矣。按之近时药物中可挥发物质作用之理，古今之说固大有可通之处，证之临床效果亦灼然可见，例证如下：

1964年北京第六医院中医病房收治肝炎，某部干部患湿热黄疸，时临床总结知可于12日内消黄疸症状，而此患者服药12日无寸进，检方核证相符，不得其解，诊毕返门诊，于院中树根旁见药渣中有干燥茵陈，检之就询于煎药室，则恰为某者，盖煎时不加锅盖，茵陈浮于上，煎犹不煎也，因严嘱加盖煎煮，并日日查视，5日而该患者黄疸退矣。

1967年秋收时，余在乡，邻村钱家桥一妇胃痛，处方平肝理气药3剂，2日后，余适应友人邀至其村，遇诸村西桥头，妇方打场扬谷，询其服药有效否，曰：已服2剂无效，痛仍如前，详问煎药情景，则不盖而煮者，因嘱煎最后1剂时，需盖严，煮一刻钟，不得泄气，今晚、明晨分服头、二煎，若无效，余明日午后始离村，可来复诊，迨翌日余离村时，复遇之于桥头，询之，曰痛已蠲，因嘱再服原方3剂。

1982年长鼓楼医院时，病房袁晓宁医师治一泌感发热，3剂热不退，时病房有规定：非抢救患者，必先用中药，5日不效始可加用西药，袁时随余门诊，因邀余会诊，2剂亦不效，袁惶急，余查证与药符，忆及中药煎煮之弊，嘱袁亲为如法煎药2剂，方仍其旧，连夜服三煎，翌晨未热，午后亦未再作。

上述仅就煎药必须加盖而言，京地风气，自煎者每煎均达

三刻钟至一小时左右，以为煮久则效著，而先下之味，仅先煎10分钟，固不独不加盖也，此种煎法，亦为求效之谬，盖轻清之味，久煎则挥发殆尽，先下之药，多金石贝骨难溶之属，不煎达半小时以上，溶者少而效自减矣。至有以一煎分代头、二煎，得液不足则加开水以足之，得液有余则倾弃，及夫连屉蒸而不煎，不同之病而药气互串等，均属弊端，其有损于治效则一也。故医者为治，不独需求之于理法方药之切符于病证，药之煎煮调剂，尤需讲求而不容有忽，盖调剂煎煮，犹药厂之制剂，其可以草根树皮而轻心哉，否则医则徒劳心，病者徒耗费，甚或贻误病机，医患两不达利矣，古之医者有亲视药之举，良有以也，忆初业时邻有短工傭，患外感发热甚，余诊后亲为煎之如法，一剂得解，今之医者既不能为之亲视，委之旁人，或知有不足，或竟然渎职，其能不谆谆于此哉。

中药有过敏

古籍无中药过敏之说，60年代以来，因大量研究中药及中医之进入医院，审视密切而渐有所闻，且或有极严重之症状出现者。1962年春夏之交，北京市第六医院内科收治十数名“日光性紫癜”，均由余会诊，此症于人体暴露之可经日照部分，均紫红作肿而痒，其为衣遮蔽处则肤如常人，界划截然，即如额间帽沿所庇之区，亦紫白攸别，症之轻者则惟变色作肿，痒木不适，重则溃破而水液浸淫，且全身发热。询病起之前，悉有采食灰菜史，或早食而暮病，或昨日而今发，是则灰菜之过敏明矣，因或清热、或化湿，总参解毒之品为治而愈；按灰菜即药籍所记之“蒴藋”，藜藿之属，人之素所采食者，《本草纲目》载其有解毒之功，而竟致疾，病者或告曰：叶背脉紫、茎亦紫者

多致此病，茎脉青白如叶面者则食之安然；是则品种小有异也，且《本草纲目》载食用之法，须经灰水淘煮、滤清后始可再加佐料煮食，则服法亦有讲求也。

又，1972年治无锡县人民银行周姓职员，溃疡病且兼不寐，就诊时语余曰：“余忌用当归，药中涉此则风疹立起，然可自愈、不为害”，余初不信，曰小试亦可，以实其信，因处方外另予当归3钱（9克），入第一剂第二煎同煎服，药后来示，果疹隐隐起矣；此患者之信余而亦欲余信故也，医患间若此固非易易可得者。

记此篇时，适于北京第六医院中西医结合病房会诊一衄血患者，血小板仅 $20\sim40\times10^9/\text{升}$ 间已4年，自诉服阿胶则衄甚，曾于中医研究院、市中医院等处服药时见此象，余会诊时衄初止，嗣后于1986年春节前试服阿胶，诚然衄复作。

于以见中药之有过敏信然也，第曩昔未倡此识耳；夫物之于人、人之于物，固未必尽然一例，人之个体有差异，物之品类有不齐、制食有规则，医者安可不审乎其间哉，然而以养血之当归而起瘾疹，以止衄之阿胶而致衄，则非医患二者之所亲历不得知矣。

草药有捷效

草药单方，散于民间，是盖习面知之者，实为汤液之起源，医药之肇始，其间或累代相传，或互为传告，不著于文而著于言，久而讹误遗忘，或实有效，或有浪说，稽之《本草纲目》及《本草纲目拾遗》等籍，收入者亦比比。而所以铺店不备者，因草药之效具于鲜而失于干，具于量大而失于量小，及夫贵远贱近等均为其因。自70年代为备战计，屡兴就地取药号召，遂而

举国皆动，或刊为手册，余返锡之后，参与入山采集及临床使用，药记其临床效捷并兼及素所习知者，条列于后，然准之药有因地而异效之情，是固仅以苏南地域为准者也。

1967年夏秋间，农友马阿宜患痢，贫不能治药，余嘱以“鲜马齿苋”为菜或打汁服，日尽两大盘，2日而愈。

1971年夏，在东峰医院，与陆万仁医师，采“地锦”、“铁苋”、“马齿苋”，晒干各1两（30克）为1剂，遇有痢者，发一包，愈者比比，所采不厌给，往往中断不继。

1972年暑假，安镇团结中学师生采“水菖蒲根”（即蒲黄之根），晒干研末，糊小丸如桐子大，治肠炎、痢疾，日服3次，每次10克，效捷往往2日即愈；学校师生俱从事，形成小工厂，延续2年，因限于此药经霉变则无纤效，无贮藏之备而停事。

1972年以还，安镇人民医院王伯华医师因民间用“垂盆草”（一名鼠牙半枝莲）打汁服可降转氨酶，因就胶山地30亩种植，制为垂盆草糖浆，发其中各医院为降酶之新药，观察中发现成批有效或成批无效，求其故，盖需随割随制，设割后堆集室隅一夜，则因蒸热故，虽草色仅变淡而制后竟无效矣。此药迄今尚用，而伯华前辈仙逝有年矣。

余14岁时，学医中因暑假休暇，时复耘方殷，某日，堂伯父福根饭后感咽塞痛，及申初已不能汤饮；距王氏喉科处计途30里，且抬送乏人，伯母弟妹俱惶惶然，急切间忆及家藏单方中“野蔷薇根”（乡中称谓“刺棘根”）可治咽肿痛，遂挖一根约3两（90克）洗净煎浓汁一碗，口呷缓缓渗入喉间，傍昏时尽一盞，咽稍可咽，因复煎一大碗服，翌量往探愈否，则已下田耘矣。按此药之治，载《本草纲目》“营实”条注中，营实即野蔷薇子也，茎叶俱如蔷薇而矮，茎多刺且锐，夏初开花，白色四瓣，中有黄蕊，甚香馥，结子如梧桐子大，秋后渐老成红色，攒簇如

珊瑚珠，乡人于冬时以利剪裁其条为薪，不以为药也。此后余常用以治急性咽喉炎，均收捷效，然均嘱患者新挖煎服者，入京而还，遂难求矣。

“积雪草”生溪畔近水处，蔓延如藤，叶如钱而裂其一侧，两两对生，凌冬尚青碧，故名积雪，亦有名之为金钱草者，盖其清热利湿之效同也，两者较之，此草之叶大于小金钱草（一名打破铜钱草）十数倍，无光泽而有短毛，叶边裂亦不若小金钱草明显，余以此草治肝炎初起之湿热盛而转氨酶高者有效，是为乡村经济计，咫尺间可自采而药肆无售也。记同村巫凤林患肝炎，时余在东峰，往返百余华里来就诊；某日余返里，又来复诊，送渠之屋后小溪，见是草，因嘱取打汁或煎服，日用鲜草 4 两（120 克）至 1 斤（500 克），毋数日一至东峰，计服 28 日而肝功复常矣。此草不甚苦，逊三黄之久服可伤胃者，然脾胃虚而飧泄者，总当留意斟酌。

“地榆”治淋巴结核，地榆不拘量、新挖者佳，黄酒浸一周至半月，量饮酒量饮，日 3 次。余用治县中某干部，后右发际一核如指大，可按之左右移动，已半年，服此酒 2 月而消。第服此酒时需禁食鸡。

垂柳条煎汤服，日 4 两（120 克），柳条需梢端一二尺者（约 0.33~0.67 米），治肝炎转氨酶有效，此得之昆山人民医院袁吉人医师，彼用治肝炎流行时之收住病房患者，计百余例，有效率在 80% 左右，余用之于门诊，计效约需 30 日。

“银杏叶”，菜籽油浸一月，乡间用治疔疮之久不愈合者，70 年代初，县麻疯病院用以治麻疯溃疡，疮面用“九一四”膏，外覆此叶，或单以此叶覆，纱布包扎之，日一换药，效胜它药，愈合者甚多。

“桃花”、“桃叶”，可缓泻。师叔陈继高，无锡市二院中医

师，在乡时曾患痔疮，便不得干，干则挟血而痛甚，不欲用硝、黄之属，桃花开时，则日以桃花七八朵去蒂汤饮一二盏，无花时则以桃叶八九片代之，可日得软便。

“菊叶三七”、“景天三七”之止血，外伤则用鲜草捣烂外敷，虽血肿亦可用，努伤、击伤而吐、衄者捣汁内服，煎饮效稍逊。

以上均所亲历亲知者，它如“凤尾草”之治妇科湿热带下，男妇尿路结石，亦屡有效；“辣蓼”、“白头翁”之治痢，亦有确效，是均药籍有记载而乡间所习用者也。兹条记在东坪时所收集当地各卫生机构所用草药方于下：

1. 喘咳汤。治顿咳非外感性者，仅可作暂时性控制。

风茄花 1.5 克 杜苏子 10 克 生甘草 3 克。

上方为成人用量，一次煎服。

2. 上感马兰饮。治上感之轻症，微有发热咳嗽咽痛等。

鲜马兰 30 克(干草用 25 克)，煎服。打汁佳。

此方服后可能咽喉有刺激感，此为药性，可以继服。

3. 急性咽喉炎方。

鲜矛莓 60 克，或野蔷薇鲜根 60 克。煎服。

4. 天马汤。治外感引起之急性扁桃体炎。

天名精 30 克 马兰 30 克。煎服。

5. 牛膝煎。治非外感性急性扁桃体炎。

土牛膝 20 克 煎服。孕妇禁用本方。野蔷薇根效亦佳。

6. 腮肿 1 号方。

板蓝根 15 克 紫地丁 15 克 杨树根须(需河边垂于水际之红色根须)30~60 克。煎服。

7. 腮肿 2 号方。

马兰 15 克 杨树根须 30~60 克。煎服。

8. 腮肿外敷散。

鲜板蓝根 60 克,打烂,连渣敷患处,外用纱布固定,干则更换新药。

9. 退黄汤。治急性肝炎黄疸。

茵陈 30 克 生山栀 10 克 板蓝根 15 克 积雪草 30 克 车前草 15 克。煎服,日 1 剂。

10. 胃痛粉。治胃神经痛。

一枝香(一名徐长卿),打粉,每服 1~1.5 克,一日 3 次,温水送下。

11. 助胃散。治消化不良,食欲不振。

生鸡内金(洗净) 生野糖球(即山楂之野生山坡之极小者),等份,共打成粉,成人每服 10 克,一日 2 次,小儿按年龄减量。

12. 止泻粉。治消化不良性腹泻。

助胃散加炒车前子粉、炒扁豆粉,比例量为助胃散一倍。小儿每次 10 克,日 3 次;成人倍量服。

13. 治痢汤。兼治肠炎。

马齿苋 60 克 铁苋(即野苋之有刺者)30 克。水煎服,1 日 1 剂。

14. 胆蛔汤(亦称甜酸苦辣汤)。治胆道蛔虫。

乌梅 30 克 川椒 9 克 甘草 6 克 胡黄连 6 克。水煎服。日 1 剂。

15. 利胆散。治胆囊胆管结石。

明矾 30 克 郁金 60 克 鱼脑石 60 克 芒硝 30 克(用元明粉亦可)。

上药同研细末,每日 2 次,每次 3 克,温开水送服。药

末需研至过 100 目筛。

16. 溃疡粉。治胃及十二指肠溃疡。

蚌壳 30 克(火上煨) 乌鲗骨 30 克(漂淡) 生甘草 30 克 延胡索 30 克。

上药同研成细末,每日 3 次,每次服 3~6 克,温开水送服。药末需过 100 目筛,如乡间不具条件,以研至两指撮药磨擦时无颗粒感为度。

17. 溃疡粉 2 号。治溃疡病出血。

蚌壳 30 克(火上煨) 乌鲗骨 30 克(漂淡) 生甘草 30 克 生地榆 30 克(去粗皮) 白芨 20 克。

上药同研成细末(过 100 目筛),每日 3 次,每次服 3~6 克,温水送服。

18. 驱蛔汤

苦楝根皮 30 克 石榴皮 15 克 生槟榔 13 克。煎服,日 1 剂,连服 2 剂。

19. 净腑汤。治疗急性泌尿系感染。

凤尾草 30 克 瞿麦 15 克 篇蓄 15 克 石菖蒲 10 克 银花 30 克 车前草 30 克。煎服,日 1 剂。

20. 定血汤。治疗血尿。

大蓟 30 克 墨旱莲 30 克 瞿麦 20 克 生甘草梢 12 克。煎服,每日 1 剂。血多加仙鹤草 30 克。

21. 浣带散。治白带。

椿树根皮 120 克 鸡冠花 120 克 苦楝根皮 60 克 白毛藤(即蜀羊泉)60 克 土茯苓 60 克。共研细粉(过 80 目筛),每日早、午、晚各服 6 克,温开水送。

22. 浣带煎。治白带。

鲜大蓟 60 克 鲜矛莓 60 克 鲜海金沙藤 60 克。干

草用各 30 克。连服 2 剂，每日 1 剂；第一剂加煨瘦猪肉 60 克同煎，第二剂加红糖 30 克同煎。

23. 调经止痛汤。治经行腹痛。

丹参 30 克 益母草 30 克 香附 15 克。

煎服，每日 1 剂。

24. 乳块散。治乳房可活动小块及乳腺炎。

露蜂房(需野外树上者，连子用)1~2 个。瓦上煨，研成粉(要存性，不宜煨枯)，每服 3 克，早、午、晚各 1 次。

25. 乳炎外消散。治乳腺急性发炎。

鲜公英(连根) 鲜紫地丁 鲜芙蓉叶。三药等量(至少各 30 克)，加醋捣烂，外敷肿痛处。干药可共研成粉，用醋加面粉调成糊状外敷。

26. 外用止血粉。治皮肤、肌肉损伤出血。

生地榆(去粗皮)30 克 乌鲗骨(漂淡)30 克 陈石灰 30 克 生半夏 20 克。共研成粉，需研至无声，外撒伤处，纱布包扎。

27. 扭伤方

(1) 鲜菊叶三七，茎叶俱可。按扭伤部位定用量多少，捣烂外敷。纱布固定。

(2) 生山栀子，捣成末，醋、面粉调成糊状，外敷患处，纱布固定。

28. 补血糖浆。治缺铁性贫血。

仙鹤草 30 克 红枣 10 枚 女贞子 30 克 十大功劳叶 30 克 桑椹子 30 克 首乌藤 30 克。柏子仁 15 克。

上药浓煎 2 次，合并药液，加红糖 30 克浓煎成稠汁，

装入有封口容器，每日晨起、临睡各服一匙（约 10～15 毫升）。

29. 麦粒肿、霰粒肿。

白芨。碗底（需用翻转后底部粗糙无釉处）磨研，加水成糊，用糊外涂肿粒处。

30. 牙痛。临时止痛。

细辛，约米粒大，按痛牙上咬紧。此方即“牙痛哭来笑去”方。用草拔亦有效。

31. 急性岔气痛。

硼砂少许研细，用骨针或体温表头着水，蘸点入内背，初点入时有刺激微痛，一刻钟左右即可活动自如。

32. 夜盲症、幻视。

马尾松枝 5～6 条，切碎，水煎，滤去渣，取汤煮饭、煮粥服。此法需较长期服用，能同时多吃羊肝更佳。

33. 止痒除湿粉。治稻田性皮炎烂、痒。

洁净粗草纸（稻草杆所做之纸）10 张，烧成灰研细，明矾 120 克，煨，研成粉。两药混和；先用温开水洗净患处，然后搽掺药粉均匀，外用净纸或纱布包扎，一日更换药粉 2 次。未溃破时，可单用生矾（明矾未煨者）研粉外涂。

34. 百日咳糖粉

蜈蚣 生甘草等量。

分别将两药在瓦上焙，研成粉，用时酌加白糖或冰糖。1～2 岁儿童每服 1.5 克，一日 3 次，3～4 岁儿童每服 2 克，一日 3 次。

35. 神经性头痛方

(1) 头痛胶

全虫，研细末，少许安入小块胶布内，贴痛侧太阳穴。

(2) 除风热汤 治由风热引起之神经性头痛。冬桑叶(需用经霜后桑树上所采)15克菊花(最好用原菊—可食黄野菊)15克。水煎服，一日1剂。

36. 胃神经痛方

凤茄子(曼陀罗子)3~5粒，嚼碎吞服。

此方起临时止痛作用，不能常服、多服。

四 日 症

症有疟症、疟症等，有日作、间日作、三日作者，《内经》记其证，亦数以理，明乎2000年前即有此疾，然医籍无四日症之记载，虽西论主原虫者亦然，而余实遇之。19岁时余行医第三年，秋七月，外祖母病寒热已延半月，索余往，询得寒热每四日一作，始而作于傍晚，渐而移向午后，作时先微恶寒，继之发热，迨傍晚则得汗而热退，口苦泛恶，胸痞困顿，数作之后，面色渐黄，精神萎弱，午前亦感萧索；余思证具疟象，尤符少阳，第无四日之症何，余幼就养外氏，外祖母亲视食于者年外，至此放胆言为疟之一种，以慰老人，是日适在疾作前一日，因投截疟七宝饮一剂，嘱翌晨服初煎、午时服二煎。第三日，即疟发之翌日往探视，悉昨未作寒热，遂而心得以安，留西药奎宁片一周量，以杜复发。于此知病之未知者甚多，未可泥于古，亦未可泥于籍也，当酌古斟今而与古为新。症之变，虽三日者可作为日日作，此屡可见者；而虚人则三日延为四日矣，外祖母固体虚而多劳者也，当日但据形寒、发热、汗出热退之疟证幸中耳，而理亦存焉。外祖母亡于1967年初，余受遣在乡，亡时适值在

舅家，得亲为洗沐送殓，然无寸报于老人，记此不禁黯然。

曾见异病

病之有不可究诘者，见之说部甚多，《池北偶谈》载：高阳民家子，十余岁，臂生瘤，痛痒不可忍，溃出圆卵化为石，以之治膈病神效；60年代初《参考消息》载：苏联一人臂膊患瘤，医为割出脱脂棉四两，逾年复作，又出棉四两，如是每年一作，已三次矣，总不知其故。又载一村数人可以指识字，或以食指，或以中指，亦有四指俱用者，抚书页报纸即知何字，第各人之多寡不等，颜色之敏感亦不等，敏于赤者为多，亦有以腋挟而知者，是亦异于常理而易目之视为肤之察也，自特异功能之说起，有所归矣。余在东埭亦遇异症：一雪浪乡人，以脘痛来就医，一诊已愈，为巩固计而复诊，诊毕指其右颧小疣谓余曰，此是疾否？余见小包仅绿豆大，青壮人之常可见者，以为疣瘤粉刺之属，曰不然，谓当顶有孔，时出白毛，拔之复渐出，不去则渐长，谛视之，果有孔，毛四、五茎出孔外成束，真羊毛也，长已可抵短毫小楷笔锋，告余曰，此亦无痛苦，第须随时拔去，否则招人怪异耳。余无以解，告以《参考消息》事，令毋庸忧亦毋庸治；又一妇于无锡市第二医院摄片有膀胱结石、腰腹注痛，来就诊，予分利化石药4剂，洩出一线球而愈，来告余曰：洩出后曾反复检视，确为棉线裹成，引之则线绵延而球滚。人固有血、涎、液之化为石者，如尿石、胃石、胆石以及腮腺、眼睑内等之结石，渔洋之记尚可以想见，而棉之与线，因非人体之可化生者，亦复无由而入也，诚哉医理之难达，生化之未易论也，医岂易乎哉。

惊吓气厥

气厥之证，原就本气之变异而言。其有外邪之厥，亦必经气机之逆乱而后成，如疾、热、寒等，则分别以痰厥、热厥、寒厥名之，盖其初因邪而起，是邪袭而病及本气，非内因而致，故冠以痰、热、寒也，其中秽、中噤之属亦犹之。夫气厥之来，要不离乎情志，证分虚实者，系乎素体之盛衰，盛者证实而弱者为虚；其于情志中尤以大怒、大悲、大惊恐为多见，盖七情之来以此为迅而暴故也。日军侵华之初过也，烧杀殊甚，余乡当其樱，小舅父为掠去作伕，外祖母及村人避邻空屋中，时余幼，亦随众避，外祖闻舅父掠，悲急且惊，始而犹呼奈何，继而气息涌急，四肢渐厥冷，面色渐转苍白，目上视而昏，气息不续，同避者恐日军未远，复不敢高呼，第急为掐人中穴，继捶其背，移时而汗溦然微出得甦，萎弱不能动，日军去，犹籍草卧，傍晚始勉强扶归，小舅父亦得间回，将养数日始平复。余业医以来数十年，无复见此证之始终全程如此者，盖医者之视此疾，均在既厥之后，或紧急之状止后始得至，当其始起病时得见者鲜矣，亦势之然也；此症犹需赖当场诸人，以仓卒中无以求药，第针刺、甲掐，可以得甦如外祖然，是所不能不为传布者也，针刺以水沟、十宣穴为主，予强刺激，毋避其痛，盖痛可使由“惊则气乱”、“恐则气下”所引起之“神无所倚”气机、得以凝集而建立常序也。掐押水沟，亦犹此义。

附 文

温课小启

盖夫业精于勤，学进乎习；三余之益，宜日计而月累，六经之诂，须寸较而铢求；壮志树精益求精，宁辞白首，疑义析玄之又玄，毋负青灯。又尝闻：耻独学之陋，期朋来乎远方，集众论之长，收石效于他山；虽老成之有素，宜乎友其友生，惟后生之可畏，允矣吾亦吾徒。取长补短，原以宏岐轩之基础，相与伸讨三因；与古为新，的在创中西之联璧，庶几功添四化。是以期定半月，各应各抒己见，悟言一室，共宜共榷所知；凡与同集，均此同志，用作小启，以为大章。

（1979年中秋节，与路志正、方和谦同学倡议温课会而作。）

《中医内科急症》跋

求中医之振兴，必先有中医院，俾医、教、研得所凭藉，而中医院之能以致信于群众而益强者，则唯治疗之效且速也，其间寒热昏沉，患起仓卒等疾之疗效，尤足以昭人耳目，惜乎习势之忽于兹者几十数年矣。路志正同志有鉴于此，遂徵于古，求于今，为《中医内科急症》之作。其于一病之治，治则集汤液、砭针、按跷、敷、贴、噍、灌、点、擦，药则详辨证论治，单方、验方，以及于新型注射之剂，且复医、护联述，防、养并重，其为利

于病治之所患者备焉。篇幅虽少，然赅内科急症常见之病，可为职专之临床便览者也。稿成后，得先睹且预参酌，予有同求而缺缺无间，惘惜之余，因志数语，复期有续于后者也。

（1984年6月跋于北京市卫生局）

《伤寒研究》小序

仲师之籍，凡医者尽治之，或揣摩之，或训诂之，或论注之；自叔和编次、无己注解之后，雄视者迄今，稽其然；以其为热病临床之首著故也；创六经之辨证，开方药之条析，发扬《内》、《难》，直接症治，是所以圣之经之者在此。有清一代，原于历史时势，训诂条途之学盛，流风被及医林，而注《伤寒》者亦蔚然云起，如陈氏之以经解经，在于求其论直；《金鉴》之简误存疑，在于求其理贯；柯氏之《来苏》，以方而赅证变；尤氏之《贯珠》，以证而析药治，均为佼佼者也，然而仁智之见，各有所得，亦各有所缺，加以康、雍以还，温病学起，《寒》、《温》之见异而南北之争起，遂而纷然杂陈，明者愈明而暗者仍暗，究其因，以今人之识求古义为其一，典籍流失，讹讹未能核实为其二，古今气候之迁、风俗之变、品物之不齐为其三。就一言以蔽此三者，则失之于历史唯物辩证也。近读孙瑞同志《伤寒研究》，恍有新得，“超以象外，得其囿中”，执其大而略其末，示人以规矩之方法论也，如文中以三阳经证为邪盛阶段，以三阴经证为正虚阶段，此阳之所以为阳、阴之所以为阴之理见，不悖于《内经》而统观全局，发展乎《内经》而六经之辨证得详于《伤寒》；以厥阴为阴阳不相顺接之病亟阶段，此所以为厥阴之理见，不囿于《内经》厥阴之义，而遵乎《内经》阴阳离决之机，是热病临

床实践之发展据以得证,此均前人未发之论或发而未详者,是有得于《伤寒》之运用于临床、临床之求证于《伤寒》而三反复者也。它如提倡据古字之义读《伤寒》,依考古之据定汉量,是遵乎历史唯物之旨者,求《寒》《温》之统一,伸仲师之局限,是又医林之众望而与古以为新也。顾余所谓略其末者;或谓其宜进一步解之者,如六经病之欲解时,仅论及“太阳病欲解时,从已至未上”之“上”字,而不及其所以然之在于临床现象之反征;或谓其宜略者,如卒章之《记读法》,此固读古籍之尽然者也;或谓其宜直伸已见者,如《寒温一体,应趋统一》章,虽言及《温》出于《寒》,而源与因似欠详论,凡此均有望于后也。然而要言不在繁,一斑已见,是又余所谓执其大者也,故乐为此两存之语,见此论之实而复寄意焉。

(1988年5月于京华之瓣杏斋中)

《倚云轩医话》序

夫医话之作,其有别于巨篇者,曰文短、理明、论精辟,记翔实,超乎医籍之外而中乎医事者也。或发典章之微而旁及文、史、地、哲,或采乡俗之治而析其理、法、方、药,评前人之曲直,可悟超于象外,记临床之得失,以比类而旁通,故虽琐屑之述,不妨比之于米珠薪桂,既以灿日蕴香,而复俾益饮食也。且夫集狐腋以成裘,列鱼祭而为文,非作者之学有根底、富于识见者难能为也;为之而不能积健为雄、返虚入浑,则亦难为乎上者。是故虽由来已久,刊著攸多,而称是者麟角,上溯乎元、宋,则张杲之《医说》或为滥觞,而缪氏之《先醒》著于明代,陆氏之《冷庐》刊乎清时,是均嘉集之昭然在入耳目间者。方耕霞

先达以古吴积学，西溪薪传，历经清朝、太平天国、民国三代，治医锡、澄、虞之域，当其际于取消中医令时，能集众为社，据理以争，创刊医报，互徵治验，于此见其识见，亦以见其风骨，诚吾道之俊士也。先生医著之传世者，仅见《王旭高临证医案》，初刊于光绪，再刊于民国，解放以后，复两刊于沪与京，书中按语、序文，均先生手笔，钝初邻境后学，望巫咸山翠，初不识先生之名，读旭高医案，后而知先生之学，嗣常以不见余著为憾。去冬10月，同学江一平爰以《倚云轩医话医案》见寄，浣读数过，深喜灼见，集中辨伤寒之传经，丹溪治产后等，均深有益于后学者；而岁气变化之与病治，余实历乎临床。盖60年代初乙脑流行，客岁石家庄有白虎之验，京中遂尔效用，然亡者屡屡，是年雨水之盛为京地仅见，八月经霖，往往深及胫膝，余疾呼于诸同学间，共倡霍佩银翘之治，得挽颓势，此情固与先生之论同也，予以知载道之言，需从学验中来，乃为订审误字讹句，以谋传播焉。

（无锡丘君玉、钝初氏1989年5月15日在北京中医医院）

《北京郊区县中医院论文集第一辑》序

中医事业发展的标志是临床疗效和学术水平。中医在历史长河中之所以能够不断发展，就是因为它治病救人，为人类做出了贡献，赢得了人民群众的信赖。由此广而思之，治疗效果可视为中医生命线之理甚明。一所中医院在群众心目中的地位，同样取决于临床之理也就不言而喻了。假如一所中医院的疗效不高，或一个中医不能够为群众治好多种疾病，则必然

“门庭冷落”，久而久之，就有被群众遗忘的可能。因此，提高临床疗效，对各中医院和中医药工作者来说，不论目前或今后都是当务之急。

临床疗效与学术水平紧密相关，中医药人员在未经临床之前，所接受的仅仅是前人和师长的学问与知识，欲真正掌握并运用这些知识，则必须通过实践。时代的推移，社会的变迁，气候、地理等外在环境和人类本身起居饮食、劳作、情绪等主客观方面的变化，对病因、病机、发病和转归等都有着很大的影响，仅仅因袭前人的经验，势必是不够的。因此，朱丹溪有“古方今病不相能”之说；张仲景在“勤求古训、博采众方”和大量临床实践中，总结出了《伤寒论》这部皇皇巨著；叶、薛、吴、王等前贤，又在《伤寒论》的基础上，结合自己的临床实践，创立了温病学说。此皆符合“实践，认识，再实践，再认识”的规律。为提高治疗效果和学术水平，中医药工作者就应当不断总结临床经验，不断深化对疾病的认识，不断发现新的有效治疗方法。

我们接受了先人的临床经验和由他们升华了的中医理论，其不足之处，势必要由自己去寻觅、创造和补充。而恰巧就在这些不足之处，维系着中医学术发展的生命线。之所以要寻觅、要创造、要补充，与其说是要“补前人之不逮”，倒不如说是“形势之所迫”。换一种看法，也可以说是先人在中医学术这个大戏台上，留给了我们一片广阔天地，任我们去发挥各自的主观能动作用。这当然必须严肃从事，因为这是学术，是关系着人命的学术。

《实践论》中有几段话应该记住：“经过实践得到了理性的认识，还需再回到实践去。”“客观现实世界的变化运动永远没有完结，人们在实践中，对真理的认识也就永远没有完结。”从

中可以悟出,临床实践对提高理论认识的作用和理论对提高临床疗效的作用,都是极为重要的,而且两者之间相互促进、相得益彰的作用永无止境。只有不断学习,不断总结,才能不断前进。近年来提出的“终身教育”与“知识更新”之说,对中医院的发展和中医药工作者自身素质的提高都有着深远的意义。其具体做法则必须结合当前办医形势,除短期专题学习之外,还应当在工作中加强学习,不断总结临床疗效,探索新的有效方法及其理论依据。

北京市自80年代初以来,几经努力,扭转了“10年内乱”所留下的中医颓势局面,全市设置了高、中两级中医人才培养基地,各区县又相继成立了中医院。但是,历史遗留下来的人才断层问题短期内是难以解决的,其必然导致学术层次的脱节,为了弥补这点,必须紧紧抓住疗效、学术双提高及在工作中学习这些环节。郊区县中医院的同志们,在几年来办院、办医的甘苦中统一了这方面的认识并付诸行动,他们汇各院论文为一体,集成《北京郊区县中医院论文集》。尽管文笔较粗,上百例总结的大块文章不多,理论探讨方面尚欠深入,但毕竟是来之于实践的第一手材料和切身体会,是他们多年来心血的结晶。古人说:“涓涓细流,可成江河”;“登高者必自卑”。通过院际文字交流相互学习,实事求是地渐进,定能收到可观的效果。

房山区中医医院的同志们,在论文集的编辑过程中,担负了组织、审核、统改、加工工作,付出了繁重的劳动。我因关心此事,愿将个人所见附人集中,借此寄托对中医事业的希望和对作者、编者的敬意。

(1990年4月3日)

《“正气存内”与“意导”》文按

本文通过对《素问·遗篇·刺法论》中一个章节的译释,论述了“正气存内,邪不可干”及其整节的内涵为导引法之一的“意导”的作者观点,并否定了这一节中的迷信疑义,从而将本节《遗篇》内容纳入了类于近代医疗心理学的范畴。心理学在社会现实中是常可见到其存在的,诸如“信念”、“士气”等等,其含义均带有心理因素。巴甫洛夫的“第一信号”、“第二信号”,以及“保护性医疗制度”的出现,不仅为心理学在医疗上的运用开拓了境界,也为医疗心理学奠定了物质基础。心理学在中医学中的运用,除本文提到的马王堆出土帛书中的导引图和《素问·遗篇》外,在《素问·移精变气论》、《灵枢·贼风第五十八》等篇中所提到“祝由而已”、“祝由不能已也”等描述也同属医疗心理学的运用。论述中不仅排除了鬼神之说,也为心理学在医疗运用中明确了能“已”和“不能已”的界线,更清楚地道出了其原理是“移精变气”的实质。就今所知:医疗心理学是有条件的,能否引出“条件反射”是其效用关键所在,此点应与能否“移精变气”有同一涵义。《素问·遗篇》亡于唐·王冰注释之前,故王本只存篇目,王注于“病能论”篇末曾提及佚之佚,所以后世称为“遗篇”;“遗篇”的出现在宋林亿校注之前,后人对之均持非《内经》原文之见,但其中“正气存内,邪不可干”、“慎其大喜欲情于中”及“守神”等强调预防疾病的观点,是有一定科学意义的,本文作者正是从“正气存内”出发,强调了其防治疾病的积极方面。

(本文系对《探“正气存内,邪不可干”及其全节之原意》一

文的按语,该文载于《北京郊区县中医院论文集》第一辑。)

《北京郊区县中医院论文集第二辑》序

《北京郊区县中医院论文集第二辑》将刊出了,上溯第一辑刊出相距约一年时间,在这一年中,郊区县中医院同志通过院长联席会议,组成了论文集的编辑委员会,锲而不舍,进行了征集、审编等工作,其意义不仅是体现在论文集第二辑的刊出方面,更积极的意义是:通过稿件的征集,促进了郊区县中医院工作同道的留心总结、注意收集资料和翻阅必要的参考书籍以及写作积极性,这一点无疑是学术发展、临床水平提高的必由之路。中医学是自然科学的一部分,她之转化为生产力的表示,在于治疗效果和提高人民体质这方面。因此,提高中医学学术水平是提高为人民服务水平的基本手段,而且学术水平的提高,必须通过具体工作的最基本单体——劳动者素质的提高来实现。郊区县中医院论文集的组织者们抓到了这个重点。这个重点,就是江泽民同志《在庆祝中国共产党成立70周年大会上的讲话》中说的:“我们一定要最大限度地发挥科学技术的作用,尊重知识,尊重人才,更加自觉地把经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,采取有力措施,把科研成果转化为现实生产力。”基于此,郊区县中医院论文集的继续刊出,就意味着是与我国的建设步骤一体的、一致的,由此而应该联想到的是,必须不断提高论文集的水平,突出其科学性、先进性。基层单位的著作,也应该注意到“提高与普及相结合”的原则,这样才能更好地适应基层需要和带动北京中医基层学术水平的全面提高。这是我所深寄希望的。

在第一辑的刊出工作中,我曾参与过一些文章的审阅、修

改和加按工作,还表达了通过“实践、认识、再实践、再认识”的规律,敢于开拓新境界,做到治疗效果、学术水平双提高的意见。此次编辑同志又谈了工作进度和内容,粗略知道栏目和篇幅大体相当于第一辑。作为中医队伍的一名成员,对二辑刊出是极为高兴的,借此谈点编刊论文集的作用,不仅是希望组织者能再接再厉,也希望论文集的作者和北京郊区县的中医同道,为了改革开放的需要和中医学术发展的需要,在“把经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上”的过程中,在北京市中医管理局的领导下,自觉地作出更大的成绩来。

(1991年8月10日)

扬长避短,增强内在活力, 开拓中医事业

十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》中提出的第三产业,包括卫生服务部门,这是在政策上将改革放到了卫生服务部门面前。尤其在1985年国务院批转的卫生部8项改革方案中,更确定了卫生服务部门的改革。作为我国医疗力量之一的中医工作,无疑同样要进行改革;面临的形势是要我们在薄弱的基础上改革出社会效益和经济效益,如何改革出社会主义新时期的中医事业来,是我们必须探讨的问题,本文试从现有条件、对策等方面来探索。

一、情况分析

中医是我国卫生事业的组成部分,对卫生事业有影响的因素必然影响到中医,对中医有影响的因素也必然影响到整个卫生事业,所以本节将影响到整个卫生事业和影响到中医发展的因素合并讨论:

(一) 现状中的薄弱环节和原因

由于过去“左”的影响,尤其是在10年内乱中,在学术上只提倡中西医结合一种观点,中西院校停止招生及其后的限定在工、农、兵中招生,致中西医务人员1966~1972年间出现断层,不仅人员得不到补充,而且水平下降,在办医方法上包得过多过宽,一切由上级决定,一切要向上级伸手,使医院越办越穷,房屋得不到扩展,设备得不到补充更新,职工躺在单位身上,单位躺在国家身上,抑制了单位和医务人员的积极性和主观能动作用,在办院方法上,将大批高水平中医下放或靠边,以护代医,以工管医,使卫生单位管理混乱,技术水平下降,服务质量不是进而是退,这是造成今天卫生服务事业中薄弱环节的主要原因,具体有如下述:

1. 把医疗机构资料,包括房屋、家具、技术设备的所有权、经管权混为一谈。过去把医院视为上级卫生主管部门的附属物,由国家卫生行管部门直接统管医院,剥夺了医院在经营管理上必要的自主权,压抑了医院的主观能动性和积极性,助长了依赖性和惰性,吃大锅饭的状况也就必然出现。这一影响至今未能完全消除。

现有的条块分割情况,削弱了医院之间的横向联系和合理的分工协作,各自为政,追求小而全、大而全,削弱了宏观上的管理,突不出重点建设、重点学术、业务深度,大的小的都搞

不活,实际上是没有真正发挥好卫生行政部门的领导职能。

2. 分配上的平均主义与按需分配混淆起来,否认各个单位、各个工作的差别,否认按劳分配原则。过去在“左”的思想指导下,曾多次把按劳分配当作“资产阶级法权”批判,形成了似乎“社会主义就是要平均”的错觉,因而在工资、奖金的发放上都不敢同医院的经营成果和职工工作成果挂钩,不敢从物质分配上体现脑力劳动和体力劳动、复杂劳动和简单劳动的差别,不敢拉开档次,不敢体现多劳多得的原则,一旦出现较大的差别就认为是两极分化、背离社会主义倾向,这就出现了“干多干少一个样,干好干坏一个样,干和不干一个样”,这是抑制医院活力的一个重要原因,三中全会指出,这种“平均主义思想是贯彻执行按劳分配原则的一个严重障碍,平均主义的泛滥必然破坏社会生产力”。

3. 将卫生事业与福利事业等同起来。认为医疗收费越少就越体现社会主义的优越性,降低医疗收费标准,几次药品降价,由此而形成了医院赔钱,越办越穷,设备得不到更新而大大落后于国外,复杂脑力劳动的医务人员的收入,相类于简单的体力劳动者,各个医疗单位由此而只能躺在国家身上,躺在上级主管部门身上,事事都要向国家伸手的局面。

4. 忽视传统医学,杯水车薪式的发展中医事业。以下述数则情况说明:

(1) 全国中医院校的总资产相当于一所南京工学院。对一所县级中医院的投资相当于综合医院的一台 CT 或不足一台 CT 价值。

(2) 在中医人员数上,部分大城市从纵向比较是增加了,横向比较则不足;从全国范围看,无论纵向或横向比较均属严重短缺,举例如下:

a. 全国解放初期与 1984 年中医人员与人口对比:1952 年中医人数 38 万,全国人口数 4 亿。1981 年中医人数 31 万,全国人口数 10 亿。

b. 北京市 1984 年在职中西医人数对比为 1:8。

c. 北京市中医人员与人口比例:由 1949 年的 1:1800 降为 1984 年的 1:3000。

d. 北京市房山县“文革”前与 1983 年中医人数对比分别为 300 和 97。

(3). 专业人员缺少。全国现有副主任医师以上中医 2000 左右,中医总数 31 万,其中专科人员比例极小,个别专科有濒临无人之虞:

a. 全国耳鼻喉科中医仅 255 人(1984 年统计)。

b. 全国骨伤科中医仅 3100 余人,其中主治医师以上人员仅 30 余人(1984 年统计)。

c. 北京市、区、县属现有中医综合性医院中仅市医院一所有中医外科、眼科门诊,各中医院中均无中医耳鼻喉科(1984 年统计)。

5. 将中医各科混视为一个科。中医分科,可以上溯至周代的“疾医、疡医、食医”,宋代分 9 科,元代分 13 科,清代分 11 科,各科各有专著,《医宗金鉴》中所列的各科心法是其明证之一,而现今在综合医院中绝大多数以中医科一科统治各科疾病,甚至出现以“三个指头、一个枕头”来况整个中医,这是一种不合情理的现象。

在中医教学方面缺少分系,各中医院校的医疗系中绝大多数只有内科,除近二年来部分院校增设针灸按摩系外,其它原属中医大科的外、妇、儿科均未建系,致使专科中医人员后继乏人。翘足菱折,如何起飞!

出现这种情况的原因,在现象上看是10年内乱造成人才上的断层和中医院校科系设置的单一性、综合医院中医科的混一性,而其实质是“左”的影响和对传统医学的忽视,所以才会在前段时间中出现“老粗管老细”的情况。

(二) 中医的内在活力和趋势

世界各区域、各民族的劳动人民,均在漫长的历史进程中创造了自己的医学,尤其是作为古文明中心的阿拉伯、古希腊、印度和中国的医学,都在很长的历史时期内有着辉煌成就,对人类的生存繁衍作出贡献,但随着时代的前进、科学的发展,现在只有中国这一支传统医学始终不衰,而且随着每个历史时期的发展而不断丰富,在清中叶以前一直处于世界医学的领先地位,之所以如此,是中医学的合理部分、科学内涵的坚实,其核心是以机体为基础的整体观念和辨证论治。中医学强调人体脏腑、经络、气血的作用及其相互关系作用,又强调人体与气候、地理、人事等外在环境的相互关系作用,这种内在的整体观和外在环境的整体观,是朴素的唯物观和辩证法,据此而直接提出了在治疗上要因时、因地、因人的辨证论治法则,提出了“上工治未病,不治已病”的预防观点。这一科学的核心部分,在2000年前的《内经》中较完整地提出以后,一直贯穿强调至今,而西方医学只是在近阶段才注意到气候、社会因素对疾病的关系而转向宏观。中医学的这个核心部分,今天正在被近代科学所证实,诸如太阳黑子活动的强弱与疾病的关系,证实了中医学“天人合一”的观点,心理因素与癌症、溃疡病的发病关系,证实了中医学的“七情”是发病因素的存在。这种证实,恰好是证实了中医学固有的内在动力,证实得愈多,说明中医学内在的动力愈强,正因为如此,近几年来出现了世界性的中医热。

中医热不仅在亚洲出现,欧、美各国也在积极研究中国医学,美国已有了中医学院,面向世界招生,加拿大、法国接受针灸治疗的人数日益增加,认为中药比化学合成药物对人体损害少已是一种普遍心理,日本有些人更在公开场合表示要在中医学术上与中国争胜;这是一种趋势,这种趋势在我国中药大宗出口,各国派留学生来我国学习中医,东南亚国家来我国考察中医等一系列事实中是显而易见的,这种趋势不仅表明了中医学内在的动力之坚强,也表明了中医学的发展前途是广阔的。

(三) 应否发展中医事业

这里从另一角度来阐述根据世界医学形势,应该将中医事业放在什么位置上对待的问题。

中医是中国特有的医学,虽然几个世纪前就传到国外,现在很多国家在研究和运用中医学,但掌握学术的程度最深和掌握学术人数最多的仍是中国,这是在世界医学领域中中国所独具的特色,也是中国社会主义特色内容之一,这是我之所长于人的方面。西方的近代医学,由于资本主义的产生早和工业机械的先进,带动了医学的进步,它在微观方面是明显的胜于中医学的,从清末民初传入我国以来,我国的近代医学工作者虽然一直急起直追,努力不懈,但只有距离上的缩短,跟着人家走的局面没有改变,这个局面在将来的一定时期内也不可能改变,这是历史客观所造成的形势。如何在此形势下使我国在医学领域里胜于人,应该要考虑“扬长避短”的策略;我国在世界医学领域里的何长何短,如前所述是清楚的,只有扬我所长的传统医学才能在短期内转劣为强。据此,中医事业的应否发展就可知了,了解到中医工作中的薄弱环节及其原因,了解到了中医学内在的动力,中医学的能否发展也就可知了;也

可由此而认清中共中央历次提出的中医政策、重视传统医学的方针的正确性。

二、对 策

发展中医事业,根据我国国情,要解决好中医单位的管理,中医人才的培养,中医单位经济效益和人员积极性等相互关系。因而扬长避短的策略,必然要结合农村、城市的经济改革的发展才能进行得好,只有随着经济改革发挥好单位自身的内在活力才有发展中医的撑支点。中医单位的改革与所有医疗单位一样,主要要解决好:

1. 确立行政管理部门与医疗实体间的正确关系,要扩大医疗实体的自主权。

2. 确定医务人员与医疗单位间的正确关系,要保证医务人员在医疗单位中的能动作用和主人翁地位及其责任。

但是,医疗单位虽是第三产业,还具有卫生保健服务的责任,在有了上述两点改革基础后,必然应该以社会效益为第一位,而后才是经济效益,经济效益要以提高医疗质量的社会效益为基础,不如此,就失掉了群众基础,凡是不能为群众创造利益的事业,最终都是没有前途的,这是社会主义所决定的前提,也是人类社会发展的规律。综合上述各情,必先明确发展中医事业的目的,而后据此作出措施,定出注意点。只有这样,才能有效地发展中医事业,使中医事业发扬光大,使我国的传统医学更好地为人类的健康服务。

(一) 目的

发展中医事业的目的有内、外两个方面,一是在中医学术内部:要求使传统特色得到保持、继承、发扬,促使中医学术加速发展。二是国际方面:要扬我之长,体现中国社会主义的特

色,使中国医学能跻身于世界医学领域的先进行列。两个方面的归结点,必然是要通过对人民健康服务的有效程度,是为了对全人类作出更大的贡献。

(二) 措施及其注意点

1. 发挥主观能动作用,结合本地区、本单位情况,改善管理工作,相应发展新的医疗技术。只要有利于改革,有利于单位发展,都应主动去依情调整。在发展新技术方面,要依据群众需要,按常见病、多发病的防治要求和本单位内部条件的可能性去发展;可以一个单位搞,也可以上下左右纵横联系起来搞,以弥补条件的不足和病例的不足,这种上下左右纵横的关系,包括到科室之间、单位之间、省内省外等范围,只有这样,才能在短期内实现对一种新技术、新学术的结论。

与此同时,单位还要发动各类人员的积极性、能动性,还要协调好单位工作的轻重缓急、人员的思想统一等项,才能办事有力、有速度,这里还是有民主与集中的关系,仍有职责分明、行动统一的要求;在改革开放的同时,必须开展岗位责任、工作纪律、医德教育和法制教育。经济是个杠杆,但必须保证正确的改革方向。

2. 领导班子要有开拓精神,要有敢于竞争的精神。成都中医学院李仲愚大夫在给彭真委员长的信中提到中医中很多人员“素有黄老思想,清贫自守,恬淡为怀”的情况,一方面固然反映了“不计个人报酬”,另一方面也反映了不敢于、不善于竞争和缺少开拓精神。抱残守缺,不但不能扩大为人民服务的广度和深度,也有碍于改善一个医疗单位的内涵和发展,单位的中医领导应该改革自己的这个方面。一个医疗实体的各级领导,要在具有专业知识的同时具备点经营观念(现在叫作管理科学),要依靠技术、学术的进步和发展,开发单位的内涵和

外延,过去我们习惯于靠上级拨款,不懂得向社会集资;重视新建、扩建,轻视对现有条件的充分利用和改善;重视规模上的扩大、新摊子的延伸,不善于依靠技术上的进步和发挥去求得社会效益和经济效益;重视调进人员,轻视单位本身的智力开发;重视各项技术的提高,不懂得整体配合的合理、可以求得以乘数计算的效能提高,凡此等等,都是我们思想上、精神上所需要改革的,敢不敢发挥本单位之长去开拓新的医疗领域、新的医疗对象,是关系到这个单位能否保持旺盛的生命力的问题,也就是活力的问题。

竞争是个好事,有竞争就有比较,就有优劣之分,这是进步的催化剂,有竞争就能促使学术、技术进步,就可扩大和出现新的为人民服务的深度和广度。竞争不仅进行于西医之间、中医之间、中西医之间,不仅进行于单位之间、省市之间,最终是要在国际之间起到作用,要使中国的医学为世界人民多作贡献,这就直接关系到我国传统文化的发扬和国家威信的大事。竞争的基础一定要建立在团结协作上面,而不是互相排斥、打击对方,要建筑在社会效益上面而不是只向钱看,决不是单纯为了增加单位经济收入和提高职工福利,单纯增加经济效益决不是改革的方向。竞争是发挥我之所长,充分运用现有的设备、技术、人力等条件,去扩大、开拓医疗预防的深度和广度而取信于民、取胜于兄弟单位,同时取得相应的经济效益。在竞争中,各单位都应按“以我为主,博采众长,融合提炼,自成一家”的原则,从本单位的实际情况出发,积极借鉴兄弟单位的管理经验和科研成果以丰富自己的竞争力。

3. 以“专科办院,院办专科”措施,突出专科建设。目前各医疗单位均处于设备陈旧简陋、技术力量不足、人才不配套的落后局面,如何在此基础上取得效益,是大家不能回避的事

实,是必须深思的问题。不论哪一个单位,要全面取胜于兄弟单位是不可能的,我有所长,人亦有所长,我与人亦各有所短,只有扬长避短才能取得胜利。因此,专科建设是可行之法;只有突出一个、二个专科,各单位才有将人才、设备相对集中使用的能力,才能创造出有活力的路子,从而才有社会效益、经济效益可谈。突出专科建设,是扬长避短策略的具体体现之一,是在劣势下取得胜利的办法,古代齐国“斗马”之能取得二胜一负,为我们提供了历史上的范例。

通过专科建设,对外可以加强群众对单位的凝聚力,树立单位威信,对内可以培养一批人才,使一个学科的学术深化而提到新的水平,更可以以点带面,促进全局工作。这里涉及到一个单位能否自立,能否有社会效益和经济效益,能否对国家、对人民作出贡献,能否对传统医学起到继承发扬的作用等方面的问题,我们要严肃思考。

专科建设既然是扬我所长以胜于人,那着眼点还要放在“胜于人”这点上,如果所扬的长不能胜于人,那就说不上是长,就收不到效益,所以有了专科还必须有专长(胜于兄弟单位的长),这种长,可以以一科长于人,也可以以一类病、一种病的防或治长于人,否则各医疗单位都是儿科、妇科、肛肠科……,没有各自的特色,还不就是目前的老局面吗?老局面就没有特色可谈了。

4. 保持特色、发挥特色的作用,是增强医院活力不可忽视的因素。各医院要有各自的特色,这种特色就是上述的特长,是各医院自己的竞争活力,另一方面,各中医单位还有个共同的特色,就是传统医学的特色,这是个更大范围的竞争的活力。中医的特色是整体观念的学术和辨证论治方法的统一运用,中医单位改革中要注意如何保持它的内涵和发展它的

外延;保持内涵,是要将整体观念、辨证论治运用在治疗上并反映到各种医疗文件中去,尤其是病历的书写,要按照卫生部发布的全国统一要求去书写,要强调反映出整体观和辨证性;保持传统医学的内涵,决不是保持“三个指头,一个枕头”的形式,这种形式不是传统医学特色的核心,形式是要根据核心需要而改变的,如果某个中医院只要求保持这种形式,就必然不能发展,也就没有竞争的活力。发展特色的外延,是要围绕传统医学的特色建立健全自己的指标、数据、护理方法和由此而需要的药品剂型改革等,进一步还要与其它学科,包括现代医学相互渗透、沟通,这里是中医现代化的问题,也同样适用“以我为主,博采众长,融会提炼,自成一家”的原则。

今天大家都已看到:中医学固有的指标和数据,由于在漫长的历史过程中的分散行医、各自领会之故而很难求得掌握上的一致性,以及中药剂型、给药途径上的局限性,都是不利于中医事业发展的,对这方面需要通过改革以求得适应人民群众的要求;这种改革,是无损于中医传统特色的整体观和辨证论治,而其效益是更方便、更迅速地取得中医学术的发展及防治疾病的效果。还应该看到传统医学在历史上无论是在理论或药物方面,都是接受、吸收外来的内容的,问题只在于以我为主的去运用,去丰富、壮大自己。

三、简短小结

本文试用管理科学、运筹学等原理,根据社会现状,分析了医疗服务工作中的薄弱环节和产生原因,侧重分析了中医事业方面的劣势与优势,并分析了传统医学固有的内在活力和发展趋势,在此基础上提出了发展中医事业的目的,并据以

提出了综合治理措施及其必要性。依据人民群众的要求和党的中医政策和党和国家领导人的支持,这些措施是有很大大可行性的,但各级卫生行政管理人员的决心、重视程度和努力程度,仍是能否取得成效的要素。

(本文为1985年6月在卫生部办卫生厅、局长班时写,曾发表于《北京中医杂志》1986年第5期。)

《温病条辨》方歌诀叙

曲阜孔伯华繁棣先生毕生治医,名籍甚,都下推为京华四大名医之一,解放初任全国政协委员,周总理曾亲蒞其不龟手卢医舍。先生学宗温热而上溯《伤寒》、《内》、《难》,以善治热证著人耳目,临症疏方,寓辛于寒,寓开于清,首石膏而常著麻桂于方末,且出之旁注,阅者往往有忽;治小儿外感,亦多伍用至宝、牛黄,以为乳儿神弱,受邪即易入里,且往往挟有内热,故清内疏表兼施,邪外解而内亦安,应手取效者比比;余以1954年供职来京,与先生弟仲华同事,复识其哲嗣祥瑞同志,得睹其方、闻其效者如此。先生以1955年逝,医稿散藏诸及门处,10年风雨,杏林凋落,难乎问及著述,1982年市卫生局始组织收集编次,今春刚杀青,今祥瑞同志以过庭受读《条辨》之初,出韵语编鞠通方,自临床以还,复三四修改订正,将以付梓;夫医方歌诀之作,著于汪昂、修园,所以便于上口朗朗,易为记忆,今祥瑞便己以及人,是亦步宪之为也,来书索叙,复述及值伯华先生诞辰100周年,有追远之思,因错杂言及数事,亦以緬伯仲两先辈也。

(1987年秋辨杏斋)

《当代中医实用临床效验方》小序

这本集子,是几位年轻中医抱着为同道做点工作的意念,日夜兼程从几千份中医刊物中辑节而成的,不能说是他们的巨著,但他们的辛劳对中医工作会起到一定的作用

这种作用的主要方面是为中医工作者节约时间,能够有系统地综览到近 10 年中中医临床的成就和经验。从党的十二届三中全会为中医迎来了第二个春天以后,各地的中医刊物纷纷恢复或创刊,加上各地中医院校的建立而刊出的学报,总计省市以上的中医刊物迄今就不下于 50 种,面对这些学术刊物,对一个中医人员来说,想要利用业余时间去尽数阅读,无疑是不可能的,只能阅者半而置者亦半,力不从心,望洋兴叹。这本集子的问世正是解决了这个问题,对大家起到事半功倍作用,并且可以分门别类地有选择、有比较地吸收到各自的学术思路和工作中去,更可借以了解国内中医学术动态。

其次的作用,应该是几位编辑者本身所能得到的方面。本集子中所收集的并非原作者的全文,而是对原文的摘要,这既是他们几位的工作所在,也是得益所在。由于要做好摘要,必先通读每篇选入文章的全文,才能提出要点而撷其精英,完成这一工作的本身,无疑就是学习全国中医工作者的经验,理所当然是会受益的。

这本集子收集辑节于 1976~1987 年省市级以上杂志及绝大部分各中医学院学报,几位编辑者把临床报道文章按临床分科分成系统,对各病种的文章作了归类,对每篇文章摘要以方药、加减原则及疗效统计作为重点予以突出,并均注明原刊名及刊出期号,使阅者读来可以简要而又了然,是一种极适

合于临床实用的参考书籍；在摘辑过程中，我就看过部分文字，感到是适应广大中医工作者的实际需要的，至少在现在对信息有广阔要求的情况下，是能够起到及时传播学术进度的作用的，因而志此数语，以作序言。

（1988年3月于北京瓣杏斋）

发展中医的几个认识问题

第三届全国中医疑难病学术研讨会总结发言节录

中医事业自党的十一届三中全会以来，得到了重大发展，全国各省市中医院校的恢复和发展、中医医院、中医药学会、学组的恢复和发展亦均由中央延伸到区、县，从而使中医医疗、教学、科研工作有了广泛、坚实的阵地，这是今后中医药事业蓬勃发展的基本保证，但在这种大好形势的另一面，各单位经费不足，设备落后而简陋，人才匮乏，学术滑坡等问题还是客观存在的。为了使中医药事业进一步发展，这些问题是亟待解决的。造成这些不足之处的原因，有历史方面的，也有社会方面的。这是中医药事业发展道路中必然出现的问题，是每个事物发展过程中的共性问题，具体分析，和投入中医药事业的人力、财力以及科学管理都有密切关系，这不能靠某个单位、某个人去解决，要随着中医事业的不断发展去解决。然而，面对这种客观存在，我们每一个中医人员应该如何对待？是等待，做事物发展的“尾巴”，还是运用主观能动作用去促进它的解决？我认为应该是后者，只有发挥每个中医人员的能动作用，合成一股共同力量，才能使中医事业不断壮大。这是毛主

席提出的“自力更生”办法,也是最可靠的办法。但是,必须充分调动每个中医人员的主观能动作用,中医人员自觉的思想认识至关重要,下面谈点拙见。

中医学作为华夏传统医学,其所以能够存在而且能不断壮大,在于中医学的几千年的历史发展中,形成了自身特有的诊疗体系、理论体系,有明显的医疗效果,能为人民解除病痛。中医学有自己的诊断手段——望、闻、问、切,有自己的治疗指标——证候,中医学的理论运用了人类对宇宙时空宏观认识论,运用了古哲学中的辩证法、唯物论。凡此等等,均是中医学的特色,是与世界其它医学的区别点。这种特色如得不到保持和发展,或者为其它医学所同化,就等于没有了中医学,也就谈不上毛主席所说的“应该努力发掘,整理提高”了。也正是这种特色,使中医学能跻身于世界医学之林,受到世界各国的重视,由此而出现了国际性的中医热,使中医学成为“有中国特色的社会主义”的重要组成部分,使之与中国国威有息息相关之处。由此可知,中医学的特色是必须保持和发展的,才能持久的持有“你无我有,你有我优”的形势而自立于世界医学之林,并为全人类服务。因此,这里提出几点认识,提请同道给予足够的重视:

1. 不能妄自菲薄:虽然目前“中医不科学”之类言论听不到了,但想用西医模式套中医、改造中医的认识尚可见之刊物,“中医没有发展前途”、“中医说不清”之类言论尚有所闻,甚至可闻于课堂之上,这类意识如果存在于中医药人员之中,必然要影响到中医特色的保持和发展。中医学的前途,正是中医人员要不断争取的前途,中医学说不清的地方,正是中医人员要不断钻研、争取说清的地方,这些也是各种事物发展过程中所共有的。西方医学至今仍有不清楚之处便是明证,在哲学

观点上说,医学对所有对象全部正确弄清楚时,正就是医学停止发展之时,这个要求的达到,谈何容易,应该说是与人类共存的。中医人员要具有的意识是,听共产党的话,挺起腰杆做主人,而不是随着别人说外国的月亮比中国亮。不卑躬屈膝,才能树立敢于争胜的雄心。

2. 不能固步自封:满足于用传统的诊断方法、治疗手段,满足于中医对某些疾病的疗效,认为中医一切都好的意识,也是阻滞中医学发展的因素;众所周知,一种学术的生命力,在于有新理论、新认识的不断补充,或者说新血液的不断增加,才能“既日新,又日新”,中医学自身的形成,就吸收了其它学科的知识,天文、气候、地理、数学、物理等的运用,在《内经》篇章中就明确反映了,在中医发展史中,引进道家学识、佛教学识,引进国外药物、印度哲学等也是有章可查,说明我们的先人就理解到“集思广益”了,理所当然,我们必须沿着这条有利于人民大众的路走下去,有利于中医学发展的路走下去。对由于痛心中医学特色的滑坡而发的激愤之言,应该要作深刻理解。

3. 对实用主义要分别对待:用什么办法效果好就用什么办法,不分中西,这种思想患者有,中医人员中也有,无可厚非;医生的天职是治好病、患者的要求是尽快去除病痛,这是天经地义的。但中医人员必需认清自己的责任,肩负有发展中医学术、建设中医事业的历史使命,这是华夏各民族的需要,是建设“具有中国特色的社会主义”的需要,所以应该结合到一点上去行事,就是尽力运用中医学术方法去取得好疗效,这就需要在中医学方面不断深入钻研、探索,不断提高自己的水平,这也就是中医行管部门提出中医医院要“先中后西,能中不西”和中医药的治疗率要达到70%的原因所在,如不是

如此要求,中医院将不成其为中医院,只用西药治病的中医人员也失掉了中医人员的本职。中医能够治病,能在世界公认难治病方面取得疗效,群众希望能用中医药治病的情况,是众所周知的,问题是在我们自己能否放掉西药这个拐杖的思想意识方面。

我认为,只有在“建设具有中国特色的社会主义”前提指导下,“古为今用”,“洋为中用”,而推陈出新,用鲁迅先生的话说,是“拿来主义”,一方面要遵循传统特色,学习前人的理论和经验而去芜存菁;另一方面要不断吸收其它学科之长,丰富中医学术自身,两者的同归是落实到充实和发展中医学术这一点上。为此,运用西方医学的各种检查、诊断手段,运用其有关仪器是应该的,用一点西医名词也是可以的,但必须是在中医的辨证论治、中医的理论指导下,作为辨证的参考内容去运用;大家知道中医有望、问、闻、切,西医有视、触、叩、听诊查手段,用西医的视、触、叩、听来扩大、延伸中医的四诊范围是对中医四诊的丰富,甚至如X线检查,也可以作为中医的望诊延伸而纳入辨证运用,《史记·扁鹊仓公列传》中用“饮上池水,视垣一方”来颂扬扁鹊能洞见脏腑癥结,说明从古就要求医务人员能对疾病有明析的了解的。中医人员的担子,一头是治疗效果,是群众威信,威信是建立在疗效上的,这正是中医学的命脉所在,中医学是靠疗效才延续到今天,否则是要被历史所淘汰的,这是要点。另外,威信的建立还要让群众懂得医生对他所患疾病的解释,才可以取得患者对治疗的配合,这一点又反过来与疗效有密切关系,也是扩大中医学影响的手段。担子的另一头,是发展中医特色,包括发展中医的理论和方法,这是实质所在,要用近代检查、数据、诊断方法、给药途径等来发展中医学的内涵和威力;《内经·上古天真论》中“行不

欲离于世”而“以自得为功”的要求,是我们完成发展中医事业任务的应有思想基础。

(本文曾发表于《光明中医》1992年第4期)

后 记

这本集子收集了我从事中医业务近 50 年中所写的绝大部分中医文章,其中主要是 1970 年以后所写。由于想借此集表达我在医学道路上的学习概貌,所以将 1954 年进入医院工作后所写的也一并收入。但这部分资料的收集比较困难,由于 10 年风雨,初稿毁散已尽,王新佩同学为此费了很大精力,从“北京中医药大学”和“中国中医研究院”等图书馆中搜阅了当时的《中华医学杂志》、《健康报》、《江苏中医杂志》,并加以复印始得。

汇集这本集子的最早起因,是 1979 年回京工作后与几位中医老友定期温习经典著作时,有“可否共同写个医话”之说,此后忙于医疗业务,一放数年,直到路志正学兄的《医林集腋》问世,才又想起;其间又受到刘寿永、张纲、江丹、袁晓宁等同志、同学的一再敦促,我才将历年所记医话、随笔一起收到集中。集子的整理和抄写,贾桂琴同学出力最多,其次是小女浣宜的襄助;现在这本集子付印了,而这些同志中有几位已经住到国外,系情所及,不能不时时想起他们。

由于此集是一己之作、一己之见,虽然包括了临床总结、临证体会、读书心得、四诊经验等内容,但毕竟只是中医学发展道路上的小石子,只能作为读者参考,我在自序中说过,“能得宏扬华夏之学,则虽斯集之覆瓿亦何憾哉”,实是寄深望于读者的。同样因为是一己之作,我只请冯其庸兄写了一篇序言,其庸兄与我同乡,并且同年晋京,自 1955 年由诊务而诗文相交,风雨中互疑生死,并与路志正、方和谦两学兄共同促我返京,至以泪眼相邀;能得挚友一序,已胜汪伦得《桃花潭诗》

多多。

有几位同志问起过《瓣杏医谈》的命意，医谈之意我在口序中已说过，是因文体长、短、文、白不一，称作医谈，可以不受体例限止。瓣杏之义：一是我国历来以杏林作为中医的代称，

三国时董奉的庐山杏林（见《南康府志》）是其起源，心仪其人其事，所以要瓣香膜拜；二是此集虽为中医之作，但在浩瀚的中医学海洋中，不过犹如在万树杏林中拾取了一些花朵花瓣；另有一个原因是，我从1987年退回医疗业务岗位后，将读书动笔之室称作“瓣杏斋”，寄托我一生从事中医的敬业之思，此集的收集编辑也就在此斋中完成，由此寄意寄地，所以就称此集为《瓣杏医谈》了。

此集辑成付印，正逢我晋京工作40周年，明年将是行医50周年和从医55周年之际，回首师门，授业师执11人均已作古，就将此集作为向师恩回报而策我后来吧。

1995年1月再识

封面
版权
前言
目录
目录

痧症和刮痧疗法

感冒

伤寒

尿路结石

乙脑浅见

中医学中的整体观念

急性支气管炎辨证随谈

五行说与中医学

眩晕

漫谈肝炎

对三焦的探讨

中医学对“阴阳”的运用

肠病

一、痢疾

二、肠风

三、便秘

四、虫病（附：钩虫病）

头痛

中风

对脾的认识

脾胃病的诊治体会

表证辨治三要

卫、气之分用药有别

溃疡病可参用外科治法

“失水”之治应找捷径

直中三阴症

梦洩梦飞

敏于听者多虚

治虚人呕泄养重于药

痺症之治

同药不同效其因诸多

药证相符宜守方

“医者意也”辨

“长夏”说

冬不藏精说

伏气说

前人论喉症虚实之治

梅核气

对“溃疡病”辨证论治的管见

慢性胃炎浅识

健脾益气治疗笔谈

河间学说的渊源与成就浅探

外感热病表证的辨证

冬令进补琐谈

谈外邪发病及其化热

外感热病前期辨治续谈

学习《素问·四气调神大论》

学习《素问·金匱真言论》

学习《素问·灵兰秘典论》

学医读书之道

《内经》成书时期说

通过反鬼神观点看《内经》的唯物思想

“若火熏之”我识

小议暑症“汗出而散”

从仲景条文谈“热入血室”的辨治

论麻杏甘膏汤证

大青龙汤多面观

少阳丛谈

脉学管见

脉诊记识

一、孕脉

二、滑脉

三、弦脉

四、长脉

五、濡脉主表湿

六、芤、革脉之异同

七、无根脉

八、来去至止

九、辨脉在于习

十、浮中沉定脉法及举按寻

十一、寸关尺之据

十二、脉之神气、胃气

色诊琐谈

舌诊记要

以茵陈蒿汤为主治疗黄疸的疗效观察和体会

82例传染性肝炎疗效观察

柿胃石病案报告

60例上消化道出血的临床观察

9例破伤风治疗小结

医案三则

- 一、健脾益气法治愈十二指肠溃疡案
- 二、肝硬化腹水案
- 三、补气摄血法治愈过敏性紫癜案

阑尾脓肿 9 例小结

慢性腹泻的治疗

对“热入血室”的虚实辨治

术后呃逆病案二则

石淋虚实辨证

中药配合动脉导管结扎治愈巨块型肝癌 1 例

肺癌诊治管见

越鞠丸义解

越婢义解

治病用血药

治病用湿药一得

黄连阿胶汤治肠溃疡

狗肉治症

南北用药异同

“异法方宜”新证

灵芝五色变化为其生化过程

三七可行血

地黄膩膈种种

药品之效因产地异

药性有新效

“雪上一枝蒿”中毒例

“白常山”无截疟之功

煎药宜讲求

中药有过敏

草药有捷效

四日疟

曾见异病

惊吓气厥

附文

温课小启

《中医内科急症》跋

《伤寒研究》小序

《倚云轩医话》序

《北京郊区县中医院论文集第一辑》序

《“正气存内”与“意导”》文按

《北京郊区县中医院论文集第二辑》序

扬长避短，增强内在活力，开拓中医事业

《温病条辨》方歌诀叙

《当代中医实用临床效验方》小序
发展中医的几个认识问题

后记